

GUIA CLÍNICO DE BOLSO

Antibioticoterapia no Plantão

Decisão antimicrobiana à beira do leito: síndrome por síndrome, com dose, via, duração, critérios de gravidade e plano de descalonamento.

162

quadros clínicos

19

sistemas

41

antimicrobianos

Dr. Felipe Frank Pinto

4ª edição · revisão de setembro de 2026

Aviso clínico e médico-legal

Este guia é ferramenta de apoio à decisão dirigida a profissionais de saúde. Não é prescrição automática nem protocolo institucional, e não substitui exame presencial, julgamento clínico, bula, CCIH, infectologia ou a microbiologia do seu serviço.

ANTES DE PRESCREVER — EM TODOS OS QUADROS

- Confirme diagnóstico, gravidade, alergias e o tipo de reação prévia.
- Confirme peso atual, função renal e hepática, gestação e lactação, e interações.
- Colha culturas quando mudarem a conduta, sem atrasar terapia tempo-dependente.
- Considere controle de foco, epidemiologia local, resistência e disponibilidade institucional.
- Reavalie em 24–72 h para descalonar, trocar a via e limitar a duração.

Este bloco vale para todos os quadros do livro e por isso não é repetido em cada página.

POLÍTICA EDITORIAL

Brasil e SUS como padrão; alternativas internacionais aparecem explicitamente identificadas. Cada quadro exibe, no cabeçalho, um selo com o nível da sua referência:

Verificado	Há diretriz dedicada àquela síndrome, identificada na própria página.
Revisão parcial	Há diretriz pertinente, mas parte das doses ou durações vem de fonte farmacêutica ou de prática consolidada.
Bibliografia de capítulo	Não há diretriz dedicada ao tema; a conduta é sustentada pela bibliografia do capítulo e por prática consolidada. Doses exigem validação institucional.

A bibliografia de capítulo, consolidada e sem repetições, fecha cada capítulo. A bibliografia de capítulo não deve ser lida como validação individual de cada dose.

A data que aparece no selo de cada quadro é a da última verificação clínica registrada para aquele tópico. Sobre ela, esta 4ª edição aplicou uma revisão clínica e editorial transversal, síndrome por síndrome, concluída em setembro de 2026 — o que mudou está documentado no relatório de revisão que acompanha esta edição.

O selo **validação institucional** indica o quanto aquela conduta depende do protocolo, do antibiograma e da disponibilidade do seu serviço: **dispensável**, **recomendada** ou **obrigatória**.

A anatomia de um quadro

Todos os quadros clínicos seguem a mesma sequência. Ela foi desenhada para que a primeira decisão esteja sempre no alto da página e o refinamento venha depois.

Conduta de partida	O bloco escuro no alto da página. Fármaco, dose, via e duração para o cenário mais frequente. É ponto de partida, não dispensa a leitura dos critérios e alertas.
Agentes e contexto	Patógenos prováveis e o que torna cada um mais provável naquele paciente.
Esquemas terapêuticos	Dose, via, duração e observações, organizados por gravidade e por risco de resistência.
Alternativas e alergia	Separa alergia verdadeira, intolerância, reação tardia grave e necessidade de especialista.
Quando ampliar a cobertura	Critérios objetivos para acrescentar MRSA, Pseudomonas, ESBL ou anaeróbios — e apenas eles.
Alertas de segurança	Três níveis. Informação : contexto útil. Atenção : erro frequente. Alerta crítico : erro que muda desfecho.
Conduta passo a passo	A sequência operacional, do reconhecimento à reavaliação.
Critérios	Internação, UTI, gravidade e falha terapêutica.
Microbiologia e stewardship	Culturas, controle de foco, marco da duração, descalonamento e transição EV → VO.
Antimicrobianos e ajustes	Dose padrão e de gravidade, ajuste renal, teto, ajuste hepático e monitorização. O selo ao lado do fármaco resume gestação e lactação.

SELOS DE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO

Gestação: uso aceito	Experiência clínica geralmente favorável quando há indicação. Considerar idade gestacional, função orgânica e foco; em lactação, avaliar o lactente.
Gestação: com ressalva	Uso possível dentro de um recorte específico, com a restrição indicada no próprio quadro.
Gestação: evitar	Escolher alternativa específica para o foco; usar apenas se o benefício superar claramente o risco e não houver opção adequada.

Apresentações disponíveis no Brasil

Uma dose correta pela diretriz pode não existir na farmácia. As diretrizes que sustentam este livro são majoritariamente norte-americanas e europeias, e várias apresentações que elas usam não têm registro no Brasil. Esta página reúne os pontos em que a diferença muda a prescrição.

ONDE A APRESENTAÇÃO BRASILEIRA MUDA A RECEITA

Amoxicilina	Cápsula de 500 mg e comprimido de 875 mg. Não há apresentação de 1 g: a dose de 1 g VO 8/8 h da pneumonia comunitária corresponde a duas cápsulas de 500 mg.
Amoxicilina + clavulanato	Comprimidos de 500/125 mg e 875/125 mg; suspensões de 250/62,5 e 400/57 mg por 5 mL; injetável de 1000/200 mg. A apresentação de liberação prolongada 2000/125 mg (XR) não existe no Brasil. Quando for necessária maior exposição à amoxicilina, associar amoxicilina isolada em vez de aumentar o clavulanato.
Amoxicilina + clavulanato em pediatria	A dose alta das diretrizes norte-americanas (90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato) depende da suspensão 600/42,9 mg por 5 mL, proporção 14:1, que não existe aqui. Com a suspensão brasileira (400/57 mg por 5 mL, proporção 7:1), dar até 70 mg/kg/dia por ela e completar com amoxicilina isolada, mantendo o clavulanato em até 10 mg/kg/dia.
Penicilina V	Comprimido de 500.000 UI ($\approx$ 312 mg) e solução oral de 80.000 UI/mL. Não há comprimido rotulado em miligramas: prescrever em unidades internacionais.
Oxacilina	Apenas apresentação injetável. Para cobertura antiestafilocócica oral, a opção é cefalexina.
Cefdinir	Disponível apenas como suspensão oral pediátrica. Não há cápsula para adulto.
Cefpodoxima e cefixima	Disponibilidade variável. Não contar com elas como plano B sem confirmar no formulário do serviço.
Colírios e pomadas oftálmicas	As opções com registro nacional são tobramicina 0,3% (colírio e pomada), ciprofloxacino 0,3%, azitromicina 1,5% e as associações oxitetraciclina + polimixina B e neomicina + polimixina B + bacitracina.

CITADAS NA LITERATURA INTERNACIONAL, SEM EQUIVALENTE NO BRASIL

- **Amoxicilina-clavulanato 2000/125 mg (XR)** — usar 875/125 mg 12/12 h, ou 500/125 mg 8/8 h, associando amoxicilina isolada quando for preciso elevar a amoxicilina.
- **Suspensão pediátrica 600/42,9 mg por 5 mL (14:1)** — usar a suspensão 400/57 mg por 5 mL e completar com amoxicilina isolada.
- **Dicloxacilina** — usar cefalexina por via oral; oxacilina apenas endovenosa.
- **Colírio de polimixina B + trimetoprima** — usar tobramicina, ciprofloxacino ou azitromicina colírio.
- **Pomada oftálmica de eritromicina e de bacitracina isolada** — usar tobramicina pomada ou as associações disponíveis.

ANTIMICROBIANOS DE RESERVA: REGISTRO NÃO É O MESMO QUE DISPONIBILIDADE

Ceftazidima-avibactam, ceftolozano-tazobactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam, cefiderocol, sulbactam-durlobactam, aztreonam-avibactam, fidaxomicina e bezlotoxumabe aparecem nos capítulos hospitalares como as opções corretas para os respectivos mecanismos de resistência. Nem todos estão registrados no país, e mesmo os registrados podem não estar padronizados no seu serviço. Antes de contar com qualquer um deles, confirme com a farmácia clínica e a CCIH — os quadros correspondentes trazem o esquema alternativo para quando o preferencial não estiver disponível.

Apresentações e marcas mudam. Esta página reflete a verificação feita para a 4ª edição; diante de dúvida, confirmar na bula da apresentação efetivamente dispensada e no formulário da instituição.

Alergia a betalactâmico em uma página

Rotular um paciente como alérgico à penicilina sem classificar a reação leva a esquemas inferiores, mais tóxicos e mais caros. Esta página vale para todos os quadros do livro; o quadro 19.7 traz a versão operacional para o plantão.

PRIMEIRO: QUE REAÇÃO FOI ESSA?

Efeito adverso ou intolerância	Náusea, diarreia, cefaleia. Não é alergia. O betalactâmico de escolha pode ser mantido.
Reação tardia leve	Exantema maculopapular após dias, sem sinais sistêmicos. Baixo risco de reação imediata; cefalosporina de cadeia lateral distinta costuma ser segura.
Reação imediata (IgE)	Urticária, angioedema, broncoespasmo, hipotensão em minutos a poucas horas. Evitar o fármaco implicado; escolher por cadeia lateral ou considerar dessensibilização em infecção crítica.
Reação cutânea grave tardia	SSJ/NET, DRESS, PEGA, nefrite intersticial, citopenia. Contraindica a classe implicada. Não fazer teste ou desafio no pronto-socorro.

DEPOIS: O QUE ISSO MUDA

- A reatividade cruzada entre penicilinas e cefalosporinas depende sobretudo da **cadeia lateral**, não do anel betalactâmico. Cefalosporinas de cadeia lateral distinta são frequentemente seguras mesmo com história de reação imediata a penicilina.
- Carbapenêmicos têm reatividade cruzada baixa com penicilinas.
- Aztreonam não tem reatividade cruzada relevante com penicilinas e cefalosporinas — exceto ceftazidima, com quem compartilha cadeia lateral.
- Em infecção grave na qual o betalactâmico é claramente superior, a dessensibilização é uma opção real e deve ser discutida em vez de aceitar um esquema inferior.
- Registre no prontuário **qual** fármaco, **quanto tempo** depois e **quais** sintomas. Um rótulo sem descrição perpetua o erro por anos.

Sumário

Páginas de abertura	
Aviso clínico e médico-legal	2
A anatomia de um quadro	3
Apresentações disponíveis no Brasil	4
Alergia a betalactâmico em uma página	5
01	Respiratório
1.1	Pneumonia Adquirida na Comunidade — Adulto
1.2	Pneumonia Grave / UTI
1.3	Exacerbação Infecçiosa de DPOC
1.4	Sinusite Bacteriana Aguda — Adulto
1.5	Pneumonia Broncoaspirativa
1.6	Abscesso Pulmonar
1.7	Empiema / Infecção Pleural
1.8	Exacerbação de Bronquiectasias
1.9	Pneumonia Hospitalar / Nosocomial
02	Otorrinolaringológico
2.1	Faringoamigdalite Estreptocócica — Adulto
2.2	Abscesso Peritonsilar / Celulite Periamigdaliana
2.3	Otite Média Aguda — Adulto
2.4	Otite Externa Aguda Difusa
2.5	Otite Externa Maligna / Necrotizante
2.6	Mastoidite Aguda
2.7	Epiglote / Supraglote — Adulto
2.8	Sialadenite / Parotidite Bacteriana Aguda
03	Odontogênico
3.1	Abscesso Odontogênico Localizado / Infecção Dentária Aguda
3.2	Celulite Facial Odontogênica
3.3	Angina de Ludwig / Infecção do Assoalho da Boca
3.4	Infecção Cervical Profunda de Origem Odontogênica
3.5	Sinusite Odontogênica / Pós-procedimento Dentário
3.6	Alveolite / Infecção Pós-extração Dentária
3.7	Osteomielite Mandibular/Maxilar Odontogênica
3.8	Profilaxia Antibiótica em Procedimento Dentário — Alto Risco
04	Pele e Partes Moles

4.1	Celulite Não Purulenta / Erisipela	78
4.2	SSTI Purulenta — Abscesso / Furúnculo / Carbúnculo	81
4.3	Mordedura Humana / Animal — Infectada ou Alto Risco	83
4.4	Pé Diabético Infectado	86
4.5	Fasciite Necrosante / Infecção Necrosante de Partes Moles	89
4.6	Infecção de Ferida Operatória / Sítio Cirúrgico	91
4.7	Hidradenite Supurativa — Doença Inflamatória ± Infecção Secundária	94
4.8	Impetigo / Ectima	96
05	Urinário	99
5.1	Pielonefrite Aguda — Adulto	100
5.2	Cistite Simples — Mulher Não Gestante	104
5.3	ITU Complicada / Urosepse	106
5.4	ITU Associada a Cateter Vesical — CAUTI	109
5.5	Prostatite Bacteriana Aguda	111
5.6	Epididimite / Orquiepididimite Aguda	114
5.7	ITU na Gestante / Bacteriúria Assintomática	116
5.8	Bacteriúria Assintomática	118
06	Gastrointestinal	120
6.1	Diverticulite Aguda — Adulto	121
6.2	Colecistite Aguda	124
6.3	Colangite Aguda	126
6.4	Apendicite Complicada / Peritonite Secundária	129
6.5	Abscesso Intra-abdominal após Controle de Foco	131
6.6	Diarreia Infecciosa / Disenteria — Adulto	133
6.7	Colite por Clostridioides difficile	136
6.8	Abscesso Hepático Piogênico	138
07	SNC	141
7.1	Meningite Bacteriana — Adulto	142
7.2	Encefalite Herpética — Adulto	146
7.3	Abscesso Cerebral	148
7.4	Meningite/Ventriculite Pós-neurocirurgia ou Shunt	150
7.5	Neurotoxoplasmose / Lesões Cerebrais em HIV Avançado	153
7.6	Meningite Tuberculosa	155
7.7	Empiema Subdural / Abscesso Epidural Craniano	157
08	Cardiovascular	160
8.1	Endocardite Infecciosa — Valva Nativa / Comunitária	161
8.2	Endocardite — Prótese Valvar / Associada a Cuidado de Saúde	164
8.3	Endocardite Direita / Uso de Droga EV	167

8.4	Bacteremia por <i>Staphylococcus aureus</i> — Risco de Endocardite	169
8.5	Infecção de Cateter Venoso Central / CRBSI	171
8.6	Infecção de Dispositivo Cardíaco Implantável — Marcapasso/CDI	174
8.7	Mediastinite Pós-Esternotomia / Infecção Profunda de Ferida Cardíaca	176
09	Osteoarticular	179
9.1	Artrite Séptica — Articulação Nativa / Adulto	180
9.2	Osteomielite Aguda — Hematogênica ou Contígua	182
9.3	Espondilodiscite / Osteomielite Vertebral Nativa	185
9.4	Infecção de Prótese Articular — Joelho/Quadril	187
9.5	Osteomielite no Pé Diabético	190
9.6	Infecção de Material de Síntese / Osteossíntese	192
9.7	Bursite Séptica — Olecraniana/Pré-patelar	195
9.8	Tenossinovite Piogênica dos Flexores — Mão	197
10	Gineco/Obstétrico	200
10.1	DIP — Doença Inflamatória Pélvica	201
10.2	Abscesso Tubo-Ovariano	203
10.3	Endometrite Pós-parto / Pós-procedimento	205
10.4	Infecção Intra-amniótica / Corioamnionite	208
10.5	Aborto Séptico / Infecção Pós-abortamento	210
10.6	Mastite Puerperal / Abscesso Mamário	212
10.7	Bartholinite / Abscesso de Bartholin	215
10.8	Corrimento Vaginal/Cervicite — Escolher a Síndrome	217
11	IST	220
11.1	Uretrite / Cervicite — Abordagem Sindrômica Inicial	221
11.2	Gonorreia Não Complicada — Urogenital/Retal/Faríngea	223
11.3	Clamídia Não Complicada — Urogenital/Retal	226
11.4	Sífilis Adquirida — Primária/Secundária/Latente	228
11.5	Herpes Genital — Primeiro Episódio ou Recorrência	230
11.6	Tricomoníase — Adulto	232
11.7	Proctite por IST / Suspeita de LGV	234
11.8	<i>Mycoplasma genitalium</i> — Uretrite/Cervicite Persistente	236
11.9	Doxi-PEP — Prevenção Pós-Exposição de IST Bacteriana	238
12	Oftalmológico	240
12.1	Conjuntivite Bacteriana — Adulto	241
12.2	Conjuntivite Gonocócica Hiperpurulenta	243
12.3	Ceratite Bacteriana / Úlcera de Córnea — Lente de Contato	245
12.4	Celulite Pré-septal / Periorbitária — Adulto	247
12.5	Celulite Orbitária — Adulto	249

12.6	Endoftalmite Pós-procedimento / Pós-trauma	252
12.7	Dacriocistite Aguda — Adulto	254
12.8	Herpes Zoster Oftálmico	256
12.9	Blefarite / Hordéolo / Calázio Infectado	258
13	Tropicais/Zoonoses	260
13.1	Leptospirose — Leve/Moderada	261
13.2	Leptospirose Grave / Síndrome de Weil	263
13.3	Febre Maculosa / Rickettsiose — Suspeita Clínica	265
13.4	Malária Não Complicada — Abordagem Inicial	267
13.5	Malária Grave — Emergência	269
13.6	Febre Tifoide / Paratifoide	271
13.7	Brucelose — Adulto	273
13.8	Tétano Acidental Instalado — Tratamento em UTI	275
14	Pediatria	278
14.1	PAC Pediátrica — >3 meses	279
14.2	Otite Média Aguda — Pediátrica	282
14.3	Sinusite Bacteriana Aguda — Pediátrica	284
14.4	Faringoamigdalite Estreptocócica — Pediátrica	286
14.5	ITU Febril — Lactente após Período Neonatal e Criança	288
14.6	Celulite / Erisipela — Pediátrica	291
14.7	Impetigo / Ectima — Pediátrico	293
14.8	Meningite Bacteriana — Pediátrica (>1 mês)	295
14.9	Sepse / Choque Séptico — Pediátrico	297
14.10	Osteomielite / Artrite Séptica — Pediátrica	300
14.11	Mordedura Humana/Animal — Pediátrica	302
15	Imunossuprimidos	305
15.1	Febre Neutropênica — Alto Risco / Internação	306
15.2	Febre Neutropênica — Baixo Risco / Possível Ambulatorial	309
15.3	Febre em Asplenia / Hipoesplenia	311
15.4	Candidemia / Candidíase Invasiva	313
15.5	Pneumocistose — PJP/PCP em HIV ou Imunossupressão	315
15.6	Nocardiose — Pulmonar/Cutânea/Disseminada	317
15.7	Febre em Transplantado de Órgão Sólido	319
15.8	Doença por CMV — Imunossuprimido/Transplantado	322
15.9	Febre Persistente na Neutropenia — Suspeita de Fungo Invasivo	324
16	Sepse/Sistêmicas	327
16.1	Sepse e Choque Séptico — Abordagem Inicial	328

17	Profilaxias/Exposições	334
17.1	PEP HIV — Pós-exposição Sexual/Ocupacional	335
17.2	Hepatite B — Profilaxia Pós-exposição	337
17.3	Raiva — Profilaxia Pós-exposição	338
17.4	Profilaxia do Tétano após Ferimento — Brasil	341
17.5	Meningococo — Quimioprofilaxia de Contatos	343
17.6	Coqueluche — Profilaxia de Contatos de Alto Risco	345
17.7	Influenza — Profilaxia Pós-exposição em Alto Risco	346
17.8	Acidente Biológico Ocupacional — Sangue/Material Perfurocortante	348
17.9	Asplenia/Hipoesplenia — Febre e Profilaxia	350
17.10	Profilaxia Antibiótica Cirúrgica — Princípios Básicos	352
18	Hospitalares	355
18.1	Febre Hospitalar Sem Foco Definido — Adulto Internado	356
18.2	PAV / Pneumonia Hospitalar com Risco de MDR	359
18.3	Bacteremia Hospitalar / Hemocultura Positiva Sem Foco Claro	361
18.4	Infecção de Cateter de Hemodiálise / Acesso Dialítico	364
18.5	ITU Hospitalar / CAUTI com Risco de MDR	366
18.6	Infecção Intra-abdominal Hospitalar / Peritonite Terciária	369
18.7	Enterobacterales ESBL — Suspeita ou Confirmação	371
18.8	Enterobacterales Resistentes a Carbapenêmicos — Tratamento por Carbapenemase	374
18.9	Pseudomonas MDR/DTR — Suspeita ou Confirmação	377
18.10	Enterococcus / VRE — Infecção Hospitalar Relevante	380
18.11	Stenotrophomonas maltophilia — Infecção Hospitalar	382
18.12	Acinetobacter baumannii Resistente a Carbapenêmico — CRAB	384
19	Síndromes Práticas	388
19.1	Febre Sem Foco — Adulto Imunocompetente Estável	389
19.2	Febre no Idoso Frágil — Sem Foco Claro	391
19.3	Sepse Sem Foco Definido — Adulto	393
19.4	Choque Séptico Sem Foco Definido — Abordagem Imediata	396
19.5	Hemocultura Positiva — Interpretação Inicial no PS/Enfermaria	399
19.6	Falha Terapêutica em 48–72 h de Antibiótico	402
19.7	Alergia a Betalactâmico — Decisão Antibiótica no Plantão	404
19.8	Culturas Antes do Antibiótico — Quando Colher	407
19.9	Quando NÃO Prescrever Antibiótico — Decisão Negativa	409
19.10	Descalonamento e Duração Curta — Stewardship no Plantão	411
19.11	Ajuste Renal / Hemodiálise — Antibióticos no Plantão	413
19.12	Antibiótico na Gestante/Lactante — Abordagem Inicial	415
19.13	Antibiótico Antes de Transferência/Regulação — PS	417
19.14	PCR / Procalcitonina / Leucocitose — Como Não Supertratar	420

01

Respiratório

9 quadros clínicos neste sistema

1.1	Pneumonia Adquirida na Comunidade — Adulto	13
1.2	Pneumonia Grave / UTI	17
1.3	Exacerbação Infecciosa de DPOC	21
1.4	Sinusite Bacteriana Aguda — Adulto	23
1.5	Pneumonia Broncoaspirativa	26
1.6	Abscesso Pulmonar	28
1.7	Empiema / Infecção Pleural	31
1.8	Exacerbação de Bronquiectasias	34
1.9	Pneumonia Hospitalar / Nosocomial	36

1.1

Pneumonia Adquirida na Comunidade — Adulto

LEVE A MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Infecção aguda do parênquima pulmonar adquirida na comunidade. O sítio de cuidado depende de estabilidade, oxigenação, comorbidades, capacidade de tratamento oral, suporte social e escores validados; CURB-65 ou PSI apoiam, mas não substituem julgamento clínico.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina

1 g VO a cada 8 horas

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias na maioria dos pacientes, desde que haja estabilidade clínica; 3–5 dias apenas em internado não grave selecionado e com decisão diária; mínimo de 5 dias na PAC grave

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL	Principal agente em todos os graus de gravidade
Haemophilus influenzae	FREQUENTE	Mais comum em DPOC e tabagismo
Mycoplasma pneumoniae	CONTEXTUAL	Pacientes jovens, curso mais brando
Chlamydia pneumoniae	CONTEXTUAL	Apresentação subaguda
Legionella pneumophila	CONTEXTUAL	Formas graves, epidemia, exposição a água
Staphylococcus aureus (MSSA)	CONTEXTUAL	Pós-vírus, gripe, internação recente
Vírus respiratórios	FREQUENTE	Influenza, RSV, SARS-CoV-2

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve, sem comorbidades, ambulatorial (CURB-65: 0–1)	Amoxicilina · 1 g VO 8/8 h · VO	5 dias, se resposta clínica adequada	Primeira linha. Alternativa: Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h
Ambulatorial com comorbidades relevantes (CURB-65: 0–1)	Amoxicilina + Clavulanato + Azitromicina OU Amoxicilina + Clavulanato + Doxiciclina · Amox-Clav 875/125 mg VO 12/12 h OU 500/125 mg VO 8/8 h + Azitro 500 mg VO 24/24 h; alternativa: Amox-Clav + Doxi 100 mg VO 12/12 h · VO	5 dias, se resposta clínica adequada	Em comorbidades, associar cobertura para atípicos com macrolídeo ou doxiciclina, salvo baixa suspeita/localidade. Idade isolada não define gravidade nem indica ampliação de espectro.
Moderada a grave, internação necessária (CURB-65: 2–3)	Ceftriaxona + Azitromicina · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h + Azitromicina 500 mg EV/VO 24/24 h · EV	3–5 dias somente se estabilidade clínica objetiva, ausência de complicação e resposta adequada; não fixar 3 dias na admissão	Cobertura ampliada para PAC internada. Considerar Piperacilina-Tazobactam apenas se risco validado de GNB resistentes/Pseudomonas.
Severa/UTI sem risco validado de MRSA/Pseudomonas	Ceftriaxona + Azitromicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Azitromicina 500 mg EV 24/24 h · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias conforme evolução	Adicionar Vancomicina apenas se risco de MRSA; trocar para betalactâmico antipseudomonal apenas se risco de Pseudomonas.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PAC em paciente com DPOC, sem risco de Pseudomonas	Amoxicilina + Clavulanato + Azitromicina OU Levofloxacino · Amox-Clav 875/125 mg VO 12/12 h + Azitro 500 mg 24/24 h OU Levo 750 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	5 dias, se resposta clínica adequada	Reservar quinolona para alergia, falha, impossibilidade de combinação ou maior risco de resistência. Atenção ao QT.

Sobre a duração: Cursos de 3–4 dias podem ser considerados apenas em pacientes selecionados, com estabilidade clínica objetiva, sem complicação e com seguimento confiável.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico (leve)	Levofloxacino · 750 mg VO 24/24 h · VO	5 dias, se resposta clínica adequada	Monitorar intervalo QT. Não usar se risco de arritmia.
Alergia a betalactâmico (grave/anafilaxia)	Moxifloxacino · Moxi 400 mg VO 24/24 h · VO	5 dias se estabilidade; 5–7 dias conforme resposta	Evitar associar macrolídeo/quinolona sem necessidade pelo risco de QT. Reavaliar indicação e riscos individuais.
Alergia grave, internado	Levofloxacino ± Vancomicina · Levo 750 mg EV 24/24 h; adicionar Vanco apenas se risco de MRSA · EV	5–7 dias; individualizar se grave/complicada	Vancomicina não deve ser rotina sem critério de MRSA. Monitorar QT e função renal.
Falha com amoxicilina	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h; quando for necessária maior exposição à amoxicilina, associar amoxicilina isolada 500–875 mg VO 12/12 h em vez de aumentar o clavulanato · VO	5 dias, se resposta clínica adequada	Provavelmente H. influenzae ou MSSA produtor de betalactamase. No Brasil não há a apresentação de 2000/125 mg (XR): as apresentações orais são 500/125 mg e 875/125 mg.

Sobre a duração: Mesma regra de duração do esquema principal.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	- Isolamento respiratório ou infecção prévia por MRSA, especialmente recente - Internação com antibiótico EV nos últimos 90 dias - Pneumonia necrosante/cavitária, empiema ou superinfecção grave pós-influenza - Fator de risco validado pelo protocolo e epidemiologia local	Vancomicina com dose/monitorização individualizadas por AUC/nível; linezolid pode ser opção em cenário selecionado
PSEUDOMONAS	- Isolamento respiratório ou infecção prévia por Pseudomonas - Internação com antibiótico EV nos últimos 90 dias - Doença pulmonar estrutural com colonização prévia ou risco validado - Neutropenia/imunossupressão relevante com epidemiologia compatível - Fator de risco validado pelo protocolo e microbiologia local	Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

ESTABILIDADE PARA CURSO CURTO/ALTA

Confirmar melhora de temperatura, frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, estado mental, ingestão e oxigenação/necessidade de O₂. Não encurtar apenas porque completou um número de dias.

ATENÇÃO

CORTICOIDE NA PAC: NÃO ROTINEIRO, CONSIDERAR APENAS NO GRAVE

PAC não grave: não usar corticoide sistêmico de rotina. Ressalvadas indicações independentes, como exacerbação de asma ou DPOC, insuficiência adrenal e choque séptico. PAC grave em adulto internado: o corticoide sistêmico pode ser considerado; recomendação condicional, com baixa qualidade de evidência. Não aplicar a pneumonia grave por influenza. Os resultados dos estudos são heterogêneos e o REMAP-CAP não demonstrou redução significativa de mortalidade. Se optar por usar, hidrocortisona 200 mg/dia IV aparece na literatura apenas como exemplo derivado de ensaio clínico: tipo, duração e desmame não foram padronizados pela diretriz e devem seguir avaliação individual ou protocolo institucional. Monitorar hiperglicemia, infecção secundária e contraindicações relativas.

INFORMAÇÃO

ULTRASSOM PULMONAR NO DIAGNÓSTICO

Em centros com profissional adequadamente treinado, o ultrassom pulmonar pode ser utilizado como alternativa à radiografia de tórax para apoiar o diagnóstico de PAC. A recomendação é condicional, depende da experiência do operador e não exclui radiografia ou tomografia quando houver suspeita de diagnóstico alternativo ou complicação.

ATENÇÃO

TESTE VIRAL POSITIVO NÃO EXCLUI COINFECÇÃO BACTERIANA

Ambulatorial sem comorbidades, com teste viral positivo e baixa suspeita de coinfeção bacteriana: pode-se não iniciar antibiótico. Ambulatorial com comorbidades e pacientes internados: manter antibioticoterapia empírica inicialmente, pelo risco de coinfeção. A decisão depende do contexto clínico, imagem, marcadores inflamatórios, presença de consolidação, purulência, dupla piora e possibilidade de seguimento.

INFORMAÇÃO

CULTURAS ANTES DO ANTIBIÓTICO QUANDO INDICADAS

Em internação, sepse, PAC grave, risco de patógeno resistente ou falha terapêutica, colher hemoculturas e escarro quando viável sem atrasar tratamento. Em PAC ambulatorial leve, hemocultura não é rotina. Na sepse, iniciar em até 1 h mesmo sem culturas.

ALERTA CRÍTICO

COBERTURA PARA MRSA

Associar cobertura anti-MRSA apenas diante de isolamento prévio, internação com antibiótico EV recente, quadro necrosante/cavitário/empiema, pós-influenza grave ou outro fator validado localmente.

ATENÇÃO

RISCO DE QT LONGO

Macrolídeos (azitromicina) e quinolonas podem prolongar o QT. Verificar K^+ e Mg^{2+} , ECG basal se paciente com risco.

INFORMAÇÃO

DURAÇÃO: DECIDIR PELA ESTABILIDADE, NÃO PELO CALENDÁRIO

Critérios objetivos de estabilidade clínica: temperatura $\leq 37,8^\circ\text{C}$; FC < 100 bpm; FR < 24 irpm; PAS ≥ 90 mmHg; estado mental normal; $\text{SpO}_2 \geq 90\%$ em ar ambiente ou retorno a necessidade basal de oxigênio; capacidade de ingestão e ausência de nova necessidade de oxigênio. Ambulatorial: 5 dias como padrão prático. Internado não grave: 3–5 dias com decisão diária. Grave/UTI: mínimo 5 dias. Prolongar em resposta lenta, pneumonia necrotizante, abscesso, empiema, bacteremia relevante, foco não controlado ou patógenos que exijam duração própria, como MRSA e Pseudomonas.

ATENÇÃO

PROCALCITONINA NÃO DECIDE ISOLADAMENTE

Não usar valor isolado de procalcitonina para excluir pneumonia bacteriana ou adiar antibiótico em paciente grave. Pode integrar reavaliação e suspensão quando o contexto clínico for favorável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Confirmar síndrome e gravidade	Avaliar oxigenação, estabilidade, comorbidades e PSI/CURB-65; idade isolada não define internação.
2	Ambulatorial sem comorbidade relevante	Amoxicilina 1 g VO 8/8 h; doxiciclina é alternativa quando adequada.
3	Internado não grave	Ceftriaxona + azitromicina; reavaliar diariamente estabilidade e duração total de 3–5 dias apenas se critérios objetivos forem atendidos.
4	PAC grave	Betalactâmico + macrolídeo; ampliar para MRSA/Pseudomonas apenas com risco validado e culturas.
5	48–72 h	Revisar diagnóstico, culturas, complicações, necessidade de oxigênio, descalonamento e via oral.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	- Hipoxemia ou nova necessidade de oxigênio - Instabilidade hemodinâmica, taquipneia importante ou alteração do estado mental - Incapacidade de ingestão/absorção oral ou descompensação de comorbidade - PSI/CURB-65 compatível, sem usar idade >65 anos isoladamente como indicação - Ausência de suporte/seguimento ambulatorial seguro
UTI	- Critério maior: ventilação mecânica invasiva - Critério maior: choque séptico com necessidade de vasopressor - Ou pelo menos 3 critérios menores ATS/IDSA: FR ≥ 30; PaO₂/FiO₂ ≤ 250; infiltrado multilobar; confusão; ureia ≥ 43 mg/dL (equivalente a BUN ≥ 20 mg/dL); leucócitos $<4.000/\text{mm}^3$; plaquetas $<100.000/\text{mm}^3$; temperatura $<36^\circ\text{C}$; hipotensão que exige reposição volêmica agressiva
Falha terapêutica	- Ausência de melhora clínica após 48–72 h - Agravamento radiológico após 72 h - Persistência de febre > 72 h - Necessidade de troca de antibiótico - Surgimento de complicações (empiema, abscesso)

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Em internação, sepse, PAC grave, risco de MRSA/Pseudomonas ou falha terapêutica: hemoculturas (2 pares) e escarro para Gram/cultura antes do 1º antibiótico se isso não atrasar tratamento. Em PAC ambulatorial leve, hemoculturas não são rotina. Urocultura apenas se sintomas urinários ou dúvida de foco. PCR viral se disponível.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	- Após 48–72 h de estabilidade clínica e identificação microbiológica - Reduzir o espectro do esquema empírico amplo - Com pneumococo ou outro patógeno identificado, estreitar para o agente ativo; não manter automaticamente ceftriaxona + azitromicina - Retirar cobertura anti-MRSA/antipseudomonas não sustentada por cultura ou fator de risco
Transição EV → VO	- Afebril por 24–48 h, hemodinamicamente estável, tolerando dieta e com absorção preservada - Pneumococo confirmado: amoxicilina 1 g VO 8/8 h - Sem agente identificado: amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h - Escolher o oral pelo patógeno, alergia, absorção e apresentação disponível no Brasil

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO Gestação: uso aceito	1 g VO 8/8 h GRAVE 2 g VO 8/8 h	>30 mL/min: Dose padrão; 10–30 mL/min: 1 g 12/12 h; <10 mL/min: 1 g 24/24 h	TETO 4 g/dia No Brasil não há apresentação de 1 g; a dose de 1 g corresponde a duas cápsulas de 500 mg. As apresentações orais são cápsula de 500 mg e comprimido de 875 mg.
Amoxicilina + Clavulanato VO Gestação: uso aceito	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE 875/125 mg VO 12/12 h; quando for necessária maior exposição à amoxicilina, associar amoxicilina isolada 500–875 mg VO 12/12 h em vez de aumentar o clavulanato	>30 mL/min: Dose padrão; <30 mL/min: Não usar a apresentação 875/125 mg; selecionar formulação e intervalo conforme bula/protocolo.	TETO Amoxicilina: 4 g/dia
Ceftriaxona EV Gestação: uso aceito	1–2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	>10 mL/min: Dose padrão (não requer ajuste renal significativo); <10 mL/min: Máximo 2 g/dia (evitar acúmulo)	TETO 2 g/dia na maioria dos casos de PAC; doses maiores apenas em indicações específicas/protocolo local Reduzir dose em insuficiência hepática grave combinada com renal
Azitromicina VO/EV Gestação: uso aceito	500 mg EV/VO 24/24 h GRAVE 500 mg EV/VO 24/24 h	>10 mL/min: Dose padrão (não requer ajuste); <10 mL/min: Dose padrão, monitorar efeitos adversos	TETO 500 mg/dia Reduzir dose em insuficiência hepática grave

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Levofloxacino VO/EV Gestação: evitar	750 mg EV/VO 24/24 h GRAVE 750 mg EV/VO 24/24 h	≥50 mL/min: 750 mg a cada 24 h (sem ajuste); 20–49 mL/min: 750 mg a cada 48 h (mesma dose, intervalo estendido — não reduzir a dose); 10–19 mL/min, hemodiálise ou DPAC: 750 mg dose inicial, depois 500 mg a cada 48 h	TETO 750 mg/dia
Cefepime EV Gestação: uso aceito	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60 mL/min: 2 g 8/8 h; 30–60 mL/min: 2 g 12/12 h; 11–29 mL/min: 2 g 24/24 h; ≤10 mL/min: 1 g 24/24 h (esquema de infecção grave, 2 g 8/8 h)	TETO 6 g/dia
Vancomicina EV Gestação: uso aceito	ataque 20–35 mg/kg (peso real, teto 3 g); manutenção 15–20 mg/kg a cada 8–12 h GRAVE ataque 25–30 mg/kg; manutenção guiada por AUC ₂₄ /CIM 400–600	>50 mL/min: 15 mg/kg 12/12 h; 30–50 mL/min: 15 mg/kg 24/24 h; 15–29 mL/min: 15 mg/kg 48/48 h; <15 mL/min: Dose única, monitorar níveis; consultar infecto	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria. Monitorizar por AUC ₂₄ /CIM 400–600; vale 15–20 mg/L apenas como substituto quando a AUC não estiver disponível
Piperacilina-Tazobactam EV Gestação: uso aceito	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h (infusão estendida 4 h)	>40 mL/min: 4,5 g 6/6 h; 20–40 mL/min: 3,375 g 6/6 h; <20 mL/min: 2,25 g 6/6 h (faixas do esquema de pneumonia nosocomial 4,5 g 6/6 h)	TETO 16 g/dia de piperacilina (18 g de piperacilina-tazobactam)

REFERÊNCIA DO QUADRO

ATS. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia, 2025. doi:10.1164/rccm.202507-1692ST.
<https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202507-1692ST>

1.2

Pneumonia Grave / UTI

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Pneumonia associada a critérios de gravidade que necessitam de internação em UTI. Requer cobertura ampla incluindo Pseudomonas e MRSA conforme fatores de risco.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Azitromicina; ampliar somente se risco validado de MRSA/ Pseudomonas ou resistência

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Azitromicina 500 mg EV 24/24 h; ajustar o betalactâmico ao risco microbiológico e ao foco

VIA

EV

DURAÇÃO

Mínimo de 5 dias; prolongar apenas por instabilidade, complicação, controle de foco inadequado ou patógeno que exija duração própria

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL	Mesmo em formas graves, principal agente
Staphylococcus aureus (MRSA)	RISCO ESPECÍFICO	Pós-gripe, comorbidades, prévio abx

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	DPOC, bronquiectasias, corticoide, prévio abx
Klebsiella pneumoniae (ESBL)	RISCO ESPECÍFICO	Se fatores de risco para GNB resistentes
Haemophilus influenzae	CONTEXTUAL	DPOC
Legionella pneumophila	CONTEXTUAL	Considerar sempre em UTI
Vírus respiratórios	CONTEXTUAL	Coinfecção bacteriana comum

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Pneumonia grave padrão (sem risco de Pseudomonas/MRSA)	Ceftriaxona + Azitromicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Azitromicina 500 mg EV 24/24 h · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias conforme evolução	Cobertura pneumococo, H. influenzae, atípicos. Trocar por Cefepime se risco de GNB resistentes.
Grave com risco de Pseudomonas, sem critério de MRSA	Cefepime + Azitromicina · Cefepime 2 g EV 8/8 h + Azitromicina 500 mg EV 24/24 h · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias	Adicionar Vancomicina somente se também houver critério de MRSA. Ajustar conforme culturas em 48–72 h.
PAC grave com risco validado de MRSA e Pseudomonas	Cefepime + Vancomicina + Azitromicina · Cefepime 2 g EV 8/8 h + Vanco EV (carga + manutenção) + Azitro 500 mg EV · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias	Não aplicar universalmente. Colher culturas/testes apropriados e retirar coberturas não sustentadas em 24–48 h.
Risco de ESBL/KPC	Meropenem + Azitromicina ± Vancomicina · Mero 2 g EV 8/8 h (infusão 3 h) + Azitro 500 mg EV; adicionar Vanco se MRSA · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias	Risco: contato prévio com ESBL, transferência de outro hospital, colonização conhecida.
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Vancomicina + Levofloxacin · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Vanco EV + Levo 750 mg EV 24/24 h · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias conforme evolução	Aztreonam cobre G- (incluindo Pseudomonas). Vanco cobre G+ e MRSA. Levo cobre atípicos.

Sobre a duração: Prolongar se MRSA com bacteremia ou resposta lenta. Individualizar por resposta e complicação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia betalactâmico (grave)	Aztreonam + Vancomicina + Levofloxacin · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Vanco EV + Levo 750 mg EV 24/24 h · EV	Mínimo de 5 dias, geralmente 5–7 dias conforme evolução	Atenção: Aztreonam não cobre G+ nem anaeróbios.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	- Isolamento respiratório ou infecção prévia por MRSA - Internação com antibiótico EV nos últimos 90 dias associada a risco local validado - Pós-influenza grave, cavitação/necrose ou empiema quando o conjunto clínico sustentar MRSA	Vancomicina individualizada por peso/função renal/monitorização ou linezolida em cenário selecionado
PSEUDOMONAS	- Isolamento respiratório prévio - Doença pulmonar estrutural com colonização - Antibiótico EV recente e fator validado localmente	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem conforme epidemiologia e cultura
ESBL	- ESBL prévia e síndrome compatível - Falha/cultura que sustente	Carbapenêmico quando necessário; não confundir ESBL com KPC/CRE
KPC	KPC/CRE prévio ou teste molecular/cultura compatível	Agente ativo dirigido à carbapenemase; meropenem isolado não é cobertura universal

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**ESQUEMA AMPLO NÃO É AUTOMÁTICO**

Cefepime + vancomicina + azitromicina não deve ser iniciado em toda PAC grave. A base é betalactâmico + macrolídeo; ampliar apenas com risco validado e plano de retirada.

ATENÇÃO**CORTICOIDE NA PAC: NÃO ROTINEIRO, CONSIDERAR APENAS NO GRAVE**

PAC não grave: não usar corticoide sistêmico de rotina. Ressalvadas indicações independentes, como exacerbação de asma ou DPOC, insuficiência adrenal e choque séptico. PAC grave em adulto internado: o corticoide sistêmico pode ser considerado; recomendação condicional, com baixa qualidade de evidência. Não aplicar a pneumonia grave por influenza. Os resultados dos estudos são heterogêneos e o REMAP-CAP não demonstrou redução significativa de mortalidade. Se optar por usar, hidrocortisona 200 mg/dia IV aparece na literatura apenas como exemplo derivado de ensaio clínico: tipo, duração e desmame não foram padronizados pela diretriz e devem seguir avaliação individual ou protocolo institucional. Monitorar hiperglicemia, infecção secundária e contraindicações relativas.

ALERTA CRÍTICO**COLETAR CULTURAS ANTES DO 1º ANTIBIÓTICO**

2 pares de hemoculturas + escarro para Gram/cultura + antigenúria Legionella + antigenúria pneumocócica. Se sepse, iniciar em até 1 h!

ALERTA CRÍTICO**VANCOMICINA: DOSE DE ATAQUE E ALVO DE AUC**

Dose de ataque 20–35 mg/kg de peso real (usualmente 25–30 mg/kg no crítico), teto de 3 g por dose e infusão em pelo menos 60 min por dose de 1 g. Manutenção 15–20 mg/kg a cada 8–12 h ajustada à função renal. Alvo: AUC₂₄/CIM 400–600 (consenso ASHP/IDSA/PIDS/SIDP 2020). O alvo de vale 15–20 mg/L só deve ser usado como substituto quando a AUC não estiver disponível — associa-se a mais nefrotoxicidade e não é mais o alvo recomendado.

ATENÇÃO**ATENÇÃO AO RISCO DE QT**

Azitromicina + quinolonas podem prolongar QT. Verificar K⁺ e Mg²⁺, avaliar ECG se risco.

INFORMAÇÃO**INFUSÃO ESTENDIDA DE CEFEPIME E MERO**

Cefepime e Meropenem em infusão estendida podem melhorar PK/PD em infecção grave. Ajuste renal e vigilância de neurotoxicidade seguem obrigatórios.

ALERTA CRÍTICO**REAVALIAR EM 48–72 h PARA DESCALONAR**

Se culturas negativas e clínica estável: descalonar. Se identificado MSSA: trocar Vanco por Oxacilina/Cefazolina. Se pneumococo: Ceftriaxona + Azitro.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	PAC grave sem risco validado de resistência	Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + azitromicina 500 mg EV 24/24 h.
2	Risco validado de Pseudomonas	Trocar ceftriaxona por betalactâmico antipseudomonas; considerar dois agentes apenas em contexto de alta resistência/mortalidade e protocolo local.
3	Risco validado de MRSA	Adicionar vancomicina ou linezolida; colher cultura respiratória e retirar se não sustentado.
4	CRE/carbapenemase	Não presumir cobertura por meropenem; usar identificação da carbapenemase e sensibilidade.
5	24–48 h	Rever culturas, teste viral, PCR nasal para MRSA quando disponível, complicações e descalonamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ CURB-65 ≥ 3 ▪ PA sistólica < 90 mmHg ▪ SatO₂ < 90% em O₂ ▪ Confusão mental ▪ Leucócitos < 4.000 ou > 20.000
UTI	▪ Ventilação mecânica invasiva OU choque séptico com vasopressor ▪ Ou ≥ 3 critérios menores ATS/IDSA: FR ≥ 30; P/F ≤ 250; multilobar; confusão; ureia ≥ 43 mg/dL (BUN ≥ 20 mg/dL); leucócitos <4.000; plaquetas <100.000; temperatura <36 °C; hipotensão que exige fluidos agressivos
Falha terapêutica	▪ Piora clínica após 48–72 h ▪ Progressão radiológica ▪ Febre persistente > 72 h ▪ Crescimento de patógeno resistente ▪ Complicações: empiema, abscesso

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Em PAC grave/UTI: 2 pares de hemoculturas antes do 1º antibiótico se não atrasar, escarro para Gram/cultura, antígeno Legionella/pneumocócica e PCR viral se disponível.
Controle de foco	▪ Procurar e tratar derrame parapneumônico complicado/empiema, abscesso e obstrução brônquica ▪ Toracocentese e drenagem quando indicadas ▪ Antibiótico isolado não resolve coleção pleural
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Se culturas negativas e clínica estável após 48–72 h: avaliar descalonamento ▪ Se MSSA isolado: trocar Vanco por Oxacilina 2 g EV 4/4 h ou Cefazolina 2 g EV 8/8 h ▪ Se pneumococo: Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Azitromicina 500 mg EV ▪ Se H. influenzae: Ceftriaxona ou Amox+Clav VO ▪ Transição VO quando afebril 24–48 h e estável
Transição EV → VO	▪ Afebril por 24–48 h, sem vasopressor, tolerando dieta e com foco controlado ▪ Escolher o oral pelo patógeno e sensibilidade ▪ Não transicionar em bacteremia complicada, empiema não drenado ou instabilidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV Gestação: uso aceito	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h (infusão 3 h)	>60 mL/min: 2 g 8/8 h; 30–60 mL/min: 2 g 12/12 h; 11–29 mL/min: 2 g 24/24 h; ≤ 10 mL/min: 1 g 24/24 h (esquema de infecção grave, 2 g 8/8 h)	TETO 6 g/dia
Vancomicina EV Gestação: uso aceito	ataque 20–35 mg/kg (peso real, teto 3 g); manutenção 15–20 mg/kg a cada 8–12 h GRAVE ataque 25–30 mg/kg; manutenção guiada por AUC ₂₄ /CIM 400–600	>50 mL/min: 15 mg/kg 12/12 h; 30–50 mL/min: 15 mg/kg 24/24 h; <30 mL/min: Monitorar níveis; consultar	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria. Monitorizar por AUC ₂₄ /CIM 400–600; vale 15–20 mg/L apenas como substituto quando a AUC não estiver disponível
Meropenem EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h (infusão 3 h)	>50 mL/min: 2 g 8/8 h; 26–50 mL/min: 2 g 12/12 h; 10–25 mL/min: 1 g 12/12 h; <10 mL/min: 1 g 24/24 h	TETO 6 g/dia

REFERÊNCIA DO QUADRO

ATS. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia, 2025. doi:10.1164/rccm.202507-1692ST.
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202507-1692ST

1.3

Exacerbação Infecciosa de DPOC

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Aumento agudo dos sintomas respiratórios em paciente com DPOC (dispneia, volume e purulência do escarro). Tratamento depende da gravidade e das comorbidades.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina + Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias na resposta adequada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Haemophilus influenzae	PRINCIPAL	Principal agente, muitas cepas produzem betalactamase
Streptococcus pneumoniae	FREQUENTE	Especialmente em pacientes não vacinados
Moraxella catarrhalis	FREQUENTE	Quase 100% produzem betalactamase
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	DPOC com VEF ₁ < 30% (GOLD 4), corticoide sistêmico, antibiótico prévio
Vírus respiratórios	FREQUENTE	Influenza, rinovirus, coronavírus

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve (sem comorbidades; GOLD A/B)	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5 dias	Primeira linha. Cobertura para H. influenzae e M. catarrhalis (betalactamase)
Moderada, com comorbidades, sem risco de Pseudomonas	Amoxicilina + Clavulanato OU Doxiciclina · Amox-Clav 875/125 mg VO 12/12 h OU Doxi 100 mg VO 12/12 h · VO	5 dias	Preferir espectro moderado; reservar quinolona para alergia, falha ou maior risco microbiológico. Antibiótico se escarro purulento + piora dispneia/ volume ou necessidade ventilatória.
Grave/internação, sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona OU Ampicilina + Sulbactam · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h OU Amp/Sulb 3 g EV 6/6 h · EV	5 dias; 5–7 dias se resposta lenta	Cobertura para H. influenzae, pneumococo e Moraxella. Considerar via VO assim que estável.
DPOC grave com risco de Pseudomonas	Cefepime OU Piperacilina + Tazobactam · Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h · EV	5–7 dias	Dupla cobertura antipseudomônica não é obrigatória; considerar apenas em choque, MDR ou perfil local desfavorável.

Sobre a duração: Individualizar se pneumonia/bronquiectasia associada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Boa cobertura para H. influenzae e pneumococo.
Alergia grave, internado	Levofloxacin · 750 mg EV 24/24 h · EV	5–7 dias	Monoterapia de ampla cobertura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ VEF₁ < 30% (GOLD 4) ou exacerbador frequente (grupo E) ▪ Uso de corticoide sistêmico crônico ▪ Antibióticos nos últimos 30 dias ▪ Bronquiectasias associadas	Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h; dupla cobertura apenas se choque/MDR/perfil local

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

QUANDO ANTIBIÓTICO É INDICADO

Priorizar quando há purulência do escarro associada a aumento de dispneia e/ou volume, ou necessidade de ventilação. Não tratar toda exacerbação como bacteriana.

INFORMAÇÃO

5 DIAS É SUFICIENTE

Na maioria das exacerbações infecciosas de DPOC, 5 dias de antibiótico são não inferiores a 7–10 dias.

ATENÇÃO

QUINOLONAS E QT

Levofloxacin e ciprofloxacin podem prolongar QT. Verificar K⁺ e Mg²⁺.

INFORMAÇÃO

DPOC NÃO É SEMPRE BACTERIANA

Muitas exacerbações são virais. Antibiótico se escarro purulento associado a aumento de dispneia/volume ou se houver necessidade de ventilação invasiva/não invasiva.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Exacerbação com purulência de escarro + aumento de dispneia/volume, ou necessidade de ventilação	Indicar antibiótico. Sem esses critérios, tratar como exacerbação não bacteriana.
2	Leve/moderada, sem comorbidade descompensada e sem risco de Pseudomonas	Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h por 5 dias; doxiciclina 100 mg VO 12/12 h é alternativa.
3	Grave/internada, sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h OU ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h; passar para VO assim que estável.
4	Risco de Pseudomonas (VEF ₁ < 30%, corticoide sistêmico crônico, antibiótico nos últimos 30 dias, bronquiectasias)	Cefepime 2 g EV 8/8 h OU piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h. Dupla cobertura antipseudomonas só em choque, MDR ou perfil local desfavorável.
5	Alergia, falha ou impossibilidade de combinação	Levofloxacin 750 mg VO/EV 24/24 h; atenção a QT, tendinopatia e resistência.
6	Reavaliação em 72 h	Melhora: completar 5 dias. Piora: revisar cobertura, pesquisar pneumonia associada e considerar painel viral.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ SatO2 < 90% em ar ambiente ▪ Acidose respiratória (pH < 7,35) ▪ Alteração do nível de consciência ▪ Insuficiência cardíaca descompensada ▪ Incapacidade de manter hidratação VO
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 72 h ▪ Piora da função pulmonar ▪ Nova infiltração ▪ Febre persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina + Clavulanato VO Gestação: uso aceito	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE 875/125 mg VO 12/12 h	>30 mL/min: Dose padrão; <30 mL/min: Não usar a apresentação 875/125 mg; selecionar formulação e intervalo conforme bula/protocolo.	
Levofloxacino VO/EV Gestação: evitar	750 mg EV/VO 24/24 h GRAVE 750 mg EV/VO 24/24 h	≥50 mL/min: 750 mg a cada 24 h (sem ajuste); 20–49 mL/min: 750 mg a cada 48 h (mesma dose, intervalo estendido — não reduzir a dose); 10–19 mL/min, hemodiálise ou DPAC: 750 mg dose inicial, depois 500 mg a cada 48 h	

1.4

Sinusite Bacteriana Aguda — Adulto

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Rinossinusite bacteriana suspeita quando sintomas persistem por ≥10 dias sem melhora, quadro grave com febre alta/secreção purulenta/dor facial por 3–4 dias, ou piora bifásica após melhora inicial.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina + Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias se estabilidade clínica; 5–7 dias conforme resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL	Principal alvo do tratamento empírico
Haemophilus influenzae	FREQUENTE	Considerar betalactamase
Moraxella catarrhalis	FREQUENTE	Frequentemente produtora de betalactamase

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus respiratórios	MAIORIA DOS CASOS	Antibiótico não indicado na rinossinusite viral simples

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Adulto, quadro bacteriano não complicado	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Evitar macrolídeos e TMP-SMX como empíricos pela resistência pneumococo/ H. influenzae.
Risco de pneumococo resistente ou infecção mais grave	Amoxicilina + Clavulanato em dose alta · 875/125 mg VO 12/12 h; quando for necessária maior exposição à amoxicilina, associar amoxicilina isolada 500–875 mg VO 12/12 h em vez de aumentar o clavulanato · VO	7 dias	Considerar se >65 anos, antibiótico no último mês, hospitalização recente, imunossupressão ou quadro grave.
Sinais orbitários, neurológicos ou toxemia	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	10–14 dias	Internar, imagem de face/órbita/SNC conforme clínica e avaliação ORL/ Oftalmo/Neuro.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico em adulto	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Opção preferencial para alergia em adulto sem contraindicação.
Alergia grave/intolerância ou falha inicial	Levofloxacino · 500 mg VO 24/24 h · VO	5–7 dias	Reservar para cenários selecionados. Atenção a QT, tendinopatia, interações e risco de eventos adversos.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Complicação intracraniana/orbitária ▪ Odontogênica associada ▪ Coleção/abscesso em imagem	Adicionar Metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h se suspeita de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

TRÊS PADRÕES QUE SUSTENTAM ETIOLOGIA BACTERIANA

Sintomas persistentes ≥10 dias sem melhora; início grave com febre alta e secreção purulenta/dor facial por ≥3–4 dias; ou piora dupla após melhora inicial. Quadro viral inicial não recebe antibiótico.

ATENÇÃO

NÃO TRATAR TODO RESFRIADO COM ANTIBIÓTICO

Antibiótico deve ser reservado para critérios de rinossinusite bacteriana: persistente ≥10 dias, grave 3–4 dias ou piora bifásica.

ALERTA CRÍTICO

SINAIS DE COMPLICAÇÃO

Edema periorbitário importante, alteração visual, dor ocular, proptose, cefaleia intensa, rigidez de nuca, rebaixamento ou déficit focal exigem avaliação urgente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sintomas <10 dias e sem gravidade	Tratamento sintomático e orientação; não iniciar antibiótico empírico.
2	Critérios bacterianos não complicados	Amox+Clav 875/125 mg VO 12/12 h por 5–7 dias.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
3	Risco de resistência ou grave	Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h por 7 dias, associando amoxicilina isolada 875 mg VO 12/12 h quando houver risco de pneumococo com sensibilidade reduzida.
4	Alergia betalactâmico	Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h por 5–7 dias; considerar quinolona apenas se necessário.
5	Sinais orbitários/neurológicos	Internar, iniciar EV, solicitar imagem e acionar ORL/Oftalmo/Neuro conforme achados.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sinais orbitários ▪ Sinais neurológicos ▪ Toxemia ▪ Complicação em imagem ▪ Imunossupressão importante
Gravidade	▪ Febre alta persistente ▪ Dor facial intensa ▪ Secreção purulenta franca ▪ Imunossupressão ▪ Falha após 48–72 h de antibiótico adequado
Falha terapêutica	▪ Piora em 48–72 h ▪ Ausência de melhora após 3–5 dias ▪ Recorrência precoce ▪ Sinais de complicação

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura não é necessária na maioria dos casos ambulatoriais. Considerar aspirado/cultura em falha, imunossupressão ou complicação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina + Clavulanato VO Gestação: uso aceito	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE 875/125 mg VO 12/12 h	>30 mL/min: Dose padrão; <30 mL/min: Não usar a apresentação 875/125 mg; selecionar formulação e intervalo conforme bula/protocolo.	
Doxiciclina VO/EV Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h GRAVE 100 mg EV/VO 12/12 h	Qualquer CLCr: Não requer ajuste renal	

1.5

Pneumonia Broncoaspirativa

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção pulmonar após broncoaspiração, especialmente em rebaixamento do nível de consciência, disfagia, alcoolismo, convulsões, institucionalização ou saúde oral precária. Diferenciar de pneumonite química, que pode melhorar com suporte sem antibiótico automático.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina-sulbactam — se houver pneumonia bacteriana

3 g EV 6/6 h. Na aspiração testemunhada sem evolução infecciosa sustentada, suporte e reavaliação em 24–48 h, sem antibiótico automático

VIA

EV

DURAÇÃO

5–7 dias se resposta clínica adequada; prolongar se complicação, necrose, empiema ou abscesso

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Flora orofaríngea mista	FREQUENTE	Inclui estreptococos e anaeróbios em cenários selecionados
Streptococcus pneumoniae	CONTEXTUAL	Pode coexistir com pneumonia comunitária convencional
Enterobacterales	CONTEXTUAL	Mais provável em institucionalização, aspiração hospitalar ou uso recente de antibiótico
Staphylococcus aureus	RISCO ESPECÍFICO	Considerar se pós-influenza, necrose ou risco de MRSA

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Aspiração recente sem sinais infecciosos persistentes	Sem antibiótico automático · Suporte clínico, higiene brônquica, avaliação de via aérea e reavaliação seriada · Conduta	Reavaliar evolução nas primeiras 24–48 h	Usar este ramo quando pneumonite química for mais provável e não houver evidência sustentada de infecção.
Broncoaspiração comunitária com pneumonia bacteriana e necessidade de internação	Ampicilina + Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	5–7 dias se resposta rápida	Boa opção quando há suspeita de flora oral e necessidade de tratamento hospitalar.
Transição VO ou quadro leve selecionado	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h ou 500/125 mg VO 8/8 h · VO	5–7 dias conforme resposta	Usar quando estável, tolerando VO e sem choque/hipoxemia grave.
Aspiração hospitalar, quadro grave ou risco de GNB/ Pseudomonas	Piperacilina + Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	7–14 dias conforme gravidade e resposta	Considerar MRSA apenas se houver fatores de risco locais ou individuais.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Moxifloxacino · 400 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	5–7 dias; ajustar conforme resposta e gravidade	Atenção a QT, interações e perfil local de resistência; validar alternativa em casos graves.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Necrose/cavitação ▪ Escarro fétido ▪ Má saúde oral ▪ Empiema associado ▪ Suspeita de abscesso pulmonar	Ampicilina-sulbactam, amox-clav ou pip-tazo; não tratar toda broncoaspiração como anaeróbia complicada
MRSA	▪ Hospitalização recente ▪ Colonização MRSA ▪ Pós-influenza ▪ Pneumonia necrotizante ▪ Uso de antibiótico IV recente	Vancomicina EV ou linezolida conforme contexto
PSEUDOMONAS	▪ Bronquiectasias ▪ Internação recente ▪ Aspiração hospitalar ▪ Antibiótico recente ▪ DPOC grave	Piperacilina-tazobactam ou cefepime + metronidazol conforme risco e protocolo local

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ASPIRAÇÃO NÃO SIGNIFICA ANTIBIÓTICO AUTOMÁTICO

Pneumonite química testemunhada pode melhorar com suporte em 24–48 h. Iniciar antibiótico se houver evolução infecciosa sustentada. Cobertura anaeróbia adicional não é rotina sem abscesso, empiema, necrose ou foco odontogênico relevante.

ATENÇÃO

BRONCOASPIRAÇÃO NÃO É SEMPRE INFECÇÃO

Pneumonite química após aspiração pode melhorar com suporte; tratar como pneumonia bacteriana quando houver febre persistente, leucocitose, secreção purulenta, hipoxemia progressiva ou infiltrado em progressão.

ALERTA CRÍTICO

PROCURAR COMPLICAÇÃO

Abscesso pulmonar, empiema, necrose, obstrução brônquica ou corpo estranho devem ser considerados se falha clínica em 48–72 h.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Aspiração recente sem sinais infecciosos persistentes	Oferecer suporte e evitar antibiótico automático se pneumonite química provável.
2	Pneumonia broncoaspirativa comunitária internada	Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h.
3	Risco hospitalar/GNB/Pseudomonas	Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; adicionar cobertura para MRSA apenas se houver critério.
4	Falha em 48–72 h	Reavaliar diagnóstico, complicações, culturas, imagem, empiema, abscesso ou obstrução.
5	Melhora clínica	Transicionar para VO quando estável e completar duração curta se não houver complicação.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Hipoxemia ▪ Sepses ▪ Rebaixamento ou risco de nova aspiração ▪ Empiema ou suspeita de abscesso ▪ Falha ambulatorial

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Choque ▪ Insuficiência respiratória ▪ Imunossupressão ▪ Aspiração hospitalar ▪ Necrose/cavitação extensa
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Febre persistente ▪ Piora radiológica ▪ Hemoptise ▪ Suspeita de obstrução, abscesso ou empiema

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se internação/sepse. Escarro se produtivo. Considerar broncoscopia/culturas se falha, obstrução, imunossupressão ou pneumonia hospitalar.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina + Sulbactam EV Gestação: uso aceito	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	>30 mL/min: 3 g 6/6 h; 15–30 mL/min: 3 g 12/12 h; <15 mL/min: 1,5–3 g 24/24 h	
Piperacilina + Tazobactam EV Gestação: uso aceito	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	>40 mL/min: 4,5 g 6/6 h; 20–40 mL/min: 3,375 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial — a redução para 2,25 g é a coluna de outras indicações.; <20 mL/min: 2,25 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial.	

1.6

Abscesso Pulmonar

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção cavitária pulmonar com necrose e coleção, geralmente associada a aspiração, má saúde oral, obstrução brônquica, neoplasia, corpo estranho ou pneumonia necrotizante. Exige cobertura anaeróbia e curso mais prolongado que pneumonia broncoaspirativa simples.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina + Sulbactam

3 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

3–6 semanas, guiado por resposta clínica e radiológica

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Anaeróbios orais	FREQUENTE	Mais prováveis com má dentição, escarro fétido e aspiração

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus anginosus group	FREQUENTE	Associado a abscessos e coleções
Enterobacterales	CONTEXtual	Mais provável em institucionalização, diabetes, aspiração hospitalar ou gravidade
Staphylococcus aureus	RISCO ESPECÍFICO	Considerar em pneumonia necrotizante, pós-influenza ou risco de MRSA

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Abscesso pulmonar comunitário sem risco de Pseudomonas	Ampicilina + Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	3–6 semanas conforme resposta	Cobertura para flora oral e anaeróbios; considerar transição VO após estabilização.
Abscesso grave, hospitalar ou risco de GNB/Pseudomonas	Piperacilina + Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	3–6 semanas conforme resposta	Avaliar MRSA conforme fatores de risco e epidemiologia local.
Transição VO após melhora clínica	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h ou 500/125 mg VO 8/8 h · VO	Completar 3–6 semanas conforme resposta radiológica	Usar quando afebril/estável, tolerando VO e com melhora laboratorial/radiológica.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa para anaeróbios em cenário selecionado	Clindamicina · 600 mg EV 8/8 h; depois 300–450 mg VO 6/6 h · VO/EV	3–6 semanas conforme resposta	Risco maior de <i>C. difficile</i> ; evitar uso indiscriminado e validar em casos graves.
Alergia grave a betalactâmico	Moxifloxacino · 400 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	3–6 semanas conforme resposta	Atenção a QT, interações e perfil local de resistência; considerar infectologia/CCIH.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Cavitação/necrose ▪ Escarro fétido ▪ Má saúde oral ▪ Aspiração ▪ Empiema associado	Ampicilina-sulbactam, amox-clav, pip-tazo ou clindamicina em cenários selecionados
MRSA	▪ Pós-influenza ▪ Colonização MRSA ▪ Uso de antibiótico IV recente ▪ Pneumonia necrotizante ▪ Hospitalização recente	Vancomicina EV ou linezolida conforme contexto
PSEUDOMONAS	▪ Abscesso hospitalar ▪ Bronquiectasias ▪ Internação recente ▪ Antibiótico recente ▪ DPOC grave	Piperacilina-tazobactam ou cefepime + metronidazol conforme protocolo local

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**DRENAGEM E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA**

Empiema requer avaliação de drenagem; abscesso exige busca de obstrução, corpo estranho e complicação. Duração deve acompanhar controle do foco e resposta clínica, não apenas opacidade radiográfica residual.

ALERTA CRÍTICO**NÃO CONFUNDIR COM PNEUMONIA SIMPLES**

Abscesso pulmonar costuma exigir tratamento prolongado e reavaliação clínica/radiológica; não usar duração curta de pneumonia simples.

ATENÇÃO**PROCURAR CAUSA E COMPLICAÇÕES**

Se evolução ruim, investigar obstrução brônquica, neoplasia, corpo estranho, empiema, imunossupressão ou patógeno não coberto.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Abscesso pulmonar suspeito ou confirmado	Iniciar cobertura para flora oral/anaeróbios e avaliar gravidade, imagem e necessidade de internação.
2	Abscesso comunitário sem risco de Pseudo-monas	Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h; transicionar para amox-clav VO quando estável.
3	Hospitalar, grave ou risco de GNB/Pseudo-monas	Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; considerar MRSA se critério.
4	Falha, abscesso grande, persistente ou complicação	Reavaliar com imagem, culturas, broncoscopia/obstrução e discutir drenagem/infectologia/cirurgia torácica conforme recursos.
5	Melhora clínica e laboratorial	Completar curso prolongado conforme resposta clínica e radiológica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Hipoxemia ▫ Sepses ▫ Abscesso grande ou múltiplo ▫ Empiema associado ▫ Falha terapêutica ▫ Risco de obstrução ou neoplasia
Gravidade	▫ Choque ▫ Necrose extensa ▫ Insuficiência respiratória ▫ Imunossupressão ▫ Hemoptise ▫ Abscesso hospitalar
Falha terapêutica	▫ Sem melhora em 7–10 dias ▫ Febre persistente ▫ Aumento da cavidade ▫ Derrame/empiema ▫ Hemoptise ▫ Suspeita de obstrução

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se internação/sepses. Escarro se produtivo. Considerar cultura por broncoscopia ou material de drenagem se falha, imunossupressão, suspeita de obstrução, hospitalar ou patógeno incomum.
Controle de foco	Reavaliar com imagem, culturas, broncoscopia/obstrução e discutir drenagem/infectologia/cirurgia torácica conforme recursos.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina + Sulbactam EV Gestação: uso aceito	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	>30 mL/min: 3 g 6/6 h; 15–30 mL/min: 3 g 12/12 h; <15 mL/min: 1,5–3 g 24/24 h	
Piperacilina + Tazobactam EV Gestação: uso aceito	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	>40 mL/min: 4,5 g 6/6 h; 20–40 mL/min: 3,375 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial — a redução para 2,25 g é a coluna de outras indicações.; <20 mL/min: 2,25 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial.	

1.7

Empiema / Infecção Pleural

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Derrame pleural infectado/parapneumônico complicado. O tratamento combina antibiótico com cobertura adequada e controle de foco pleural, frequentemente com drenagem.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Metronidazol
Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

2–6 semanas conforme resposta e controle de foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	COMUM	Associado a pneumonia comunitária
Streptococcus anginosus group	COMUM	Frequentemente associado a coleção/abscesso
Anaeróbios	FREQUENTE	Cobertura empírica geralmente indicada
Staphylococcus aureus	RISCO ESPECÍFICO	MSSA/MRSA conforme risco
Enterobacterales/Pseudomonas	HOSPITALAR	Mais provável em infecção hospitalar ou pacientes fragilizados

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Empiema comunitário	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	2–6 semanas	Associar drenagem pleural quando indicado. Ajustar por cultura do líquido pleural.
Empiema hospitalar ou risco de Pseudomonas/MRSA	Piperacilina + Tazobactam + Vancomicina · Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h + Vancomicina EV conforme peso/nível · EV	2–6 semanas	Cobrir anaeróbios, GNB e MRSA até cultura orientar descalonamento.
Risco de ESBL ou falha com cefalosporina	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h ± Vancomicina EV · EV	2–6 semanas	Reservar para risco microbiológico ou cultura compatível.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vanco EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metro 500 mg EV 8/8 h · EV	2–6 semanas	Ajustar conforme cultura; avaliar infectologia se disponível.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Empiema comunitário ▪ Aspiração ▪ Odontogênica ▪ Escarro fétido ▪ Abscesso associado	Metronidazol associado, ampicilina-sulbactam ou pip-tazo
MRSA	▪ Hospitalar ▪ Pós-procedimento ▪ Colonização MRSA ▪ Uso de antibiótico IV recente ▪ Pneumonia necrotizante	Vancomicina EV ou Linezolida conforme contexto
PSEUDOMONAS	▪ Hospitalar ▪ Bronquiectasias ▪ Ventilação/internação recente ▪ Antibiótico recente	Pip-tazo, cefepime + metronidazol ou meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DRENAGEM E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA

Empiema requer avaliação de drenagem; abscesso exige busca de obstrução, corpo estranho e complicação. Duração deve acompanhar controle do foco e resposta clínica, não apenas opacidade radiográfica residual.

ALERTA CRÍTICO

ANTIBIÓTICO SOZINHO PODE FALHAR

Empiema exige avaliar controle de foco: toracocentese diagnóstica, drenagem pleural, fibrinolítico intrapleural ou cirurgia conforme fase e resposta.

ATENÇÃO

DURAÇÃO VARIÁVEL

A duração depende de drenagem efetiva, melhora clínica, PCR/leucócitos e imagem. Evite encurtar se foco não controlado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de derrame parapneumônico complicado	Solicitar imagem e toracocentese diagnóstica se seguro.
2	Líquido purulento, Gram/cultura positivo ou pH/glicose sugestivos	Iniciar antibiótico EV com anaeróbios e indicar drenagem.
3	Comunitário	Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h.
4	Hospitalar/MRSA/Pseudomonas	Pip-tazo + Vancomicina; descalonar conforme cultura.
5	Falha de drenagem	Reavaliar imagem, posicionamento do dreno, loculações e necessidade de fibrinolítico/cirurgia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Todo empiema confirmado ▪ Derrame complicado ▪ pH pleural baixo ▪ Glicose pleural baixa ▪ LDH elevado ▪ Pus ou Gram/cultura positivos
Gravidade	▪ Sepses ▪ Loculações extensas ▪ Derrame volumoso ▪ Falha de drenagem ▪ Insuficiência respiratória
Falha terapêutica	▪ Febre/dor persistente ▪ PCR/leucócitos sem queda ▪ Drenagem insuficiente ▪ Coleção loculada residual ▪ Sepses persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Enviar líquido pleural para Gram, cultura aeróbia/anaeróbia, pH, glicose, LDH, proteínas e celularidade. Hemoculturas se febre/sepses.
Controle de foco	▪ Iniciar antibiótico EV com anaeróbios e indicar drenagem. ▪ Reavaliar imagem, posicionamento do dreno, loculações e necessidade de fibrinolítico/cirurgia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV Gestação: uso aceito	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV a cada 12–24 h conforme gravidade	Geral: Não requer ajuste renal significativo	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Geral: Não requer ajuste renal usual; monitorar em diálise/uso prolongado	HEPÁTICO Reduzir/monitorar em hepatopatia grave

1.8

Exacerbação de Bronquiectasias

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Piora aguda de tosse, volume/purulência do escarro, dispneia ou sintomas sistêmicos em paciente com bronquiectasias. Idealmente guiar por culturas prévias de escarro.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina + Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

10–14 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Haemophilus influenzae	COMUM	Agente frequente em exacerbação ambulatorial
Pseudomonas aeruginosa	COMUM EM DOENÇA AVANÇADA	Pesquisar culturas prévias e gravidade estrutural
Moraxella catarrhalis	CONTEXTUAL	Pode produzir betalactamase
Staphylococcus aureus	CONTEXTUAL	Considerar conforme cultura prévia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem cultura prévia de Pseudomonas, leve/moderada	Amoxicilina + Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	10–14 dias	Coletar escarro antes se possível, sem atrasar em paciente grave.
Pseudomonas prévia ou forte suspeita, estável para VO	Ciprofloxacino · 750 mg VO 12/12 h · VO	10–14 dias	Usar se sensibilidade provável/confir-mada. Atenção a QT, tendão e intera-ções.
Grave, hipoxemia, sepse ou falha VO	Piperacilina + Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias	Alternativas conforme cultura: cefepime, ceftazidima, meropenem. Considerar dupla cobertura se choque/risco alto.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia betalactâmico sem Pseudomonas	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	10–14 dias	Opção em quadro leve/moderado se perfil microbiológico compatível.
Alergia betalactâmico com Pseudomonas	Ciprofloxacino · 750 mg VO 12/12 h ou 400 mg EV 8/8 h · VO/EV	10–14 dias	Preferir guiado por cultura/sensibili-dade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	- Isolamento prévio - Bronquiectasias extensas - Exacerbações frequentes - Internações recentes - Uso recente de antibiótico	Ciprofloxacino VO se estável; pip-tazo/cefepime/ceftazidima/meropenem EV se grave
MRSA	- Cultura prévia MRSA - Colonização conhecida - Internação recente - Falha com esquema usual	Vancomicina ou linezolida conforme gravidade/cultura

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

CULTURA DE ESCARRO É CHAVE

Sempre procurar cultura prévia e coletar nova amostra antes do antibiótico quando possível.

ATENÇÃO**DURAÇÃO MAIS LONGA**

Exacerbação de bronquiectasias costuma exigir 10–14 dias, diferente de DPOC simples.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Exacerbação suspeita	Checar culturas prévias e coletar escarro antes do antibiótico se possível.
2	Sem Pseudomonas prévia e estável	Amox-clav VO 10–14 dias.
3	Pseudomonas prévia e estável	Ciprofloxacino 750 mg VO 12/12 h 10–14 dias se sensível/provável.
4	Grave/internação	Antipseudomonal EV guiado por cultura: pip-tazo, cefepime, ceftazidima ou meropenem.
5	Reavaliar	Ajustar por cultura, avaliar fisioterapia respiratória, higiene brônquica e complicações.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	- Hipoxemia - Sepse - Falha VO - Hemoptise relevante - Comorbidades importantes - Pseudomonas multirresistente
Gravidade	- FR elevada/desconforto - Necessidade de O₂ - Instabilidade hemodinâmica - Confusão - Incapacidade de hidratar/usar VO
Falha terapêutica	- Sem melhora em 48–72 h - Cultura resistente - Nova consolidação - Complicação pleural - Suspeita de micobactéria/fungo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Escarro para Gram/cultura antes do antibiótico sempre que possível; hemoculturas se febre alta, internação ou seps.

EIXO	CONDUTA		
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.		
ANTIMICROBIANOS E AJUSTES			
FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ciprofloxacino VO/EV Gestação: evitar	750 mg VO 12/12 h GRAVE 400 mg EV 8/8 h	>50 mL/min: Dose padrão; 30–50 mL/min: Ajustar intervalo/dose conforme protocolo local; <30 mL/min: Ajuste obrigatório; conferir protocolo local	
Piperacilina + Tazobactam EV Gestação: uso aceito	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	>40 mL/min: 4,5 g 6/6 h; 20–40 mL/min: 3,375 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial — a redução para 2,25 g é a coluna de outras indicações.; <20 mL/min: 2,25 g 6/6 h Faixa específica para pneumonia nosocomial.	

1.9

Pneumonia Hospitalar / Nosocomial

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Pneumonia que surge ≥48 h após admissão hospitalar, não incubada na entrada. O esquema empírico depende de gravidade, risco de MRSA, Pseudomonas e perfil microbiológico local.

CONDUTA DE PARTIDA

Piperacilina + Tazobactam

4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7 dias se boa resposta e sem complicações

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	IMPORTANTE	Risco maior com internação prolongada, VM, antibiótico recente e doença pulmonar estrutural
Enterobacterales	COMUM	Klebsiella, E. coli, Enterobacter; avaliar ESBL conforme risco
Staphylococcus aureus	COMUM	MSSA ou MRSA conforme colonização/risco local
Acinetobacter spp.	RISCO ESPECÍFICO	Mais associado a UTI e surtos locais

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
HAP sem choque, sem VM e sem alto risco de MRSA/MDR	Piperacilina + Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	7 dias	Alternativas: cefepime ou ceftazidima conforme perfil local.
Risco de MRSA ou alta mortalidade	Piperacilina + Tazobactam + Vancomicina · Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h + Vancomicina EV com dose de carga · EV	7 dias; ajustar por culturas	Linezolida pode substituir vancomicina conforme contexto.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque, VM, alto risco de MDR ou <i>Pseudomonas</i> resistente	Cefepime + Ciprofloxacino + Vancomicina · Cefepime 2 g EV 8/8 h + Cipro 400 mg EV 8/8 h + Vanco EV · EV	7 dias; individualizar	Dupla antipseudomonal empírica apenas se risco alto; descalonar rapidamente.
Risco de ESBL ou cultura prévia ESBL	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h ± Vanco EV · EV	7 dias; individualizar	Reservar carbapenem para risco microbiológico real ou instabilidade grave.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Vancomicina ± Ciprofloxacino · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Vanco EV ± Cipro 400 mg EV 8/8 h · EV	7 dias	Cobertura deve ser ajustada conforme cultura e perfil local; aztreonam não cobre gram-positivos/anaeróbios.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização MRSA ▪ Uso de antibiótico IV nos últimos 90 dias ▪ Alta prevalência local/desconhecida ▪ Choque séptico ▪ Necessidade de ventilação mecânica	Vancomicina EV ou Linezolida 600 mg EV/VO 12/12 h
PSEUDOMONAS	▪ HAP por definição exige considerar GNB ▪ Doença pulmonar estrutural ▪ Antibiótico recente ▪ UTI/VM ▪ Choque séptico	Pip-tazo, cefepime, ceftazidima, meropenem; dupla cobertura se alto risco/choque
ESBL	▪ Colonização/cultura prévia ESBL ▪ Uso recente de cefalosporina/carbapenem ▪ Internação prolongada ▪ Instituição com alta prevalência	Meropenem conforme sensibilidade e gravidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

DUPLA COBERTURA ANTIBACTERIANA NÃO É AUTOMÁTICA

Usar dois antipseudomonas apenas diante de alto risco de mortalidade, resistência local relevante ou exposição/colonização que justifique; descalonar com microbiologia.

ALERTA CRÍTICO

COLETAR CULTURAS E DESCALONAR

Coletar hemoculturas e amostra respiratória antes do antibiótico quando possível. Reavaliar em 48–72 h para estreitar ou suspender se diagnóstico alternativo.

ATENÇÃO

NÃO DUPLICAR ANTI-PSEUDOMONAL SEM CRITÉRIO

Dupla cobertura empírica aumenta toxicidade e deve ser reservada para alto risco de MDR/choque/VM ou perfil local desfavorável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de HAP	Confirmar critérios clínico-radiológicos e coletar culturas respiratórias/hemoculturas.
2	Sem choque/baixo risco MRSA-MDR	Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h ou cefepime 2 g EV 8/8 h.
3	MRSA ou alta mortalidade	Adicionar vancomicina ou linezolida.
4	Choque/VM/alto risco MDR	Considerar dupla antipseudomonal inicial + MRSA, com descalonamento precoce.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
5	48-72 h	Revisar cultura, estabilidade, PCT se usada, e descalonar/suspender conforme probabilidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Já internado; avaliar necessidade de unidade monitorizada/UTI conforme gravidade
UTI	▪ Choque séptico ▪ Necessidade de VM ▪ Hipoxemia grave ▪ Falência orgânica ▪ Rebaixamento importante
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Cultura resistente ▪ Diagnóstico alternativo ▪ Complicação pleural ▪ Foco não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e amostra respiratória antes do antibiótico se possível. Usar cultura quantitativa/semiquantitativa conforme disponibilidade local.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV Gestação: uso aceito	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida	>60 mL/min: 2 g 8/8 h; 30–60 mL/min: 2 g 12/12 h; 11–29 mL/min: 2 g 24/24 h; <11 mL/min: 1 g 24/24 h	
Vancomicina EV Gestação: uso aceito	Dose de ataque 20–25 mg/kg EV; manutenção conforme função renal/nível GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg EV se choque/crítico	Variável: Individualizar por função renal, peso e monitorização de níveis/AUC	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 01 — RESPIRATÓRIO

- ATS/IDSA. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia, 2019 — base dos esquemas empíricos e dos critérios de gravidade.
- ATS. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia, 2025. doi:10.1164/rccm.202507-1692ST.
- ATS/IDSA. Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia, 2016.

02

Otorrinolaringológico

8 quadros clínicos neste sistema

2.1	Faringoamigdalite Estreptocócica — Adulto	40
2.2	Abscesso Peritonsilar / Celulite Periamigdaliana	42
2.3	Otite Média Aguda — Adulto	44
2.4	Otite Externa Aguda Difusa	45
2.5	Otite Externa Maligna / Necrotizante	47
2.6	Mastoidite Aguda	49
2.7	Epiglote / Supraglote — Adulto	52
2.8	Sialadenite / Parotidite Bacteriana Aguda	54

2.1

Faringoamigdalite Estreptocócica — Adulto

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional dispensável

Faringite/amigdalite por Streptococcus pyogenes. A maioria das faringites é viral; tratar apenas quando teste rápido/cultura positivos ou probabilidade clínica alta em contexto adequado, evitando antibiótico em sinais virais evidentes.

CONDUTA DE PARTIDA

Testar quando indicado; penicilina ou amoxicilina se estreptococo confirmado/provável pelo protocolo

500 mg VO 12/12 h ou 1 g VO 24/24 h

VIA

VO

DURAÇÃO

10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes	PRINCIPAL BACTERIANO	Alvo do tratamento; penicilina/amoxicilina seguem drogas de escolha
Vírus respiratórios	MAIS COMUM NO GERAL	Tosse, coriza, rouquidão, conjuntivite e úlceras orais favorecem etiologia viral
Fusobacterium necrophorum	JOVENS/ADULTOS	Considerar se piora importante, sepse, dor cervical ou suspeita de síndrome de Lemierre

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Teste rápido/cultura positivo ou alta suspeita sem sinais virais	Amoxicilina · 500 mg VO 12/12 h ou 1 g VO 24/24 h · VO	10 dias	Alternativa clássica: penicilina V (fenoximetilpenicilina) 500.000 UI VO 6/6 h a 8/8 h por 10 dias.
Baixa adesão, vômitos ou preferência por dose única	Penicilina benzatina · 1.200.000 UI IM dose única · IM	Dose única	Usar se não houver alergia a penicilina.
Quadro viral evidente ou baixa probabilidade clínica	Sem antibiótico · Conduta: analgesia/antitérmico, hidratação e orientação de retorno · Conduta	Reavaliar se piora	Evita antibiótico desnecessário; retorno se trismo, dispneia, toxemia ou piora progressiva.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não anafilática a penicilina	Cefalexina · 500 mg VO 12/12 h · VO	10 dias	Evitar se anafilaxia/reação grave imediata a betalactâmico.
Alergia grave a betalactâmico	Azitromicina · 500 mg VO D1; depois 250 mg VO 24/24 h D2-D5 · VO	5 dias	Usar considerando resistência local a macrolídeos; alternativa: clindamicina 300 mg VO 8/8 h por 10 dias.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

POR QUE TRATAR: PREVENÇÃO DE FEBRE REUMÁTICA

O ganho sintomático do antibiótico na faringite estreptocócica é pequeno (cerca de um dia). A razão principal para tratar é prevenir febre reumática aguda — desfecho ainda relevante no Brasil — e complicações supurativas. Isso justifica completar os 10 dias de betalactâmico oral, e não encurtar o curso.

INFORMAÇÃO

QUADRO VIRAL NÃO RECEBE ANTIBIÓTICO

Tosse, coriza, rouquidão, úlceras orais ou conjuntivite favorecem vírus. Quando não houver sinais virais claros, aplicar o escore de Centor/McIsaac e o teste rápido ou cultura conforme disponibilidade.

ATENÇÃO

Não tratar quadro viral evidente

Coriza, tosse, rouquidão, conjuntivite ou úlceras orais reduzem muito a probabilidade de estreptococo.

ALERTA CRÍTICO

Sinais de complicação

Trismo, desvio de úvula, voz abafada, rigidez cervical, toxemia, dor cervical ou dispneia sugerem complicação supurativa/profunda.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sinais virais	Evitar antibiótico; analgesia, hidratação e orientação de retorno.
2	Sem sinais virais e probabilidade intermediária/alta	Testar quando disponível; tratar se positivo ou se contexto justificar tratamento empírico.
3	Sinais de abscesso/perigo	Avaliar via aérea, hidratação, imagem/ORL se suspeita de complicação.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Complicação supurativa ▪ Desidratação/incapacidade de VO ▪ Toxemia ou suspeita de infecção cervical profunda
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Piora com trismo/odinofagia intensa ▪ Febre persistente ou dor cervical

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste rápido/cultura de orofaringe quando disponível e houver dúvida clínica; cultura não é necessária em quadro viral típico.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	500 mg VO 12/12 h ou 1 g VO 24/24 h GRAVE Não aplicável	<30 mL/min: Ajustar intervalo conforme função renal	
Penicilina benzatina IM	1.200.000 UI IM dose única GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste usual em dose única	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Conduta ambulatorial bem padronizável quando o diagnóstico é confirmado e não há sinais de complicação.

- Evitar antibiótico em quadro viral
- Confirmar alergia e risco de macrolídeo/resistência local
- Orientar retorno se sinais de complicação

2.2

Abscesso Peritonsilar / Celulite Periamigdaliana

MODERADA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Complicação supurativa de amigdalite com odinofagia intensa, trismo, voz abafada, desvio de úvula e abaulamento periamigdaliano. Antibiótico é necessário, mas abscesso organizado geralmente exige drenagem.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina-Sulbactam

3 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

10–14 dias total

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes / grupo anginosus	FREQUENTE	Cocos Gram-positivos orais
Anaeróbios orais	FREQUENTE	Fusobacterium, Prevotella, Bacteroides
Staphylococcus aureus	RISCO ESPECÍFICO	MRSA apenas se risco específico ou falha

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Abscesso, trismo importante, toxemia, incapacidade VO ou necessidade de drenagem	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias total	Associar drenagem por ORL quando houver coleção; analgesia/hidratação são essenciais.
Pós-drenagem ou quadro estável com transição VO	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	Completar 10–14 dias	Alta se tolera VO, dor controlada, sem progressão e sem risco de via aérea.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Clindamicina · 600–900 mg EV 8/8 h ou 300–450 mg VO a cada 6–8 h · VO/EV	10–14 dias	Cobre estreptococos e anaeróbios; avaliar resistência local e risco de C. difficile.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Abscesso peritonsilar ▪ Halitose importante ▪ Necrose ▪ Infecção odontogênica associada	Ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulanato ou clindamicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Avaliar via aérea**

Estridor, sialorreia, dispneia, voz muito abafada ou toxemia exigem abordagem urgente.

ATENÇÃO**Drenagem quando há coleção**

Antibiótico isolado pode falhar se houver abscesso organizado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Avaliar via aérea, hidratar, analgesia e acionar ORL se abscesso provável.
2	Coleção ou dúvida anatômica	Considerar imagem cervical com contraste se suspeita de extensão profunda.
3	Melhora clínica	Transicionar para VO e completar 10–14 dias.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Incapacidade de VO ▪ Desidratação ▪ Toxemia ▪ Trismo importante ▪ Risco de via aérea ▪ Comorbidade relevante
Falha terapêutica	▪ Sem melhora após drenagem/antibiótico ▪ Recorrência ▪ Extensão cervical

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do material drenado se grave, recorrente, imunossupressão, falha terapêutica ou internação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	
Clindamicina VO/EV	300–450 mg VO a cada 6–8 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condições otorrinolaringológicas podem depender de disponibilidade de ORL, drenagem, imagem, cultura, fluxo de via aérea e padronização local de antimicrobianos.
- Confirmar disponibilidade de ORL, anestesia, imagem e sala/procedimento quando houver risco de via aérea ou coleção
- Checar protocolo local para ceftriaxona, ampicilina-sulbactam, vancomicina e antipseudomonais
- Coletar cultura de material drenado ou secreção profunda quando grave, recorrente, imunossuprimido ou falha terapêutica
- Reavaliar necessidade de drenagem, controle de foco e desescalamento em 24–72 h

2.3

Otite Média Aguda — Adulto

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional dispensável

Infecção aguda da orelha média com otalgia, febre e membrana timpânica abaulada/hiperemiada. Em adulto, antibiótico costuma ser usado quando o diagnóstico é claro; analgesia e reavaliação são fundamentais.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina

875 mg VO 12/12 h ou 500 mg VO 8/8 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5–7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	FREQUENTE	Principal alvo da amoxicilina
Haemophilus influenzae	FREQUENTE	Mais provável se conjuntivite, DPOC/tabagismo ou falha com amoxicilina
Moraxella catarrhalis	FREQUENTE	Produtora de betalactamase

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Adulto, quadro não complicado e diagnóstico claro	Amoxicilina · 875 mg VO 12/12 h ou 500 mg VO 8/8 h · VO	5–7 dias	Associar analgesia; reavaliar se piora ou sem melhora em 48–72 h.
Uso recente de amoxicilina, conjuntivite, recorrência, comorbidade ou falha inicial	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	7–10 dias	Cobertura para produtores de betalactamase.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico em adulto estável	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Evitar em gestação. Macrolídeo tem menor cobertura pneumocócica e deve considerar resistência local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Sinais de complicação

Mastoidite, paralisia facial, vertigem intensa, cefaleia importante, sinais meníngeos ou neurológicos exigem avaliação urgente.

INFORMAÇÃO

Hiperemia isolada não basta

Confirmar abaulamento, nível líquido, otorreia aguda ou sinais compatíveis antes de rotular como OMA.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Diagnóstico claro	Prescrever antibiótico quando indicado e analgesia efetiva.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Falha em 48–72 h	Trocar para amoxicilina-clavulanato ou avaliar complicação/diagnóstico alternativo.
3	Sinais de mastoidite/neurológicos	Encaminhar para PS/ORL e considerar imagem.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Mastoidite ▪ Complicação intracraniana ▪ Toxemia ▪ Imunossupressão grave
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Otorreia persistente ▪ Dor progressiva

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	875 mg VO 12/12 h GRAVE Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h se risco/falha	<30 mL/min: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Conduta ambulatorial usualmente padronizável quando não há complicação.
- Confirmar otoscopia compatível
- Garantir analgesia e retorno se falha
- Ajustar para alergia, gestação e função renal

2.4

Otite Externa Aguda Difusa

LEVE

AMBULATORIAL

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional dispensável

Inflamação/infecção difusa do conduto auditivo externo, tipicamente com dor ao tracionar pavilhão ou pressionar tragus. Tratamento principal é tópico; antibiótico sistêmico só se extensão para fora do conduto ou hospedeiro de alto risco.

CONDUTA DE PARTIDA

Quinolona otológica ± corticoide

Conforme apresentação otológica

VIA

Topica

DURAÇÃO

7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	FREQUENTE	Principal agente em otite externa

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	Inclui MSSA; MRSA conforme epidemiologia
Fungos	OCASIONAL	Prurido intenso, detritos, falha com antibacteriano

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Otite externa não complicada	Ciprofloxacino/ofloxacino otológico ± corticoide · Conforme bula/apresentação otológica · Topica	7 dias	Se perfuração ou membrana timpânica não visualizada, preferir quinolona otológica e evitar aminoglicosídeo tópico.
Conduto muito edemaciado impedindo penetração	Mecha/ear wick + terapia tópica · Procedimento local + gotas tópicas · Procedimento	Reavaliar em 24–48 h	Melhora chegada do colírio; analgesia é essencial.
Extensão para pavilhão/face ou celulite associada	Cefalexina + tratamento tópico · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h · VO	7–10 dias	Se diabetes/imunossupressão ou dor desproporcional, investigar otite externa maligna.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia/intolerância a esquema oral para celulite por Gram-positivo	Clindamicina + tratamento tópico · 300 mg VO 8/8 h · VO	7–10 dias	Não cobre Pseudomonas; não usar para suspeita de otite externa maligna.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Otite externa difusa ▪ Perfuração ou conduto úmido ▪ Diabetes/imunossupressão com dor intensa	Tópico com quinolona; se maligna, antipseudomonas sistêmico

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Evitar antibiótico sistêmico na otite externa simples

Tratamento tópico, analgesia e limpeza/penetração adequada resolvem a maioria dos casos.

ALERTA CRÍTICO

Diabético com dor intensa: pensar em otite externa maligna

Dor noturna, granulação no conduto, otorreia persistente ou pares cranianos exigem ORL, imagem e antipseudomonas sistêmico.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Conduto edemaciado	Considerar mecha/ear wick para permitir chegada do colírio.
2	Sem complicação	Tópico + analgesia; evitar água/manipulação.
3	Diabetes/imunossupressão e dor intensa	Investigar otite externa maligna.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de otite externa maligna ▪ Imunossupressão grave ▪ Celulite extensa ▪ Pares cranianos

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Dor progressiva ▪ Febre ou extensão local

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ciprofloxacino/ofloxacino otológico Tópica	Conforme apresentação GRAVE Se maligna, usar tratamento sistêmico antipseudomonas	Tópico: Sem ajuste renal relevante	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Otite externa simples é geralmente padronizável; validar institucionalmente apenas se alto risco, extensão ou suspeita de maligna.
- Confirmar ausência de sinais de extensão/maligna
- Usar via tópica como base
- Orientar retorno em 48–72 h se falha

2.5

Otite Externa Maligna / Necrotizante

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção invasiva do conduto externo/base do crânio, clássica em diabéticos e imunossuprimidos. Dor intensa/desproporcional, otorreia persistente, granulação no conduto e pares cranianos são sinais de gravidade.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefepime

2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

≥6 semanas, guiado por ORL/infectologia e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	PRINCIPAL	Cobertura antipseudomonas obrigatória
Staphylococcus aureus	POSSÍVEL	Considerar MRSA se risco
Fungos	RARO	Considerar em imunossupressão intensa ou falha

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Internação, suspeita de osteomielite de base de crânio	Cefepime · 2 g EV 8/8 h · EV	≥6 semanas	Cultura profunda, imagem e seguimento ORL/infectologia obrigatórios; ajustar por sensibilidade.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Extensão de partes moles, suspeita polimicrobiana ou necessidade de anaeróbios	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	≥6 semanas	Individualizar conforme cultura, gravidade e protocolo local.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Step-down em paciente estável, cultura sensível e seguimento garantido	Ciprofloxacino · 750 mg VO 12/12 h · VO	Completar curso prolongado	Somente se sensível, boa absorção, controle metabólico e seguimento próximo.
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam ± Vancomicina · Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h ± Vancomicina · EV	≥6 semanas	Coertura de Pseudomonas com aztreonam; adicionar MRSA se risco.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	Todo caso suspeito de otite externa maligna	Cefepime, ceftazidima, piperacilina-tazobactam ou ciprofloxacino se sensível
MRSA	▪ Colonização prévia ▪ Internação recente ▪ Infecção hospitalar ▪ Falha com antipseudomonas	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
CULTURA E SENSIBILIDADE

Obter cultura antes do tratamento quando isso não atrasar cuidado. Antipseudomonas deve ser escolhido por gravidade, função renal, imagem e sensibilidade; cefepime não é opção universal.

ALERTA CRÍTICO
Não manejar como otite externa simples

Diabetes/imunossupressão + dor intensa/desproporcional exige investigação agressiva.

ALERTA CRÍTICO
Pares cranianos = gravidade

Paralisia facial, disfagia, diplopia ou rouquidão sugerem extensão para base de crânio.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Internar, controlar glicemia, coletar cultura profunda/secreção e iniciar antipseudomonas EV.
2	Extensão/osteomielite	Solicitar TC/RM conforme disponibilidade e acionar ORL/infectologia.
3	Melhora e cultura sensível	Considerar step-down com ciprofloxacino VO e seguimento estreito.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita diagnóstica ▪ Diabetes descompensado ▪ Dor intensa ▪ Pares cranianos ▪ Necessidade EV

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Sepses ▪ Comprometimento neurológico/via aérea
Falha terapêutica	▪ Dor persistente ▪ PCR/VHS sem queda ▪ Cultura resistente ▪ Progressão em imagem

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de secreção profunda/tecido antes do antibiótico quando possível; hemoculturas se febre/sepses.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<60 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Ciprofloxacino VO/EV	750 mg VO 12/12 h GRAVE 400 mg EV a cada 8–12 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Infecção otorrinolaringológica grave com risco de complicação intracraniana, osteomielite, MDR, necessidade de cirurgia ou curso prolongado.
- Validar esquema com ORL/infectologia/CCIH conforme gravidade e microbiologia local
- Avaliar necessidade de TC/RM e drenagem/abordagem cirúrgica
- Coletar cultura profunda antes do antibiótico quando possível, sem atrasar sepses ou via aérea
- Monitorar função renal e níveis quando usar vancomicina/aminoglicosídeos ou tratamento prolongado
- Descalonar conforme cultura e resposta clínica

2.6

Mastoidite Aguda

GRAVE

HOSPITALAR

TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Complicação da otite média com dor, febre, edema/eritema retroauricular e protrusão do pavilhão. Risco de abscesso subperiosteal, trombose venosa e complicação intracraniana.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ± Vancomicina

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h; considerar 2 g 12/12 h se complicação SNC

VIA

EV

DURAÇÃO

2–4 semanas conforme complicação e controle de foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	FREQUENTE	Agente clássico pós-OMA
Streptococcus pyogenes	POSSÍVEL	Pode ter curso agressivo

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	POSSÍVEL	Considerar MRSA se risco
Pseudomonas aeruginosa	ESPECIAL	Mais provável em otite crônica, colesteatoma ou otorreia crônica

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mastoidite aguda comunitária sem risco específico de MRSA/ Pseudomonas	Ceftriaxona · 2 g EV 24/24 h; 2 g EV 12/12 h se complicação SNC · EV	2–4 semanas	ORL obrigatório; avaliar miringotomia/ tubo/drenagem. Adicionar vancomicina se risco de MRSA, sepse ou complicação grave.
Mastoidite grave, abscesso, sepse ou risco de MRSA	Ceftriaxona + Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h (2 g 12/12 h apenas se houver extensão intracraniana) + Vancomicina EV conforme peso/nível · EV	2–4 semanas	Descalonar vancomicina se MRSA for improvável/excluído.
Otite crônica, colesteatoma, otorreia crônica ou risco de Pseudomonas	Cefepime + Vancomicina se risco de MRSA · Cefepime 2 g EV 8/8 h ± Vancomicina EV · EV	2–4 semanas	Cobertura antipseudomonas; ajustar por cultura.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h · EV	2–4 semanas	Ajustar por cultura e avaliação especializada.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Mastoidite grave ▪ Internação recente ▪ Colonização prévia ▪ Abscesso ▪ Sepse	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ Otite crônica ▪ Colesteatoma ▪ Otorreia crônica ▪ Falha prévia	Cefepime ou ceftazidima

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
Complicação intracraniana
Cefaleia intensa, rigidez nuchal, vômitos, rebaixamento, convulsão ou déficit focal exigem neuroimagem urgente.

ATENÇÃO
ORL precoce
Pode precisar de miringotomia, tubo, drenagem de abscesso ou mastoidectomia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Internar, iniciar EV, analgesia e acionar ORL.
2	Sinais de complicação	TC temporal/crânio com contraste ou RM conforme contexto.
3	Falha/abscesso	Drenagem cirúrgica conforme ORL.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Todo caso suspeito ▫ Abscesso subperiosteal ▫ Febre/toxemia ▫ Dor importante
UTI	▫ Complicação intracraniana ▫ Sepses ▫ Rebaixamento
Falha terapêutica	▫ Sem melhora em 24–48 h ▫ Abscesso ▫ Progressão em imagem

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se febre/toxemia; cultura de material drenado quando procedimento.
Controle de foco	Drenagem cirúrgica conforme ORL.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 12/12 h se complicação SNC	Geral: Sem ajuste renal usual	
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<60 mL/min: Ajustar	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Infecção otorrinolaringológica grave com risco de complicação intracraniana, osteomielite, MDR, necessidade de cirurgia ou curso prolongado.
- Validar esquema com ORL/infectologia/CCIH conforme gravidade e microbiologia local
- Avaliar necessidade de TC/RM e drenagem/abordagem cirúrgica
- Coletar cultura profunda antes do antibiótico quando possível, sem atrasar sepse ou via aérea
- Monitorar função renal e níveis quando usar vancomicina/aminoglicosídeos ou tratamento prolongado
- Descalonar conforme cultura e resposta clínica

2.7

Epiglottite / Supraglotite — Adulto

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Emergência de via aérea com odinofagia intensa, disfagia, voz abafada, sialorreia, estridor ou postura antálgica. Prioridade absoluta é via aérea segura; exames e antibiótico vêm sem atrasar manejo respiratório.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ± Vancomicina
Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h; adicionar Vancomicina se grave/risco MRSA

VIA

EV

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Haemophilus influenzae	CLÁSSICO	Menos comum após vacina, ainda possível em adultos
Streptococcus spp.	FREQUENTE	Inclui pneumococo e estreptococos beta-hemolíticos
Staphylococcus aureus	POSSÍVEL	Considerar MRSA em casos graves/risco

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita clínica com risco de via aérea	Ceftriaxona ± Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h ± Vancomicina EV conforme peso/nível · EV	7–10 dias	Não atrasar via aérea por exame. Manejo em ambiente controlado com anestesia/ ORL/UTI.
Estável, sem risco de MRSA, após avaliação especializada	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	7–10 dias	Opção em cenário comunitário estável; ajustar por cultura e evolução.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Levofloxacino · Vancomicina EV + Levofloxacino 750 mg EV 24/24 h · EV	7–10 dias	Individualizar conforme gravidade, QT, gestação e culturas.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Grave/UTI ▪ Abscesso ▪ Colonização ou infecção prévia ▪ Uso recente de antibiótico/hospitalização	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Não manipular orofaringe se via aérea instável
Exame agressivo pode precipitar obstrução. Priorizar equipe de via aérea e ambiente controlado.

ALERTA CRÍTICO**Estridor/sialorreia = emergência**

Preparar intubação em centro cirúrgico/ambiente controlado; via aérea cirúrgica como backup.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de epiglote	Manter paciente sentado, oxigênio se necessário e acionar anestesia/ORL/UTI para via aérea controlada.
2	Via aérea ameaçada	Não manipular orofaringe nem transportar sem equipe capaz de intubação/cirurgia de resgate.
3	Após segurança da via aérea	Iniciar antimicrobiano, colher culturas quando viável e descalonar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Todo caso suspeito
UTI	▪ Estridor ▪ Sialorreia ▪ Dispneia ▪ Necessidade de via aérea ▪ Toxemia
Falha terapêutica	▪ Piora respiratória ▪ Febre persistente ▪ Abscesso

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se não atrasar via aérea/antibiótico.
Controle de foco	Não manipular orofaringe nem transportar sem equipe capaz de intubação/cirurgia de resgate.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV a cada 12–24 h conforme gravidade	Geral: Sem ajuste renal usual	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	Geral: Ajustar por função renal e nível/AUC	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Risco de obstrução de via aérea exige fluxo institucional claro, equipe experiente e ambiente controlado antes de exames/manipulação.
- Acionar precocemente anestesia/ORL/UTI conforme fluxo local
- Não atrasar proteção de via aérea por exame, imagem ou coleta laboratorial se houver instabilidade
- Evitar manipulação agressiva de orofaringe fora de ambiente controlado
- Definir backup cirúrgico de via aérea quando indicado
- Após via aérea segura, coletar culturas quando possível e ajustar antimicrobiano por evolução/cultura

2.8

Sialadenite / Parotidite Bacteriana Aguda

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Infecção aguda de glândula salivar, geralmente parótida/submandibular, associada a desidratação, hipossalivação, cálculo ou obstrução. Pode haver secreção purulenta pelo ducto.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	Principal agente bacteriano
Streptococcus spp.	FREQUENTE	Flora oral
Anaeróbios orais	POSSÍVEL	Especialmente com doença odontológica/obstrução

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve/moderada, tolera VO, sem abscesso	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	7–10 dias	Hidratação, calor local, massagem glandular e sialogogos se seguro; avaliar causa obstrutiva.
Grave, toxemia, imunossupressão ou incapacidade VO	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	7–10 dias	Imagem se suspeita de abscesso/ cálculo; ORL se obstrução ou falha.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Clindamicina · 300–450 mg VO 8/8 h ou 600–900 mg EV 8/8 h · VO/EV	7–10 dias	Cobre Gram-positivos e anaeróbios; considerar MRSA conforme risco.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Doença odontológica associada ▪ Secreção fétida ▪ Abscesso ▪ Obstrução salivar	Amoxicilina-clavulanato ou ampicilina-sulbactam
MRSA	▪ Colonização prévia ▪ Abscesso ▪ Internação recente ▪ Falha com betalactâmico	Vancomicina EV se grave; doxiciclina/TMP-SMX se leve e adequado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Procurar obstrução

Recorrência, dor ao alimentar ou glândula muito aumentada sugerem sialolitíase/estenose.

ALERTA CRÍTICO

Abscesso ou extensão cervical

Trismo, toxemia, disfagia, flutuação ou piora progressiva exigem imagem e ORL.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Quadro leve/moderado	Antibiótico VO + hidratação + calor + sialogogo/massagem se seguro.
2	Pus pelo ducto	Coletar cultura quando possível.
3	Suspeita de abscesso/obstrução	Solicitar US/TC e acionar ORL.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toxemia ▪ Imunossupressão ▪ Incapacidade VO ▪ Abscesso ▪ Extensão cervical
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Piora de edema/dor ▪ Secreção persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura da secreção ductal se houver pus, falha, imunossupressão ou quadro grave.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condições otorrinolaringológicas podem depender de disponibilidade de ORL, drenagem, imagem, cultura, fluxo de via aérea e padronização local de antimicrobianos.
- Confirmar disponibilidade de ORL, anestesia, imagem e sala/procedimento quando houver risco de via aérea ou coleção
- Checar protocolo local para ceftriaxona, ampicilina-sulbactam, vancomicina e antipseudomonais
- Coletar cultura de material drenado ou secreção profunda quando grave, recorrente, imunossuprimido ou falha terapêutica
- Reavaliar necessidade de drenagem, controle de foco e descalonamento em 24–72 h

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 02 — OTORRINOLARINGOLÓGICO

- IDSA. Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis, 2012.
- CDC. Clinical Guidance for Group A Streptococcal Pharyngitis, versão vigente.
- IDSA. Group A Streptococcal Pharyngitis, 2012.
- AAO-HNSF. Acute Otitis Externa, versão vigente.
- ENT/infectious disease principles for peritonsillar abscess, mastoiditis, necrotizing otitis externa and deep neck infection
- NICE. Otitis media (acute): antimicrobial prescribing, NG91.

03

Odontogênico

8 quadros clínicos neste sistema

3.1	Abscesso Odontogênico Localizado / Infecção Dentária Aguda	58
3.2	Celulite Facial Odontogênica	60
3.3	Angina de Ludwig / Infecção do Assoalho da Boca	63
3.4	Infecção Cervical Profunda de Origem Odontogênica	66
3.5	Sinusite Odontogênica / Pós-procedimento Dentário	68
3.6	Alveolite / Infecção Pós-extração Dentária	70
3.7	Osteomielite Mandibular/Maxilar Odontogênica	72
3.8	Profilaxia Antibiótica em Procedimento Dentário — Alto Risco	74

3.1

Abscesso Odontogênico Localizado / Infecção Dentária Aguda

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026

Infecção pulpar/periapical ou periodontal com dor, edema local, drenagem intraoral ou pequena coleção. A conduta central é odontológica: drenagem, exodontia ou tratamento endodôntico. Antibiótico isolado não substitui controle de foco e, em dor dentária sem sinais de disseminação, geralmente não é necessário.

CONDUTA DE PARTIDA

Tratamento odontológico e drenagem; antibiótico somente se disseminação, sinais sistêmicos ou impossibilidade temporária de controle

Quando indicado e sem gravidade: amoxicilina simples pode preceder amoxicilina-clavulanato; escolher por avaliação odontológica e protocolo

VIA

Conduta

DURAÇÃO

3–7 dias; reavaliar em 48–72 h e suspender 24 h após resolução clínica se foco controlado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus viridans / grupo anginosus	FREQUENTE	Flora oral aeróbia/facultativa; importante em abscessos odontogênicos.
Anaeróbios orais	FREQUENTE	Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus; relevantes em abscesso, necrose e odor fétido.
Flora polimicrobiana oral	REGRA	Cobertura anaeróbia é desejável quando há abscesso ou disseminação para partes moles.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Dor dentária/abscesso localizado sem febre, sem celulite progressiva e sem sinais sistêmicos	Controle de foco odontológico · Drenagem, exodontia ou endodontia conforme avaliação odontológica · Conduta	Urgente; idealmente no mesmo dia ou em 24–48 h	Analgesia e retorno orientado. Antibiótico não resolve coleção fechada e pode ser desnecessário se houver tratamento odontológico definitivo.
Abscesso com edema local, drenagem purulenta ou atraso inevitável no controle de foco	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	3–7 dias	Usar como ponte até controle de foco. Reavaliar em 48–72 h; suspender 24 h após resolução dos sintomas se foco controlado.
Alternativa com reforço anaeróbio quando clavulanato indisponível	Amoxicilina + Metronidazol · Amoxicilina 500 mg VO 8/8 h + Metronidazol 500 mg VO 8/8 h · VO	3–7 dias	Evitar álcool com metronidazol; reavaliar necessidade após drenagem/tratamento dentário.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia imediata/grave a betalactâmico	Clindamicina · 300 mg VO a cada 6–8 h · VO	3–7 dias	Usar com cautela pelo risco de C. difficile e resistência; priorizar controle de foco e reavaliação precoce.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave com contraindicação/intolerância à clindamicina	Azitromicina ± Metronidazol · Azitromicina 500 mg VO no D1, depois 250 mg VO 24/24 h D2-D5 ± Metronidazol 500 mg VO 8/8 h · VO	5 dias	Cobertura oral menos previsível; preferir avaliação odontológica rápida e retorno obrigatório se piora.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Abscesso ▪ Necrose pulpar ▪ Odor fétido ▪ Drenagem purulenta ▪ Disseminação para partes moles	Amoxicilina-clavulanato ou amoxicilina + metronidazol

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Antibiótico não substitui dentista

O tratamento definitivo é drenagem, exodontia ou endodontia. Antibiótico isolado tende a falhar se houver coleção/foco fechado.

INFORMAÇÃO

Quando não tratar com antibiótico

Dor dentária isolada, pulpíte ou abscesso localizado com acesso imediato a tratamento odontológico e sem sinais sistêmicos geralmente não exigem antibiótico.

ALERTA CRÍTICO

Pesquisar extensão profunda

Trismo, disfagia, sialorreia, elevação do assoalho oral, voz abafada, dispneia, toxemia ou edema cervical mudam a conduta para urgência hospitalar.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor dentária ou abscesso localizado	Avaliar sinais sistêmicos e sinais de espaço profundo; prescrever analgesia e priorizar controle de foco odontológico.
2	Sem extensão e sem toxemia	Tratamento ambulatorial; antibiótico apenas se edema/abscesso, drenagem incompleta, atraso no tratamento definitivo ou risco clínico.
3	Sinais de gravidade/extensão	Encaminhar para hospital, avaliar via aérea, solicitar imagem se indicado e acionar bucomaxilo/ORL.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Trismo importante ▪ Disfagia, sialorreia ou voz abafada ▪ Edema facial/cervical progressivo ▪ Febre/toxemia ▪ Imunossupressão ou diabetes descompensado ▪ Falha após 24–48 h de conduta adequada
Falha terapêutica	▪ Piora em 24–48 h ▪ Persistência de febre ▪ Aumento do edema ▪ Ausência de controle de foco ▪ Abscesso não drenado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não coletar cultura de rotina em infecção leve. Coletar material drenado se grave, recorrente, imunossuprimido, falha terapêutica ou hospitalização.

EIXO	CONDUTA
Controle de foco	- Avaliar sinais sistêmicos e sinais de espaço profundo; prescrever analgesia e priorizar controle de foco odontológico. - Tratamento ambulatorial; antibiótico apenas se edema/abscesso, drenagem incompleta, atraso no tratamento definitivo ou risco clínico.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h se grave/hospitalar	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Clindamicina VO/EV	300 mg VO a cada 6–8 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar apenas conforme droga específica e contexto clínico.	

REFERÊNCIA DO QUADRO

American Dental Association. Antibiotic Use for Urgent Dental Pain and Intraoral Swelling, 2019.
CDC/ADA. Be Antibiotics Aware — dor e edema de origem dentária.

3.2

Celulite Facial Odontogênica

MODERADA

HOSPITALAR

ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Disseminação odontogênica para partes moles da face. O risco clínico é progressão para espaços profundos, órbita, mediastino ou via aérea. A avaliação deve separar celulite sem coleção de abscesso drenável e sempre buscar o dente/foco causal.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina-Sulbactam

3 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7–14 dias no total, conforme controle de foco e resposta clínica

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus viridans / grupo anginosus	FREQUENTE	
Anaeróbios orais	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus	RISCO ESPECÍFICO	Cobertura para MRSA apenas se fatores de risco ou infecção grave.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Celulite facial moderada, progressiva, com necessidade de observação/EV	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	7–14 dias total	Associar avaliação odontológica/ bucomaxilo para drenagem ou tratamento do foco dentário.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve, sem sinais de espaço profundo, sem toxemia e com seguimento garantido	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias, individualizar	Adequado apenas se baixo risco, sem trismo/disfagia e com controle de foco programado.
Grave, sepse, diabetes descompensado ou suspeita de extensão profunda	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias ou conforme drenagem	Considerar vancomicina se risco de MRSA. Solicitar imagem e avaliação cirúrgica.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico em quadro não crítico	Clindamicina · 600–900 mg EV 8/8 h ou 300–450 mg VO 6/6 h se leve · VO/EV	7–14 dias	Monitorar risco de <i>C. difficile</i> ; verificar resistência local e resposta precoce.
Alergia grave com quadro grave/sepse e necessidade de amplo espectro	Vancomicina + Metronidazol + Aztreonam · Vancomicina EV por peso/AUC + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Individualizar	Exige validação institucional/infectologia; ajustar por culturas e controle de foco.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Origem dentária ▪ Abscesso ▪ Necrose ▪ Halitose ou secreção purulenta	Ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulanato ou piperacilina-tazobactam se grave
MRSA	▪ Colonização prévia ▪ Infecção cutânea purulenta recorrente ▪ Hospitalização recente ▪ Falha terapêutica ▪ Sepse	Vancomicina se internado/grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Face odontogênica pode virar pescoço profundo

Trismo, disfagia, odinofagia intensa, sialorreia, voz abafada ou edema submandibular indicam alto risco.

ATENÇÃO

Imagem se progressiva ou profunda

TC de face/pescoço com contraste ajuda a diferenciar celulite de abscesso e mapear extensão.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Celulite facial odontogênica	Avaliar via aérea, trismo, deglutição, extensão cervical/orbitária e comorbidades.
2	Moderada/grave	Iniciar EV, solicitar avaliação bucomaxilo/odontologia e considerar TC com contraste.
3	Coleção, piora ou falha	Drenagem/cultura + controle do foco dentário; descalonar conforme evolução.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Edema progressivo ▪ Trismo ▪ Disfagia ou sialorreia ▪ Febre/toxemia ▪ Imunossupressão/diabetes descompensado ▪ Falha VO ▪ Suspeita orbitária/cervical
UTI	▪ Sepses/choque ▪ Via aérea ameaçada ▪ Necessidade de intubação ou drenagem urgente
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 24–48 h ▪ Abscesso não drenado ▪ Progressão cervical/orbitária ▪ Foco dentário não abordado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se febre/sepsis; cultura do material drenado se houver coleção.
Controle de foco	Drenagem/cultura + controle do foco dentário; descalonar conforme evolução.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Amoxicilina-Clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar VO em grave	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Celulite facial odontogênica moderada/grave depende de disponibilidade de bucomaxilo/URL, imagem, drenagem e perfil local de MRSA.
- Definir fluxo de avaliação bucomaxilo/URL
- Checar critérios locais de internação
- Validar cobertura MRSA apenas quando indicada

REFERÊNCIA DO QUADRO

American Dental Association. Antibiotic Use for Urgent Dental Pain and Intraoral Swelling, 2019.

3.3

Angina de Ludwig / Infecção do Assoalho da Boca

CRÍTICA UTI ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Celulite rapidamente progressiva dos espaços submandibular, sublingual e submentoniano, geralmente odontogênica. É emergência de via aérea: pode cursar com elevação da língua, sialorreia, disfagia, voz abafada, trismo e obstrução.

CONDUTA DE PARTIDA

Via aérea e controle cirúrgico do foco odontogênico + antimicrobiano

Comunitária: ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h. Risco de Gram-negativo/assistência à saúde ou sepse: piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

10–14 dias ou mais, conforme drenagem, necrose e evolução

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Anaeróbios orais	MUITO FREQUENTE	
Streptococcus viridans / anginosus	FREQUENTE	
Flora oral polimicrobiana	REGRA	
Staphylococcus aureus/MRSA	RISCO ESPECÍFICO	Considerar se fatores de risco, infecção hospitalar, purulência extensa ou sepse.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Angina de Ludwig, via aérea potencialmente ameaçada ou sepse	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias ou individualizar	Priorizar via aérea e avaliação cirúrgica. Adicionar vancomicina se risco MRSA ou choque com risco hospitalar.
Sem choque, baixo risco de resistência, com equipe cirúrgica disponível	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias ou individualizar	Cobertura oral usual; escalar se necrose, sepse ou falha.
Adicionar se risco de MRSA ou infecção associada a cuidado de saúde	Vancomicina · Dose EV por peso/AUC conforme protocolo · EV	Conforme cultura e evolução	Não é automática em todo caso comunitário; descalonar se MRSA excluído.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia imediata grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Exige validação institucional/infectologia; não atrasar via aérea ou drenagem.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Origem odontogênica ▪ Assoalho oral ▪ Necrose ▪ Abscesso profundo	Piperacilina-tazobactam ou ampicilina-sulbactam
MRSA	▪ Colonização prévia ▪ Hospitalização recente ▪ Uso de droga EV ▪ Sepses grave ▪ Falha terapêutica	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

VIA AÉREA ANTES DO ANTIBIÓTICO

Acionar anestesia/ORL/bucomaxilo e planejar via aérea sem manipulação insegura. Ampicilina-sulbactam é base comunitária; reservar piperacilina-tazobactam para risco de Gram-negativo/assistência.

ALERTA CRÍTICO

Via aérea antes da tomografia

Sialorreia, dispneia, voz abafada, elevação da língua ou incapacidade de deitar indicam via aérea ameaçada. Acionar anestesia/ORL/bucomaxilo/UTI.

ALERTA CRÍTICO

Não aguardar flutuação

A angina de Ludwig pode ser celulite difusa sem abscesso inicial. A decisão cirúrgica é clínica/imagem, mas via aérea é prioridade.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de Ludwig	Acionar ajuda sênior; avaliar via aérea imediatamente antes de manipulação/exames.
2	Via aérea ameaçada	Preparar via aérea em ambiente controlado com anestesia/ORL/bucomaxilo; evitar sedação sem plano de resgate.
3	Após estabilização	ATB EV amplo, TC com contraste se possível, drenagem/controle do foco dentário e cultura.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de acometimento de espaço profundo, progressão cervical/facial, trismo importante, toxemia ou risco de via aérea
UTI	▪ Sialorreia ▪ Dispneia ▪ Estridor ▪ Voz abafada ▪ Elevação do assoalho da boca/língua ▪ Sepses/choque ▪ Necessidade de via aérea protegida
Falha terapêutica	▪ Progressão em horas ▪ Via aérea piorando ▪ Coleção não drenada ▪ Necrose ▪ Persistência de febre/sepses

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepse; cultura profunda no momento da drenagem. Não atrasar via aérea/antibiótico por cultura.
Controle de foco	ATB EV amplo, TC com contraste se possível, drenagem/controle do foco dentário e cultura.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Vancomicina EV	Dose por peso/AUC GRAVE Dose por peso/AUC	Geral: Ajustar por função renal, nível/AUC e protocolo institucional.	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Emergência de via aérea e infecção profunda. Exige fluxo institucional para anestesia, ORL/bucomaxilo, cirurgia, UTI e antibiótico EV amplo.
- Acionar protocolo de via aérea difícil
- Definir equipe cirúrgica responsável
- Validar cobertura MRSA conforme risco local
- Garantir controle de foco odontogênico

3.4

Infecção Cervical Profunda de Origem Odontogênica

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção de espaços profundos do pescoço relacionada a foco dentário/oral. Pode evoluir para obstrução de via aérea, mediastinite descendente, trombose séptica, sepse e complicações vasculares.

CONDUTA DE PARTIDA

Via aérea e controle cirúrgico do foco odontogênico + antimicrobiano

Comunitária: ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h. Risco de Gram-negativo/assistência à saúde ou sepse: piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

10–21 dias, conforme drenagem, extensão e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus grupo anginosus	FREQUENTE	
Anaeróbios orais	FREQUENTE	
Gram-negativos orais	CONTEXTUAL	
MRSA	SELECIONADO	Cobrir se fatores de risco, infecção hospitalar, uso de droga EV ou sepse grave.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção profunda grave, sepse, extensão cervical inferior ou risco de mediastinite	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	10–21 dias	Avaliação cirúrgica urgente; drenagem se coleção. Considerar vancomicina se risco MRSA.
Infecção profunda sem choque, baixo risco MDR/MRSA	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	10–21 dias	Cobertura adequada para flora oral usual; ajustar por cultura e resposta.
Alternativa em paciente estável, sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	10–21 dias	Adicionar vancomicina apenas se risco de MRSA.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vancomicina EV por peso/AUC + Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Validar com infectologia/CCIH; ajustar conforme cultura e drenagem.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	- Origem oral/odontogênica - Abscesso cervical - Necrose - Gás em tecidos	Piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam ou ceftriaxona + metronidazol

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização prévia ▪ Infecção hospitalar ▪ Uso de droga EV ▪ Falha terapêutica ▪ Sepses grave	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
VIA AÉREA ANTES DO ANTIBIÓTICO

Acionar anestesia/ORL/bucomaxilo e planejar via aérea sem manipulação insegura. Ampicilina-sulbactam é base comunitária; reservar piperacilina-tazobactam para risco de Gram-negativo/assistência.

ALERTA CRÍTICO
Controle cirúrgico de foco

Coleções profundas exigem drenagem; antibiótico isolado pode ser insuficiente.

ALERTA CRÍTICO
Mediastinite descendente

Dor torácica, crepitação, toxemia, extensão inferior no pescoço ou ar em tecidos exigem TC cervical/torácica e cirurgia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de infecção profunda	Avaliar via aérea e estabilidade. Iniciar ATB EV sem atrasar se grave.
2	Estável	Solicitar TC de pescoço com contraste; incluir tórax se extensão inferior ou suspeita de mediastinite.
3	Coleção/necrose/mediastinite	Drenagem cirúrgica + cultura profunda + controle do foco dentário.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de acometimento de espaço profundo, progressão cervical/facial, trismo importante, toxemia ou risco de via aérea
UTI	▪ Via aérea ameaçada ▪ Sepses/choque ▪ Mediastinite ▪ Complicação vascular/neurológica ▪ Necessidade de drenagem extensa
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 24–48 h ▪ Coleção não drenada ▪ Progressão em imagem ▪ Foco dentário não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepsis; cultura profunda durante drenagem. Não atrasar antibiótico/cirurgia em instabilidade.
Controle de foco	Drenagem cirúrgica + cultura profunda + controle do foco dentário.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Ceftriaxona + Metronidazol EV	2 g EV 24/24 h + 500 mg EV 8/8 h GRAVE Ampliar conforme choque/MDR	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar apenas conforme droga específica e contexto clínico.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Infecção profunda do pescoço exige fluxo cirúrgico, imagem, via aérea e UTI conforme gravidade.
- Definir bucomaxilo/ORL/cirurgia
- Validar TC cervical/torácica conforme extensão
- Definir cobertura MRSA/MDR local
- Garantir drenagem e cultura profunda

3.5

Sinusite Odontogênica / Pós-procedimento Dentário

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026

Sinusite maxilar relacionada a foco dentário, doença periapical, fístula oroantral, implante ou extração. Frequentemente unilateral, com secreção purulenta/fétida e flora anaeróbia oral. Requer tratamento do foco odontogênico além do antibiótico quando indicado.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7–14 dias, conforme controle de foco e evolução

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Anaeróbios orais	FREQUENTE	
Streptococcus viridans	FREQUENTE	
Flora mista odontogênica	FREQUENTE	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Quadro ambulatorial sem sinais orbitários/intracranianos	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	7–14 dias	Tratar foco dentário. Considerar TC se unilateral persistente, recorrente, pós-procedimento ou falha.
Grave, falha VO, imunossupressão ou complicação orbitária/intracraniana	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	10–14 dias ou individualizar	Avaliação ORL/bucomaxilo; drenagem se coleção ou complicação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico em quadro não grave	Clindamicina ± Levofloxacino · Clindamicina 300 mg VO a cada 6–8 h ± Levofloxacino 750 mg VO 24/24 h · VO	7–14 dias	Avaliar risco QT/tensão com fluoroquinolona e necessidade real de Gram-negativo. Reavaliar em 48–72 h.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Sinusite unilateral fétida ▪ Foco dentário ▪ Pós-extração/implante ▪ Fístula oroantral	Amoxicilina-clavulanato

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Sinusite unilateral sugere dente

Odor fétido, manipulação dentária recente, implante ou doença periapical devem direcionar para etiologia odontogênica.

ALERTA CRÍTICO

Complicação orbitária/intracraniana

Edema periorbitário, diplopia, alteração visual, cefaleia intensa, rigidez de nuca, alteração mental ou déficit neurológico exigem hospital.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita odontogênica	Iniciar tratamento com cobertura anaeróbia se indicado e encaminhar para odontologia/bucomaxilo.
2	Recorrente/persistente/unilateral pós-procedimento	Considerar TC de seios da face e avaliação ORL/bucomaxilo.
3	Sinais orbitários/neurológicos	Internar, solicitar imagem urgente e iniciar ATB EV.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Complicação orbitária/intracraniana ▪ Toxemia ▪ Imunossupressão ▪ Falha VO ▪ Abscesso facial/cervical associado
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Persistência unilateral ▪ Foco dentário não tratado ▪ Fístula oroantral não corrigida

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura apenas se drenagem, falha, recorrência ou quadro grave.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h se grave	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	

3.6

Alveolite / Infecção Pós-extração Dentária

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026

Dor pós-extração pode ser alveolite seca, que não é infecção purulenta e não exige antibiótico sistêmico de rotina. Antibiótico é reservado para infecção verdadeira com celulite, pus, febre, edema progressivo ou imunossupressão.

CONDUTA DE PARTIDA

Controle local odontológico

Irrigação, curativo local, analgesia e reavaliação odontológica

VIA

Procedimento

DURAÇÃO

Conforme avaliação odontológica

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Alveolite seca	FREQUENTE	Processo inflamatório/doloroso, não necessariamente infeccioso.
Flora oral mista	QUANDO INFECÇÃO VERDADEIRA	Considerar se pus, celulite ou sinais sistêmicos.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alveolite seca/dor intensa sem pus, febre ou celulite progressiva	Controle local odontológico · Irrigação delicada, curativo alveolar quando indicado e analgesia · Conduta	Reavaliar conforme dor	Não usar antibiótico sistêmico de rotina.
Infecção pós-extração com pus, celulite, febre ou edema progressivo	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Associar avaliação odontológica para drenagem/remoção de foco/fragmento se necessário.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico com infecção verdadeira	Clindamicina · 300 mg VO a cada 6–8 h · VO	5–7 dias	Usar com cautela pelo risco de C. difficile.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Infecção pós-extração com pus ▪ Celulite ▪ Mau odor ▪ Necrose	Amoxicilina-clavulanato

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

Alveolite não é sinônimo de antibiótico

Na ausência de celulite, pus, febre ou sinais sistêmicos, priorizar controle local e analgesia.

ATENÇÃO**Reavaliar complicações**

Dor progressiva, edema importante ou trismo após extração pode indicar abscesso, osteomielite ou infecção profunda.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor pós-extração	Diferenciar alveolite seca de infecção verdadeira.
2	Sem sinais infecciosos	Analgesia, irrigação/curativo local e odontologia; evitar antibiótico.
3	Infecção verdadeira ou gravidade	Antibiótico + avaliação para drenagem/controlar de foco; internar se sinais profundos.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Edema facial/cervical progressivo ▪ Trismo importante ▪ Disfagia ▪ Febre/toxemia ▪ Imunossupressão ▪ Suspeita de infecção profunda
Falha terapêutica	▪ Dor/edema progressivo ▪ Pus persistente ▪ Febre ▪ Ausência de avaliação odontológica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Geralmente desnecessária; coletar se drenagem em infecção grave, falha ou imunossupressão.
Controle de foco	Antibiótico + avaliação para drenagem/controlar de foco; internar se sinais profundos.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h se grave	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	

REFERÊNCIA DO QUADRO

American Dental Association. Antibiotic Use for Urgent Dental Pain and Intraoral Swelling, 2019.

3.7

Osteomielite Mandibular/Maxilar Odontogênica

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Infecção óssea mandibular/maxilar associada a foco dentário, trauma, extração, radioterapia ou doença periodontal. Exige imagem, cultura/biópsia quando possível e avaliação bucomaxilo. Tratamento costuma ser prolongado e depende de desbridamento quando há sequestro ósseo/necrose.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina-Sulbactam

3 g EV 6/6 h inicialmente se grave/internado

VIA

EV

DURAÇÃO

4–6 semanas ou mais, conforme cirurgia, cultura e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus orais	FREQUENTE	
Anaeróbios orais	FREQUENTE	
Actinomyces spp.	CONSIDERAR	Curso crônico, fístulas ou grânulos sulfúricos sugerem actinomicose.
Staphylococcus aureus	CONTEXTUAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Osteomielite odontogênica internada ou grave	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	Inicial	Coletar cultura profunda/biópsia quando possível e avaliar desbridamento.
Transição VO após melhora e cultura compatível	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	Completar curso prolongado	A duração deve ser individualizada com bucomaxilo/infectologia.
Suspeita/confirmada actinomicose	Penicilina/Amoxicilina em curso prolongado · Esquema conforme gravidade, cultura e especialista · VO/EV	Prolongado	Necessita validação especializada.

Sobre a duração: Completar 4–6 semanas ou mais conforme evolução. Frequentemente meses se actinomicose extensa.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico e isolado sensível/baixo risco	Clindamicina · 600–900 mg EV 8/8 h ou 300–450 mg VO 6/6 h · VO/EV	Prolongado; individualizar	Usar guiado por cultura quando possível; atenção a C. difficile.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Origem dentária ▪ Necrose óssea ▪ Fístula ▪ Sequestro	Ampicilina-sulbactam ou amoxicilina-clavulanato, idealmente guiado por cultura

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA prévio ▪ Infecção hospitalar ▪ Falha terapêutica ▪ Hemocultura positiva para S. aureus	Vancomicina inicialmente se grave; ajustar por cultura

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Não tratar osteomielite “no escuro” por meses

Sempre que possível, buscar imagem, cultura profunda/biópsia e avaliação bucomaxilo/infectologia.

ALERTA CRÍTICO

Controle cirúrgico pode ser necessário

Sequestro ósseo, necrose, fístula persistente ou falha clínica exigem desbridamento/controle do foco.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de osteomielite mandibular/maxilar	Solicitar imagem adequada e avaliar foco odontogênico, fístula, sequestro e sinais sistêmicos.
2	Estável	Priorizar cultura profunda/biópsia antes de antibiótico prolongado, se não houver sepse.
3	Grave ou com necrose/sequestro	Internar, iniciar EV, acionar bucomaxilo e considerar desbridamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepse ▪ Dor/edema progressivo ▪ Fístula extensa ▪ Imunossupressão ▪ Necrose/sequestro ▪ Necessidade de cirurgia ▪ Falha ambulatorial
Falha terapêutica	▪ Persistência de dor/fístula ▪ PCR elevada sem queda ▪ Imagem progressiva ▪ Ausência de cultura/controle de foco

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura profunda/biópsia óssea quando possível, especialmente antes de curso prolongado. Evitar cultura superficial como único guia.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	
Amoxicilina-Clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar VO em instabilidade	<30 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal e protocolo institucional.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Tratamento prolongado e decisão cirúrgica dependem de bucomaxilo/infectologia, cultura, imagem e disponibilidade de seguimento.
- Validar duração com especialista
- Confirmar necessidade de desbridamento
- Ajustar por cultura/biópsia
- Avaliar actinomicose se curso crônico

3.8

Profilaxia Antibiótica em Procedimento Dentário — Alto Risco

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Profilaxia antibiótica antes de procedimento dentário não é rotina. Para prevenção de endocardite, é reservada a grupos cardíacos de maior risco e a procedimentos que manipulam gengiva, região periapical ou perfuram mucosa oral. Não deve ser usada para todo sopro, todo idoso, toda prótese ortopédica ou todo procedimento simples.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina

2 g VO dose única 30–60 min antes do procedimento

VIA

VO

DURAÇÃO

Dose única pré-procedimento

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus viridans	ALVO PRINCIPAL	Bacteremia transitória após manipulação gengival/periapical.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Paciente com condição cardíaca de alto risco + procedimento odontológico indicado para profilaxia	Amoxicilina · 2 g VO 30–60 min antes · VO	Dose única	Confirmar que o paciente pertence a grupo de alto risco e que o procedimento envolve gengiva/periapical/mucosa.
Não consegue VO	Ampicilina · 2 g IM/EV 30–60 min antes · IM/EV	Dose única	Alternativa parenteral quando VO não possível.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não anafilática a penicilina	Cefalexina · 2 g VO 30–60 min antes · VO	Dose única	Evitar cefalosporina se história de anafilaxia, angioedema ou urticária imediata com penicilina.
Alergia imediata/grave a betalactâmico	Azitromicina ou Claritromicina · 500 mg VO 30–60 min antes · VO	Dose única	Avaliar QT/interações. Clindamicina não é preferida em recomendações recentes para profilaxia de endocardite.
Alternativa em alergia conforme protocolo	Doxiciclina · 100 mg VO 30–60 min antes · VO	Dose única	Usar conforme protocolo local e avaliação do risco/benefício.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

PROFILAXIA APENAS PARA MAIOR RISCO

Limitar a cardiopatias de maior risco e procedimentos com manipulação gengival, região periapical ou perfuração de mucosa. Clindamicina não é recomendada como alternativa de rotina.

ATENÇÃO

Profilaxia é exceção, não regra

Reservar para maior risco de mau desfecho por endocardite e procedimentos odontológicos específicos.

INFORMAÇÃO

Prótese ortopédica isolada

Prótese articular isolada não justifica automaticamente profilaxia antibiótica dentária; individualizar se imunossupressão/complicações e protocolo local.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Pedido de profilaxia	Confirmar se há condição cardíaca de alto risco e qual procedimento será realizado.
2	Indicação presente	Prescrever dose única 30–60 min antes do procedimento.
3	Sem indicação clara	Evitar antibiótico e orientar boa saúde oral/seguimento odontológico.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	Alto risco cardíaco: valva protética/material protético valvar, endocardite prévia, certas cardiopatias congênitas, transplante cardíaco com valvulopatia — confirmar lista institucional/AHA
Falha terapêutica	Não aplicável; trata-se de prevenção. Se procedimento já ocorreu sem profilaxia, não administrar dose tardia sem orientação especializada.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não se aplica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	2 g VO 30–60 min antes GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar apenas conforme droga específica e contexto clínico.	
Azitromicina VO	500 mg VO 30–60 min antes GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar apenas conforme droga específica e contexto clínico.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- A indicação de profilaxia deve seguir critérios institucionais alinhados a AHA/ADA e avaliação do risco cardíaco real.
- Confirmar condição cardíaca de alto risco
- Confirmar tipo de procedimento dentário
- Evitar profilaxia sem indicação
- Registrar alergias e antibiótico escolhido

REFERÊNCIA DO QUADRO

American Heart Association. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis, 2021.

American Dental Association. Antibiotic Prophylaxis Prior to Dental Procedures.

American Heart Association. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis, 2021 (cartão de bolso).

<https://www.heart.org/-/Media/Files/Health-Topics/Infective-Endocarditis/Infective-Endocarditis-Wallet-Card.Pdf>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 03 — ODONTOGÊNICO

- American Dental Association. Antibiotics for Dental Pain and Swelling, 2019.
- American Heart Association. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis, 2021 (cartão de bolso).

04

Pele e Partes Moles

8 quadros clínicos neste sistema

4.1	Celulite Não Purulenta / Erisipela	78
4.2	SSTI Purulenta — Abscesso / Furúnculo / Carbúnculo	81
4.3	Mordedura Humana / Animal — Infectada ou Alto Risco	83
4.4	Pé Diabético Infectado	86
4.5	Fasciite Necrosante / Infecção Necrosante de Partes Moles	89
4.6	Infecção de Ferida Operatória / Sítio Cirúrgico	91
4.7	Hidradenite Supurativa — Doença Inflamatória ± Infecção Secundária	94
4.8	Impetigo / Ectima	96

4.1

Celulite Não Purulenta / Erisipela

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção não purulenta da derme/subcutâneo, geralmente estreptocócica. O ponto crítico é separar de abscesso drenável, fasciite necrosante, trombose venosa, dermatite de estase e eritema inflamatório não infeccioso. Cobertura para MRSA não é automática.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefalexina

500 mg VO 6/6 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias; estender se resposta lenta ou gravidade

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes e outros beta-hemolíticos	PRINCIPAL	Principal alvo na celulite/erisipela não purulenta
Staphylococcus aureus MSSA	POSSÍVEL	Mais provável se trauma, porta de entrada, ferida ou exsudato
MRSA	SELECIONADO	Cobrir apenas se fator de risco ou falha clínica compatível

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve, sem SIRS, sem pus, ambulatorial	Cefalexina · 500 mg VO 6/6 h · VO	5 dias; reavaliar/estender se lenta resposta	Primeira linha prática para estreptococos e MSSA. Elevar membro e tratar porta de entrada/intertrigo/tínea.
Erisipela clássica estreptocócica	Penicilina V ou Amoxicilina · Penicilina V (fenoximetilpenicilina) 500.000 UI VO 6/6 h OU amoxicilina 500 mg VO 8/8 h · VO	5–7 dias	Boa opção quando o quadro é tipicamente estreptocócico, sem purulência. No Brasil a penicilina V é apresentada em comprimido de 500.000 UI (≈ 312 mg) e em solução oral de 80.000 UI/mL — não há comprimido expresso em miligramas.
Moderada, extensa, falha VO ou necessidade de observação	Cefazolina · 2 g EV 8/8 h · EV	EV até melhora	Trocar para VO quando afebril, dor/eritema em regressão e tolerando via oral.
Grave com SIRS, toxicidade ou risco validado para MRSA	Cefazolina + Vancomicina · Cefazolina 2 g EV 8/8 h + vancomicina 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h · EV	7–10 dias; individualizar	Adicionar vancomicina se MRSA prévio/colonização, uso de droga EV, trauma penetrante, falha com betalactâmico ou SIRS importante.
Celulite com ferida crônica, necrose, imunossupressão ou origem perineal/diabética	Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina se MRSA · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vancomicina se indicado · EV	Individualizar conforme foco e cultura	Não é esquema de rotina para celulite simples; usar quando há risco de Gram-negativos/anaeróbios ou infecção profunda.

Sobre a duração: Completar 5–7 dias totais ou mais se resposta lenta.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não grave a betalactâmico	Clindamicina · 300–450 mg VO 6/6 h · VO	5–7 dias	Cobre estreptococos e parte dos <i>S. aureus</i> ; considerar resistência local e risco de <i>C. difficile</i> .
Alergia grave + necessidade EV	Vancomicina · 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h · EV	7–10 dias; ajustar por nível/função renal	Boa opção hospitalar quando não se pode usar betalactâmico e há gravidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA prévio ou colonização conhecida ▪ Uso de droga EV ▪ Trauma penetrante ▪ Falha com betalactâmico adequado ▪ SIRS/toxicidade importante	Vancomicina EV se grave; clindamicina/SMX-TMP/doxiciclina conforme cenário e necessidade estreptocócica
ANAEROBIOS	▪ Necrose ▪ Períneo ▪ Ferida crônica profunda ▪ Mordedura ▪ Pé diabético moderado/grave	Não é rotina; usar ampicilina-sulbactam, pip-tazo ou ceftriaxona + metronidazol conforme foco

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Excluir fasciite necrosante**

Dor desproporcional, progressão muito rápida, anestesia cutânea, bolhas, necrose, crepitação, choque ou toxicidade sistêmica exigem cirurgia imediata.

ATENÇÃO**Se tem pus, muda o algoritmo**

Flutuação, coleção ou secreção purulenta indicam SSTI purulenta: drenagem é o eixo do tratamento.

INFORMAÇÃO**Eritema pode piorar nas primeiras 24 h**

A borda pode expandir inicialmente por inflamação; reavaliar dor, febre, toxemia e velocidade de progressão.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sem pus e sem sinais graves	Cefalexina VO + elevar membro + tratar porta de entrada; retorno em 48 h.
2	Erisipela típica	Penicilina/amoxicilina ou cefalexina; foco em estreptococo.
3	MRSA de risco ou grave	Adicionar cobertura anti-MRSA; não usar de rotina na celulite simples.
4	Dor desproporcional ou necrose	Suspender lógica de celulite simples: cirurgia + antibiótico amplo para necrosante.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ SIRS/toxicidade ▪ Progressão rápida ▪ Dor importante ▪ Imunossupressão ▪ Falha VO ▪ Face/órbita/mão/genital ▪ Suspeita de necrosante ▪ Descompensação clínica/social

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ Disfunção orgânica ▪ Suspeita de fasciite necrosante ▪ Necessidade de cirurgia urgente com instabilidade
Falha terapêutica	▪ Sem melhora clínica em 48–72 h ▪ Piora da dor ▪ Nova purulência/abscesso ▪ Febre persistente ▪ Diagnóstico alternativo provável

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemocultura apenas se grave, imunossuprimido, mordedura/imersão, neutropenia, falha terapêutica ou sinais sistêmicos relevantes. Swab superficial não ajuda em celulite fechada.
Controle de foco	Suspender lógica de celulite simples: cirurgia + antibiótico amplo para necrosante.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Retirar vancomicina se MRSA improvável e culturas/curso favorecem estreptococo/MSSA ▪ Trocar EV para VO quando melhora clínica consistente
Transição EV → VO	▪ Afebril ▪ Dor e eritema em regressão ▪ Sem nova coleção ▪ Tolerando VO

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefalexina VO	500 mg VO 6/6 h GRAVE 1 g VO 6/6 h se adulto grande/grave e função renal preservada	>30 mL/min: Dose usual; 10–30 mL/min: Ajustar intervalo; <10 mL/min: Ajustar intervalo/dose	
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 6/6 h em infecção grave, se função renal permitir	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE Dose de ataque 20–25 mg/kg se grave; ajustar por AUC/nível	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

4.2

SSTI Purulenta — Abscesso / Furúnculo / Carbúnculo

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção purulenta com coleção drenável. A drenagem é a intervenção principal; antibiótico é adjuvante quando há sinais sistêmicos, celulite extensa, múltiplas lesões, imunossupressão, extremos de idade, falha após drenagem ou localização de risco.

CONDUTA DE PARTIDA

Incisão e drenagem

Drenar coleção; associar antibiótico se critério clínico

VIA

Procedimento

DURAÇÃO

Reavaliar em 24–48 h; antibiótico 5–7 dias se indicado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	Inclui MSSA e MRSA comunitário conforme epidemiologia local
Streptococcus pyogenes	ASSOCIADO	Relevante quando há celulite ao redor
Flora mista	SELECIONADO	Períneo, perianal, mordedura, pé diabético, imunossupressão

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Abscesso simples, pequeno, sem SIRS e sem celulite extensa	Incisão e drenagem · Procedimento local + analgesia + curativo · Procedimento	Reavaliar em 24–48 h	Antibiótico pode ser dispensado se drenagem completa e paciente estável.
Abscesso drenado com febre, celulite, múltiplas lesões ou risco de MRSA	Sulfametoxazol-Trimetoprim · 800/160 mg VO 12/12 h; considerar 2 comprimidos 12/12 h em adulto grande/grave conforme protocolo · VO	5–7 dias	Boa opção para MRSA comunitário. Se forte componente estreptocócico, associar/considerar betalactâmico.
Alternativa VO anti-MRSA	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Evitar em gestantes. Cobertura estreptocócica pode ser limitada.
Monoterapia quando precisa cobrir MRSA e estreptococo	Clindamicina · 300–450 mg VO 6/6 h · VO	5–7 dias	Usar considerando resistência local e risco de C. difficile.
Sepse, imunossupressão, falha, abscesso profundo ou necessidade cirúrgica ampla	Vancomicina · 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h · EV	7–14 dias conforme foco e controle cirúrgico	Internar, coletar cultura do pus e garantir drenagem adequada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico quando antibiótico é indicado	SMX-TMP ou Doxiciclina ou Clindamicina · SMX-TMP 800/160 mg 12/12 h OU doxi 100 mg 12/12 h OU clinda 300–450 mg 6/6 h · VO	5–7 dias	Escolher conforme gestação, interação, risco de C. difficile, necessidade estreptocócica e resistência local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Abscesso purulento com indicação de antibiótico ▪ MRSA prévio ▪ Surto/local com alta prevalência ▪ Falha terapêutica ▪ SIRS ou imunossupressão	SMX-TMP, doxiciclina ou clindamicina VO; vancomicina se grave
ANAEROBIOS	▪ Períneo/perianal ▪ Mordedura ▪ Necrose ▪ Pé diabético ▪ Odor fétido	Amox-clav/amp-sulb/pip-tazo ou ceftriaxona + metronidazol conforme gravidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Antibiótico não substitui drenagem**

Coleção drenável precisa de incisão e drenagem. Falha sem drenagem adequada é esperada.

ATENÇÃO**Não drenar áreas de alto risco sem suporte**

Face central, mão, genitais, perianal profundo, suspeita de fístula ou abscesso grande/profundo exigem avaliação especializada/imagem.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Coleção drenável	Drenar, quebrar loculações, enviar cultura se grave/recorrente/falha.
2	Sem critérios de antibiótico	Curativo, analgesia e retorno precoce.
3	Com critérios de antibiótico	SMX-TMP/doxiciclina/clindamicina por 5–7 dias; adaptar ao perfil clínico.
4	Grave/profundo	Internar, vancomicina EV e controle cirúrgico/imagem.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ SIRS/seps ▪ Imunossupressão ▪ Abscesso profundo/extenso ▪ Mão/face/genital/perianal ▪ Falha após drenagem ▪ Necessidade de centro cirúrgico
Falha terapêutica	▪ Persistência de dor/flutuação ▪ Febre após 48–72 h ▪ Celulite em progressão ▪ Drenagem incompleta ▪ Resistência ou diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do pus se abscesso grave, recorrente, imunossuprimido, falha terapêutica, surto, internação ou suspeita de patógeno incomum.
Controle de foco	Drenar, quebrar loculações, enviar cultura se grave/recorrente/falha.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sulfametoxazol-Trimetoprim VO	800/160 mg VO 12/12 h GRAVE Considerar 2 cp 12/12 h em adulto grande/grave conforme protocolo	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Doxiciclina VO/EV Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h GRAVE 100 mg EV/VO 12/12 h	Qualquer ClCr: Não requer ajuste renal usual	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE Dose de ataque 20–25 mg/kg se grave	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

4.3

Mordedura Humana / Animal — Infectada ou Alto Risco

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Mordeduras exigem limpeza/irrigação vigorosa, avaliação de tendão, articulação, osso, neurovascular, tétano e raiva. Antibiótico é profilático em feridas de alto risco e terapêutico quando há infecção estabelecida.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

Profilaxia 3–5 dias; infecção estabelecida em geral 5–7 dias, prolongando por profundidade, osso/articulação, controle inadequado ou resposta lenta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pasteurella multocida	COMUM EM CÃO/ GATO	Gato: maior risco de inoculação profunda
Capnocytophaga canimorsus	RARO, GRAVE EM ASPLENIA/ ALCOOLISMO/ CIRROSE	Pode causar sepse fulminante
Eikenella corrodens	MORDEDURA HUMANA	Resistente a clindamicina isolada e cefalosporina de 1ª geração
Anaeróbios orais	FREQUENTES	Importantes em mordedura humana, ferida profunda ou tardia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Ferida de alto risco sem infecção	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	3 dias	Indicar em mão, face, pé, genital, perfuração profunda, gato, imunossupressão, diabetes, asplenia, cirrose, prótese articular ou apresentação tardia.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mordedura infectada leve/moderada	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5 dias; 7–10 se lenta resposta	Cobre Pasteurella, flora oral, anaeróbios e MSSA de forma prática.
Infeção grave, celulite extensa, mão profunda, tenossinovite, articulação ou sepse	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	EV até melhora; total conforme profundidade	Internar, imagem/avaliação cirúrgica se suspeita de articulação, tendão, osso ou coleção.
Mordedura humana em mão/punho ou “fight bite”	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	Individualizar; mínimo 5–7 dias se infectada	Alto risco de articulação/tendão. Avaliação cirúrgica precoce é decisiva.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Doxiciclina + Metronidazol · Doxiciclina 100 mg EV/VO 12/12 h + metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h · VO/EV	Profilaxia 3 dias; tratamento 5–7 dias	Evitar doxiciclina em gestação. Em gestante/alergia grave, discutir alternativa com infectologia/protocolo local.
Alternativa se doxiciclina contraindicada e adulto não gestante	Clindamicina + Ciprofloxacino · Clinda 300 mg VO 6/6 h + cipro 500 mg VO 12/12 h · VO	5 dias se infectada	Não usar clindamicina isolada; Eikenella e Pasteurella podem não ficar cobertas.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Mordedura humana ▪ Ferida profunda ▪ Odor/necrose ▪ Apresentação tardia ▪ Infecção estabelecida	Amox-clav, amp-sulb ou metronidazol combinado
MRSA	▪ MRSA prévio ▪ Abscesso purulento ▪ Falha terapêutica ▪ Alta prevalência local	Adicionar SMX-TMP/doxiciclina ou vancomicina se grave, sem perder cobertura oral/anaeróbia

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

FERIDA, RAIVA E TÉTANO

Irrigar, explorar estruturas profundas e decidir fechamento. Aplicar o fluxo brasileiro de raiva e atualizar tétano; antibiótico não substitui essas medidas.

ALERTA CRÍTICO

Mão e “fight bite” são alto risco

Pequena lesão sobre MCP pode comunicar com articulação/tendão. Não fechar primariamente sem avaliação adequada.

ATENÇÃO

Tétano e raiva não são opcionais

Avaliar vacinação antitetânica e necessidade de profilaxia antirrábica conforme animal, ferida e vigilância local.

INFORMAÇÃO

Evitar esquemas incompletos

Cefalexina ou clindamicina isoladas não cobrem adequadamente Pasteurella/Eikenella/anaeróbios.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Caso suspeito/confirmado	Irrigação copiosa + exploração + avaliar tendão/articulação/osso/corpo estranho.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Alto risco sem infecção	Amox-clav por 3 dias + tétano/raiva conforme indicação.
3	Infectada	Amox-clav VO ou amp-sulb EV; cultura se pus/gravidade.
4	Mão/fight bite/articulação	Cirurgia/ortopedia precoce; não subestimar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Mão profunda ▪ Face extensa ▪ Articulação/tendão/osso ▪ Sepse ▪ Imunossupressão/asplenia/cirrose ▪ Falha VO ▪ Necrose/coleção
Falha terapêutica	▪ Piora em 24–48 h ▪ Dor progressiva ▪ Déficit funcional ▪ Febre ▪ Coleção ▪ Suspeita de corpo estranho/dente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura se ferida infectada com secreção, grave, falha terapêutica, imunossupressão ou necessidade de drenagem/cirurgia. Não colher swab de ferida limpa sem infecção.
Controle de foco	Cirurgia/ortopedia precoce; não subestimar.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Usar amp-sulb EV se grave	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Doxiciclina + Metronidazol VO/EV	Doxi 100 mg 12/12 h + metro 500 mg 8/8 h GRAVE EV/VO conforme gravidade	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Fluxograma da Profilaxia da Raiva Humana, versão vigente.

Ministério da Saúde. Tétano Acidental — vigilância, profilaxia e tratamento.

IDSA. Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections, 2014.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/raiva/fluxograma-da-profilaxia-da-raiva-humana-cartaz>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tetano-acidental>

<https://www.idsociety.org/practice-guideline/skin-and-soft-tissue-infections/>

4.4

Pé Diabético Infectado

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Infecção do pé diabético é diagnóstico clínico. Não tratar úlcera não infectada. Classificar gravidade, avaliar isquemia, abscesso, necrose, gás e osteomielite. Antibiótico sem desbridamento, drenagem, offloading e avaliação vascular falha com frequência.

CONDUTA DE PARTIDA

Classificar gravidade + controle de foco

Leve: VO; moderada/grave: EV + cultura de tecido profundo

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Partes moles 1–2 semanas; osteomielite conforme ressecção/cultura

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
S. aureus e Streptococcus spp.	LEVE/RECENTE	Alvos principais se infecção superficial e sem antibiótico recente
Enterobacterales	MODERADA/ GRAVE/CRÔNICA	Mais provável em ferida crônica, antibiótico prévio, internação
Anaeróbios	NECROSE/ ISQUEMIA/ PROFUNDA	Odor, tecido desvitalizado, abscesso, isquemia
Pseudomonas aeruginosa	SELECIONADO	Não cobrir empiricamente de rotina; considerar isolamento prévio/exposição/epidemiologia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Úlcera sem sinais clínicos de infecção	Sem antibiótico · Curativo, offloading, controle glicêmico e vascular · Procedimento	Não se aplica	Antibiótico não cicatriza úlcera não infectada e aumenta resistência/eventos adversos.
Leve: superficial, eritema limitado, sem sinais sistêmicos	Cefalexina ou Amoxicilina-Clavulanato · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h OU amox-clav 875/125 mg VO 12/12 h · VO	1–2 semanas	Escolher conforme necessidade de anaeróbios/Gram-negativos e contexto da ferida.
Moderada: profunda/extensa, sem choque	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	1–2 semanas para partes moles; adaptar ao foco	Coletar cultura de tecido profundo após limpeza/desbridamento.
Grave: sepse, necrose, gás, abscesso profundo ou risco amplo	Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vancomicina EV · EV	Individualizar	Cobertura ampla inicial se grave; cirurgia/vascular precoce.
ESBL prévio/risco alto ou choque com exposição recente a antibiótico	Meropenem + Vancomicina se MRSA · Meropenem 1 g EV 8/8 h; considerar 2 g 8/8 h se choque + vanco se MRSA · EV	Individualizar	Usar quando risco real de ESBL; descalonar rapidamente.
Osteomielite confirmada ou muito provável	Terapia dirigida por cultura óssea/tecido profundo · Conforme agente e sensibilidade · VO/EV	6 semanas se osso infectado não ressecado	Não tratar imagem isolada sem correlação. Preferir cultura óssea quando viável.

Sobre a duração: Até 3 semanas se amputação menor com margem óssea positiva. Descalonar por cultura e controle de foco.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico em infecção moderada/grave	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vanco EV + aztreonam 2 g EV 8/8 h + metro 500 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Alternativa ampla; ajustar por cultura, renal e gravidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA prévio/colonização ▪ Infecção grave ▪ Falha terapêutica ▪ Alta prevalência local ▪ Hemodiálise/internações frequentes	Vancomicina EV se grave; opções EV/VO conforme cultura e gravidade
PSEUDOMONAS	▪ Isolamento prévio recente ▪ Exposição frequente a água/umidade ▪ Clima/epidemiologia local favorável ▪ Infecção grave com risco específico	Pip-tazo, cefepime + metronidazol ou meropenem conforme contexto
ANAEROBIOS	▪ Necrose ▪ Odor fétido ▪ Isquemia ▪ Abscesso ▪ Ferida profunda	Amp-sulb, pip-tazo, carbapenem ou metronidazol combinado
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Antibiótico amplo recente ▪ Internação recente ▪ Colonização conhecida	Meropenem se grave; descalonar por cultura

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**NÃO TRATAR ÚLCERA NÃO INFECTADA**

Antibiótico requer sinais clínicos de infecção. Não cobrir Pseudomonas empiricamente sem isolamento prévio, exposição/ambiente compatível ou epidemiologia regional que sustente.

ALERTA CRÍTICO**Não tratar úlcera não infectada**

Colonização e odor isolado não bastam. Exigir sinais clínicos de infecção.

ALERTA CRÍTICO**Controle de foco e vascular importam tanto quanto antibiótico**

Abscesso, necrose, gás, síndrome compartimental, isquemia crítica ou osteomielite exigem cirurgia/vascular.

ATENÇÃO**Cultura correta**

Preferir tecido profundo após limpeza/desbridamento; swab superficial costuma confundir.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Úlcera diabética	Confirmar infecção clínica; se não infectada, sem antibiótico.
2	Infectada	Classificar leve/moderada/grave; avaliar isquemia, abscesso, necrose, gás, osteomielite.
3	Leve	VO focado em Gram positivos por 1–2 semanas.
4	Moderada/grave	Cultura profunda + EV + desbridamento/drenagem + avaliação vascular.
5	Osteomielite	Definir cirurgia vs tratamento clínico; preferir cultura óssea/tecido profundo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Moderada/grave ▪ Sepses ▪ Necrose/gás ▪ Abscesso profundo ▪ Isquemia crítica ▪ Suspeita de osteomielite ▪ Falha ambulatorial ▪ Descompensação metabólica
UTI	▪ Choque séptico ▪ Necrose extensa/fasciite ▪ Disfunção orgânica ▪ Cirurgia urgente com instabilidade
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ Isquemia não corrigida ▪ Coleção não drenada ▪ Osteomielite não reconhecida ▪ Cultura resistente ▪ Offloading inadequado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Tecido profundo após limpeza/desbridamento; hemoculturas se sepsis. Cultura óssea se osteomielite e viável. Evitar swab superficial.
Controle de foco	▪ Cultura profunda + EV + desbridamento/drenagem + avaliação vascular. ▪ Definir cirurgia vs tratamento clínico; preferir cultura óssea/tecido profundo.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Usar EV se grave	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h se choque/infecção grave conforme foco	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

REFERÊNCIA DO QUADRO

IWGDF/IDSA. Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Diabetes-related Foot Infections, 2023.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/diabetic-foot-infections/>

4.5

Fasciíte Necrosante / Infecção Necrosante de Partes Moles

CRÍTICA UTI ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Emergência cirúrgica. Antibiótico é indispensável, mas não substitui desbridamento precoce e agressivo. LRINEC baixo não exclui. Suspeitar diante de dor desproporcional, toxicidade, progressão rápida, bolhas, necrose, crepitação ou anestesia cutânea.

CONDUTA DE PARTIDA

Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina + Clindamicina

Píp-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vanco EV + clinda 900 mg EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Até controle cirúrgico + 48–72 h após último desbridamento e estabilidade

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Polimicrobiana	FREQUENTE	Gram positivos, Gram negativos e anaeróbios
Streptococcus pyogenes	CLÁSSICO/ MONOMICRO- BIANO	Associar agente antitoxina: clindamicina ou linezolida conforme protocolo
S. aureus/MRSA	POSSÍVEL	Cobrir empiricamente até definição
Vibrio vulnificus/Aeromonas	EXPOSIÇÃO AQUÁTICA	Considerar em água salgada/doce, frutos do mar, cirrose
Clostridium spp.	TRAUMA/SOLO	Mionecrose, gás, toxemia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de infecção necrosante — não esperar exame	Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina + Clindamicina · Píp-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vanco-micina EV + clindamicina 900 mg EV 8/8 h · EV	Até desbridamento completo + 48–72 h de estabilidade	Chamar cirurgia imediatamente. Coletar culturas se não atrasar antibiótico/cirurgia.
Risco de ESBL, choque ou infecção hospitalar grave	Meropenem + Vancomicina + Clindamicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h + vancomicina EV + clindamicina 900 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar conforme desbridamentos	Preferir em risco alto de Gram-negativo resistente.
GÁS confirmado ou altamente provável	Penicilina G + Clindamicina · Penicilina G 4 milhões UI EV 4/4 h + clindamicina 900 mg EV 8/8 h · EV	Até controle de foco; geralmente 7–14 dias	Clindamicina/antitoxina é mantida pela síndrome toxigênica.
Exposição a água salgada/frutos do mar ou suspeita de Vibrio	Doxiciclina + Ceftazidima · Doxi 100 mg EV/VO 12/12 h + ceftazidima 2 g EV 8/8 h · EV	7–14 dias conforme resposta e desbrida-mento	Manter cobertura ampla inicial se polimicrobiana/MRSA ainda não exclu-ídos.
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol + Clindamicina · Vanco EV + aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h + metro 500 mg EV 8/8 h + clinda 900 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Alternativa de resgate; envolver infecto-logia/UTI/cirurgia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa antitoxina/MRSA conforme protocolo local	Linezolida + Gram-negativo/anaeróbio amplo · Linezolida 600 mg EV/VO 12/12 h + pip-tazo/ meropenem conforme risco · VO/EV	Individualizar	Pode substituir vancomicina + clindamicina em alguns protocolos; avaliar plaquetas, serotonérgicos e disponibilidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Cobertura empírica inicial em necrosante até culturas ▪ MRSA prévio/risco local ▪ Choque/toxicidade	Vancomicina ou linezolida conforme protocolo
ANAEROBIOS	▪ Cobertura obrigatória na suspeita empírica ▪ Períneo, abdome, diabetes, necrose, gás	Pip-tazo, meropenem ou metronidazol combinado
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Internação/antibiótico recente ▪ Choque hospitalar ▪ Colonização conhecida	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Cirurgia agora

Não aguardar TC, cultura ou laboratório se a suspeita clínica é alta. Antibiótico isolado não salva tecido necrosado.

ALERTA CRÍTICO

LRINEC não exclui

Score baixo não afasta fasciite. A decisão é clínica-cirúrgica.

ATENÇÃO

Clindamicina/antitoxina

Manter agente antitoxina quando GÁS ou choque tóxico são suspeitos.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Acionar cirurgia + iniciar pip-tazo/vanco/clinda imediatamente.
2	Centro cirúrgico	Desbridamento agressivo, cultura de tecido profundo, reabordagem em 24–48 h se necessário.
3	GÁS confirmado	Penicilina G + clindamicina; avaliar choque tóxico.
4	Após controle	Descalonar por cultura e manter até estabilidade + 48–72 h após último desbridamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de infecção necrosante ou necessidade de avaliação cirúrgica urgente
UTI	▪ Choque/disfunção orgânica ▪ Progressão rápida ▪ Necessidade de múltiplos desbridamentos ▪ Ventilação/vasopressor
Falha terapêutica	▪ Progressão após cirurgia ▪ Necrose residual ▪ Novo choque ▪ Necessidade de novo desbridamento ▪ Foco não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e cultura de tecido profundo intraoperatório. Não atrasar antibiótico nem cirurgia para coleta.
Controle de foco	Acionar cirurgia + iniciar pip-tazo/vanco/clinda imediatamente.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE Dose de ataque 20–25 mg/kg se grave; ajustar por AUC/nível	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Clindamicina EV	900 mg EV 8/8 h GRAVE 900 mg EV 8/8 h	Qualquer ClCr: Não requer ajuste renal usual	
Penicilina G cristalina EV	4 milhões UI EV 4/4 h GRAVE 4 milhões UI EV 4/4 h	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h se choque/risco CNS conforme contexto	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

4.6

Infecção de Ferida Operatória / Sítio Cirúrgico

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Classificar como superficial, profunda ou órgão/espaco. O tratamento-chave é abrir suturas/drenar coleção quando há pus. Antibiótico não é obrigatório em toda infecção superficial drenada; é indicado quando há resposta sistêmica, celulite extensa, infecção profunda ou órgão/espaco.

CONDUTA DE PARTIDA

Abrir/drenar + antibiótico conforme gravidade/sítio

Cefazolina 2 g EV 8/8 h se cirurgia limpa com celulite sistêmica

VIA

EV

DURAÇÃO

5 dias se superficial com resposta; 4–7 dias após controle de foco intra-abdominal; individualizar profunda

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
S. aureus/MSSA e Streptococcus spp.	CIRURGIA LIMPA	Cobertura de pele é suficiente quando superficial e sem contaminação de cavidade
MRSA	SELECIONADO	Colonização, internação, hemodiálise, próteses, alta prevalência local

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales e anaeróbios	ABDOMINAL/ PERINEAL/ GINECOLÓGICA	Cobrir conforme sítio cirúrgico e profundidade

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Superficial com pus, sem celulite extensa ou SIRS	Remover suturas + incisão/drenagem · Controle local, curativo e reavaliação · Procedimento	Antibiótico pode não ser necessário	Enviar cultura se secreção relevante, recorrência, falha ou contexto hospitalar.
Cirurgia limpa com celulite extensa ou resposta sistêmica	Cefazolina · 2 g EV 8/8 h · EV	5 dias após controle local; estender se resposta lenta	Cobertura MSSA/estreptococos.
Risco de MRSA ou infecção grave por Gram positivo	Vancomicina · 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h · EV	Individualizar	Associar cobertura Gram-negativa/ anaeróbia se cirurgia abdominal/ perineal/ginecológica.
Profunda ou órgão/espaco após cirurgia abdominal/perineal	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	4–7 dias após controle de foco adequado	Imagem e drenagem percutânea/cirúrgica quando houver coleção.
Alternativa abdominal sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h · EV	4–7 dias após controle de foco	Adequado para muitos cenários comunitários/iniciais sem risco MDR.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave em cirurgia limpa	Vancomicina ou Clindamicina · Vanco EV OU clinda 600–900 mg EV 8/8 h · EV	5 dias se indicada	Escolher conforme gravidade, MRSA e risco de C. difficile.
Alergia grave em sítio abdominal/perineal	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vanco EV + aztreonam 2 g EV 8/8 h + metro 500 mg EV 8/8 h · EV	4–7 dias após controle de foco	Alternativa ampla sem betalactâmico.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA prévio/colonização ▪ Hemodiálise ▪ Internação prolongada ▪ Prótese/material ▪ Alta prevalência local ▪ Infecção grave	Vancomicina; linezolida/daptomicina conforme contexto
ANAEROBIOS	▪ Cirurgia abdominal ▪ Perineal ▪ Ginecológica ▪ Necrose/odor ▪ Deiscência contaminada	Pip-tazo ou ceftriaxona/cefepime + metronidazol
PSEUDOMONAS	▪ Hospitalização prolongada ▪ Antibiótico recente ▪ Cultura prévia ▪ Urologia/umidade ▪ MDR local	Pip-tazo, cefepime + metronidazol ou meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Pus precisa sair

Abrir suturas, drenar e lavar quando há coleção. Antibiótico isolado mantém foco fechado.

ATENÇÃO**Procurar órgão/espço**

Febre, dor profunda, íleo, instabilidade ou drenagem persistente exigem imagem e avaliação cirúrgica.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Ferida operatória com pus	Abrir pontos/drenar; cultura se relevante.
2	Superficial sem SIRS	Controle local pode bastar; antibiótico se celulite extensa/sistêmico.
3	Cirurgia limpa + sistêmico	Cefazolina; adicionar MRSA se risco.
4	Abdominal/perineal/profunda	Imagem + controle de foco + cobertura Gram-negativa/anaeróbia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ SIRS ▪ Infecção profunda ▪ Órgão/espço ▪ Prótese/material ▪ Imunossupressão ▪ Falha ambulatorial ▪ Necessidade de drenagem guiada/cirúrgica
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ Dor profunda ▪ Secreção persistente ▪ Deiscência ▪ Coleção não drenada ▪ Cobertura inadequada ao sítio

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de secreção profunda/coleção ou material cirúrgico. Hemoculturas se sepse. Evitar swab superficial seco.
Controle de foco	▪ Abrir pontos/drenar; cultura se relevante. ▪ Imagem + controle de foco + cobertura Gram-negativa/anaeróbia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 6/6 h se grave e função renal permitir	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	
Ceftriaxona + Metronidazol EV	Ceftriaxona 2 g 24/24 h + metro 500 mg 8/8 h GRAVE Mesmo esquema; ajustar por gravidade/foco	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

4.7

Hidradenite Supurativa — Doença Inflamatória ± Infecção Secundária

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Doença inflamatória crônica folicular. Doxiciclina por 8–12 semanas pode ter papel anti-inflamatório e não significa infecção bacteriana crônica; abscesso agudo, celulite e sepse exigem avaliação própria.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina

100 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

8–12 semanas em doença leve/moderada; curto curso se celulite secundária

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Inflamação folicular/oclusiva	BASE DA DOENÇA	Não é apenas infecção
Flora cutânea mista	SECUNDÁRIA	Pode haver S. aureus, estreptococos, anaeróbios em abscessos crônicos
MRSA	SELECIONADO	Considerar se cultura prévia, abscesso purulento recorrente ou falha

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Hurley I leve/localizado	Clindamicina tópica 1% · Aplicar 12/12 h · Tópica	Até 12 semanas conforme dermatologia	Útil em lesões leves; orientar seguimento dermatológico.
Exacerbação inflamatória leve/moderada sem celulite grave	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	8–12 semanas	Atua também como anti-inflamatório. Evitar em gestação.
Moderada/recorrente ou falha com tetraciclina	Clindamicina + Rifampicina · Clinda 300 mg VO 12/12 h + rifampicina 300 mg VO 12/12 h · VO	10–12 semanas	Atenção a interações da rifampicina e hepatotoxicidade; idealmente com dermatologia/infectologia.
Celulite secundária ao redor de lesão	Cefalexina ou Amoxicilina-Clavulanato · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h OU amox-clav 875/125 mg 12/12 h · VO	5–7 dias	Usar quando há sinais de infecção bacteriana aguda, não apenas drenagem crônica.
Abscesso profundo, sepse, necrose ou imunossupressão	Vancomicina + Piperacilina-Tazobactam se grave/polimicrobiana · Vanco EV + pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h · EV	Individualizar	Internar, imagem/drenagem se coleção profunda; excluir fasciite.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia/intolerância a tetraciclina	Clindamicina + Rifampicina · 300 mg + 300 mg VO 12/12 h · VO	10–12 semanas	Ver interações, hepatopatia e contraceptivos.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA prévio ▪ Abscesso purulento recorrente com cultura ▪ Falha terapêutica ▪ Sepses	Cultura e terapia dirigida; vancomicina se grave
ANAEROBIOS	▪ Doença perineal extensa ▪ Odor fétido ▪ Túneis crônicos ▪ Abscesso profundo	Amox-clav, clinda+rifampicina ou esquema amplo se grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Não tratar toda hidradenite como abscesso simples

É doença inflamatória crônica; precisa de seguimento dermatológico e controle de fatores agravantes.

ALERTA CRÍTICO

Excluir necrosante se dor desproporcional/toxemia

Períneo e região inguinal podem evoluir com infecção necrosante/Fournier.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Lesão típica sem toxemia	Classificar Hurley, tratar dor, orientar dermato; antibiótico prolongado se indicado.
2	Abscesso flutuante	Drenagem para alívio se coleção; considerar técnica definitiva se recorrente.
3	Celulite secundária	Curso curto direcionado para infecção aguda.
4	Períneo/toxemia	Excluir Fournier/necrosante e internar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepses ▪ Celulite extensa ▪ Abscesso profundo ▪ Períneo com dor importante ▪ Imunossupressão ▪ Falha ambulatorial ▪ Necrose
Falha terapêutica	▪ Recorrência frequente ▪ Túneis extensos ▪ Sem melhora após 8–12 semanas ▪ Cultura resistente ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura se drenagem purulenta importante, falha, recorrência incomum, sepses ou imunossupressão. Não há necessidade em todo surto leve típico.
Controle de foco	Drenagem para alívio se coleção; considerar técnica definitiva se recorrente.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO/EV Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h GRAVE 100 mg EV/VO 12/12 h	Qualquer ClCr: Não requer ajuste renal usual	
Clindamicina + Rifampicina VO	300 mg + 300 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar como resgate de sepse; internar se grave	Geral: Monitorar função hepática/interações; rifampicina tem muitas interações	

4.8

Impetigo / Ectima

LEVE AMBULATORIAL TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção superficial contagiosa por *S. aureus* e/ou *S. pyogenes*. Impetigo limitado pode ser tratado com antibiótico tópico; ectima é mais profundo e geralmente requer via oral. Considerar MRSA se purulência recorrente, surto ou falha.

CONDUTA DE PARTIDA

Mupirocina tópica

Aplicar 8/8 h nas lesões

VIA

Topica

DURAÇÃO

5 dias se impetigo limitado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus MSSA	COMUM	Principal em impetigo bolhoso
Streptococcus pyogenes	COMUM	Associado a impetigo não bolhoso/ectima
MRSA	SELECIONADO	Considerar se surto, falha, abscesso ou colonização

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Impetigo limitado, poucas lesões	Mupirocina tópica · Aplicar 8/8 h após higiene/remoção suave de crostas · Topica	5 dias	Evitar compartilhar toalhas; cobrir lesões; avaliar afastamento se surto/escola conforme norma local.
Múltiplas lesões, surto, falha tópica ou ectima	Cefalexina · 500 mg VO 6/6 h · VO	7 dias	Preferir VO no ectima por ser lesão mais profunda.
Suspeita de MRSA	SMX-TMP ou Doxiciclina ou Clindamicina · SMX-TMP 800/160 mg 12/12 h OU doxi 100 mg 12/12 h OU clinda 300–450 mg 6/6 h · VO	7 dias	Doxiciclina apenas em adultos/não gestantes; clinda depende de resistência local.
Extenso, imunossuprimido ou sinais sistêmicos	Cefazolina ou Vancomicina se MRSA grave · Cefazolina 2 g EV 8/8 h OU vancomicina EV · EV	7–10 dias	Internar se toxemia, celulite extensa ou incapacidade de VO.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Clindamicina · 300 mg VO 6/6 h · VO	7 dias	Cobre estreptococo e parte dos <i>S. aureus</i> ; checar resistência local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	- Falha com betalactâmico - Surto de MRSA - Abscesso associado - Colonização conhecida	SMX-TMP/doxiciclina/clindamicina conforme idade, gestação e sensibilidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

Ectima é mais profundo

Ectima costuma exigir antibiótico oral, não apenas tópico.

ATENÇÃO

Impetigo é contagioso

Higiene, cobrir lesões e evitar compartilhamento de objetos reduzem transmissão.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Poucas lesões	Mupirocina tópica por 5 dias + higiene.
2	Ectima/múltiplas lesões	Cefalexina VO por 7 dias.
3	MRSA/falha	Cultura se possível e terapia anti-MRSA.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	- Extenso com sinais sistêmicos - Celulite importante - Imunossupressão - Falha oral - Suspeita de síndrome estafilocócica/complicação
Falha terapêutica	- Sem melhora em 3–5 dias - Novas lesões apesar de adesão - Surto domiciliar/escolar - Suspeita de MRSA

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não precisa em casos típicos leves. Colher se surto, MRSA suspeito, falha terapêutica, imunossupressão ou doença extensa.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Mupirocina Tópica	Aplicar 8/8 h por 5 dias GRAVE Não se aplica	Geral: Sem ajuste renal	
Cefalexina VO	500 mg VO 6/6 h GRAVE 1 g VO 6/6 h se extenso e renal preservado	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Clindamicina VO/EV	300–450 mg VO 6/6 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h se grave	Geral: Conferir ajuste renal conforme ClCr/protocolo local	

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 04 — PELE E PARTES MOLES

- IDSA. Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections, 2014.
- IWGDF/IDSA. Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Diabetes-related Foot Infections, 2023.

05

Urinário

8 quadros clínicos neste sistema

5.1	Pielonefrite Aguda — Adulto	100
5.2	Cistite Simples — Mulher Não Gestante	104
5.3	ITU Complicada / Urosepse	106
5.4	ITU Associada a Cateter Vesical — CAUTI	109
5.5	Prostatite Bacteriana Aguda	111
5.6	Epididimite / Orquiepididimite Aguda	114
5.7	ITU na Gestante / Bacteriúria Assintomática	116
5.8	Bacteriúria Assintomática	118

5.1

Pielonefrite Aguda — Adulto

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Infecção do trato urinário superior com febre, calafrios, dor lombar, náuseas/vômitos ou sinais sistêmicos. A prioridade no PS é separar pielonefrite não complicada, pielonefrite complicada/obstrutiva e urosepse. Nitrofurantoína e fosfomicina não tratam pielonefrite.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona

1 g EV 24/24 h; considerar 2 g EV 24/24 h se grave/bacteremia

VIA

EV

DURAÇÃO

Resposta favorável e foco controlado: em geral 5–7 dias com fluoroquinolona ou 7 dias com não fluoroquinolona; prolongar se prostatite, abscesso, obstrução não resolvida ou outra exclusão

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	Principal agente; avaliar risco individual de ESBL e resistência a FQ
Klebsiella spp.	FREQUENTE	Mais comum em idosos, diabetes e exposição hospitalar
Proteus mirabilis	FREQUENTE	Associado a litíase/estruvita e urina alcalina
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Considerar em idoso, manipulação urológica, sonda, falha a cefalosporina
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Sonda, nefrostomia, internação recente, antibiótico prévio, uropatia estrutural
Enterobacterales ESBL	RISCO ESPECÍFICO	Colonização prévia, cefalosporina/FQ recente, institucionalização, ITU recorrente

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Pielonefrite sem choque e baixo risco de ESBL/Pseudomonas	Ceftriaxona · 1 g EV 24/24 h; usar 2 g EV 24/24 h se bacteremia, maior gravidade ou obesidade importante · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Coletar urocultura antes do antibiótico quando viável. Transição VO conforme cultura e melhora clínica.
Paciente muito estável, sem vômitos, sem gestação e seguimento confiável	Ciprofloxacino ou Levofloxacino somente se adequado ao perfil local/cultura · Ciprofloxacino 500–750 mg VO 12/12 h OU Levofloxacino 750 mg VO 24/24 h · VO	5 dias com levofloxacino 750 mg	Evitar fluoroquinolona se uso da classe nos últimos 12 meses, QT prolongado, alto risco de resistência ou gestação.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse, internação recente, sonda/nefrostomia, manipulação urológica ou risco de <i>Pseudomonas</i>	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime · Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h OU Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Usar dose otimizada e ajustar à função renal. Considerar meropenem se risco simultâneo de ESBL/choque.
ESBL prévio/provável, choque séptico ou falha a cefalosporina	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; considerar 2 g EV 8/8 h em choque/infecção crítica conforme protocolo · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Ertapenem é opção se ESBL confirmado, paciente estável e sem risco de <i>Pseudomonas</i> .
<i>Enterococcus</i> provável ou documentado	Ampicilina se sensível · Ampicilina 2 g EV 4/4 h; associar gentamicina apenas em situações selecionadas · EV	10–14 dias ou conforme bacteremia/foco	Ceftriaxona não cobre <i>Enterococcus</i> . Evitar aminoglicosídeo rotineiro em DRC/idosos; monitorar toxicidade.

Sobre a duração: 7 dias com ciprofloxacino; ajustar conforme resposta.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam ± cobertura gram-positiva · Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h; adicionar vancomicina se <i>Enterococcus</i> /MRSA relevante · EV	7–14 dias conforme foco e culturas	Aztreonam cobre gram-negativos, mas não cobre <i>Enterococcus</i> /anaeróbios. Ajustar rapidamente por cultura.
Transição VO guiada por cultura, sem FQ	Sulfametoxazol-trimetoprima · 800/160 mg VO 12/12 h · VO	10–14 dias totais	Usar apenas se sensível e paciente estável. Ajustar à função renal e potássio.
Gestante com pielonefrite	Ceftriaxona · 1–2 g EV 24/24 h · EV	10–14 dias totais	Internação inicial, hidratação, urocultura, avaliação obstétrica e transição VO após melhora.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ESBL	- ESBL prévio - Uso recente de cefalosporina ou fluoroquinolona - Hospitalização/institucionalização recente - ITU recorrente com múltiplos antibióticos - Choque séptico ou falha inicial	Meropenem se choque/grave; ertapenem se estável, ESBL provável/confirmado e sem <i>Pseudomonas</i>
PSEUDOMONAS	- Sonda vesical ou nefrostomia - Manipulação urológica recente - Internação recente - Antibiótico de amplo espectro recente - Uropatia estrutural - Transplante renal	Piperacilina-Tazobactam, Cefepime, Ceftazidima ou Meropenem conforme risco de ESBL e gravidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**DURAÇÃO DEPENDE DO SUBGRUPO**

Homem com suspeita de prostatite, obstrução, abscesso, cateter ou bacteremia complicada não deve receber automaticamente a mesma duração da cUTI com resposta rápida e foco controlado.

ALERTA CRÍTICO**NITROFURANTOÍNA/FOSFOMICINA NÃO TRATAM PIELONEFRITE**

Essas drogas não atingem concentração adequada em parênquima renal. Usar apenas para cistite baixa selecionada.

ALERTA CRÍTICO**PROCURAR OBSTRUÇÃO OU FOCO FECHADO**

Litíase obstrutiva, piodrose, abscesso renal/perinefrítico ou dispositivo obstruído exigem drenagem/controle de foco.

ATENÇÃO**CULTURA ANTES, MAS SEM ATRASAR SEPSE**

Coletar urocultura e hemoculturas se febre/seps, desde que isso não atrase antibiótico em paciente instável.

ATENÇÃO**FLUOROQUINOLONA COM CRITÉRIO**

Evitar uso empírico se exposição a fluoroquinolona nos últimos 12 meses, alta resistência local ou maior risco de evento adverso.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de pielonefrite	Coletar urina 1/urocultura; hemoculturas se febre, calafrios, internação ou seps.
2	Baixo risco e sem choque	Ceftriaxona 1 g EV 24/24 h; considerar 2 g se maior gravidade/bacteremia.
3	Risco Pseudomonas ou seps	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime; ajustar função renal.
4	ESBL provável ou choque	Meropenem; descalonar com cultura.
5	Suspeita de obstrução/abscesso	Imagem e Urologia para drenagem; antibiótico isolado pode falhar.
6	Melhora em 48–72 h	Transição VO guiada por cultura e completar duração adequada.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Seps ou toxemia ▪ Vômitos/intolerância VO ▪ Gestaç ▪ Idoso frágil ▪ Imunossupress ▪ DRC/transplante ▪ Dor intensa/desidratação ▪ Suspeita de obstrução/litíase ▪ Falha ambulatorial ▪ Risco de resistência
UTI	▪ Choque séptico ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica aguda ▪ Alteraç ▪ Necessidade de vasopressor ▪ Hipoxemia ou suporte ventilatório

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Febre ou instabilidade após 48–72 h ▪ Cultura resistente ao esquema ▪ Foco obstrutivo não drenado ▪ Abscesso renal/perinefrético ▪ Bacteremia persistente ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura antes do antibiótico quando viável; hemoculturas se febre, calafrios, sepse, internação ou pielonefrite grave.
Controle de foco	Imagem e Urologia para drenagem; antibiótico isolado pode falhar.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Revisar cultura em 48–72 h ▪ Reduzir espectro se sensível ▪ Trocar para VO quando afebril/estável e tolerando via oral ▪ Evitar manter carbapenêmico sem indicação microbiológica
Transição EV → VO	▪ Instabilidade persistente ▪ Febre >72 h ▪ Cultura resistente ▪ Suspeita de obstrução/abscesso ▪ Evento adverso/toxicidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV Gestação: uso aceito	1 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Geral: Sem ajuste renal usual	TETO 2 g/dia na maioria dos cenários urinários; individualizar
Ciprofloxacino VO/EV Gestação: evitar	500–750 mg VO 12/12 h ou 400 mg EV 12/12 h GRAVE 400 mg EV 8/8 h em situações selecionadas	>30 mL/min: Dose usual; 5–29 mL/min: Ajustar intervalo/dose conforme formulação	TETO 1500 mg/dia VO
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 1–2 g EV 8/8 h	>50 mL/min: Dose usual; 26–50 mL/min: 1 g 12/12 h; 10–25 mL/min: 500 mg 12/12 h; <10 mL/min: 500 mg 24/24 h	TETO 6 g/dia em infecções críticas selecionadas

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, 2025.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/complicated-urinary-tract-infections/>

5.2

Cistite Simples — Mulher Não Gestante

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção baixa, não complicada, em mulher adulta não gestante, sem febre, dor lombar, náuseas/vômitos, imunossupressão ou anormalidade urológica. O objetivo é curso curto, evitar fluoroquinolona e não tratar exames isolados.

CONDUTA DE PARTIDA

Nitrofurantoína

100 mg VO 6/6 h por 5 dias; se formulação macrocristal/monoidratada
100 mg VO 12/12 h conforme disponibilidade

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	Principal agente
Staphylococcus saprophyticus	MENOS COMUM	Mulheres jovens, atividade sexual
Klebsiella spp.	MENOS COMUM	Pode ter resistência
Proteus mirabilis	MENOS COMUM	Naturalmente resistente à nitrofurantoína com frequência; suspeitar se litíase/urina alcalina
Enterococcus spp.	MENOS COMUM	Nitrofurantoína costuma ter atividade urinária para E. faecalis

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Primeira escolha para cistite simples	Nitrofurantoína · 100 mg VO 6/6 h por 5 dias ou 100 mg VO 12/12 h se formulação apropriada · VO	5 dias	Não usar se suspeita de pielonefrite. Evitar se CrCl <30 mL/min.
Dose única / adesão difícil	Fosfomicina trometamol · 3 g VO dose única · VO	Dose única	Opção para cistite baixa. Não usar para pielonefrite.
Alternativa se resistência local baixa ou cultura sensível	Sulfametoxazol-trimetoprima · 800/160 mg VO 12/12 h · VO	3 dias	Usar se resistência local de E. coli <20% ou antibiograma sensível. Atenção a alergia, DRC e hipercalemia.
Alternativa quando primeiras opções não podem ser usadas	Cefalexina ou Amoxicilina-Clavulanato · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h OU Amoxicilina-Clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Preferir quando há boa probabilidade de sensibilidade. Pode ter menor eficácia que opções de primeira linha.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Evitar como rotina	Fluoroquinolona · Usar apenas se não houver opção adequada · VO	3 dias se excepcionalmente indicada	Reservar por eventos adversos e impacto ecológico; não é primeira linha para cistite simples.
Alergia a betalactâmico	Nitrofurantoína, Fosfomicina ou TMP-SMX conforme elegibilidade · Conforme esquema de primeira linha · VO	3–5 dias ou dose única	A escolha deve considerar função renal, alergia a sulfa, gestação e suspeita de pielonefrite.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

NITROFURANTOÍNA DEPENDE DA FORMULAÇÃO

Confirmar se o produto é macrocristalino ou monoidratado/macrocristais e aplicar o intervalo da bula disponível no Brasil. Nitrofurantoína não trata pielonefrite nem prostatite.

ALERTA CRÍTICO

SE FEBRE/DOR LOMBAR, NÃO É CISTITE SIMPLES

Reclassificar como pielonefrite/ITU complicada se houver febre, calafrios, dor lombar, vômitos ou sinais sistêmicos.

ATENÇÃO

EVITAR FLUOROQUINOLONA COMO 1ª LINHA

Ciprofloxacino/levofloxacino devem ser reservados quando não houver alternativa adequada.

ATENÇÃO

NITROFURANTOÍNA EXIGE FUNÇÃO RENAL

Evitar se CrCl <30 mL/min e nunca usar para pielonefrite.

INFORMAÇÃO

UROCULTURA NÃO É OBRIGATÓRIA EM TODA CISTITE SIMPLES

Pedir se recorrente, falha terapêutica, sintomas atípicos, risco de resistência ou dúvida diagnóstica.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Disúria/polaciúria sem sinais sistêmicos	Tratar como cistite simples se mulher não gestante e sem fatores de complicação.
2	Escolha empírica	Nitrofurantoína 5 dias ou fosfomicina dose única; TMP-SMX se resistência local baixa/sensível.
3	Sinais de alarme	Febre, dor lombar, vômitos ou gestação mudam a classificação.
4	Falha/recorrência	Colher urocultura, revisar diagnóstico e ajustar terapia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	- Sintomas persistentes após 48–72 h - Recorrência precoce em até 2 semanas - Febre/dor lombar - Cultura resistente - Diagnóstico alternativo como vaginite/IST

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não obrigatória na cistite simples típica; colher se recorrente, falha, sintomas atípicos, risco de resistência ou antes de antibiótico em casos complicados.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Nitrofurantoína VO	100 mg VO 6/6 h por 5 dias ou 100 mg VO 12/12 h conforme formulação GRAVE Não indicada para infecção grave	≥30 mL/min: Pode usar; <30 mL/min: Evitar	TETO 400 mg/dia na formulação 6/6 h
Gestação: com ressalva			

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Fosfomicina trometamol VO Gestação: com ressalva	3 g VO dose única GRAVE Não indicada para pielonefrite/sepse	Geral: Sem ajuste usual para dose única; individualizar DRC avançada	
TMP-SMX VO	800/160 mg VO 12/12 h GRAVE Não indicado para cistite grave isoladamente	>30 mL/min: Dose usual; 15–30 mL/min: Reduzir 50%; <15 mL/min: Evitar/individualizar	

5.3

ITU Complicada / Urosepse

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

ITU com fator de complicação anatômico, funcional, metabólico ou imunológico, ou com apresentação sistêmica. Inclui homem, obstrução, cálculo, sonda, anomalia urológica, DRC/transplante, imunossupressão, sepse ou falha terapêutica.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona, Piperacilina-Tazobactam ou Meropenem conforme gravidade e risco de resistência

Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h OU Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h OU Meropenem 1 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Resposta favorável e foco controlado: em geral 5–7 dias com fluoroquinolona ou 7 dias com não fluoroquinolona; prolongar se prostatite, abscesso, obstrução não resolvida ou outra exclusão

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	Principal agente; avaliar ESBL
Klebsiella/Enterobacter spp.	FREQUENTE	Risco de ESBL/AmpC conforme exposição
Proteus mirabilis	FREQUENTE	Litíase e cateter
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Instrumentação, idoso, sonda, cefalosporina prévia
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Sonda, internação, antibiótico prévio, uropatia
Enterobacterales ESBL/CRE	RISCO ESPECÍFICO	Colonização prévia, hospitalar, antibiótico amplo recente

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem sepse, baixo risco de ESBL/Pseudomonas	Ceftriaxona · 1–2 g EV 24/24 h · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Adequada para muitos pacientes sem choque/resistência. Reavaliar cultura em 48–72 h.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse, sonda, manipulação urológica, hospitalização recente ou risco de <i>Pseudomonas</i>	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime · Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h OU Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Considerar infusão estendida conforme protocolo em paciente grave.
Choque, ESBL prévio/provável ou falha a cefalosporina	Meropenem · 1 g EV 8/8 h · EV	7 dias na resposta favorável com foco controlado (5–7 dias se fluoroquinolona), contados a partir da primeira terapia ativa; 10–14 dias apenas em bacteremia complicada, abscesso, prostatite, obstrução não resolvida ou resposta lenta	Ertapenem é opção em ESBL sem choque e sem <i>Pseudomonas</i> .
Transição VO após melhora e cultura sensível	Ciprofloxacino, Levofloxacino ou TMP-SMX · Ciprofloxacino 500–750 mg VO 12/12 h OU Levofloxacino 750 mg VO 24/24 h OU TMP-SMX 800/160 mg VO 12/12 h · VO	Completar 7–14 dias conforme cenário	Preferir VO apenas se cultura sensível, paciente estável, tolerando VO e sem foco fechado.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam ± Vancomicina · Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h; adicionar Vancomicina se Enterococcus/MRSA relevante · EV	7–14 dias	Ajustar por cultura; aztreonam não cobre gram-positivos/anaeróbios.
Opção de dose única/ponte em cenário selecionado	Amicacina ou Gentamicina · Amicacina 15–20 mg/kg EV dose única OU Gentamicina 5–7 mg/kg EV dose única · EV	Dose única ou curta, com monitorização	Útil em resistência selecionada; evitar/monitorar em DRC, idoso, ototoxicidade e nefrotoxicidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Sonda/nefrostomia ▪ Internação recente ▪ Uropatia estrutural ▪ Antibiótico amplo recente ▪ Transplante renal ▪ Manipulação urológica	Piperacilina-Tazobactam, Cefepime, Ceftazidima ou Meropenem conforme risco de ESBL
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Cefalosporina/FQ recente ▪ Institucionalização ▪ ITU recorrente ▪ Choque ▪ Falha a cefalosporina	Meropenem se grave/choque; Ertapenem se estável e sem <i>Pseudomonas</i>

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DURAÇÃO DEPENDE DO SUBGRUPO

Homem com suspeita de prostatite, obstrução, abscesso, cateter ou bacteremia complicada não deve receber automaticamente a mesma duração da cUTI com resposta rápida e foco controlado.

ALERTA CRÍTICO**UROSEPSE = ANTIBIÓTICO PRECOCE + FOCO**

Não basta escalar antibiótico: investigar e corrigir obstrução, cateter obstruído, piodrose, cálculo infectado ou abscesso.

ATENÇÃO**NÃO TRATAR BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA**

Mesmo em idoso, diabético ou sondado, cultura positiva sem sintomas não é indicação automática de antibiótico.

INFORMAÇÃO**DURAÇÃO MENOR QUANDO FOCO CONTROLADO**

Muitos casos respondem com 7 dias se controle de foco, estabilidade e boa resposta; prolongar se bacteremia complicada/foco não drenado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de ITU complicada	Urina 1, urocultura e hemoculturas se febre/sepse; não atrasar antibiótico em choque.
2	Baixo risco	Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h.
3	Risco Pseudomonas/sepse	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime.
4	ESBL provável/choque	Meropenem e revisão em 48–72 h.
5	Suspeita de foco urológico	Imagem + Urologia para drenagem/troca de dispositivo.
6	Cultura disponível	Descalonar, definir duração e transição VO se possível.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepsis/sinais sistêmicos ▪ Homem com febre/dor lombar ▪ Obstrução/litíase ▪ Sonda/dispositivo urinário ▪ DRC/transplante ▪ Imunossupressão ▪ Gestaçao ▪ Falha VO ▪ Vômitos/desidratação
UTI	▪ Choque ▪ Vasopressor ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica ▪ Alteração mental ▪ Hipoxemia
Falha terapêutica	▪ Sem melhora 48–72 h ▪ Cultura resistente ▪ Foco não drenado ▪ Bacteremia persistente ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura antes do antibiótico quando possível; hemoculturas se febre, calafrios, sepsis, internação ou suspeita de bacteremia.
Controle de foco	Imagem + Urologia para drenagem/troca de dispositivo.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60 mL/min: 2 g 8/8 h se grave; 30–60 mL/min: Ajustar intervalo; <30 mL/min: Ajustar conforme protocolo	TETO 6 g/dia
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	>40 mL/min: Dose usual; 20–40 mL/min: Ajustar dose/intervalo; <20 mL/min: Ajustar conforme protocolo	TETO 16 g/dia de piperacilina (18 g de piperacilina-tazobactam)
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 1–2 g EV 8/8 h	>50 mL/min: Dose usual; 26–50 mL/min: 1 g 12/12 h; 10–25 mL/min: 500 mg 12/12 h; <10 mL/min: 500 mg 24/24 h	TETO 6 g/dia em cenários selecionados

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, 2025.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/complicated-urinary-tract-infections/>

5.4

ITU Associada a Cateter Vesical — CAUTI

MODERADA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção urinária sintomática em paciente com cateter atual ou recente. Bacteriúria e piúria são esperadas com sondagem e não bastam para diagnosticar infecção. Remover/trocar cateter e coletar cultura corretamente é parte do tratamento.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ou Piperacilina-Tazobactam conforme gravidade/risco

Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h OU Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7 dias se resposta rápida; 10–14 dias se resposta lenta ou bacteremia/foco não controlado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	COMUM	E. coli, Klebsiella, Proteus; risco de MDR aumenta com tempo de sonda
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Mais provável em hospitalização, sonda prolongada e antibiótico prévio
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Idosos, cefalosporina prévia, manipulação
Candida spp.	COLONIZAÇÃO FREQUENTE	Candidúria assintomática geralmente não requer antifúngico

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sintomático, sem sepse e baixo risco de MDR	Ceftriaxona · 1–2 g EV 24/24 h · EV	7 dias se resposta rápida	Remover ou trocar cateter antes da cultura se possível; não coletar da bolsa.
Sepses, cateter prolongado, hospitalar ou risco de Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime · Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h OU Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	7–14 dias	Escolher conforme microbiologia local e risco de ESBL.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESBL prévio/provável, choque ou falha	Meropenem · 1 g EV 8/8 h · EV	7–14 dias; descalonar	Ertapenem se estável, sem Pseudomonas e cultura permitir.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Transição VO guiada por cultura	Ciprofloxacino, Levofloxacino ou TMP-SMX · Conforme sensibilidade e função renal · VO	Completar 7–14 dias	Evitar FQ se uso recente ou alto risco de resistência/eventos adversos.
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam · 2 g EV a cada 6–8 h · EV	7–14 dias	Não cobre Enterococcus; adicionar cobertura se clinicamente relevante.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Cateter prolongado ▪ Internação recente/atual ▪ Antibiótico recente ▪ Uropatia estrutural ▪ Nefrostomia/duplo J	Piperacilina-Tazobactam, Cefepime ou Meropenem
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Cefalosporina/FQ recente ▪ Institucionalização ▪ ITU recorrente ▪ Choque	Meropenem se grave; ertapenem se estável sem Pseudomonas

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DISPOSITIVO E CONTROLE DE FOCO

Retirar ou trocar o cateter quando indicado e colher cultura de urina de amostra adequada; duração de 7 dias costuma bastar na resposta rápida, prolongando apenas por resposta lenta, foco não controlado ou complicação.

ALERTA CRÍTICO

NÃO COLETAR URINA DA BOLSA

Coletar do dispositivo novo ou portal apropriado. Amostra da bolsa contamina e induz erro.

ATENÇÃO

BACTERIÚRIA/PIÚRIA EM SONDADO NÃO É ITU

Tratar apenas se sintomas urinários ou sinais sistêmicos sem outro foco provável.

INFORMAÇÃO

TROCAR OU REMOVER CATETER

Se ainda necessário e antigo/obstruído, trocar antes da cultura e do tratamento quando viável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sonda + sintomas/sinais sistêmicos	Remover/trocar cateter se possível e coletar cultura corretamente.
2	Sem sepse/baixo risco	Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h.
3	Risco MDR/Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime.
4	ESBL/choque	Meropenem e revisão por cultura.
5	Cultura disponível	Descalonar e definir duração.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre/sinais sistêmicos ▪ Seps ▪ Obstrução do cateter ▪ Imunossupressão ▪ Idoso frágil ▪ Sem condição de VO/seguimento
Falha terapêutica	▪ Febre 48–72 h ▪ Cateter não trocado/removido ▪ Patógeno resistente ▪ Outro foco ▪ Obstrução

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura do cateter novo ou coleta pelo portal apropriado; hemoculturas se febre/seps.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

5.5

Prostatite Bacteriana Aguda

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção aguda da próstata com febre, sintomas urinários, dor pélvica/perineal, próstata dolorosa e risco de bacteremia, retenção urinária e abscesso. Exige cultura, antibiótico com boa penetração prostática na fase de transição e avaliação urológica se complicações.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona inicial; transição para Ciprofloxacino ou TMP-SMX se sensível

Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h; depois Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 h ou TMP-SMX 800/160 mg VO 12/12 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

2–4 semanas; 4–6 semanas se abscesso, bacteremia, grave ou recorrente

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	Enterobacterales predominam
Klebsiella/Proteus spp.	COMUM	Idoso, uropatia, litíase
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Sonda, instrumentação, hospitalar
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Instrumentação ou falha a cefalosporina
N. gonorrhoeae / C. trachomatis	JOVEM/RISCO SEXUAL	Se uretrite, secreção ou exposição sexual

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Estável, sem sepse/retenção/abscesso	Ceftriaxona inicial, depois Ciprofloxacino ou TMP-SMX se sensível · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h; transição conforme cultura · VO/EV	2–4 semanas	FQ/TMP-SMX têm melhor penetração prostática para continuidade, mas devem ser guiados por cultura quando possível.
Sepse, idoso frágil, sonda/instrumentação ou risco <i>Pseudomonas</i>	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime · Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h OU Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	2–4 semanas; ajustar/descalonar	Imagem se febre persistente, dor intensa ou suspeita de abscesso.
ESBL prévio, choque ou falha a cefalosporina	Meropenem · 1 g EV 8/8 h · EV	2–4 semanas; transição VO se sensível	Descalonar assim que possível.
Suspeita de IST associada/uretrite	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h · Mista	Doxiciclina 7–10 dias	Investigar/tratar parceiros e coinfeções conforme protocolo de IST.

Sobre a duração: Prostatite bacteriana pode exigir curso maior conforme quadro.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Ciprofloxacino ou Aztreonam conforme gravidade/cultura · Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h ou 500 mg VO 12/12 h; se grave e necessidade EV sem quinolona, Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h · VO/EV	2–4 semanas	Cultura é central para evitar subtratamento.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Sonda ▪ Instrumentação urológica ▪ Internação recente ▪ Antibiótico recente	Piperacilina-Tazobactam, Cefepime ou Meropenem
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Cefalosporina/FQ recente ▪ Choque/falha	Meropenem; ertapenem se estável sem <i>Pseudomonas</i>

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

NÃO MASSAGEAR PRÓSTATA

Massagem pode precipitar bacteremia/sepse.

ALERTA CRÍTICO

RETENÇÃO URINÁRIA

Evitar sondagem uretral traumática; discutir cistostomia suprapúbica com Urologia se retenção importante.

ATENÇÃO

FEBRE PERSISTENTE = PENSAR EM ABSCESSO

Se febre/dor persistem após 48–72 h, solicitar imagem e acionar Urologia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Urina 1, urocultura e hemoculturas se febre/sepse. Não massagear próstata.
2	Estável	Ceftriaxona inicial; transição para FQ/TMP-SMX se sensível.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
3	Grave/risco Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime.
4	ESBL/choque	Meropenem.
5	Retenção/abscesso	Urologia; evitar manipulação traumática.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre alta/toxemia ▪ Seps ▪ Retenção urinária ▪ Vômitos/intolerância VO ▪ Imunossupressão ▪ Idoso frágil ▪ Dor intensa ▪ Suspeita de abscesso
UTI	▪ Choque ▪ Disfunção orgânica ▪ Vasopressor ▪ Lactato elevado
Falha terapêutica	▪ Febre >72 h ▪ Retenção não resolvida ▪ Abscesso ▪ Patógeno resistente ▪ Intolerância/baixa adesão VO

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura antes do antibiótico; hemoculturas se febre, calafrios, seps ou internação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

5.6

Epididimite / Orquiepididimite Aguda

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Dor e edema epididimário/testicular, geralmente por IST em homens jovens ou enterobactérias em homens mais velhos/ instrumentação. A prioridade no PS é excluir torção testicular, abscesso e sepse.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Doxiciclina ou Levofloxacino conforme etiologia provável

Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h; ou Levofloxacino 500 mg VO 24/24 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

10 dias na maioria dos esquemas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Chlamydia trachomatis	COMUM EM JOVENS	IST; uretrite pode estar presente
Neisseria gonorrhoeae	COMUM EM IST	Cobrir com ceftriaxona quando risco sexual
Enterobacterales	HOMENS MAIS VELHOS/INSTRUMENTAÇÃO	Associado a HBP, ITU, sonda, sexo anal insertivo
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Instrumentação/uropatia/hospitalar

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Provável gonococo/clamídia	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h · Mista	Doxiciclina por 10 dias	Se ≥150 kg, usar Ceftriaxona 1 g IM. Orientar abstinência e tratamento de parceiros.
Risco de IST + enterobactérias, como sexo anal insertivo	Ceftriaxona + Levofloxacino · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Levofloxacino 500 mg VO 24/24 h · Mista	Levofloxacino por 10 dias	Cobre gonococo e enterobactérias; avaliar riscos de FQ.
Enterobactéria provável e gonococo descartado	Levofloxacino · 500 mg VO 24/24 h · VO	10 dias	Usar quando gonorreia foi descartada e quadro sugere origem urinária/entérica.
Sepse, abscesso, imunossupressão ou dor/inchaço importante	Ceftriaxona EV ou esquema amplo conforme foco · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h; ampliar se risco Pseudomonas/MDR · EV	10–14 dias conforme evolução	Imagem escrotal, urologia e avaliação de internação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a cefalosporina com suspeita de gonococo	Avaliação especializada / protocolo IST · Individualizar · VO/EV	Conforme agente	Gonorreia com alergia grave exige alternativa protocolar e seguimento microbiológico.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Instrumentação urológica ▪ Sonda ▪ Internação recente ▪ Uropatia estrutural	Escolher esquema antipseudomonal se grave/hospitalar

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
EXCLUIR TORÇÃO TESTICULAR

Dor súbita intensa, testículo alto, náuseas/vômitos ou reflexo cremastérico ausente exigem avaliação urológica imediata.

ATENÇÃO
TRATAR PARCEIROS SE IST

Notificar/tratar parceiros e orientar abstinência até completar tratamento e resolução dos sintomas.

INFORMAÇÃO
SUORTE LOCAL

Elevação escrotal, analgesia/anti-inflamatório se permitido e retorno em 48–72 h.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor testicular aguda	Excluir torção; se dúvida, Urologia antes de assumir epididimite.
2	Risco IST	Ceftriaxona IM dose única + Doxiciclina 10 dias.
3	IST + enterobactéria	Ceftriaxona + Levofloxacino 10 dias.
4	Enterobactéria apenas	Levofloxacino 10 dias se gonococo descartado.
5	Reavaliação	Retorno em 48–72 h; se piora, ultrassom e Urologia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepses ▪ Abscesso ▪ Imunossupressão ▪ Dor intratável ▪ Vômitos ▪ Falha ambulatorial ▪ Dúvida com torção
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 72 h ▪ Piora da dor/edema ▪ Febre persistente ▪ Abscesso ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT para gonococo/clamídia quando disponível; urina 1/urocultura se sintomas urinários, idoso, instrumentação ou etiologia entérica provável.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

5.7

ITU na Gestante / Bacteriúria Assintomática

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Na gestação, bacteriúria assintomática e cistite devem ser tratadas para reduzir pielonefrite e complicações obstétricas. Pielonefrite na gestante geralmente exige internação e antibiótico EV inicial.

CONDUTA DE PARTIDA

Separar bacteriúria/cistite de pielonefrite; escolher por cultura e idade gestacional

Cefalexina 500 mg VO 6/6 h por 5–7 dias OU Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h

VIA

Conduta

DURAÇÃO

5–7 dias para cistite/bacteriúria; 10–14 dias para pielonefrite

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	Agente predominante
Klebsiella/Proteus spp.	MENOS COMUM	Avaliar cultura
Streptococcus agalactiae	RELEVANTE OBSTÉTRICO	GBS na urina tem implicação para profilaxia intraparto
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Considerar se cultura

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cistite ou bacteriúria assintomática em gestante	Cefalexina · 500 mg VO 6/6 h · VO	5–7 dias	Preferir guiado por urocultura. Fazer controle conforme pré-natal/protocolo local.
Cistite baixa, sem febre/dor lombar	Nitrofurantoína · 100 mg VO 6/6 h por 5 dias ou 100 mg VO 12/12 h conforme formulação · VO	5 dias	Não usar para pielonefrite. Evitar em deficiência de G6PD e próximo ao termo; no 1º trimestre pode ser usada se não houver alternativa adequada conforme avaliação risco-benefício.
Cistite/bacteriúria com necessidade de adesão simples	Fosfomicina trometamol · 3 g VO dose única · VO	Dose única	Não usar para pielonefrite. Confirmar cultura quando possível.
Pielonefrite na gestante	Ceftriaxona · 1–2 g EV 24/24 h · EV	10–14 dias totais	Internação inicial, hidratação, urocultura/hemoculturas se febre/seps e avaliação obstétrica.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa VO se sensível	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Preferir guiado por cultura; resistência de E. coli pode limitar uso empírico.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Nitrofurantoína ou Fosfomicina se baixo trato; individualizar se pielonefrite · Conforme esquema de baixo trato; pielonefrite exige avaliação hospitalar · VO/EV	Conforme cenário	Alergia grave + pielonefrite na gestante deve ser individualizada com obstetrícia/infectologia quando disponível.

ALERTAS DE SEGURANÇA**ALERTA CRÍTICO****NITROFURANTOÍNA NÃO TRATA PIELONEFRITE**

Bacteriúria assintomática/cistite e pielonefrite são ramos distintos. Pielonefrite na gestação requer avaliação hospitalar e antimicrobiano com concentração renal sistêmica. Programar cultura de controle quando indicada pelo protocolo obstétrico.

ALERTA CRÍTICO**PIELONEFRITE NA GESTANTE = INTERNAR**

Risco materno-fetal. Iniciar EV, hidratar, colher cultura e avaliar obstetricamente.

ATENÇÃO**NÃO USAR FQ NA GESTAÇÃO**

Evitar ciprofloxacino/levofloxacino. TMP-SMX exige cautela, especialmente no 1º trimestre e próximo ao termo.

INFORMAÇÃO**UROCULTURA E CONTROLE**

Ideal coletar antes do antibiótico e documentar erradicação conforme protocolo obstétrico.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Gestante com sintomas urinários ou bacteriúria	Coletar urina 1 e urocultura antes do tratamento se possível.
2	Baixo trato sem febre/dor lombar	Cefalexina, nitrofurantoína ou fosfomicina conforme contexto/cultura.
3	Febre, dor lombar ou sintomas sistêmicos	Internar e iniciar ceftriaxona EV.
4	Cultura disponível	Ajustar e programar controle.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre/dor lombar ▪ Vômitos ▪ Sepses ▪ Contrações/dor abdominal obstétrica ▪ Desidratação ▪ Falha VO ▪ Comorbidade importante
Falha terapêutica	▪ Persistência 48–72 h ▪ Cultura resistente ▪ Evolução para febre/dor lombar ▪ Recorrência precoce

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura antes do tratamento e cultura de controle conforme obstetrícia/protocolo local.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

5.8

Bacteriúria Assintomática

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Presença de bactérias na urina sem sintomas urinários ou sistêmicos. Em geral, não tratar — inclusive idosos, diabéticos, sondados, institucionalizados, lesão medular e pré-operatório não urológico. Exceções principais: gestação e procedimento urológico com trauma de mucosa.

CONDUTA DE PARTIDA

Não tratar na maioria dos casos

Antibiótico apenas nas exceções

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Conforme exceção

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	COMUM	Colonização frequente
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Especialmente em idosos/sondados
Candida spp.	FREQUENTE EM SONDA	Candidúria assintomática geralmente não tratar, salvo exceções específicas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Adulto não gestante sem sintomas, incluindo idoso, diabético, institucionalizado ou sondado	Não usar antibiótico · Conduta: não prescrever antimicrobiano; investigar outras causas de sintomas inespecíficos · Conduta	Sem duração antimicrobiana	Evita resistência, eventos adversos e C. difficile. Investigar outras causas de delirium/queda isolada.
Gestante com bacteriúria assintomática	Cefalexina, Nitrofurantoína ou Fosfomicina · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h 5–7 dias OU Nitrofurantoína 100 mg VO 6/6 h 5 dias OU Fosfomicina 3 g dose única · VO	5–7 dias ou dose única	Preferir guiado por cultura e fazer controle conforme pré-natal/protocolo local.
Antes de procedimento urológico com trauma de mucosa	Profilaxia/tratamento guiado por cultura · Escolher conforme urocultura e protocolo do procedimento · VO/EV	Dose peri-procedimento ou curso curto conforme urologia	Coletar cultura previamente e direcionar antimicrobiano.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

NÃO TRATAR EXAME

Nitrito, leucocitúria ou cultura positiva sem sintomas não definem ITU sintomática.

ATENÇÃO

IDOSO COM DELIRIUM/QUEDA ISOLADOS

Não atribuir automaticamente à bacteriúria. Procurar desidratação, medicamentos, dor, retenção, constipação, distúrbios metabólicos e outros focos.

INFORMAÇÃO

EXCEÇÕES REAIS

Tratar gestante e antes de procedimento urológico com trauma de mucosa.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Cultura positiva sem sintomas	Não prescrever antibiótico na maioria dos casos.
2	Gestante	Tratar conforme urocultura e fazer controle.
3	Procedimento urológico com trauma de mucosa	Profilaxia/tratamento guiado por cultura.
4	Febre, disúria, dor lombar ou sepse	Reclassificar como ITU sintomática e tratar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Não internar por bacteriúria assintomática isolada ▪ Internar apenas se houver outro motivo clínico
Falha terapêutica	Não se aplica se não tratado; se sintomas surgirem, reclassificar como ITU sintomática

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não repetir culturas sem indicação. Em gestante/procedimento urológico, cultura orienta tratamento.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 05 — URINÁRIO

- IDSA. Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, 2025.
- IDSA. Management of Asymptomatic Bacteriuria, 2019.

06

Gastrointestinal

8 quadros clínicos neste sistema

6.1	Diverticulite Aguda — Adulto	121
6.2	Colecistite Aguda	124
6.3	Colangite Aguda	126
6.4	Apendicite Complicada / Peritonite Secundária	129
6.5	Abscesso Intra-abdominal após Controle de Foco	131
6.6	Diarreia Infeciosa / Disenteria — Adulto	133
6.7	Colite por Clostridioides difficile	136
6.8	Abscesso Hepático Piogênico	138

6.1

Diverticulite Aguda — Adulto

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Inflamação/infecção diverticular colônica. A decisão crítica no pronto-socorro é separar a diverticulite não complicada selecionada, que pode ser manejada sem antibiótico em imunocompetente estável, da diverticulite complicada com abscesso, perfuração, fístula, obstrução, peritonite, sepse ou imunossupressão.

CONDUTA DE PARTIDA

Sem antibiótico em paciente selecionado; antimicrobiano se complicada, sistêmica ou alto risco

Selecionar primeiro entre observação segura e esquema oral/EV conforme complicação e controle de foco

VIA

Conduta

DURAÇÃO

4 dias após controle adequado de fonte; 5–7 dias em resposta clínica lenta; prolongar se controle incompleto

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	E. coli e Klebsiella spp. predominam
Bacteroides fragilis e anaeróbios colônicos	FREQUENTE	Cobertura anaeróbica é obrigatória em infecção colônica complicada
Streptococcus anginosus group	MODERADO	Associado a abscesso
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Cobrir de rotina apenas em associada à assistência à saúde, imunossupressão, transplante, falha ou cultura

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Não complicada, imunocompetente, estável e sem sinais sistêmicos importantes	Sem antibiótico inicial · Conduta: observação clínica, analgesia, dieta conforme tolerância e reavaliação · Conduta	Reavaliar em 24–72 h	Opção para paciente selecionado, com boa adesão e acesso a retorno. Não aplicar a imunossuprimido, sepse, abscesso, perfuração ou falha.
Ambulatorial selecionado com indicação de antibiótico	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Usar se comorbidade, sinais sistêmicos leves, dor persistente, maior fragilidade ou protocolo local favorecer antibiótico.
Complicada ou internação sem choque	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h · VO/EV	4 dias após controle adequado	Cobertura para G- entéricos e anaeróbios. Avaliar cirurgia/intervenção desde a admissão se abscesso, perfuração ou peritonite.
Sepse, peritonite, abscesso grande, hospitalar ou risco de Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h, preferir infusão estendida se grave · EV	4 dias após controle de fonte	Cobre G-, anaeróbios e Pseudomonas. Se risco forte de ESBL/KPC, ajustar ao perfil local.

Sobre a duração: 5–7 dias se controle clínico mais lento. Individualizar se controle incompleto.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Ciprofloxacino + Metronidazol · Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h ou 500 mg VO 12/12 h + Metronidazol 500 mg 8/8 h · VO/EV	5–7 dias; ou 4 dias após controle de fonte	Evitar quinolona se QT longo, aneurisma/dissecção, tendinopatia, interações ou alta resistência local.
ESBL provável/confirmado sem risco de Pseudomonas	Ertapenem · 1 g EV 24/24 h · EV	4 dias após controle de fonte	Não cobre Pseudomonas. Se choque, Pseudomonas ou hospitalar complexo, preferir meropenem.
ESBL + choque ou risco de Pseudomonas	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; considerar 2 g EV 8/8 h em choque/infusão estendida · EV	4 dias após controle adequado	Descalonar assim que cultura e estabilidade permitirem.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Diverticulite complicada ▪ Abscesso ▪ Perfuração ▪ Peritonite	Metronidazol associado ou betalactâmico com anaeróbica
PSEUDOMONAS	▪ associada à assistência à saúde ▪ Internação recente ▪ Antibiótico recente ▪ Sepses grave/choque ▪ Colonização prévia	Piperacilina-tazobactam ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévia ▪ Uso recente de cefalosporina/quinolona ▪ Internação recente ▪ Falha com cefalosporina	Ertapenem se estável; meropenem se choque ou Pseudomonas

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Antibiótico não é automático na não complicada

Em imunocompetente estável, sem sepse, sem abscesso e com seguimento, pode haver manejo seletivo sem antibiótico conforme protocolo.

ALERTA CRÍTICO

Controle de fonte é decisivo

Abscesso grande, pneumoperitônio, peritonite, obstrução ou deterioração exigem cirurgia/intervenção; trocar antibiótico isoladamente não resolve foco fechado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Classificar gravidade, procurar peritonite e indicar TC com contraste se dúvida, gravidade, primeira crise ou suspeita de complicação.
2	Não complicada selecionada	Analgesia, orientação de retorno, dieta conforme tolerância e decisão individualizada sobre antibiótico.
3	Complicada	Iniciar G- + anaeróbios, coletar culturas se sepse e acionar cirurgia/intervenção.
4	Abscesso	Discutir drenagem percutânea/cirurgia conforme tamanho, localização, sepse e resposta.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Dor importante ou incapacidade de VO ▪ Febre/sinais sistêmicos ▪ Idoso frágil ▪ Imunossupressão ▪ Comorbidade relevante ▪ Abscesso, perfuração, obstrução ou fístula em TC
UTI	▪ Choque séptico ▪ Peritonite difusa ▪ Lactato elevado persistente ▪ Necessidade de vasopressor
Falha terapêutica	▪ Piora em 48–72 h ▪ Febre persistente ▪ Dor progressiva ▪ Leucocitose/PCR em ascensão ▪ Novo abscesso ou perfuração

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepse/gravidade. Cultura de abscesso ou material cirúrgico quando houver drenagem ou abordagem.
Controle de foco	▪ Iniciar G- + anaeróbios, coletar culturas se sepse e acionar cirurgia/intervenção. ▪ Discutir drenagem percutânea/cirurgia conforme tamanho, localização, sepse e resposta.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Reduzir espectro após cultura/estabilidade ▪ Trocar EV para VO quando afebril, dor controlada e tolerando dieta
Transição EV → VO	▪ Afebril 24–48 h ▪ Sem peritonite/sepse ▪ Dor em melhora ▪ Aceita VO

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar isolado em sepse/choque	<30 mL/min: Evitar 875/125; ajustar fórmula/intervalo	
Ceftriaxona EV	1–2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Conferir bula/protocolo.	HEPÁTICO Reduzir/cautela em hepatopatia grave
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h em infusão estendida	<40 mL/min: Ajustar intervalo/dose conforme clearance	

6.2

Colecistite Aguda

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Inflamação/infecção da vesícula biliar, geralmente por obstrução do ducto cístico. Antibiótico reduz progressão infecciosa, mas o tratamento definitivo é o controle de fonte: colecistectomia precoce ou colecistostomia em paciente sem condição cirúrgica.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ± Metronidazol
Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h; associar Metronidazol 500 mg EV 8/8 h se grave, gangrenosa, enfisematosa, perfurada ou anastomose bílio-entérica

VIA

EV

DURAÇÃO

24 h após colecistectomia sem perfuração; 4–7 dias se complicada ou sem controle pleno

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	E. coli e Klebsiella spp.
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Mais relevante em idosos, colangite, associada à assistência à saúde e falha
Anaeróbios	CONTEXTUAL	Não cobrir automaticamente em toda colecistite leve; considerar em grave/gangrenosa/perfurada/anastomose
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Risco hospitalar, stent/manipulação biliar, antibiótico recente

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Comunitária leve/moderada, sem choque	Ceftriaxona ± Metronidazol · Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h; adicionar Metronidazol 500 mg EV 8/8 h se necrose/perfuração/anaeróbios · EV	24 h após colecistectomia se sem complicação	Discutir colecistectomia precoce. Não prolongar antibiótico se fonte controlada e evolução boa.
Grave, gangrenosa, enfisematosa, perfurada, sepse ou associada à assistência à saúde	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	4–7 dias após controle de fonte	Cobre G-, anaeróbios e Pseudomonas. Considerar cultura de bile se procedimento.
Risco de ESBL ou falha com cefalosporina	Ertapenem ou Meropenem · Ertapenem 1 g EV 24/24 h se sem Pseudomonas; Meropenem 1 g EV 8/8 h se choque/Pseudomonas · EV	4–7 dias após controle	Descalonar por cultura e evolução.

Sobre a duração: 4–7 dias se complicada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Ciprofloxacino + Metronidazol · Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	4–7 dias	Usar apenas se epidemiologia local permitir; atentar QT e efeitos de quinolona.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Gangrenosa ▪ Enfisematosa ▪ Perfuração ▪ Abscesso ▪ anastomose bílio-entérica ▪ Sepses grave	Metronidazol ou piperacilina-tazobactam/carbapenem
PSEUDOMONAS	▪ Stent/manipulação biliar ▪ associada à assistência à saúde ▪ Internação/antibiótico recente ▪ Choque	Piperacilina-tazobactam, cefepime + metronidazol ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévia ▪ Uso recente de cefalosporina/quinolona ▪ Internação recente	Ertapenem ou meropenem conforme gravidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Antibiótico não substitui cirurgia/drenagem

Colecistectomia precoce ou colecistostomia em alto risco devem ser discutidas desde o início.

ATENÇÃO

Metronidazol não é automático em toda colecistite leve

Cobertura anaeróbica é mais relevante em perfuração, gangrena, enfisematosa, anastomose bílio-entérica ou sepse grave.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	USG abdome, hemograma, função hepática, bilirrubinas e lipase; avaliar critérios de colangite.
2	Confirmada	Jejum, analgesia, hidratação, antibiótico se sinais infecciosos e avaliação cirúrgica.
3	Alto risco cirúrgico ou grave	Discutir colecistostomia/percutânea e UTI se disfunção orgânica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Dor persistente ▪ Febre/leucocitose ▪ Idoso/comorbidades ▪ Alteração de bilirrubina/enzimas canaliculares ▪ Complicação em imagem
UTI	▪ Choque ▪ Disfunção orgânica ▪ Colecistite enfisematosa/gangrenosa ▪ Peritonite
Falha terapêutica	▪ Febre persistente 48–72 h ▪ Piora da dor ▪ Sepses ▪ Perfuração/abscesso ▪ Colangite associada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepse, febre alta ou colangite associada. Cultura de bile se drenagem/colecistectomia em grave ou falha.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

EIXO	CONDUTA
Descalçamento	▪ Reduzir espectro após controle de fonte e cultura ▪ Evitar manter antibiótico por muitos dias se colecistectomia resolveu foco e sem complicação

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	1–2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	
Metronidazol VO/EV	500 mg 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Conferir bula/protocolo.	
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h infusão estendida	<40 mL/min: Ajustar conforme clearance	

6.3

Colangite Aguda

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção de via biliar obstruída. Antibiótico deve ser imediato, mas o tratamento central é a drenagem/desobstrução biliar, especialmente em choque, confusão, disfunção orgânica, obstrução persistente ou falha inicial.

CONDUTA DE PARTIDA

Comunitária não grave: ceftriaxona ± metronidazol; grave/assistência: ampliar e realizar drenagem biliar

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h na comunitária; piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h na grave/risco de Pseudomonas, com ajuste renal

VIA

EV

DURAÇÃO

4–7 dias após drenagem/controle; ajustar se bacteremia ou controle incompleto

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	E. coli, Klebsiella, Enterobacter
Enterococcus spp.	MODERADO	Mais relevante em idosos, hospitalar, stent, transplante e grave
Anaeróbios	CONTEXTUAL	anastomose bílio-entérica, abscesso hepático ou colangite grave
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Stent, manipulação prévia, antibiótico recente, associada à assistência à saúde

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve/comunitária, sem choque e baixo risco MDR	Ceftriaxona + Metronidazol se anaeróbios · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h ± Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	4–7 dias após controle/drenagem se indicada	Metronidazol se anastomose bílio-entérica, abscesso, grave ou suspeita anaeróbia.
Moderada/grave, stent, hospitalar ou risco de Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	4–7 dias após drenagem	Acionar CPRE/drenagem. Não aguardar resposta prolongada se obstrução persistir.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque séptico, ESBL provável ou falha a esquema inicial	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h ± Vancomicina 25 mg/kg carga · EV	4–7 dias após drenagem; individualizar bacteremia	Adicionar vancomicina se risco de Enterococcus resistente/MRSA, cateter ou cultura sugestiva.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Metronidazol ± Vancomicina · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h ± Vancomicina · EV	4–7 dias após drenagem	Aztreonam não cobre G+ nem anaeróbios; associar conforme risco.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Stent biliar ▪ Manipulação/CPRE prévia ▪ associada à assistência à saúde ▪ Choque ▪ Antibiótico recente	Piperacilina-tazobactam ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévia ▪ Internação recente ▪ Falha a cefalosporina ▪ Uso recente de quinolona/cefalosporina	Meropenem; ertapenem apenas se estável e sem Pseudomonas
ANAEROBIOS	▪ anastomose bílio-entérica ▪ Abscesso hepático ▪ Colangite grave	Metronidazol ou esquema com anaerobicida

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**DRENAGEM BILIAR É CONTROLE DE FOCO**

Obstrução persistente não deve ser tratada apenas ampliando antibiótico. Priorizar CPRE/drenagem no tempo definido pela gravidade e disponibilidade.

ALERTA CRÍTICO**Drenagem biliar é pilar do tratamento**

Em colangite obstrutiva com choque, confusão, lactato alto, disfunção orgânica ou falha, acionar CPRE/drenagem urgente.

ALERTA CRÍTICO**Sepse biliar: antibiótico na primeira hora**

Coletar hemoculturas se possível, mas não atrasar antibiótico e reanimação no choque.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Hemoculturas, lactato, função hepática, bilirrubinas, coagulograma e imagem de via biliar.
2	Antibiótico	Iniciar cobertura biliar conforme gravidade e risco MDR; ajustar por cultura.
3	Obstrução/gravidade	Acionar gastro/cirurgia para CPRE, drenagem percutânea ou alternativa disponível.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toda colangite suspeita deve ser observada/internada ▪ Icterícia/colestase ▪ Febre ▪ Dor em QSD ▪ Dilatação de via biliar
UTI	▪ Hipotensão ▪ Confusão ▪ Lactato elevado ▪ Insuficiência renal ▪ Plaquetopenia ▪ INR alterado ▪ Necessidade de vasopressor
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 24–48 h ▪ Piora hemodinâmica ▪ Febre persistente ▪ Bilirrubina em ascensão ▪ Obstrução não drenada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se não atrasar. Cultura de bile se drenagem/CPRE.
Controle de foco	Acionar gastro/cirurgia para CPRE, drenagem percutânea ou alternativa disponível.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Ajustar conforme hemocultura/bile ▪ Retirar vancomicina se sem indicação/cultura

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h infusão estendida	<40 mL/min: Ajustar conforme clearance	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em choque/infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar conforme clearance	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque se grave GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque	DRC/hemodiálise: Monitorar nível/área sob curva e ajustar	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

6.4

Apendicite Complicada / Peritonite Secundária

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Apendicite perforada, abscesso apendicular ou peritonite secundária exigem antibiótico com cobertura para G- entéricos e anaeróbios, mas o ponto decisivo é o controle cirúrgico/intervencional da fonte.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Metronidazol

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

4 dias após controle adequado; 5–7 dias se resposta lenta ou controle incompleto

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	
Anaeróbios	FREQUENTE	Bacteroides spp. e flora colônica
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Mais relevante em hospitalar, imunossupressão, falha ou cultura

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Apendicite perforada/abscesso ou peritonite comunitária	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	4 dias após controle adequado	Não prolongar apenas por leucocitose discreta se evolução clínica boa e fonte controlada.
Peritonite difusa, choque ou associada à assistência à saúde	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	4 dias após controle	Avaliar necessidade de meropenem se ESBL/MDR provável.
ESBL provável/confirmado ou falha clínica	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; 2 g EV 8/8 h se choque/infusão estendida · EV	4 dias após controle adequado	Descalonar conforme cultura.

Sobre a duração: Individualizar se controle incompleto.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Ciprofloxacino + Metronidazol · Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	4–7 dias conforme controle	Usar apenas se susceptibilidade/resistência local permitir.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Perfuração ▪ Peritonite ▪ Abscesso ▪ Foco colônico/apendicular	Metronidazol associado ou betalactâmico com anaerobi-cida

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ESBL	▪ ESBL prévia ▪ Internação recente ▪ Antibiótico recente ▪ Falha a cefalosporina	Meropenem ou ertapenem conforme gravidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Controle de fonte primeiro

Peritonite secundária não é tratada adequadamente com antibiótico isolado. Acionar cirurgia/intervenção.

ATENÇÃO

Duração curta após fonte controlada

Em boa evolução após controle adequado, cursos prolongados não trazem benefício e aumentam dano.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de complicação	Imagem conforme contexto, avaliação cirúrgica precoce, jejum e analgesia.
2	Sepse/peritonite	Hemoculturas se possível, antibiótico imediato e reanimação.
3	Pós-controle	Reavaliar diariamente duração, VO, cultura e sinais de abscesso residual.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Apendicite complicada ▪ Abscesso ▪ Peritonite ▪ Seps ▪ Dor progressiva ▪ Incapacidade de VO
UTI	▪ Choque ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica ▪ Peritonite difusa
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ Dor ou íleo persistente ▪ Leucitose em ascensão ▪ Abscesso residual ▪ Controle de fonte inadequado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se seps. Cultura de líquido peritoneal/material cirúrgico em grave, hospitalar, falha ou abscesso.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Descalonar por cultura e controle de fonte ▪ Suspender em 4 dias se fonte controlada e boa evolução

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Conferir bula/protocolo.	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em choque	<50 mL/min: Ajustar conforme clearance	

6.5

Abscesso Intra-abdominal após Controle de Foco

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Coleção purulenta intra-abdominal exige antibiótico e avaliação objetiva de drenagem. Em abscesso hepático piogênico, pesquisar origem biliar, portal, hematogênica ou foco abdominal oculto.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Metronidazol

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Intra-abdominal: 4–7 dias após drenagem adequada; hepático/piogênico: 2–6 semanas conforme drenagem e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	
Anaeróbios	FREQUENTE	
Streptococcus anginosus group	MODERADO	Abscessos hepáticos/intra-abdominais
Enterococcus spp.	CONTEXtual	Hospitalar, biliar, imunossuprimido, falha ou cultura

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Comunitário, estável, sem risco MDR	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h · VO/EV	4–7 dias após drenagem; hepático geralmente semanas	Drenagem/cultura quando houver coleção acessível, grande ou falha clínica.
Hospitalar, sepse, abscesso complexo ou risco Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	4–7 dias após fonte	Cobertura ampla até cultura.
ESBL/MDR provável ou choque	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; considerar 2 g EV 8/8 h em choque · EV	Conforme fonte e resposta	Descalonar conforme cultura do abscesso.

Sobre a duração: Prolongar se drenagem incompleta/hepático.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Metronidazol ± Vancomicina · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h ± Vancomicina · EV	Conforme drenagem e foco	Adicionar vancomicina se risco de Enterococcus/MRSA/cateter ou cultura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Foco intestinal ▪ Abscesso intra-abdominal ▪ Necrose ▪ Perfuração	Metronidazol ou esquema com anaerobicida
PSEUDOMONAS	▪ Hospitalar ▪ Antibiótico recente ▪ Sepses grave ▪ Colonização prévia	Piperacilina-tazobactam ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévia ▪ Internação recente ▪ Falha a cefalosporina ▪ Uso recente de quinolona/cefalosporina	Ertapenem se estável; meropenem se grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

NÃO APLICAR AO ABSCESSO HEPÁTICO SEM RECLASSIFICAR

Abscesso hepático piogênico tem investigação etiológica, drenagem e duração próprias. Este quadro se destina à coleção intra-abdominal com controle de foco definido.

ALERTA CRÍTICO

Antibiótico isolado raramente esteriliza abscesso grande

Coleção drenável precisa de drenagem percutânea/cirúrgica e cultura para encurtar terapia e evitar falha.

ATENÇÃO

Duração depende do controle de fonte

Abscesso intra-abdominal drenado pode ter curso curto; abscesso hepático ou drenagem incompleta costuma exigir semanas e seguimento por imagem.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Imagem com coleção	Avaliar tamanho, localização, loculação, foco de origem e possibilidade de drenagem.
2	Drenável ou grave	Coletar hemoculturas se sepse, iniciar antibiótico e acionar intervenção/cirurgia.
3	Material obtido	Enviar Gram/cultura aeróbios/anaeróbios; descalonar por resultado.
4	Sem melhora	Repetir imagem e procurar controle de fonte inadequado antes de apenas ampliar antibiótico.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Abscesso intra-abdominal/hepático ▪ Febre ▪ Dor importante ▪ Sepses ▪ Incapacidade de VO ▪ Necessidade de drenagem
UTI	▪ Choque ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica ▪ Abscesso multiloculado com sepse

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ Drenagem insuficiente ▪ Coleção residual ▪ Bacteremia persistente ▪ MDR em cultura

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se febre/sepse. Cultura do abscesso quando drenado, incluindo anaeróbios.
Controle de foco	▪ Avaliar tamanho, localização, loculação, foco de origem e possibilidade de drenagem. ▪ Coletar hemoculturas se sepse, iniciar antibiótico e acionar intervenção/cirurgia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por cultura do abscesso ▪ Reavaliar duração pela drenagem e imagem

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h		Conferir bula/protocolo.
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h infusão estendida		<40 mL/min: Ajustar conforme clearance
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h		<50 mL/min: Ajustar conforme clearance

6.6

Diarreia Infecciosa / Disenteria — Adulto

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

A maioria das gastroenterites agudas é viral/autolimitada e não requer antibiótico. A prioridade é hidratação e reconhecimento de gravidade. Antibiótico empírico fica reservado a disenteria febril selecionada, sepse, imunossupressão, diarreia do viajante grave ou suspeita de cólera; evitar se suspeita de STEC/EHEC.

CONDUTA DE PARTIDA

Reidratação e investigação; antibiótico apenas em cenários selecionados

1 g VO dose única OU 500 mg VO 24/24 h por 3 dias

VIA

VO

DURAÇÃO

Dose única a 3 dias conforme gravidade/contexto

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Víruses gastrointestinais	MUITO FREQUENTE	Não usar antibiótico
Campylobacter	CONTEXTUAL	Azitromicina costuma ser preferida
Shigella	CONTEXTUAL	Disenteria, surtos

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Salmonella não tifoide	CONTEXtual	Tratar se grave, bacteremia ou alto risco
STEC/EHEC	IMPORTANTE EXCLUIR	Evitar antibiótico e antimotilidade

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Diarreia aquosa leve/moderada sem sinais de invasão	Sem antibiótico · Conduta: reidratação oral/EV conforme gravidade e sintomáticos seguros · Conduta	Reavaliar se piora ou persistência	Antibiótico não reduz benefício na maioria e aumenta risco de eventos adversos/CDI.
Disenteria febril ou doença grave sem suspeita de STEC	Azitromicina · 1 g VO dose única OU 500 mg VO 24/24 h por 3 dias · VO	1–3 dias	Preferir em Campylobacter provável ou resistência a quinolona.
Diarreia do viajante grave se perfil permitir	Azitromicina ou Ciprofloxacino · Azitromicina 1 g VO dose única OU Ciprofloxacino 750 mg VO dose única · VO	Dose única; até 3 dias se persistente	Escolher por destino/resistência. Evitar quinolona quando risco alto de efeitos adversos.
Sepse, bacteremia suspeita ou imunossuprimido	Ceftriaxona · 2 g EV 24/24 h · EV	3–7 dias; ajustar por agente/cultura	Coletar hemoculturas e fezes antes se não atrasar.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de cólera ou desidratação profusa em contexto epidemiológico	Azitromicina · 1 g VO dose única · VO	Dose única	A prioridade absoluta é a reidratação agressiva.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

NÃO TRATAR SUSPEITA DE STEC COM ANTIBIÓTICO

Diarreia sanguinolenta afebril, dor abdominal intensa ou contexto compatível exige investigação para toxina Shiga. Evitar antibióticos e antimotilidade quando STEC for suspeita, pelo risco de síndrome hemolítico-urêmica.

ALERTA CRÍTICO

Evitar antibiótico se suspeita de STEC/EHEC

Diarreia sanguinolenta sem febre importante, carne malcozida/surto ou suspeita de toxina Shiga: antibiótico pode aumentar risco de SHU.

ATENÇÃO

Hidratação é o tratamento principal

Classificar desidratação, choque, distúrbios eletrolíticos e necessidade de reidratação EV.

ATENÇÃO

Antimotilidade com cautela

Evitar loperamida em disenteria, febre alta, colite grave ou suspeita de C. difficile/STEC.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Diarreia aguda	Classificar desidratação/choque, hidratar e procurar sinais de invasão ou exposição epidemiológica.
2	Grave/disenteria	Coletar fezes quando disponível; considerar antibiótico apenas nos cenários indicados.
3	Suspeita de STEC	Evitar antibiótico e antimotilidade; monitorar hemograma, plaquetas, creatinina e sinais de SHU.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Desidratação moderada/grave ▫ Idoso frágil ▫ Imunossupressão ▫ Sepses ▫ Dor abdominal importante ▫ Incapacidade de VO ▫ Distúrbio eletrolítico
UTI	▫ Choque ▫ Lactato elevado ▫ Disfunção orgânica
Falha terapêutica	▫ Persistência >72 h ▫ Piora sistêmica ▫ Sangue persistente ▫ Bacteremia ▫ Desidratação recorrente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Coprocultura/PCR se disenteria, febre alta, sepse, surto, imunossupressão, diarreia persistente ou decisão de antibiótico. Hemoculturas se sepse.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▫ Suspender se agente viral/STEC ou cultura sem indicação ▫ Direcionar por agente e susceptibilidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Azitromicina VO/EV	1 g VO dose única ou 500 mg/dia por 3 dias GRAVE 500 mg EV/VO 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	HEPÁTICO Evitar/cautela em hepatopatia grave
Ciprofloxacino VO/EV	750 mg VO dose única ou 500 mg VO 12/12 h por 3 dias GRAVE 400 mg EV 12/12 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	

6.7

Colite por Clostridioides difficile

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Diarreia por C. difficile toxigênico, geralmente após antibiótico ou exposição a serviço de saúde. Tratar apenas quadro clínico compatível; suspender antibiótico desencadeante quando possível, fazer isolamento de contato e iniciar terapia VO específica.

CONDUTA DE PARTIDA

Fidaxomicina ou Vancomicina VO

Fidaxomicina 200 mg VO 12/12 h OU Vancomicina 125 mg VO 6/6 h

VIA

VO

DURAÇÃO

10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Clostridioides difficile toxigênico	DEFINIDOR	Doença depende de toxinas e sintomas; colonização isolada não deve ser tratada

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Episódio inicial não fulminante	Fidaxomicina ou Vancomicina VO · Fidaxomicina 200 mg VO 12/12 h OU Vancomicina 125 mg VO 6/6 h · VO	10 dias	A diretriz prefere fidaxomicina à vancomicina no episódio inicial, por menor recorrência sustentada em 4 semanas; taxas de cura, mortalidade e eventos adversos são comparáveis. Vancomicina segue alternativa aceitável, sobretudo quando custo ou disponibilidade limitam a fidaxomicina — situação frequente no Brasil. Metronidazol não é mais primeira linha no episódio inicial não fulminante.
Fulminante: choque, íleo ou megacólon	Vancomicina VO/sonda + Metronidazol EV · Vancomicina 500 mg VO/sonda 6/6 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · VO/EV	10 dias ou conforme evolução	Se íleo, considerar vancomicina retal conforme protocolo local e cirurgia precoce.
Recorrência	Fidaxomicina ou Vancomicina em pulso/taper · Fidaxomicina 200 mg VO 12/12 h por 10 dias OU esquema taper/pulso de vancomicina · VO	10 dias ou taper prolongado	Considerar bezlotoxumabe/transplante de microbiota em recorrências conforme disponibilidade e risco.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem acesso a vancomicina/fidaxomicina e não grave	Metronidazol · 500 mg VO 8/8 h · VO	10 dias	Opção inferior; evitar em grave/fulminante quando houver vancomicina/fidaxomicina.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DOENÇA FULMINANTE É UM RAMO PRÓPRIO

Hipotensão/choque, íleo ou megacólon: vancomicina 500 mg VO/sonda 6/6 h + metronidazol EV; considerar vancomicina retal no íleo e avaliação cirúrgica precoce.

INFORMAÇÃO

RECORRÊNCIA: ALÉM DO ANTIBIÓTICO

Em paciente com episódio inicial e fatores de risco para recorrência — idade igual ou maior que 65 anos, imunossupressão por doença ou tratamento, e quadro grave à apresentação — a diretriz sugere bezlotoxumabe como coadjuvante ao antibiótico padrão. A recomendação é condicional e a implementação costuma esbarrar em disponibilidade e custo; verificar registro e acesso no Brasil. A FDA alerta que, em paciente com histórico de insuficiência cardíaca congestiva, o bezlotoxumabe deve ser reservado a situações em que o benefício supere o risco. Dados sobre seu uso associado a fidaxomicina são limitados. Em recorrências múltiplas, considerar transplante de microbiota fecal com encaminhamento a serviço especializado: as diretrizes de infectologia ainda não incorporaram os produtos industrializados de microbiota, e a orientação gastroenterológica é usá-los em indicação semelhante à do transplante convencional.

ALERTA CRÍTICO

Fulminante exige UTI e cirurgia precoce

Choque, íleo, megacólon, lactato alto ou peritonite: acionar UTI/cirurgia. Não esperar falha prolongada.

ATENÇÃO

Não tratar teste positivo sem diarreia clínica

Colonização ocorre. Testar e tratar apenas paciente sintomático com quadro compatível.

ATENÇÃO

Evitar antiperistálticos em grave

Loperamida e similares podem piorar íleo/megacólon em colite grave.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Isolamento de contato, suspender antibiótico desnecessário e testar apenas fezes diarreicas.
2	Não fulminante	Iniciar fidaxomicina se disponível ou vancomicina VO.
3	Fulminante	Vancomicina dose alta VO/sonda + metronidazol EV, UTI, cirurgia e considerar vancomicina retal se íleo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Leucocitose importante ▫ Creatinina elevada ▫ Idoso frágil ▫ Dor abdominal ▫ Febre ▫ Incapacidade de VO ▫ Recorrência grave
UTI	▫ Choque ▫ Íleo ▫ Megacólon ▫ Lactato elevado ▫ Peritonite
Falha terapêutica	▫ Piora em 48–72 h ▫ Íleo ▫ Aumento de leucocitose/lactato ▫ Instabilidade

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste toxina/PCR apenas em fezes diarreicas e quadro compatível. Não fazer teste de cura rotineiro.
Controle de foco	Vancomicina dose alta VO/sonda + metronidazol EV, UTI, cirurgia e considerar vancomicina retal se íleo.

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Suspende antibiótico desencadeante se possível ▪ Evitar antimicrobianos desnecessários durante/após CDI

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Fidaxomicina VO	200 mg VO 12/12 h por 10 dias GRAVE Não é esquema principal em fulminante	Conferir bula/protocolo.	
Vancomicina VO	125 mg VO 6/6 h por 10 dias GRAVE 500 mg VO/sonda 6/6 h se fulminante	Conferir bula/protocolo.	TETO 500 mg 6/6 h em fulminante Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h associado se fulminante	Conferir bula/protocolo.	

6.8

Abscesso Hepático Piogênico

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Coleção infecciosa hepática que exige investigação de origem biliar, portal, hematogênica ou procedimento, hemoculturas e avaliação de drenagem. Não aplicar automaticamente a duração curta de infecção intra-abdominal já controlada.

CONDUTA DE PARTIDA

Drenagem quando indicada + ceftriaxona e metronidazol; ampliar por assistência/resistência

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h; ajustar por cultura, foco biliar e epidemiologia

VIA

EV

DURAÇÃO

Em geral 2–6 semanas conforme drenagem, tamanho/ número de coleções, microbiologia e resposta clínica/ radiológica

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE; VARIA POR ORIGEM E REGIÃO	
Streptococcus anginosus e outros estreptococos	FREQUENTE	
Anaeróbios	RELEVANTES, SOBRETUDO EM FOCO PORTAL/ POLIMICROBIANO	

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Klebsiella pneumoniae hipervirulenta	CONSIDERAR EM SÍNDROME INVASIVA, DIABETES E EPIDEMIOLOGIA COMPATÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Comunitário, estável, sem risco MDR	Ceftriaxona + Metronidazol · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + metronidazol 500 mg EV/VO 8/8 h · EV	Inicial EV; total geralmente 2–6 semanas	Drenar coleção acessível/maior ou com resposta inadequada; colher material para cultura.
Choque, origem hospitalar/biliar instrumentada ou risco de Pseudomonas	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h, com ajuste renal e otimização de infusão conforme protocolo · EV	Definir após drenagem, cultura e resposta	Carbapenêmico somente se risco forte/confirmado de ESBL; anti-MRSA/enterococo não é automático.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia imediata grave a betalactâmico	Aztreonam + Metronidazol ± agente para Gram-positivo conforme risco · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Validar com infectologia; aztreonam não cobre anaeróbios nem Gram-positivos.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
DRENAGEM E CULTURA

Avaliar drenagem percutânea/cirúrgica desde o início. Antibiótico isolado é inadequado em coleção grande, multiloculada, com risco de ruptura ou sem resposta.

ATENÇÃO
PESQUISAR ORIGEM E FOCOS METASTÁTICOS

Investigar doença biliar, foco abdominal, bacteremia/endocardite e, em síndrome hipervirulenta por K. pneumoniae, sintomas oculares ou neurológicos.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Diagnóstico provável	Colher hemoculturas, obter imagem contrastada e acionar radiologia intervencionista/cirurgia.
2	Coleção drenável	Drenar e enviar material para Gram, cultura aeróbia/anaeróbia e outros testes conforme contexto.
3	Após microbiologia e resposta	Descalonar, decidir transição oral e duração total pelo controle do foco e evolução clínica/radiológica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Todo abscesso hepático piogênico provável/confirmado ▫ Necessidade de drenagem ▫ Bacteremia ou comorbidade relevante
UTI	▫ Choque ▫ Insuficiência respiratória ▫ Ruptura/peritonite ▫ Disfunção orgânica

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Febre/bacteremia persistente ▪ Coleção não drenada ▪ Dreno inadequado ▪ Patógeno resistente ▪ Origem biliar não controlada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e cultura do aspirado/dreno; evitar depender apenas de cultura do dreno antigo.
Controle de foco	▪ Colher hemoculturas, obter imagem contrastada e acionar radiologia intervencionista/cirurgia. ▪ Drenar e enviar material para Gram, cultura aeróbia/anaeróbia e outros testes conforme contexto. ▪ Descalonar, decidir transição oral e duração total pelo controle do foco e evolução clínica/radiológica.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por cultura e origem ▪ Retirar coberturas de MRSA/Pseudomonas/ESBL se não sustentadas ▪ Considerar via oral apenas com controle do foco e absorção confiável

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	Conferir bula/protocolo.	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Conferir bula/protocolo.	HEPÁTICO Reduzir/monitorar em hepatopatia grave.
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h com infusão otimizada	<40 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme bula e estratégia de infusão.	

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 06 — GASTROINTESTINAL

- SIS/IDSA. Intra-abdominal Infection — princípios de controle de fonte e duração (STOP-IT).
- IDSA/SHEA. Clostridioides difficile Focused Update, 2021.
- Tokyo Guidelines 2018: acute cholangitis and cholecystitis. doi:10.1002/jhbp.597.

07

SNC

7 quadros clínicos neste sistema

7.1	Meningite Bacteriana — Adulto	142
7.2	Encefalite Herpética — Adulto	146
7.3	Abscesso Cerebral	148
7.4	Meningite/Ventriculite Pós-neurocirurgia ou Shunt	150
7.5	Neurotoxoplasmose / Lesões Cerebrais em HIV Avançado	153
7.6	Meningite Tuberculosa	155
7.7	Empiema Subdural / Abscesso Epidural Craniano	157

7.1

Meningite Bacteriana — Adulto

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Emergência neurológica/infecciosa. Suspeita clínica exige hemoculturas imediatas e antibiótico empírico sem aguardar punção lombar quando houver atraso ou contraindicação. Dexametasona deve ser feita antes ou junto ao primeiro antibiótico quando pneumococo e possibilidade relevante.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Vancomicina; adicionar Ampicilina quando houver risco de Listeria

Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + vancomicina com dose de ataque/ manutenção individualizadas por peso, TFG e AUC; adicionar Ampicilina 2 g EV 4/4 h se >50 anos, imunossupressão, alcoolismo ou outro risco de Listeria

VIA

EV

DURAÇÃO

10–21 dias (conforme agente)

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL	Principal agente em adultos; resistência a penicilina pode ser até 30%
Neisseria meningitidis	FREQUENTE	Especialmente jovens; surtos epidêmicos
Listeria monocytogenes	CONTEXTUAL	Idosos >50a, imunossuprimidos, alcoolistas, gestantes
Haemophilus influenzae	MENOS COMUM	Raro em adultos vacinados
Streptococcus agalactiae (GBS)	MENOS COMUM	Diabéticos, idosos
Staphylococcus aureus	CONTEXTUAL	Pós-neurocirurgia, trauma de crânio

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Empírico (18–50 anos, sem imunossupressão)	Ceftriaxona + Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + vancomicina com dose de ataque/ manutenção individualizadas por peso, TFG e AUC/nível · EV	10–14 dias	Cobre pneumococo (incluindo cepas com resistência intermediária a penicilina) + meningococo.
>50 anos ou imunossuprimido ou alcoolista	Ceftriaxona + Vancomicina + Ampicilina · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + vancomicina individualizada por AUC/nível + Ampicilina 2 g EV 4/4 h · EV	14–21 dias (21 dias se Listeria)	Ampicilina cobre Listeria monocytogenes — obrigatória nestes grupos.
Pneumococo confirmado sensível — descalonamento	Penicilina G cristalina OU Ceftriaxona · Penicilina G 4 MU EV 4/4 h OU Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h, conforme sensibilidade · EV	10–14 dias	Se pneumococo confirmado sensível e boa resposta: descalonar para Penicilina G ou ceftriaxona conforme CIM/antibiograma; suspender vancomicina quando resistência for excluída.
Meningococo confirmado	Ceftriaxona OU Penicilina G · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h OU Pen G 4 MU EV 4/4 h · EV	7 dias	Meningococo: curso curto (7 dias). Profilaxia para contactantes obrigatória.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Pós-neurocirurgia ou trauma de crânio	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina individualizada por AUC/nível + Cefepime 2 g EV 8/8 h, com ajuste renal · EV	14–21 dias	Cobertura para <i>S. aureus</i> (incluindo MRSA) + GNB (incluindo <i>Pseudomonas</i>).
Listeria confirmada	Ampicilina + Gentamicina · Ampicilina 2 g EV 4/4 h + Genta 5 mg/kg EV 24/24 h · EV	21 dias ou mais	Ampicilina é o fármaco de escolha. Gentamicina pode ser considerada em casos graves se a função renal permitir; evitar/retirar se houver nefrotoxicidade ou fragilidade importante.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico (sem Listeria)	Vancomicina + Moxifloxacino · Vanco 25 mg/kg EV + Moxi 400 mg EV/VO 24/24 h · EV	10–14 dias	Moxifloxacino tem boa penetração no LCR.
Alergia grave + Listeria suspeita	Vancomicina + TMP-SMX + Moxifloxacino · Vanco 25 mg/kg EV + TMP-SMX EV (ajustado ao peso) + Moxi 400 mg EV · EV	21 dias	TMP-SMX cobre Listeria e é a alternativa à ampicilina.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	· Pós-neurocirurgia · Trauma de crânio aberto	Vancomicina EV com dose de ataque/manutenção individualizadas e monitorização AUC/nível conforme protocolo

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

MENINGOCOCO: GOTÍCULAS, NOTIFICAÇÃO E CONTATOS

Manter precaução por gotículas até 24 h de terapia ativa. Notificar e organizar quimioprofilaxia dos contatos elegíveis o mais cedo possível.

ATENÇÃO

ANAFILAXIA A BETA-LACTÂMICO EXIGE ESQUEMA ESPECIALIZADO

Vancomicina + fluoroquinolona não é substituição universal. Idade, imunossupressão e risco de Listeria precisam de cobertura explícita e discussão imediata com infectologia.

ALERTA CRÍTICO

DEXAMETASONA TEM JANELA PRÓPRIA

Administrar antes ou junto da primeira dose do antimicrobiano, sem atrasá-lo. Após microbiologia/LCR, manter apenas quando o diagnóstico e o patógeno sustentarem benefício pelo protocolo adotado; documentar a decisão.

ALERTA CRÍTICO

INICIAR EM ATÉ 1 HORA!

Atraso no antibiótico aumenta mortalidade. Coletar 2 pares de hemoculturas E iniciar antibiótico + dexametasona IMEDIATAMENTE. Não esperar punção lombar para iniciar tratamento.

ALERTA CRÍTICO

DEXAMETASONA: ANTES OU COM O 1º ANTIBIÓTICO

Dexametasona 10 mg EV 6/6 h por 4 dias. Fazer antes ou junto ao primeiro antibiótico quando pneumococo e possibilidade relevante. Reavaliar manutenção quando agente/diagnóstico forem definidos.

ALERTA CRÍTICO

AMPICILINA: COBRIR LISTERIA SE >50a, IMUNOSSUPRIMIDO, ALCOOLISTA OU GESTANTE

Listeria monocytogenes deve ser coberta com ampicilina nestes grupos. Em alergia grave, discutir TMP-SMX/alternativa com infectologia.

ATENÇÃO**VANCOMICINA: AUC/NÍVEL E FUNÇÃO RENAL**

Individualizar dose de ataque e manutenção pelo peso, gravidade e função renal. Para infecção grave por MRSA, preferir monitorização por AUC quando disponível; não usar alvo de vale isolado como regra universal.

INFORMAÇÃO**PUNÇÃO LOMBAR: NÃO ATRASAR ANTIBIÓTICO**

Se PL atrasar ou houver necessidade de TC antes, iniciar antibiótico e dexametasona após hemoculturas. O antibiótico reduz rendimento da cultura do LCR, mas não deve ser atrasado.

ALERTA CRÍTICO**PROFILAXIA PARA CONTACTANTES DE MENINGOCOCO**

Se meningococo confirmado ou altamente suspeito: profilaxia com Ciprofloxacino 500 mg VO dose única OU Rifampicina 600 mg VO 12/12 h por 2 dias OU Ceftriaxona 250 mg IM dose única.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	SUSPEITA DE MENINGITE BACTERIANA	Hemoculturas (2 pares) + iniciar em até 1 h:
2	Suspeita relevante de meningite bacteriana/ pneumocócica	Dexametasona 10 mg EV AGORA, idealmente antes ou junto do 1º antibiótico.
3	Adulto 18–50a, imunocompetente	Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + vancomicina individualizada por peso, TFG e AUC/nível.
4	>50a OU imunossuprimido OU alcoolista	Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + vancomicina individualizada + Ampicilina 2 g EV 4/4 h para cobertura de Listeria.
5	Pós-neurocirurgia	Vancomicina individualizada + Cefepime 2 g EV 8/8 h com ajuste renal; envolver neurocirurgia/infec-tologia.
6	Punção lombar	Fazer se possível em <30min. Se não, iniciar abx primeiro e fazer depois.
7	Se pneumococo confirmado sensível	Suspender vancomicina e descalonar para penicilina G ou ceftriaxona conforme CIM/antibiograma.
8	Se meningococo confirmado	7 dias de ceftriaxona + PROFILAXIA para contactantes
9	Se Listeria confirmada	Ampicilina 2 g EV 4/4 h por pelo menos 21 dias; considerar gentamicina inicial apenas se benefício superar nefrotoxicidade.
10	Dexametasona	10 mg EV 6/6 h por 4 dias quando pneumococo for provável/confirmado; reavaliar quando agente definido.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Glasgow < 12 ▪ Choque séptico ▪ Convulsões ▪ Sinais de aumento da PIC refratários ▪ Coma
Falha terapêutica	▪ Sem melhora clínica em 48–72 h ▪ Persistência de febre >5 dias ▪ Agravamento do nível de consciência ▪ Crescimento de patógeno resistente ▪ Complicações (edema cerebral, hidrocefalia, abscesso)

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	2 pares de hemoculturas antes do 1º antibiótico se isso não atrasar o início; LCR para celularidade, bioquímica, Gram, cultura, antígenos (pneumococo e meningococo) e PCR multiplex se disponível. Se PL/TC atrasar, iniciar tratamento após hemoculturas ou imediatamente se instável.
Controle de foco	▪ Pesquisar e tratar foco parameningeo: otite/mastoidite, sinusite, abscesso cerebral, empiema subdural, endocardite e dispositivo neurocirúrgico ▪ Acionar ORL/neurocirurgia quando houver foco abordável
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Se pneumococo com CIM de penicilina $\leq 0,06 \mu\text{g/mL}$ (ponto de corte meníngeo do CLSI): pode substituir Ceftriaxona por Penicilina G ▪ Se meningococo confirmado: 7 dias total, sem necessidade de cobertura adicional ▪ Se Listeria: Ampicilina por 21 dias (não trocar) ▪ Se patógeno sensível identificado: simplificar conforme antibiograma
Transição EV → VO	Não se aplica: meningite bacteriana é tratada por via endovenosa durante todo o curso. A alta só ocorre após completar o esquema EV conforme o agente.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV Gestação: uso aceito	2 g EV 12/12 h GRAVE 2 g EV 12/12 h	Insuficiência renal isolada: Em geral, não requer ajuste da ceftriaxona; não reduzir dose meníngeo automaticamente.; Hepatopatia associada a doença renal importante: Exige cautela e validação especializada/bula; a restrição de dose da bula pode conflitar com necessidade meníngeo.	TETO 4 g/dia
Ampicilina EV Gestação: uso aceito	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	>50 mL/min: Dose padrão; 10–50 mL/min: 2 g 6/6 h; <10 mL/min: 2 g 8/8 h	
Vancomicina EV Gestação: uso aceito	Dose de ataque/manutenção individualizadas por peso real, TFG e AUC/nível GRAVE Em infecção grave, definir dose de ataque e alvo farmacocinético por protocolo/ AUC	Qualquer função renal: Definir intervalo/manutenção por TFG em tendência e AUC/nível; não usar tabela fixa sem protocolo.	Monitorar concentração/exposição conforme protocolo de meningite, função renal e penetração no LCR; não transportar automaticamente um alvo de AUC de MRSA invasivo para todo caso.
Cefepime EV Gestação: uso aceito	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60 mL/min: 2 g 8/8 h; 30–60 mL/min: 2 g 12/12 h; 11–29 mL/min: 2 g 24/24 h; ≤10 mL/min: 1 g 24/24 h (esquema de infecção grave, 2 g 8/8 h)	
Dexametasona EV	10 mg EV 6/6 h por 4 dias GRAVE 10 mg EV 6/6 h por 4 dias	Geral: Não requer ajuste renal	Usar se necessário (benefício > risco)

REFERÊNCIA DO QUADRO

WHO. Guidelines on Meningitis Diagnosis, Treatment and Care, 2025.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240108042>

7.2

Encefalite Herpética — Adulto

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Síndrome encefalítica aguda com febre, alteração do nível de consciência, convulsões, déficit focal ou alteração comportamental. HSV-1 é a etiologia tratável mais importante: aciclovir EV deve ser iniciado empiricamente sem aguardar PCR do LCR, com hidratação e ajuste renal.

CONDUTA DE PARTIDA

Aciclovir

10 mg/kg EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

14–21 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Herpes simplex vírus 1	PRINCIPAL TRATÁVEL	Necrose temporal; risco de sequelas se atraso no aciclovir
Herpes simplex vírus 2	MENOS COMUM	Mais associado a meningite/meningoencefalite
Varicella-zoster vírus	CONTEXTUAL	Considerar em imunossuprimidos, vasculopatia, rash ou zoster recente
Enterovirus/arbovirus	DIFERENCIAL	Tratamento geralmente suporte; investigar conforme contexto epidemiológico

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de encefalite viral/HSV	Aciclovir · 10 mg/kg EV 8/8 h, ajustar por função renal · EV	14–21 dias	Iniciar imediatamente se suspeita clínica. Hidratar, evitar nefrotóxicos e ajustar por clearance de creatinina. Validar peso de dose na obesidade, infusão, hidratação e ajuste renal.
Imunossuprimido ou dúvida entre encefalite e meningite bacteriana	Aciclovir + Ceftriaxona + Vancomicina + Ampicilina · Aciclovir 10 mg/kg EV 8/8 h + Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Vanco EV + Ampicilina 2 g EV 4/4 h · EV	Ajustar conforme LCR/PCR/culturas	Cobertura simultânea para HSV, pneumococo, meningococo e Listeria até esclarecimento. Validar peso de dose na obesidade, infusão, hidratação e ajuste renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
HSV resistente ao aciclovir ou falha comprovada	Foscarnet · 40 mg/kg EV 8/8 h OU 60 mg/kg EV 12/12 h · EV	Individualizar com infec-tologia	Reservar para resistência/falha; alto risco renal e distúrbios eletrolíticos.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ACICLOVIR: PESO, RIM E CRISTALÚRIA

Em obesidade, definir o peso de dose pelo protocolo/farmácia; infundir adequadamente, garantir hidratação, ajustar à função renal e acompanhar creatinina. PCR de HSV muito precoce pode ser falso-negativa: se a suspeita permanecer alta, manter tratamento e repetir LCR/PCR em 3–7 dias.

ALERTA CRÍTICO

NÃO AGUARDAR PCR PARA INICIAR ACICLOVIR

Se encefalite e plausível, aciclovir EV deve ser iniciado imediatamente após coleta possível de exames.

ATENÇÃO

RISCO RENAL DO ACICLOVIR

Garantir hidratação, evitar nefrotóxicos e ajustar dose por clearance de creatinina.

INFORMAÇÃO

RM E LCR AJUDAM, MAS NÃO DEVEM ATRASAR TRATAMENTO

RM temporal e PCR HSV no LCR são exames-chave; PCR pode ser falso-negativa muito precoce, devendo ser repetida se alta suspeita.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica de encefalite	Coletar hemograma, função renal/hepática, eletrólitos, hemoculturas se febre e iniciar aciclovir EV.
2	Sem contraindicação	Realizar punção lombar com PCR HSV/VZV/enterovírus, celularidade, proteína, glicose, Gram/cultura.
3	Déficit focal/rebaixamento/papiledema/ imunossupressão	TC/RM antes da PL, mas sem atrasar aciclovir.
4	Dúvida com meningite bacteriana	Associar ceftriaxona + vancomicina; adicionar ampicilina se >50a/imunossuprimido/alcoolista.
5	PCR HSV negativo precoce com alta suspeita	Manter aciclovir e repetir PCR em 3–7 dias.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toda suspeita de encefalite ▪ Alteração de consciência ▪ Convulsão ▪ Déficit focal ▪ Imunossupressão
UTI	▪ Rebaixamento importante ▪ Convulsões recorrentes ▪ Instabilidade hemodinâmica ▪ Necessidade de via aérea
Falha terapêutica	▪ Piora neurológica apesar de aciclovir ▪ PCR HSV positivo persistente ▪ Suspeita de resistência ▪ Diagnóstico alternativo não investigado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	LCR com PCR HSV/VZV/enterovírus, celularidade, proteína, glicose, Gram/cultura; hemoculturas se febre ou dúvida bacteriana.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Aciclovir EV	10 mg/kg EV 8/8 h GRAVE 10 mg/kg EV 8/8 h	>50 mL/min: 10 mg/kg 8/8 h; 25–50 mL/min: 10 mg/kg 12/12 h; 10–25 mL/min: 10 mg/kg 24/24 h; <10 mL/min: 5 mg/kg 24/24 h	Usar se indicado

REFERÊNCIA DO QUADRO

WHO. Guidelines on Meningitis Diagnosis, Treatment and Care, 2025.

7.3

Abscesso Cerebral

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Coleção purulenta intracraniana, geralmente por disseminação contígua de sinusite/otite/mastoide, foco odontogênico, bacteremia ou pós-neurocirurgia. Exige neuroimagem com contraste, antibiótico EV prolongado e avaliação neurocirúrgica precoce; punção lombar não é rotina.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Metronidazol; adicionar Vancomicina se risco de *S. aureus*/MRSA

Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h; Vancomicina EV se trauma/neurocirurgia/bacteremia/risco MRSA

VIA

EV

DURAÇÃO

6–8 semanas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
<i>Streptococcus anginosus</i> group	FREQUENTE	Clássico de foco oral/sinusite; tendência a abscesso
Anaeróbios orais	FREQUENTE	Foco odontogênico, sinusite, otite, aspiração
<i>Staphylococcus aureus</i>	CONTEXTUAL	Trauma, bacteremia, pós-neurocirurgia
Enterobacterales	CONTEXTUAL	Otogênico, nosocomial, imunossupressão
<i>Nocardia</i> spp.	RARO	Imunossuprimidos; pensar se lesões pulmonares concomitantes

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Foco sinusal/otogênico/odontogênico ou comunitário	Ceftriaxona + Metronidazol ± Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h; adicionar Vancomicina EV se risco de <i>S. aureus</i> /MRSA · EV	6–8 semanas	Cobre estreptococos e anaeróbios. Adicionar vancomicina se <i>S. aureus</i> /MRSA for plausível. Ajustar após cultura/drenagem.
Pós-neurocirurgia, trauma penetrante ou hospitalar	Vancomicina + Cefepime + Metronidazol · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	6–8 semanas	Amplia para MRSA e <i>Pseudomonas</i> . Considerar meropenem se ESBL/anaeróbios complexos.
Suspeita de <i>Nocardia</i> /imunossuprimido com lesão pulmonar	TMP-SMX + Meropenem · TMP-SMX EV em dose alta + Meropenem 2 g EV 8/8 h · EV	6–12 meses se nocardiose confirmada	Solicitar cultura específica e avaliação infectologia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Metronidazol + Ciprofloxacino · Vancomicina EV + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h + Ciprofloxacino 400 mg EV a cada 8–12 h · EV	6–8 semanas	Alternativa imperfeita; discutir com infectologia/neurocirurgia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Foco odontogênico ▪ Sinusite ▪ Otite/mastoidite ▪ Abscesso multiloculado	Metronidazol
MRSA	▪ Pós-neurocirurgia ▪ Trauma penetrante ▪ Bacteremia por <i>S. aureus</i> ▪ Colonização MRSA	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ Pós-neurocirurgia ▪ Hospitalar ▪ Derivação ventricular ▪ Antibiótico recente	Cefepime ou Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ANTIBIÓTICO NÃO SUBSTITUI CONTROLE DE FOCO

neurocirurgia, drenagem quando indicada e cultura do material fazem parte do primeiro bloco de conduta.

ALERTA CRÍTICO

AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA PRECOCE

Abscessos grandes, efeito de massa, deterioração neurológica, fossa posterior ou necessidade microbiológica exigem avaliação para aspiração/drenagem.

ATENÇÃO

NÃO FAZER PUNÇÃO LOMBAR DE ROTINA

Risco de herniação se efeito de massa. Priorizar neuroimagem.

INFORMAÇÃO

DURAÇÃO PROLONGADA

Tratamento geralmente 6–8 semanas EV, guiado por resposta clínica, imagem seriada e controle de foco.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de coleção intracraniana	Acionar neurocirurgia imediatamente; obter neuroimagem com contraste, avaliar drenagem/aspiração e enviar material profundo para cultura.
2	Origem provável	Diferenciar odontogênica/otogênica/sinusal, hematogênica/endocardite e pós-operatória/trauma para definir cobertura.
3	Após amostra ou instabilidade	Iniciar antimicrobianos sem atraso indevido e revisar com microbiologia e controle de foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Todo abscesso cerebral ▪ Necessidade de antibiótico EV ▪ Investigação de foco primário
UTI	▪ Efeito de massa ▪ Rebaixamento ▪ Convulsões ▪ Lesão de fossa posterior ▪ Instabilidade clínica

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	Aumento da coleção Nova lesão Piora neurológica Febre persistente Cultura com patógeno não coberto

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas; cultura e Gram do material drenado/aspirado; investigar foco sinusal, otológico, odontogênico e endocardite conforme contexto.
Controle de foco	Acionar neurocirurgia imediatamente; obter neuroimagem com contraste, avaliar drenagem/aspiração e enviar material profundo para cultura. Iniciar antimicrobianos sem atraso indevido e revisar com microbiologia e controle de foco.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Metronidazol EV	500 mg EV 8/8 h GRAVE 500 mg EV a cada 6–8 h	Geral: Geralmente sem ajuste renal	
Gestão: uso aceito			
Ceftriaxona EV	2 g EV 12/12 h GRAVE 2 g EV 12/12 h	>10 mL/min: Dose padrão; <10 mL/min: Individualizar	TETO 4 g/dia

7.4

Meningite/Ventriculite Pós-neurocirurgia ou Shunt

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção associada a neurocirurgia, derivação ventricular, DVE, shunt ou trauma craniano aberto. A cobertura empírica deve incluir estafilococos resistentes e bacilos Gram-negativos, incluindo Pseudomonas.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Cefepime

Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

10–21 dias conforme agente e controle do dispositivo

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus epidermidis/coagulase-negativos	FREQUENTE	Associado a shunt/DVE; biofilme
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	Inclui MRSA; pós-operatório e ferida cirúrgica
Cutibacterium acnes	CONTEXTUAL	Curso indolente em shunts
Pseudomonas aeruginosa	IMPORTANTE	Hospitalar, DVE, antibiótico prévio

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	IMPORTANTE	Klebsiella, Enterobacter, E. coli

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Empírico pós-neurocirurgia /DVE/ shunt	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina EV ajustada por níveis + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	10–21 dias	Esquema empírico padrão: MRSA/coagulase-negativos + Pseudomonas/GNB.
Risco de ESBL, Enterobacter resistente ou falha com cefepime	Vancomicina + Meropenem · Vancomicina EV + Meropenem 2 g EV 8/8 h · EV	10–21 dias	Considerar infusão prolongada e ajuste renal.
Infecção persistente ou patógeno multirresistente com DVE	Terapia intraventricular associada ao EV · Vancomicina/aminoglicosídeo/colistina intraventricular conforme patógeno e protocolo local · EV	Individualizar	Somente com neurocirurgia/infectologia; não é prescrição automática.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MRSA/CoNS resistente ou intolerância a vancomicina	Linezolida + Cefepime/Meropenem · Linezolida 600 mg EV/VO 12/12 h + Cefepime 2 g EV 8/8 h ou Meropenem 2 g EV 8/8 h · EV	Conforme cultura	Boa penetração no LCR; monitorar plaquetas e interações serotoninérgicas.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Toda meningite pós-neurocirurgia até cultura ▪ Shunt/DVE ▪ Ferida operatória	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ DVE ▪ hospitalar ▪ antibiótico prévio ▪ UTI	Cefepime ou Meropenem
ESBL	▪ Colonização ESBL ▪ internação recente ▪ uso de cefalosporina/carbapenem prévio	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DISPOSITIVO É PARTE DO FOCO

Avaliar retirada/externalização do shunt ou dreno infectado. A duração depende do patógeno, do dispositivo e do clareamento; quando aplicável, contar a partir de culturas de LCR negativas, não apenas do primeiro dia de antibiótico.

ALERTA CRÍTICO

CONTROLE DO DISPOSITIVO É ESSENCIAL

A remoção ou troca de shunt ou DVE infectada é frequentemente necessária; antibiótico isolado pode falhar por biofilme.

ATENÇÃO

COLETAR LCR DO SISTEMA QUANDO POSSÍVEL

Cultura do LCR e do dispositivo orientam descalonamento e duração.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita pós-neurocirurgia/shunt	Hemoculturas + LCR do dispositivo/PL se seguro + iniciar vancomicina + cefepime.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Risco ESBL ou falha	Usar meropenem no lugar de cefepime.
3	Shunt/DVE infectado	Acionar neurocirurgia para remoção/troca/externalização conforme caso.
4	Cultura disponível	Descalonar conforme agente e sensibilidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de ventriculite/meningite associada a shunt/DVE ou pós-neurocirurgia ▪ Presença de DVE/shunt ▪ Febre pós-neurocirurgia com alteração neurológica
UTI	▪ Rebaixamento ▪ Seps ▪ Hidrocefalia ▪ Dispositivo ventricular externo ▪ Convulsões
Falha terapêutica	▪ Cultura persistentemente positiva ▪ Febre persistente ▪ Piora neurológica ▪ Dispositivo não removido/trocado ▪ GNB resistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	LCR do dispositivo/PL se seguro, Gram/cultura, celularidade, glicose/proteína; hemoculturas; cultura de ponta/dispositivo quando removido.
Controle de foco	▪ Hemoculturas + LCR do dispositivo/PL se seguro + iniciar vancomicina + cefepime. ▪ Acionar neurocirurgia para remoção/troca/externalização conforme caso.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60 mL/min: 2 g 8/8 h; 30–60 mL/min: 2 g 12/12 h; <30 mL/min: Ajustar; risco de neurotoxicidade	
Meropenem EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, considerar infusão prolongada	>50 mL/min: 2 g 8/8 h; 26–50 mL/min: 2 g 12/12 h; 10–25 mL/min: 1 g 12/12 h	

7.5

Neurotoxoplasmose / Lesões Cerebrais em HIV Avançado

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Causa importante de lesão expansiva cerebral em HIV avançado, especialmente CD4 <100 e IgG para toxoplasma positiva. Quadro com cefaleia, febre, confusão, déficit focal ou convulsões. O diagnóstico costuma ser clínico-radiológico e terapêutico, exigindo reavaliação se não houver resposta.

CONDUTA DE PARTIDA

Sulfadiazina + Pirimetamina + Ácido folínico

Pirimetamina carga 200 mg, depois 50–75 mg/dia + Sulfadiazina 1–1,5 g VO 6/6 h + Ácido folínico 10–25 mg/dia

VIA

VO

DURAÇÃO

Indução por pelo menos 6 semanas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Toxoplasma gondii	PRINCIPAL	Reativação em HIV avançado; geralmente CD4 <100
Linfoma primário de SNC	DIFERENCIAL	Pensar se lesão única, EBV LCR positivo ou ausência de resposta
Tuberculoma/fungo	DIFERENCIAL	Conforme epidemiologia e imunossupressão

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Esquema preferencial	Pirimetamina + Sulfadiazina + Ácido folínico · Pirimetamina 200 mg carga, depois 50–75 mg VO/dia + Sulfadiazina 1–1,5 g VO 6/6 h + Ácido folínico 10–25 mg VO/dia · VO	≥6 semanas, depois manutenção	Monitorar citopenias; ácido folínico é obrigatório.
Intolerância a sulfadiazina	Pirimetamina + Clindamicina + Ácido folínico · Pirimetamina conforme peso + Clindamicina 600 mg EV/VO 6/6 h + Ácido folínico 10–25 mg/dia · VO/EV	≥6 semanas	Não protege contra pneumocistose; planejar profilaxia separada.
Manutenção (profilaxia secundária) após a indução	Pirimetamina + Sulfadiazina + Ácido folínico · Pirimetamina 25–50 mg VO/dia + Sulfadiazina 2–4 g VO/dia divididos em 2–4 tomadas + Ácido folínico 10–25 mg VO/dia · VO	Até CD4 > 200 células/mm³ por mais de 6 meses em terapia antirretroviral, com melhora clínica e radiológica	Manter a profilaxia secundária enquanto persistir a imunossupressão. A alternativa com clindamicina não protege contra pneumocistose: manter profilaxia específica.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem acesso a pirimetamina ou necessidade de esquema simples	TMP-SMX · TMP-SMX EV/VO em dose alta, baseado em TMP 5 mg/kg 12/12 h · VO/EV	≥6 semanas	Alternativa prática; ajustar renal e monitorar hipercalemia/citopenia.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

AVALIAR EFEITO DE MASSA ANTES DE PL

Lesão expansiva com edema aumenta risco de herniação. Neuroimagem primeiro.

ATENÇÃO**SEM MELHORA EM 10–14 DIAS = REVER DIAGNÓSTICO**

Considerar linfoma primário de SNC, tuberculoma, fungos, abscesso bacteriano ou biópsia/abordagem diagnóstica.

INFORMAÇÃO**ÁCIDO FOLÍNICO JUNTO DA PIRIMETAMINA**

Usar para reduzir toxicidade hematológica da pirimetamina.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	HIV avançado + lesão cerebral	Solicitar RM/TC com contraste, CD4, carga viral, IgG toxoplasma e avaliar efeito de massa.
2	Alta probabilidade de toxoplasmose	Iniciar pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico.
3	Alergia/intolerância a sulfa	Usar pirimetamina + clindamicina + ácido folínico.
4	Sem resposta 10–14 dias	Rever diagnóstico, discutir biópsia e ampliar investigação.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Déficit focal ▪ Convulsão ▪ Rebaixamento ▪ Lesão expansiva com edema ▪ Início de indução
UTI	▪ Efeito de massa importante ▪ Hipertensão intracraniana ▪ Convulsões de difícil controle ▪ Via aérea/choque
Falha terapêutica	▪ Sem melhora clínica em 7 dias ▪ Sem melhora radiológica em 10–14 dias ▪ Nova lesão ▪ Sorologia/PCR sugere outro diagnóstico

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não há cultura padrão; solicitar sorologia IgG toxoplasma, CD4/carga viral, neuroimagem; PCR LCR apenas se seguro e útil ao diferencial.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sulfadiazina vo	1–1,5 g VO 6/6 h GRAVE 1,5 g VO 6/6 h se >60kg	<50 mL/min: Ajustar intervalo; monitorar cristalúria/citopenias	
Pirimetamina vo	Dose de ataque 200 mg, depois 50–75 mg VO/dia GRAVE 75 mg VO/dia se >60kg	Geral: Sem ajuste padrão; monitorar hemograma	
Ácido folínico vo	10–25 mg VO/dia GRAVE 10–25 mg VO/dia	Geral: Sem ajuste renal	

7.6

Meningite Tuberculosa

CRÍTICA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Forma grave de tuberculose extrapulmonar. Apresentação subaguda com cefaleia, febre, confusão, pares cranianos, hidrocefalia, vasculite/AVC ou hiponatremia. Tratamento deve ser iniciado empiricamente quando a suspeita é alta.

CONDUTA DE PARTIDA

RIPE + Corticoide

Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol em doses por peso + Dexametasona/Prednisona

VIA

VO

DURAÇÃO

12 meses (2 RHZE + 10 RH) — esquema meningoencefálico do Ministério da Saúde

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Mycobacterium tuberculosis	PRINCIPAL	Pesquisar TB pulmonar, HIV e contatos

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita alta ou confirmada	RHZE + corticoide · Fase intensiva: 2 meses de rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol em comprimido combinado por faixa de peso (MS). Manutenção: 10 meses de rifampicina + isoniazida. Associar piridoxina 50 mg/dia com a isoniazida · VO	12 meses no total (2 RHZE + 10 RH), conforme o Ministério da Saúde para a forma meningoencefálica	Não aguardar cultura se suspeita clínica/LCR/imagem for alta. Coletar material antes quando possível, mas sem atrasar início.
Rebaixamento, hidrocefalia, AVC ou hipertensão intracraniana	RHZE + Dexametasona · RHZE por faixa de peso + dexametasona EV/VO nas primeiras 4–8 semanas, com desmame gradual conforme resposta neurológica · VO/EV	12 meses no total (2 RHZE + 10 RH)	Acionar neurologia/neurocirurgia se hidrocefalia; investigar resistência.

Sobre a duração: Corticoide por 4–8 semanas com desmame.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de TB resistente ou intolerância grave	Esquema individualizado para TB resistente · Definir com infectologia/pneumologia e referência em TB · VO/EV	Individualizar	Não improvisar substituições; alto risco de falha e resistência.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

TRATAR SE SUSPEITA ALTA

Atraso terapêutico aumenta mortalidade e sequelas. Cultura pode demorar.

ATENÇÃO

CORTICOIDE ADJUVANTE

Indicado na meningite tuberculosa para reduzir mortalidade/sequelas, salvo contraindicação clara.

ATENÇÃO**MONITORAR HEPATOTOXICIDADE**

RIPE exige controle de TGO/TGP, bilirrubinas, interações e adesão.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita subaguda	LCR com celularidade/proteína/glicose, BAAR, cultura para micobactéria, teste molecular se disponível.
2	Suspeita alta	Iniciar RIPE + corticoide, sem aguardar cultura.
3	Investigar extensão	RX/TC tórax, HIV, rastreio de contatos, função hepática basal.
4	Hidrocefalia/déficit progressivo	Neuroimagem e neurocirurgia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toda suspeita de meningite tuberculosa ▪ Necessidade de investigação e início supervisionado
UTI	▪ Rebaixamento ▪ Hidrocefalia ▪ Convulsões ▪ Instabilidade ▪ Hiponatremia grave
Falha terapêutica	▪ Piora neurológica ▪ Hidrocefalia progressiva ▪ Cultura/resistência ▪ Hepatotoxicidade impedindo esquema ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	LCR para BAAR, cultura de micobactéria e teste molecular; pesquisa de TB pulmonar; hemoculturas para micobactéria se HIV avançado conforme disponibilidade.
Controle de foco	Neuroimagem e neurocirurgia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Rifampicina/Isoniazida/ Pirazinamida/Etambutol vo	Doses por peso conforme protocolo nacional/local de TB GRAVE Doses por peso; não reduzir sem critério	DRC: Etambutol e pirazinamida requerem ajuste; consultar protocolo	HEPÁTICO Risco hepatotoxicidade; monitorar e individualizar se hepatopatia

7.7

Empiema Subdural / Abscesso Epidural Craniano

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Coleções purulentas extra-axiais, frequentemente associadas a sinusite, otite/mastoidite, trauma ou neurocirurgia. Emergência neurocirúrgica pelo risco de trombose venosa, convulsões e deterioração rápida.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Metronidazol; adicionar Vancomicina se risco de S. aureus/MRSA

Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h; Vancomicina EV se trauma/neurocirurgia/bacteremia/risco MRSA

VIA

EV

DURAÇÃO

4–8 semanas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus anginosus group	FREQUENTE	Sinusite/odontogênico
Anaeróbios	FREQUENTE	Sinusite, otite, foco oral
Staphylococcus aureus	IMPORTANTE	Trauma/neurocirurgia
Gram-negativos	CONTEXTUAL	Otite, hospitalar, imunossupressão

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Comunitário por sinusite/otite/odontogênico	Ceftriaxona + Metronidazol + Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h + Vancomicina EV · EV	4–8 semanas	Associar drenagem neurocirúrgica/ORL quando indicado.
Pós-neurocirurgia/hospitalar	Vancomicina + Cefepime + Metronidazol · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	4–8 semanas	Cobrir MRSA e Pseudomonas até cultura.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Metronidazol + Ciprofloxacino · Vancomicina EV + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h + Ciprofloxacino 400 mg EV a cada 8–12 h · EV	4–8 semanas	Discutir obrigatoriamente com infectologia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Sinusite ▪ Otite ▪ Foco odontogênico	Metronidazol
MRSA	▪ Trauma ▪ pós-neurocirurgia ▪ bacteremia por S. aureus	Vancomicina

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	- Hospitalar - pós-neurocirurgia - otite crônica complicada	Cefepime

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ANTIBIÓTICO NÃO SUBSTITUI CONTROLE DE FOCO

neurocirurgia, drenagem quando indicada e cultura do material fazem parte do primeiro bloco de conduta.

ALERTA CRÍTICO

EMERGÊNCIA NEUROCIRÚRGICA

Epiema subdural pode deteriorar rapidamente; acionar neurocirurgia de imediato e não tratar apenas com antibiótico quando houver coleção drenável.

ATENÇÃO

PROCURAR FOCO ORL/ODONTOLÓGICO

Sinusite, mastoidite e foco dentário precisam de controle de fonte.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de coleção intracraniana	Acionar neurocirurgia imediatamente; obter neuroimagem com contraste, avaliar drenagem/aspiração e enviar material profundo para cultura.
2	Origem provável	Diferenciar odontogênica/otogênica/sinusal, hematogênica/endocardite e pós-operatória/trauma para definir cobertura.
3	Após amostra ou instabilidade	Iniciar antimicrobianos sem atraso indevido e revisar com microbiologia e controle de foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	- Abscesso cerebral suspeito/confirmado - Necessidade de neuroimagem e antibiótico EV
UTI	- Rebaixamento - Convulsões - Efeito de massa - Déficit focal - Trombose venosa associada
Falha terapêutica	- Aumento da coleção - Febre persistente - Nova convulsão - Piora focal - Foco primário não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e cultura do material drenado; cultura de foco sinusal/otológico quando abordado.
Controle de foco	- Acionar neurocirurgia imediatamente; obter neuroimagem com contraste, avaliar drenagem/aspiração e enviar material profundo para cultura. - Iniciar antimicrobianos sem atraso indevido e revisar com microbiologia e controle de foco.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona + Metronidazol + Vancomicina EV	Ceftriaxona 2 g 12/12 h + Metronidazol 500 mg 8/8 h + Vancomicina por níveis GRAVE Mesma dose; otimizar vancomicina por AUC/níveis	DRC: Ajustar vancomicina; ceftriaxona geralmente sem ajuste importante	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 07 — SNC

- WHO. Guidelines on Meningitis Diagnosis, Treatment and Care, 2025.
- IDSA. Healthcare-associated Ventriculitis and Meningitis, 2017.

08

Cardiovascular

7 quadros clínicos neste sistema

8.1	Endocardite Infecciosa — Valva Nativa / Comunitária	161
8.2	Endocardite — Prótese Valvar / Associada a Cuidado de Saúde	164
8.3	Endocardite Direita / Uso de Droga EV	167
8.4	Bacteremia por <i>Staphylococcus aureus</i> — Risco de Endocardite	169
8.5	Infecção de Cateter Venoso Central / CRBSI	171
8.6	Infecção de Dispositivo Cardíaco Implantável — Marcapasso/CDI	174
8.7	Mediastinite Pós-Esternotomia / Infecção Profunda de Ferida Cardíaca	176

8.1

Endocardite Infecciosa — Valva Nativa / Comunitária

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Suspeitar em febre persistente, sopro novo, fenômenos embólicos/imunológicos, bacteremia por *S. aureus*, *Streptococcus*/*Enterococcus* sem foco claro, uso de droga EV ou achado ecocardiográfico sugestivo. Se estável, coletar hemoculturas antes de iniciar antibiótico; em sepse/choque, colher o possível e não atrasar tratamento.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ceftriaxona

Vancomicina 25–30 mg/kg EV ataque + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

4–6 semanas, direcionado por agente, valva, CIM e complicações

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
<i>Staphylococcus aureus</i>	FREQUENTE	MSSA/MRSA; maior risco de embolização, abscesso e bacteremia persistente.
<i>Streptococcus viridans</i> / <i>gallolyticus</i>	FREQUENTE	Associado a foco oral/GI; avaliar colonoscopia em <i>S. gallolyticus</i> .
<i>Enterococcus faecalis</i>	MODERADO	Mais comum em idosos, manipulação GU/GI e pacientes com comorbidades.
HACEK	RARO	Crescimento lento; ceftriaxona costuma ser opção dirigida.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de endocardite em valva nativa, comunitária, paciente estável	Vancomicina + Ceftriaxona · Vancomicina EV guiada por AUC/nível + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h · EV	Até identificação; depois 4–6 semanas conforme agente	Coletar 3 pares de hemoculturas antes. Não usar gentamicina de rotina no empírico pela toxicidade; reservar para esquemas dirigidos quando indicado.
MSSA confirmado em valva nativa	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	Geralmente 6 semanas	Betalactâmico é preferível à vancomicina para MSSA quando tolerado. Repetir hemoculturas até negatificação.
<i>Streptococcus viridans</i> / <i>gallolyticus</i> sensível confirmado	Penicilina G ou Ceftriaxona · Penicilina G 12–18 milhões UI/dia EV contínuo/dividido OU Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h · EV	4 semanas em valva nativa não complicada	Esquemas abreviados com aminoglicosídeo só em critérios muito estritos e com monitorização; evitar em DRC/idosos.
<i>Enterococcus faecalis</i> sensível, tratamento dirigido	Ampicilina + Ceftriaxona · Ampicilina 2 g EV 4/4 h + Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h · EV	6 semanas na maioria dos casos	Opção útil para reduzir nefrotoxicidade em comparação com aminoglicosídeo, especialmente em idoso/DRC; confirmar sensibilidade.

Sobre a duração: Individualizar se doença não complicada selecionada. Ajustar por CIM/complicações.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico ou MRSA confirmado	Vancomicina ou Daptomicina · Vancomicina por AUC/nível OU Daptomicina 8–10 mg/kg EV 24/24 h · EV	Geralmente 6 semanas, conforme agente/valva	Daptomicina é alternativa para bacteremia/endocardite por Gram-positivo; não usar se houver pneumonia como foco principal.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Hemodiálise ▪ uso de droga EV ▪ colonização/infecção prévia por MRSA ▪ infecção relacionada a cuidado de saúde	Vancomicina; daptomicina como alternativa selecionada

ALERTAS DE SEGURANÇA**ALERTA CRÍTICO****CLASSIFICAR ANTES DO EMPÍRICO**

Separar apresentação aguda/subaguda, valva nativa, prótese precoce/tardia, assistência à saúde e epidemiologia local; colher hemoculturas e envolver equipe de endocardite/cirurgia quando indicado.

ALERTA CRÍTICO**Hemoculturas antes do antibiótico se o paciente estiver estável**

Coletar idealmente 3 pares de hemoculturas de sítios diferentes. Em sepse/choque, não atrasar antibiótico para completar coletas.

ALERTA CRÍTICO**Ecocardiograma e complicações**

Solicitar ETT; usar ETE se alta suspeita, ETT negativo, prótese/material, *S. aureus*, complicação ou janela ruim.

ATENÇÃO**Endocardite é diagnóstico de equipe**

IC, abscesso, bloqueio AV, embolização recorrente, fungo, prótese ou bacteremia persistente exigem discussão precoce com cardio/cirurgia/infectologia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Coletar 3 pares de hemoculturas se estável; solicitar hemograma, função renal/hepática, PCR/VHS, urina 1 e ECG.
2	Imagem	Solicitar ETT; ETE se prótese/material, <i>S. aureus</i> , ETT negativo com alta suspeita ou complicação.
3	Antibiótico	Iniciar após hemoculturas; se sepse/choque, iniciar imediatamente após coletas possíveis.
4	Cultura/CIM	Descalonar por agente, CIM, valva e complicações; repetir hemoculturas até negatificação nos agentes de alto risco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda suspeita relevante de endocardite deve internar para investigação, hemoculturas, eco e tratamento EV.
UTI	▪ Choque séptico ▪ insuficiência cardíaca aguda ▪ bloqueio AV novo ▪ abscesso perivalvar ▪ AVC/embolia grave ▪ necessidade de vasopressor.

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Hemocultura positiva após 48–72 h de terapia adequada ▪ febre persistente ▪ embolia nova ▪ aumento de vegetação ▪ abscesso ou bloqueio novo.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	3 pares de hemoculturas antes do antibiótico se estável; repetir até negatização em <i>S. aureus</i> , <i>Candida</i> , <i>Enterococcus</i> , prótese/material ou bacteremia persistente.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ MSSA: oxacilina/cefazolina se possível. ▪ <i>Streptococcus</i> sensível: penicilina G ou ceftriaxona. ▪ <i>Enterococcus faecalis</i> sensível: considerar ampicilina + ceftriaxona. ▪ Evitar aminoglicosídeo empírico rotineiro quando não houver indicação clara.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque	<50 mL/min: Ajustar por AUC/nível Monitorar nefrotoxicidade e evitar associação desnecessária com amino-glicosídeo.	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	qualquer: Geralmente sem ajuste renal isolado	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	qualquer: Sem ajuste renal usual	
Ampicilina + Ceftriaxona EV	Ampicilina 2 g EV 4/4 h + Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h GRAVE Mesmo esquema; ajustar ampicilina se DRC importante	<50 mL/min: Ajustar ampicilina conforme função renal	

8.2

Endocardite — Prótese Valvar / Associada a Cuidado de Saúde

CRÍTICA UTI ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Endocardite em prótese valvar ou associada a cuidado de saúde tem maior risco de estafilococos coagulase-negativos, S. aureus, Enterococcus, bacilos Gram-negativos e fungos. Exige hemoculturas, ecocardiograma transesofágico precoce e discussão com cardiologia/cirurgia/infectologia.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Cefepime

Vancomicina 25–30 mg/kg EV ataque + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

≥6 semanas, direcionado por agente, prótese e complicações

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus coagulase-negativo	FREQUENTE	Biofilme; especialmente prótese precoce e material intracardíaco.
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	Alta morbimortalidade; considerar MRSA até sensibilidade.
Enterococcus spp.	MODERADO	Idosos, manipulação GU/GI, prótese e cuidado de saúde.
Bacilos Gram-negativos hospitalares	CONTEXTUAL	Considerar em infecção nosocomial/UTI/procedimentos recentes.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Prótese precoce, infecção associada a cuidado de saúde ou paciente crítico	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina por AUC/nível + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Até cultura; depois ≥6 semanas conforme agente	Cobre MRSA/coagulase-negativo e Gram-negativos. Acrescentar antifúngico apenas se risco alto/sugestão microbiológica.
Estafilococo em prótese valvar confirmado	Esquema antiestafilocócico dirigido ± rifampicina · Se MSSA: oxacilina/cefazolina; se MRSA: vancomicina/daptomicina. Rifampicina somente em momento adequado e com especialista · EV	≥6 semanas	Rifampicina não deve ser iniciada isoladamente nem durante bacteremia não controlada; risco de resistência/interação.
Enterococcus faecalis em prótese, sensível	Ampicilina + Ceftriaxona · Ampicilina 2 g EV 4/4 h + Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h · EV	6 semanas ou mais conforme complicação	Preferir esquema poupador de aminoglicosídeo quando aplicável; individualizar por CIM e função renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a cefalosporina/ betalactâmico com necessidade de cobertura Gram-negativa	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina por AUC/nível + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Até cultura; depois direcionar	Aztreonam cobre Gram-negativos, mas não Gram-positivos/anaeróbios. Ajustar rápido por cultura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Prótese valvar ▪ hemodíalise ▪ infecção nosocomial ▪ MRSA prévio	Vancomicina; daptomicina em cenário selecionado
PSEUDOMONAS	▪ Cuidado de saúde ▪ internação prolongada ▪ procedimento recente ▪ UTI	Cefepime

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

NÃO AUTOMATIZAR RIFAMPICINA/GENTAMICINA

Definir após identificação, suscetibilidade, estratégia cirúrgica e discussão especializada. Toxicidade e benefício variam por agente e fase do tratamento.

ALERTA CRÍTICO

CLASSIFICAR ANTES DO EMPÍRICO

Separar apresentação aguda/subaguda, valva nativa, prótese precoce/tardia, assistência à saúde e epidemiologia local; colher hemoculturas e envolver equipe de endocardite/cirurgia quando indicado.

ALERTA CRÍTICO

Ecocardiograma transesofágico precoce

Prótese reduz sensibilidade do ETT; ETE é geralmente necessário e deve ser repetido se suspeita persistir.

ALERTA CRÍTICO

Avaliar cirurgia precocemente

IC, abscesso/deiscência, bacteremia persistente, fungo, bloqueio de condução ou embolização recorrente são sinais de alto risco.

ATENÇÃO

Rifampicina exige cuidado

Usar apenas como parte de esquema dirigido em material protético, evitando início durante bacteremia ativa sem controle.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Coletar hemoculturas e iniciar investigação; priorizar ETE.
2	Instabilidade/complicação	UTI e discussão cardio/cirurgia/infectologia.
3	Empírico	Vancomicina + cefepime em prótese precoce/nosocomial/crítica até cultura.
4	Cultura	Definir duração, necessidade de rifampicina/combinação e cirurgia conforme agente e complicações.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita clínica relevante, bacteremia por agente de alto risco, prótese/dispositivo, febre persistente ou necessidade de investigação hospitalar.
UTI	▪ Choque ▪ IC aguda ▪ bloqueio AV ▪ abscesso/deiscência ▪ AVC grave ▪ necessidade de cirurgia urgente.

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Hemocultura persistentemente positiva ▪ piora hemodinâmica ▪ nova alteração de condução ▪ abscesso ou deiscência de prótese.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	3 pares de hemoculturas antes do antibiótico se possível; repetir até negativação em bacteremia/endocardite por agentes de alto risco.
Controle de foco	▪ UTI e discussão cardio/cirurgia/infectologia. ▪ Definir duração, necessidade de rifampicina/combinação e cirurgia conforme agente e complicações.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por cultura/CIM. ▪ Evitar manter vancomicina para MSSA quando oxacilina/cefazolina forem possíveis. ▪ Usar rifampicina apenas com indicação e timing adequados.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	<60 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE 25–30 mg/kg EV ataque	<50 mL/min: Ajustar por AUC/nível	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Aztreonam EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV a cada 6–8 h	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo	

8.3

Endocardite Direita / Uso de Droga EV

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Endocardite direita, geralmente tricúspide, é fortemente associada a *S. aureus*. Pode cursar com febre, bacteremia, dor torácica pleurítica, hemoptise, infiltrados/nódulos periféricos e embolia séptica pulmonar.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina

25–30 mg/kg EV ataque, depois guiada por AUC/nível

VIA

EV

DURAÇÃO

4–6 semanas; duração curta apenas em critérios muito selecionados

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	MSSA/MRSA; principal agente em uso de droga EV.
Streptococcus spp.	CONTEXTUAL	
Pseudomonas aeruginosa / Gram-negativos	MENOS COMUM	Considerar se contexto hospitalar, água/soluções contaminadas ou sepse grave.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Endocardite direita suspeita, MRSA possível	Vancomicina · Vancomicina EV com ataque e monitorização por AUC/nível · EV	4–6 semanas conforme cultura e complicações	Adicionar cefepime se choque, exposição hospitalar, Gram-negativo provável ou Pseudomonas possível.
MSSA confirmado, sem alergia grave	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	4–6 semanas	Duração menor somente se critérios estritos: valva direita, MSSA, resposta rápida, sem complicações, sem imunossupressão e sem foco metastático.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MRSA com intolerância/falha à vancomicina ou bacteremia persistente	Daptomicina · 8–10 mg/kg EV 24/24 h · EV	4–6 semanas	Útil para bacteremia/endocardite direita; não usar para pneumonia alveolar. Monitorar CPK.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	- Uso de droga EV - MRSA prévio - hemodiálise - infecção cutânea purulenta	Vancomicina
PSEUDOMONAS	- Choque séptico - infecção hospitalar - uso recente de antibiótico amplo - Gram-negativo em cultura	Cefepime associado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

CLASSIFICAR ANTES DO EMPÍRICO

Separar apresentação aguda/subaguda, valva nativa, prótese precoce/tardia, assistência à saúde e epidemiologia local; colher hemoculturas e envolver equipe de endocardite/cirurgia quando indicado.

ALERTA CRÍTICO

S. aureus em sangue nunca é contaminação

Repetir hemoculturas, procurar foco e excluir endocardite/material infectado.

ATENÇÃO

Embolia séptica pulmonar

Dor pleurítica, hemoptise e nódulos periféricos/cavitados sugerem embolização pulmonar.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Hemoculturas, ETT/ETE conforme suspeita, RX/TC tórax se sintomas pulmonares.
2	Empírico	Vancomicina; adicionar cefepime apenas se risco de Gram-negativo/Pseudomonas ou choque.
3	Cultura	Descalonar para oxacilina/cefazolina se MSSA; manter MRSA se indicado.
4	Persistência	Pesquisar abscesso, material, tromboflebite séptica e discutir cirurgia se complicações.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Todo caso suspeito.
UTI	▪ Choque ▪ hipoxemia importante por embolia séptica ▪ bacteremia persistente ▪ insuficiência cardíaca direita grave.
Falha terapêutica	▪ Hemocultura positiva persistente ▪ febre >72 h ▪ êmbolos sépticos recorrentes ▪ vegetação grande com complicação.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas iniciais e repetidas a cada 24–48 h até negativação.
Controle de foco	Pesquisar abscesso, material, tromboflebite séptica e discutir cirurgia se complicações.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ MSSA: trocar para oxacilina/cefazolina. ▪ Evitar cefepime prolongado se não houver Gram-negativo/Pseudomonas.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE 25–30 mg/kg EV ataque	<50 mL/min: Ajustar por AUC/nível	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Daptomicina EV	6 mg/kg EV 24/24 h GRAVE 8–10 mg/kg EV 24/24 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	Individualizar por peso/CPK
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	qualquer: Sem ajuste renal usual	

8.4

Bacteremia por Staphylococcus aureus — Risco de Endocardite

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Bacteremia por S. aureus deve ser tratada como evento grave: não é contaminação. Exige repetição de hemoculturas, controle de foco, avaliação para endocardite e definição de não complicada vs complicada.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina até definir MSSA/MRSA

Vancomicina 25–30 mg/kg EV ataque; depois ajustar por AUC/nível

VIA

EV

DURAÇÃO

Mínimo 14 dias se rigorosamente não complicada; 4–6 semanas se complicada/endocardite

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus MSSA	FREQUENTE	Oxacilina/cefazolina são preferíveis à vancomicina se toleradas.
Staphylococcus aureus MRSA	RISCO ESPECÍFICO	Vancomicina ou daptomicina conforme cenário e sensibilidade.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Hemocultura positiva para S. aureus antes de sensibilidade	Vancomicina · Vancomicina EV guiada por AUC/nível · EV	Até definição	Repetir hemoculturas em 24–48 h; remover cateter infectado; procurar foco profundo e endocardite.
MSSA confirmado	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	≥14 dias se não complicada	Não manter vancomicina para MSSA se betalactâmico for possível.
MRSA confirmado	Vancomicina ou Daptomicina · Vancomicina por AUC/nível OU Daptomicina 8–10 mg/kg EV 24/24 h · EV	≥14 dias se não complicada	Daptomicina é alternativa para bacteremia; não usar para pneumonia.

Sobre a duração: Depois 14 dias a 6 semanas conforme classificação. 4–6 semanas se complicada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MSSA com alergia grave a betalactâmico	Vancomicina ou Daptomicina · Vancomicina por AUC/nível OU Daptomicina 8–10 mg/kg EV 24/24 h · EV	Conforme complexidade	Reavaliar alergia: cefazolina pode ser possível em muitos pacientes sem anafilaxia grave.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Aguardando sensibilidade ▪ MRSA prévio ▪ hemodiálise ▪ infecção relacionada a cuidado de saúde	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

S. AUREUS NÃO COMPLICADO: TODOS OS CRITÉRIOS

Exige endocardite excluída, ausência de prótese/dispositivo infectado, hemoculturas de controle negativas em 48–72 h, defervescência em até 72 h e ausência de foco metastático. Contar a duração a partir da primeira hemocultura negativa.

ALERTA CRÍTICO

Não complicada tem critérios rígidos

Exige hemoculturas negativas em 48–72 h, sem endocardite, sem prótese/material, sem foco metastático e melhora clínica.

ALERTA CRÍTICO

Hemoculturas seriadas

Persistência após 48–72 h sugere foco não controlado, endocardite, tromboflebite séptica ou material infectado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Hemocultura positiva	Iniciar/adequar antiestafilocócico e repetir hemoculturas em 24–48 h.
2	Foco	Controlar foco: remover cateter infectado, drenar abscesso, investigar osso/articulação/pulmão/endocardite.
3	MSSA	Trocar para oxacilina ou cefazolina se tolerado.
4	Classificação	Definir não complicada vs complicada para duração; baixa tolerância para ETE se risco alto.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda bacteremia por <i>S. aureus</i> .
Gravidade	▪ Bacteremia persistente ▪ foco desconhecido ▪ material protético ▪ hemodiálise ▪ metástases sépticas ▪ endocardite.
Falha terapêutica	▪ Hemocultura positiva após 48–72 h ▪ febre persistente ▪ novo foco metastático ▪ dor lombar/óssea/articular nova.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas seriadas até negativação; cultura de foco quando disponível.

EIXO	CONDUTA
Controle de foco	Controlar foco: remover cateter infectado, drenar abscesso, investigar osso/articulação/pulmão/endocardite.
Marco da duração	Contar a duração a partir da primeira hemocultura negativa, após controle do foco, salvo complicação que defina outro marco.
Descalonamento	▪ MSSA: oxacilina/cefazolina. ▪ MRSA: vancomicina por AUC/nível ou daptomicina se cenário adequado. ▪ Suspende Gram-negativo se não houver indicação.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE 25–30 mg/kg EV ataque	<50 mL/min: Ajustar por AUC/nível	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Daptomicina EV	6 mg/kg EV 24/24 h GRAVE 8–10 mg/kg EV 24/24 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	

8.5

Infecção de Cateter Venoso Central / CRBSI

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Suspeitar em febre/sepsis sem foco claro em paciente com CVC, calafrios durante infusão, hiperemia/pus no sítio, túnel doloroso ou hemocultura positiva. A decisão principal é antibiótico + remover ou tentar salvamento do cateter conforme agente, gravidade e tipo de acesso.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Cefepime

Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7–14 dias se não complicada; 4–6 semanas se complicada/endocardite/tromboflebite

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus coagulase-negativo	FREQUENTE	Pode ser contaminação ou CRBSI real; interpretar número de frascos, clínica e diferencial de tempo.
Staphylococcus aureus	IMPORTANTE	Remover cateter, repetir hemoculturas e investigar endocardite/metástases.
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	Mais provável em UTI, neutropenia, cateter femoral, sepsis grave.
Candida spp.	RISCO ESPECÍFICO	TPN, imunossupressão, antibiótico amplo, colonização múltipla.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de CRBSI hospitalar, paciente grave ou risco de MRSA/ Gram-negativo	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina por AUC/nível + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Ajustar por agente; 7–14 dias se não complicada	Coletar hemoculturas periférica e de cada lúmen quando possível. Remover cateter se instabilidade, pus/túnel ou agente de alto risco.
Candidemia ou alto risco de Candida em paciente instável	Equinocandina · Miconazole 100 mg EV 24/24 h OU Anidulafungina 200 mg ataque, depois 100 mg/dia · EV	14 dias após primeira hemocultura negativa e resolução dos sintomas, se sem complicações	Remover CVC quando possível; repetir hemoculturas; avaliar complicações conforme protocolo local.
S. aureus relacionado a cateter	Vancomicina até sensibilidade; oxacilina/cefazolina se MSSA · Vancomicina EV; se MSSA: Oxacilina 2 g EV 4/4 h ou Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	≥14 dias se rigorosamente não complicada	Remover cateter. Investigar endocardite, trombose séptica e focos metastáticos.
Coagulase-negativo em cateter de longa permanência, paciente estável, sem túnel/pus	Vancomicina sistêmica ± lock antibiótico · Vancomicina por AUC/nível; lock conforme protocolo institucional · EV	10–14 dias se cateter mantido; individualizar	Salvamento só é razoável em situação selecionada, sem sepse, sem S. aureus/ Candida/Pseudomonas e sem complicação.

Sobre a duração: 4–6 semanas se complicada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico com necessidade de Gram-negativo	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Ajustar por cultura	Adicionar antifúngico se alto risco de Candida; aminoglicosídeo apenas em casos selecionados e monitorizados.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ CVC em UTI ▪ hemodiálise ▪ MRSA prévio ▪ infecção nosocomial	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ UTI ▪ neutropenia ▪ sepse grave ▪ antibiótico recente	Cefepime

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

RETIRADA DO DISPOSITIVO É DECISÃO CENTRAL

Definir retirada, extração completa ou exceção de salvamento por patógeno, estabilidade, tunelite/bolsa, bacteremia persistente e complicações. Não aplicar 7–14 dias a todos os cenários.

ALERTA CRÍTICO

Remover cateter em agentes de alto risco

S. aureus, Pseudomonas, Candida, micobactéria, sepse grave, túnel/pus, endocardite ou bacteremia persistente geralmente exigem remoção.

ATENÇÃO

Coleta pareada ajuda diagnóstico

Hemocultura periférica e pelo cateter/lúmens permite avaliar diferencial de tempo de positividade quando disponível.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Coletar hemoculturas periféricas e do cateter/lúmens antes do antibiótico se possível.
2	Instável ou alto risco	Iniciar vancomicina + cefepime e avaliar remoção imediata do CVC.
3	Agente de alto risco	Remover cateter se <i>S. aureus</i> , <i>Candida</i> , <i>Pseudomonas</i> , micobactéria, fungo, sepse grave ou persistência.
4	Cultura final	Definir duração, necessidade de eco, doppler para trombose e investigação de focos metastáticos.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de CRBSI com febre/sepse, hemocultura positiva ou necessidade de antibiótico EV.
UTI	▪ Choque séptico ▪ neutropenia grave ▪ candidemia instável ▪ bacteremia persistente ▪ tromboflebite séptica.
Falha terapêutica	▪ Hemocultura positiva após remoção/48–72 h ▪ febre persistente ▪ trombose dolorosa ▪ novo foco metastático.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas pareadas: periférica e pelo cateter/lúmens; cultura da ponta se removido conforme protocolo.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Ajustar por agente e sensibilidade. ▪ Suspender cobertura Gram-negativa/MRSA se cultura e cenário não sustentarem. ▪ Candidemia exige antifúngico e controle do cateter.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	<60 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100 mg EV 24/24 h	qualquer: Sem ajuste renal	
Aztreonam EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV a cada 6–8 h	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo	

8.6

Infecção de Dispositivo Cardíaco Implantável — Marcapasso/CDI

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Inclui infecção de loja, erosão do gerador, drenagem, bacteremia associada a cabos e endocardite relacionada a dispositivo. Antibiótico isolado raramente cura infecção definida de dispositivo; remoção completa do sistema costuma ser necessária.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina

25–30 mg/kg EV ataque, depois guiada por AUC/nível

VIA

EV

DURAÇÃO

10–14 dias se loja isolada após remoção; 4–6 semanas se bacteremia/endocardite/complicação

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	Maior risco de bacteremia, endocardite e complicações sistêmicas.
Staphylococcus coagulase-negativo	FREQUENTE	Biofilme em gerador/cabos.
Bacilos Gram-negativos	MENOS COMUM	Considerar em sepse/nosocomial ou cultura sugestiva.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção de loja/erosão sem bacteremia ou endocardite aparente	Vancomicina · Vancomicina EV guiada por AUC/ nível · EV	10–14 dias após remoção completa se realmente isolada	Coletar hemoculturas e cultura de secreção se houver. Acionar equipe para extração completa do sistema quando infecção definida.
Bacteremia, vegetação em cabo/ valva ou sepse associada ao dispositivo	Vancomicina + Cefepime se sepse/risco Gram-negativo · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h se necessário · EV	4–6 semanas conforme agente, hemocultura e extensão	Remoção completa de gerador e cabos é central. Solicitar ETE para cabos/valvas quando bacteremia ou suspeita endovascular.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Intolerância/falha à vancomicina ou MRSA persistente	Daptomicina · 8–10 mg/kg EV 24/24 h · EV	Conforme extensão	Monitorar CPK; discutir infectologia/ eletrofisiologia.

Sobre a duração: Geralmente 4–6 semanas se endovascular.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Infecção de dispositivo ▪ bacteremia por Gram-positivo ▪ infecção relacionada a cuidado de saúde	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ Sepse grave ▪ infecção hospitalar com risco de Gram-negativo	Cefepime associado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**RETIRADA DO DISPOSITIVO É DECISÃO CENTRAL**

Definir retirada, extração completa ou exceção de salvamento por patógeno, estabilidade, tunelite/bolsa, bacteremia persistente e complicações. Não aplicar 7–14 dias a todos os cenários.

ALERTA CRÍTICO**Não tratar dispositivo infectado apenas com antibiótico**

Biofilme e recorrência tornam a remoção completa do sistema necessária na maioria das infecções definidas.

ALERTA CRÍTICO**Não puncionar loja às cegas**

Evita inoculação/contaminação e não substitui avaliação especializada. Cultura se há drenagem espontânea ou em procedimento.

ATENÇÃO**Reimplante só após controle**

Reimplantar em outro sítio e após hemoculturas negativas/controle infeccioso conforme gravidade e dependência do dispositivo.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Loja alterada	Examinar erosão/drenagem; colher hemoculturas; não puncionar loja às cegas.
2	Infecção definida	Internar, iniciar cobertura anti-MRSA e acionar eletrofisiologia/cirurgia para extração completa.
3	Bacteremia	ETE e hemoculturas seriadas até negatificação.
4	Após extração	Ajustar antibiótico por cultura e planejar reimplante apenas após controle.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Infecção de loja, erosão, drenagem, bacteremia ou suspeita de cabo infectado.
UTI	▪ Choque ▪ endocardite com instabilidade ▪ embolização pulmonar extensa ▪ arritmia/instabilidade elétrica.
Falha terapêutica	▪ Bacteremia persistente ▪ febre após remoção ▪ vegetação grande ▪ recorrência local.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se possível; cultura de material removido/loja conforme abordagem especializada.
Controle de foco	▪ Examinar erosão/drenagem; colher hemoculturas; não puncionar loja às cegas. ▪ Internar, iniciar cobertura anti-MRSA e acionar eletrofisiologia/cirurgia para extração completa.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por cultura. ▪ Se MSSA, preferir oxacilina/cefazolina após controle. ▪ Cefepime não deve permanecer se não houver Gram-negativo.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h GRAVE 25–30 mg/kg EV ataque	<50 mL/min: Ajustar por AUC/nível	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Daptomicina EV	6 mg/kg EV 24/24 h GRAVE 8–10 mg/kg EV 24/24 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo	
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	<60 mL/min: Ajustar dose/intervalo	

8.7

Mediastinite Pós-Esternotomia / Infecção Profunda de Ferida Cardíaca

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção profunda pós-cirurgia cardíaca com dor esternal, instabilidade/crepitação do esterno, secreção profunda, febre, leucocitose, sepse ou achado tomográfico. É emergência cirúrgica: antibiótico amplo, culturas profundas e desbridamento/controle de foco.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Piperacilina-Tazobactam

Vancomicina EV + Piperacilina-Tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

4–6 semanas conforme desbridamento, osso/material e culturas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	MSSA/MRSA.
Staphylococcus coagulase-negativo	FREQUENTE	Associado a material, fios e esterno.
Gram-negativos hospitalares	CONTEXTUAL	
Anaeróbios	CONTEXTUAL	Mais provável em necrose, odor fétido, polimicrobiana.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de mediastinite pós-esternotomia	Vancomicina + Piperacilina-Tazobactam · Vancomicina EV + Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h · EV	4–6 semanas após controle de foco, individualizar	Acionar cirurgia cardíaca imediatamente; coletar hemoculturas e culturas profundas/intraoperatórias.
Choque, internação prolongada, colonização ESBL/CRE ou Gram-negativo resistente provável	Vancomicina + Meropenem · Vancomicina EV + Meropenem 1–2 g EV 8/8 h · EV	4–6 semanas conforme cultura e controle de foco	Usar quando risco epidemiológico/local justificar; descalonar assim que culturas permitirem.
MSSA confirmado após desbridamento	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	Geralmente 4–6 semanas	Descalonar de vancomicina quando MSSA e paciente tolera betalactâmico.

Sobre a duração: Ajustar se osteomielite/material.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar por cultura/controle de foco	Cobertura alternativa para MRSA, Gram-negativos e anaeróbios; envolver infectologia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Pós-operatório hospitalar ▪ material esternal ▪ sepse ▪ colonização MRSA	Vancomicina
ANAEROBIOS	▪ Necrose ▪ infecção profunda polimicrobiana ▪ odor fétido	Piperacilina-tazobactam ou metronidazol associado
ESBL	▪ Colonização ESBL ▪ uso recente de cefalosporina/carbapenem ▪ internação prolongada ▪ choque	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Controle cirúrgico de foco é central**

Antibiótico sem desbridamento/controle de foco falha com frequência em mediastinite profunda.

ALERTA CRÍTICO**Avaliar instabilidade esternal**

Dor, crepitação, deiscência ou drenagem profunda pós-esternotomia exigem avaliação cirúrgica urgente.

ATENÇÃO**Cultura profunda é melhor que swab superficial**

Swab superficial pode refletir colonização; priorizar material profundo/intraoperatório quando possível.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Avaliar ferida, estabilidade do esterno, sinais sistêmicos; colher hemoculturas.
2	Imagem	TC de tórax/mediastino se estável, sem atrasar cirurgia quando quadro é evidente.
3	Tratamento	Iniciar vancomicina + pip-tazo e acionar cirurgia cardíaca/plástica/infectologia.
4	Pós-controle	Ajustar por cultura profunda/intraoperatória e definir duração prolongada.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita clínica relevante, bacteremia por agente de alto risco, prótese/dispositivo, febre persistente ou necessidade de investigação hospitalar.
UTI	▪ Sepsis/choque ▪ instabilidade respiratória ▪ necessidade de cirurgia urgente ▪ mediastinite extensa.

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ drenagem recorrente ▪ instabilidade esternal ▪ bacteremia persistente ▪ necrose progressiva.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas; cultura profunda/intraoperatória preferencialmente antes de antibiótico quando não atrasar tratamento.
Controle de foco	▪ TC de tórax/mediastino se estável, sem atrasar cirurgia quando quadro é evidente. ▪ Iniciar vancomicina + pip-tazo e acionar cirurgia cardíaca/plástica/infectologia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ MSSA: oxacilina/cefazolina. ▪ Suspende carbapenem/antipseudomonal se cultura e contexto não sustentarem. ▪ Manter foco em desbridamento e controle cirúrgico.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h em infusão estendida	<40 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	qualquer: Sem ajuste renal usual	

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 08 — CARDIOVASCULAR

- AHA. Infective Endocarditis in Adults — Scientific Statement, versão vigente.
- IDSA. Intravascular Catheter-related Infection, 2009.
- ESC. Guidelines for the Management of Endocarditis, 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad193.
- AHA. Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections, 2023. doi:10.1161/CIR.0000000000001187.

09

Osteoarticular

8 quadros clínicos neste sistema

9.1	Artrite Séptica — Articulação Nativa / Adulto	180
9.2	Osteomielite Aguda — Hematogênica ou Contígua	182
9.3	Espondilodiscite / Osteomielite Vertebral Nativa	185
9.4	Infecção de Prótese Articular — Joelho/Quadril	187
9.5	Osteomielite no Pé Diabético	190
9.6	Infecção de Material de Síntese / Osteossíntese	192
9.7	Bursite Séptica — Olecraniana/Pré-patelar	195
9.8	Tenossinovite Piogênica dos Flexores — Mão	197

9.1

Artrite Séptica — Articulação Nativa / Adulto

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Emergência ortopédica. Monoartrite aguda com dor intensa, calor, derrame, limitação funcional ou febre exige artrocentese diagnóstica imediata. Cristais não excluem infecção. Se sepse, instabilidade ou atraso para punção, colher culturas possíveis e não atrasar antibiótico.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ceftriaxona

Vancomicina 25–30 mg/kg EV ataque + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Em geral 2–4 semanas; pode ser maior em *S. aureus*, bacteremia, drenagem incompleta ou articulação profunda

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	Inclui MSSA/MRSA; principal agente em infecções osteoarticulares agudas.
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	Mais prováveis em idosos, foco urinário/GI, trauma, imunossupressão ou infecção hospitalar.
Neisseria gonorrhoeae	CONTEXTUAL	Adulto jovem/risco sexual; pode cursar com poliartralgia e tenossinovite.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Artrite séptica sem agente definido	Vancomicina + Ceftriaxona · Vancomicina EV guiada por AUC/nível + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h · EV	Até cultura; total geralmente 2–4 semanas	Cobrir <i>S. aureus</i> /MRSA e Gram-negativos comunitários. Artrocentese/lavagem é parte central da conduta; quadril/ombro e pus espesso tendem a exigir abordagem cirúrgica.
MSSA confirmado	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	3–4 semanas em geral	Preferir betalactâmico para MSSA se tolerado; investigar bacteremia complicada se hemocultura positiva.
Suspeita/confirmada gonocócica	Ceftriaxona · 1 g EV/IM 24/24 h · EV	7 dias após melhora clínica	Tratar clamídia se não excluída, testar ISTs e avaliar parceiros conforme protocolo.

Sobre a duração: Individualizar se bacteremia/endocardite. Prolongar se evolução complicada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina ± Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h se risco de Gram-negativo · EV	Até cultura; depois direcionar	Discutir infectologia/ortopedia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodíalise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepse grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

AMOSTRA PROFUNDA ANTES DO ANTIBIÓTICO QUANDO SEGURO

Se estável, obter líquido articular, tecido ou biópsia para cultura antes do antimicrobiano. Não atrasar em sepse, instabilidade, déficit neurológico ou progressão ameaçadora.

ALERTA CRÍTICO

Artrocentese é prioridade

Enviar celularidade, diferencial, Gram, cultura e cristais. Cristais não descartam infecção concomitante.

ALERTA CRÍTICO

Acionar ortopedia

Quadril, ombro, prótese, pus espesso ou má resposta exigem drenagem/lavagem precoce.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Hemoculturas e artrocentese antes do antibiótico se possível; analgesia, imobilização relativa e avaliação ortopédica.
2	Sepse ou atraso para punção	Não atrasar antibiótico após culturas possíveis.
3	Derrame purulento ou articulação profunda	Acionar ortopedia para drenagem/lavagem.
4	Cultura disponível	Descalonar e definir duração; se <i>S. aureus</i> , avaliar bacteremia/endocardite conforme contexto.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda suspeita de artrite séptica deve ser internada.
UTI	▪ Choque séptico ▪ imunossupressão grave ▪ bacteremia persistente ▪ disfunção orgânica.
Falha terapêutica	▪ Dor/febre persistente após 48–72 h ▪ derrame recorrente ▪ PCR sem queda ▪ cultura positiva persistente.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Líquido sinovial para Gram/cultura/cristais + 2 pares de hemoculturas antes do antibiótico se possível.

EIXO	CONDUTA
Controle de foco	Acionar ortopedia para drenagem/lavagem.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▫ Direcionar por Gram/cultura e sensibilidade. ▫ Para MSSA, trocar vancomicina por oxacilina/cefazolina se tolerado.
Transição EV → VO	Considerar VO apenas após melhora clínica, queda de PCR, drenagem adequada e agente com opção oral confiável.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	<50–60 mL/min: Geralmente sem ajuste renal isolado	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual; monitorar sódio e função hepática	
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Ajustar se DRC importante	

9.2

Osteomielite Aguda — Hematogênica ou Contígua

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Dor óssea localizada, febre variável, PCR/VHS elevados, ferida crônica, trauma ou bacteremia sugerem osteomielite. Em paciente estável, buscar amostra óssea/profunda antes do antibiótico. Em sepse, instabilidade, necrose ou abscesso, colher culturas possíveis e tratar imediatamente.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ceftriaxona

Vancomicina EV + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Geralmente 4–6 semanas; individualizar por osso viável, debridamento, bacteremia, material e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	Inclui MSSA/MRSA; principal agente em infecções osteoarticulares agudas.
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	Mais prováveis em idosos, foco urinário/GI, trauma, imunossupressão ou infecção hospitalar.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Osteomielite comunitária sem risco de <i>Pseudomonas</i>	Vancomicina + Ceftriaxona · Vancomicina EV + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h · EV	Até cultura; total 4–6 semanas em geral	Evitar antibiótico antes de biópsia óssea se estável e biópsia factível; se bacteremia/seps, não atrasar.
Trauma aberto, punção plantar, hospitalar ou <i>Pseudomonas</i> provável	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	4–6 semanas ou conforme foco	Cobertura antipseudomonal só quando houver critério clínico/epidemiológico; descalonar por cultura profunda.
MSSA confirmado	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	4–6 semanas	Preferir betalactâmico se tolerado.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina ± Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h se Gram-negativo necessário · EV	Conforme cultura	Priorizar cultura óssea para direcionar.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodíalise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou seps grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

AMOSTRA PROFUNDA ANTES DO ANTIBIÓTICO QUANDO SEGURO

Se estável, obter líquido articular, tecido ou biópsia para cultura antes do antimicrobiano. Não atrasar em seps, instabilidade, déficit neurológico ou progressão ameaçadora.

ALERTA CRÍTICO

Coletar cultura profunda sempre que possível

Em paciente estável, priorizar amostra sinovial, óssea ou intraoperatória antes do antibiótico para aumentar rendimento microbiológico.

ALERTA CRÍTICO

Controle de foco muda prognóstico

Drenagem, lavagem, debridamento ou retirada de material infectado podem ser tão importantes quanto o antibiótico.

ATENÇÃO

Swab superficial é pouco confiável

Preferir osso/tecido profundo após limpeza/debridamento.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Solicitar hemoculturas, PCR/VHS e imagem; RM é preferida quando disponível.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Paciente estável	Tentar obter cultura óssea/profunda antes do antibiótico.
3	Sepse/instabilidade	Iniciar empírico após culturas possíveis.
4	Necrose, sequestro, abscesso ou material	Acionar ortopedia/cirurgia para controle de foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Seps ▪ dor incapacitante ▪ necessidade de EV ▪ abscesso/necrose ▪ falha ambulatorial ▪ material infectado.
UTI	▪ Choque séptico ▪ fascite/necrose associada ▪ bacteremia complicada.
Falha terapêutica	▪ Febre/dor persistente ▪ PCR sem queda ▪ progressão radiológica ▪ cultura positiva persistente.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas; cultura de osso/tecido profundo quando possível. Evitar basear decisão em swab superficial isolado.
Controle de foco	Acionar ortopedia/cirurgia para controle de foco.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Estreitar após cultura profunda e sensibilidade. ▪ Reavaliar MRSA/Pseudomonas em 48–72 h. ▪ Para MSSA, preferir oxacilina/cefazolina em vez de vancomicina.
Transição EV → VO	Transição VO pode ser considerada com estabilidade, controle de foco e antibiótico oral de alta biodisponibilidade conforme agente.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	<50–60 mL/min: Geralmente sem ajuste renal isolado	
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h GRAVE 2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	<50–60 mL/min: Ajustar conforme CLCr	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual; monitorar sódio e função hepática	
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Ajustar se DRC importante	

9.3

Espondilodiscite / Osteomielite Vertebral Nativa

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Dor axial persistente, PCR/VHS elevados ou bacteremia por *S. aureus* devem levantar suspeita, mesmo sem febre. Déficit neurológico, retenção urinária, anestesia em sela, instabilidade ou abscesso epidural são emergências e não devem aguardar biópsia.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ceftriaxona

Vancomicina EV + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

6 semanas na maioria; individualizar se abscesso/ extensão

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	Inclui MSSA/MRSA; principal agente em infecções osteoarticulares agudas.
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	Mais prováveis em idosos, foco urinário/GI, trauma, imunossupressão ou infecção hospitalar.
Mycobacterium tuberculosis	DIFERENCIAL	Curso subagudo/crônico, risco epidemiológico ou imagem sugestiva.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita estável, sem déficit neurológico/sepse	Aguardar biópsia se factível · Coletar hemoculturas e programar biópsia guiada antes do antibiótico · EV	Depois 6 semanas dirigidas	Em paciente estável, adiar antibiótico até diagnóstico microbiológico pode aumentar rendimento e reduzir tratamento inadequado.
Sepse, bacteremia grave, déficit neurológico ou compressão	Vancomicina + Ceftriaxona · Vancomicina EV + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h · EV	6 semanas em geral	Não atrasar antibiótico; solicitar RM urgente e neuro/ortopedia.
Risco hospitalar/Pseudomonas	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	6 semanas em geral	Ajustar conforme cultura.

Sobre a duração: Maior se abscesso extenso/controle incompleto.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Conforme cultura	Discutir infectologia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodiálise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepsis grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

AMOSTRA PROFUNDA ANTES DO ANTIBIÓTICO QUANDO SEGURO

Se estável, obter líquido articular, tecido ou biópsia para cultura antes do antimicrobiano. Não atrasar em sepse, instabilidade, déficit neurológico ou progressão ameaçadora.

ALERTA CRÍTICO

Déficit neurológico = urgência

Fraqueza, anestesia em sela, retenção urinária ou sinais medulares exigem RM urgente e avaliação cirúrgica.

INFORMAÇÃO

RM é o exame de escolha

Radiografia pode ser normal no início; RM avalia disco, abscesso e canal.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Solicitar hemoculturas, PCR/VHS e RM com contraste se possível.
2	Estável	Programar biópsia/aspirado antes do antibiótico se hemoculturas negativas.
3	Déficit/sepse	Iniciar antibiótico e acionar equipe de coluna/neurocirurgia.
4	Seguimento	Monitorar clínica e PCR; imagem de controle apenas se má evolução ou complicação.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de osteomielite vertebral geralmente requer internação para imagem, culturas e analgesia.
UTI	▪ Choque ▪ déficit neurológico progressivo ▪ compressão medular ▪ abscesso epidural extenso.
Falha terapêutica	▪ Piora da dor/febre ▪ PCR sem queda ▪ bacteremia persistente ▪ novo déficit neurológico.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	2 pares de hemoculturas; biópsia/aspirado vertebral se hemoculturas negativas e paciente estável. Se S. aureus em hemocultura com imagem compatível, biópsia pode ser desnecessária conforme contexto.
Controle de foco	Iniciar antibiótico e acionar equipe de coluna/neurocirurgia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por hemocultura ou biópsia. ▪ Investigar endocardite se S. aureus ou bacteremia persistente.

EIXO	CONDUTA		
Transição EV → VO	Duração usual 6 semanas; VO selecionado se boa biodisponibilidade, melhora clínica e controle de foco.		
ANTIMICROBIANOS E AJUSTES			
FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 24/24 h	<50–60 mL/min: Geralmente sem ajuste renal isolado	
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h GRAVE 2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	<50–60 mL/min: Ajustar conforme CLCr	

9.4

Infecção de Prótese Articular — Joelho/Quadril

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Dor em prótese, edema, calor, fístula, soltura, febre ou PCR elevado sugerem infecção de prótese. O tratamento depende de tempo de implante/sintomas, estabilidade, agente, biofilme e estratégia cirúrgica: DAIR, troca em um/dois tempos, retirada ou supressão.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Cefepime

Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Semanas a meses conforme estratégia cirúrgica/agente

AGENTES E CONTEXTO		
AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Estafilococos coagulase-negativos	FREQUENTE	Associados a biofilme e prótese.
Streptococcus spp.	MODERADO	
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS			
CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Prótese infectada, agente não definido	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Até cultura; duração depende da cirurgia	Se estável, coletar líquido articular/ culturas profundas antes. Não confiar em swab superficial. Empírico amplo se sepse ou cirurgia imediata.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MSSA confirmado com retenção de prótese	Oxacilina/Cefazolina + estratégia com rifampicina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h; rifampicina apenas com droga companheira · EV	Prolongado; frequentemente meses se DAIR/retenção	Rifampicina nunca isolada; iniciar apenas após debridamento, redução de carga bacteriana e ferida estável, com infectologia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Até cultura	Discussão obrigatória com infectologia/ortopedia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodiálise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepse grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA**ALERTA CRÍTICO****RIFAMPICINA DEPENDE DA ESTRATÉGIA CIRÚRGICA**

Vincular duração à retenção/retirada/troca do implante. Usar rifampicina apenas para isolado suscetível, sempre com agente companheiro e após controle adequado do foco; nunca como monoterapia.

ALERTA CRÍTICO**Cirurgia define sucesso**

Antibiótico isolado raramente resolve infecção de prótese; discutir DAIR/troca/retirada.

ATENÇÃO**Evitar antibiótico antes da coleta se estável**

Se estável, colher líquido articular/culturas profundas antes.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Solicitar PCR/VHS, radiografia e punção articular com cultura/celularidade.
2	Estável	Evitar antibiótico até culturas profundas se possível.
3	Aguda/sepse	Iniciar empírico e acionar ortopedia.
4	Planejamento	Definir DAIR versus troca/retirada com ortopedia/infectologia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de infecção aguda de prótese, fístula, dor intensa, sepse ou necessidade cirúrgica.
UTI	▪ Choque séptico ▪ bacteremia persistente.

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Fístula persistente ▪ dor/PCR persistentes ▪ cultura positiva ▪ soltura/progressão.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Punção articular e culturas intraoperatórias múltiplas, idealmente 3–5 amostras profundas; hemoculturas se febre/seps.
Controle de foco	Definir DAIR versus troca/retirada com ortopedia/infectologia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Terapia definitiva depende de agente, biofilme e estratégia cirúrgica. ▪ Para MSSA, preferir oxacilina/cefazolina; evitar vancomicina como definitivo sem necessidade.
Transição EV → VO	Transição oral/supressão depende do caso e deve ser individualizada.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h GRAVE 2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	<50–60 mL/min: Ajustar conforme CLCr	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual; monitorar sódio e função hepática	
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Ajustar se DRC importante	

9.5

Osteomielite no Pé Diabético

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Suspeitar em úlcera profunda/crônica, osso exposto, probe-to-bone positivo, PCR/VHS elevados ou imagem sugestiva. Não tratar úlcera não infectada; tratar infecção clínica e decidir entre ressecção óssea ou antibiótico prolongado.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-clavulanato ou Piperacilina-tazobactam conforme gravidade

875/125 mg VO 12/12 h se leve/moderado sem sepse; 4,5 g EV 6/6 h se grave

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Até 6 semanas se osso não ressecado; até 3 semanas se margem óssea positiva após amputação menor; menor se ressecção completa/margem limpa

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Enterobacterales	MODERADO	
Anaeróbios	CONTEXtual	Necrose, odor, isquemia ou infecção profunda.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção leve/moderada sem sepse e sem risco MDR	Amoxicilina-clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	1–2 semanas se apenas partes moles	Ajustar por cultura profunda quando disponível. Não cobrir Pseudomonas de rotina sem risco/isolamento prévio.
Infecção grave, isquemia, necrose ou sepse	Piperacilina-tazobactam ± Vancomicina · Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h + Vancomicina se MRSA · EV	Inicial EV; total conforme cirurgia/cultura	Avaliar desbridamento urgente, drenagem, revascularização e amputação se necessário; antibiótico isolado falha se perfusão/foco não forem corrigidos.

Sobre a duração: Até 6 semanas se osteomielite sem ressecção.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam + Metronidazol · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Metronidazol 500 mg 8/8 h · EV	Conforme foco	Alternativa ampla; ajustar por cultura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodíalise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepse grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios
ANAEROBIOS	▪ Necrose ▪ mau odor ▪ mordedura ▪ pé diabético profundo ▪ ferida contaminada ▪ infecção polimicrobiana provável	Ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam ou metronidazol associado

ALERTAS DE SEGURANÇA**ATENÇÃO****Úlcera não infectada não recebe antibiótico**

Antibiótico não acelera cicatrização sem sinais clínicos de infecção.

ALERTA CRÍTICO**Avaliar perfusão e necessidade cirúrgica**

Isquemia, necrose, abscesso ou osso desvitalizado impedem cura; considerar vascular, ortopedia/cirurgia e revascularização.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Úlcera infectada	Classificar gravidade, avaliar perfusão e probe-to-bone.
2	Suspeita de osso	Solicitar radiografia; RM se dúvida/planejamento.
3	Coleta	Preferir tecido profundo/osso; evitar swab superficial.
4	Tratamento	Combinar antibiótico, desbridamento/offloading e controle glicêmico/perfusão.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepses ▪ infecção extensa/profunda ▪ necrose/gangrena ▪ isquemia ▪ necessidade de cirurgia ▪ falha ambulatorial.
UTI	▪ Choque ▪ fascite/necrose extensa.
Falha terapêutica	▪ Piora local ▪ febre ▪ PCR sem queda ▪ necrose progressiva ▪ dor desproporcional.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de tecido profundo/osso após limpeza/debridamento; hemoculturas se sepsis.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Reduzir espectro conforme cultura profunda. ▪ Retirar MRSA/Pseudomonas se sem critério ou cultura negativa. ▪ Não tratar colonização de swab superficial como agente obrigatório.

EIXO	CONDUTA
Transição EV → VO	Até 6 semanas se osteomielite sem ressecção; até 3 semanas se margem óssea positiva após amputação menor; menor se ressecção completa com margem limpa.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida	<50–60 mL/min: Ajustar conforme CLCr	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Amoxicilina-clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não é opção isolada para sepse	<50–60 mL/min: Ajustar em DRC avançada	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual	

9.6

Infecção de Material de Síntese / Osteossíntese

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção em placa, haste, parafuso ou fixador após fratura/cirurgia. Suspeitar com dor progressiva, hiperemia, secreção, deiscência, febre, pseudoartrose ou soltura. Biofilme, estabilidade do implante e consolidação da fratura orientam retenção, troca ou retirada.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Cefepime

Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Prolongada; depende de debridamento, retenção ou retirada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Estafilococos coagulase-negativos	FREQUENTE	
Cutibacterium acnes	CONTEXTUAL	Ombro/material, curso indolente.
Bacilos Gram-negativos	CONTEXTUAL	Trauma aberto/hospitalar.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção pós-operatória/hardware sem cultura	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Até cultura; total individualizado	Coletar culturas profundas múltiplas no debridamento; cobertura antipseudomonal se trauma aberto/hospitalar/isolamento prévio.
MSSA confirmado	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h OU Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	Individualizar	Avaliar papel de rifampicina se material retido e agente sensível, com especialista.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Aztreonam · Vancomicina EV + Aztreonam 2 g EV 8/8 h · EV	Conforme cultura	Coertura temporária até cultura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodiálise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepse grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia
PSEUDOMONAS	▪ Infecção hospitalar ▪ trauma aberto/ferida contaminada ▪ punção plantar ▪ uso recente de antibiótico amplo ▪ imunossupressão ou isolamento prévio	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme necessidade de anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

RIFAMPICINA DEPENDE DA ESTRATÉGIA CIRÚRGICA

Vincular duração à retenção/retirada/troca do implante. Usar rifampicina apenas para isolado suscetível, sempre com agente companheiro e após controle adequado do foco; nunca como monoterapia.

ALERTA CRÍTICO

Controle de foco ortopédico

Debridamento e decisão sobre retenção/retirada são centrais.

ATENÇÃO

Biofilme

Material retido pode exigir estratégia combinada e/ou supressão em casos selecionados.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Radiografia, PCR/VHS, hemoculturas se febre e avaliação ortopédica.
2	Estável	Priorizar coleta profunda no debridamento antes de antibiótico.
3	Sepse	Iniciar empírico amplo após culturas possíveis.
4	Pós-cultura	Definir retenção/retirada, duração e eventual supressão.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de infecção profunda de hardware ▪ secreção persistente ▪ sepse ▪ necessidade de cirurgia.
UTI	▪ Choque séptico ▪ necrose extensa.
Falha terapêutica	▪ Secreção persistente ▪ dor/PCR sem melhora ▪ soltura ▪ cultura positiva persistente.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Culturas profundas múltiplas no intraoperatório, idealmente várias amostras separadas; evitar swab superficial.
Controle de foco	Definir retenção/retirada, duração e eventual supressão.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	Direcionar por culturas profundas e plano cirúrgico.
Transição EV → VO	Duração depende de retenção/retirada, consolidação óssea e agente.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h GRAVE 2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	<50–60 mL/min: Ajustar conforme ClCr	
Oxacilina EV	2 g EV 4/4 h GRAVE 2 g EV 4/4 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual; monitorar sódio e função hepática	
Cefazolina EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Ajustar se DRC importante	

9.7

Bursite Séptica — Olecraniana/Pré-patelar

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Edema, calor e dor sobre bursa superficial, geralmente olecraniana ou pré-patelar, após trauma/microtrauma. Diferenciar de celulite e artrite séptica; amplitude articular preservada favorece bursite, mas dúvida exige avaliação/aspiração.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefalexina ou cobertura MRSA conforme risco
Cefalexina 500 mg VO 6/6 h; ajustar se MRSA

VIA
VO

DURAÇÃO
10–14 dias em geral; aspirar/drenar se pus, recorrência, dúvida diagnóstica ou falha

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	PRINCIPAL	
Streptococcus pyogenes	FREQUENTE	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Bursite superficial sem sepse	Cefalexina · 500 mg VO 6/6 h · VO	10–14 dias	Aspirar se dúvida diagnóstica, flutuação importante ou falha.
Febre, celulite extensa, imunossupressão ou falha VO	Vancomicina · 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h · EV	10–14 dias ou conforme resposta	Internar se grave/falha.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
MRSA provável ou alergia a betalactâmico	Clindamicina ou SMX-TMP · Clindamicina 300–450 mg VO a cada 6–8 h OU SMX-TMP 800/160 mg (1 comprimido) VO 12/12 h; 2 comprimidos em adulto de grande porte conforme protocolo · VO	10–14 dias	SMX-TMP tem menor cobertura estreptocócica; considerar associação conforme celulite.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodíalise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou sepse grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Excluir artrite séptica

Dor intra-articular intensa, limitação global e derrame articular mudam a conduta; não infiltrar corticoide em suspeita infecciosa.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Avaliação	Examinar amplitude articular; se dúvida, aspirar bursa e/ou articulação.
2	Leve	ATB VO, compressão/repouso relativo e retorno em 48 h.
3	Pus/falha	Aspiração/drenagem e cultura.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre alta ▪ imunossupressão ▪ celulite extensa ▪ falha VO ▪ suspeita de artrite séptica.
Falha terapêutica	▪ Aumento de dor/edema ▪ febre ▪ sem melhora em 48–72 h.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Aspirado da bursa para Gram/cultura quando purulenta, recorrente, grave ou dúvida diagnóstica.
Controle de foco	Aspiração/drenagem e cultura.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	Ajustar por cultura do aspirado.
Transição EV → VO	VO é padrão em casos leves/moderados sem sepse.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefalexina VO	500 mg VO 6/6 h GRAVE Não usar isolada em sepse	<50–60 mL/min: Ajustar se DRC avançada	
Clindamicina VO/EV	300–450 mg VO a cada 6–8 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

9.8

Tenossinovite Piogênica dos Flexores — Mão

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção fechada da bainha dos tendões flexores, geralmente após ferimento perfurante ou mordedura. Dor à extensão passiva, dedo em flexão, edema fusiforme e dor no trajeto do tendão são sinais de Kanavel. É urgência cirúrgica/da mão.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ampicilina-sulbactam
Vancomicina EV + Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7–14 dias ou mais conforme achado cirúrgico, necrose, mordedura ou osteoarticular associada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Flora oral/anaeróbios	CONTEXTUAL	Mordedura humana/animal.
Gram-negativos	CONTEXTUAL	Imunossupressão ou ferida contaminada.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de tenossinovite flexora	Vancomicina + Ampicilina-sulbactam · Vancomicina EV + Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h · EV	7–14 dias ou conforme achado cirúrgico	Acionar cirurgia da mão/ortopedia imediatamente; imobilizar em posição funcional e elevar.
Mordedura humana/animal associada	Ampicilina-sulbactam + Vancomicina se MRSA · Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h + Vancomicina se critério · EV	10–14 dias ou conforme profundidade	Cobrir anaeróbios, Eikenella/Pasteurella e S. aureus.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Ciprofloxacino + Metronidazol · Vancomicina EV + Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h + Metronidazol 500 mg 8/8 h · EV	Conforme cirurgia	Alternativa ampla; discutir infectologia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização/infecção prévia por MRSA ▪ hemodíalise ▪ internação ou antibiótico recente ▪ infecção associada a cuidado de saúde ▪ abscesso/pus ou seps grave	Vancomicina; considerar daptomicina em bacteremia persistente ou intolerância, conforme infectologia

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Necrose ▪ mau odor ▪ mordedura ▪ pé diabético profundo ▪ ferida contaminada ▪ infecção polimicrobiana provável	Ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam ou metronidazol associado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Urgência cirúrgica

Atraso aumenta risco de necrose tendínea, rigidez e perda funcional.

ATENÇÃO

Não tratar como celulite simples

Sinais de Kanavel exigem avaliação da mão/ortopedia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Imobilização/elevação, analgesia, hemoculturas se febre e antibiótico EV.
2	Confirmação clínica	Acionar cirurgia da mão/ortopedia para irrigação/drenagem.
3	Pós-operatório	Ajustar antibiótico por cultura e evolução funcional.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda suspeita de tenossinovite piogênica deve internar.
UTI	▪ Sepses/choque ▪ necrose extensa.
Falha terapêutica	▪ Dor/edema progressivo ▪ febre persistente ▪ déficit funcional.

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura intraoperatória/aspirado quando drenado; hemoculturas se febre/sepsis.
Controle de foco	Acionar cirurgia da mão/ortopedia para irrigação/drenagem.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	Direcionar por cultura profunda.
Transição EV → VO	Transição VO após controle cirúrgico, melhora clínica e ausência de sepsis.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque GRAVE 25–30 mg/kg EV dose de ataque; monitorar AUC/nível sérico	<50–60 mL/min: Ajustar por nível/AUC e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

OSTEOARTICULAR

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina-sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	<50–60 mL/min: Ajustar conforme ClCr	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	<50–60 mL/min: Sem ajuste renal usual	

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 09 — OSTEOARTICULAR

- IDSA. Native Vertebral Osteomyelitis, 2015.
- IDSA. Prosthetic Joint Infection, 2013.

10

Gineco/Obstétrico

8 quadros clínicos neste sistema

10.1	DIP — Doença Inflamatória Pélvica	201
10.2	Abscesso Tubo-Ovariano	203
10.3	Endometrite Pós-parto / Pós-procedimento	205
10.4	Infecção Intra-amniótica / Corioamnionite	208
10.5	Aborto Séptico / Infecção Pós-abortamento	210
10.6	Mastite Puerperal / Abscesso Mamário	212
10.7	Bartholinite / Abscesso de Bartholin	215
10.8	Corrimento Vaginal/Cervicite — Escolher a Síndrome	217

10.1

DIP — Doença Inflamatória Pélvica

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção ascendente do trato genital superior. No PS, tratar empiricamente quando houver dor pélvica/baixo ventre associada a dor à mobilização cervical, dor uterina ou dor anexial, principalmente com corrimento, sangramento anormal, febre ou risco de IST. Não aguardar exame confirmatório se a suspeita clínica for relevante.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol

Ceftriaxona 500 mg IM dose única (1 g se ≥150 kg) + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h + Metronidazol 500 mg VO 12/12 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

14 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria gonorrhoeae	FREQUENTE	Cobrir empiricamente mesmo se teste indisponível.
Chlamydia trachomatis	FREQUENTE	Doxiciclina é componente central se não gestante.
Anaeróbios e flora vaginal mista	FREQUENTE	Metronidazol é rotina em esquemas atuais e trata vaginose associada.
Mycoplasma genitalium	CONTEXTUAL	Pensar em falha/recorrência, especialmente se testes para gonococo/clamídia negativos.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve/moderada, não gestante, sem sepse, sem abscesso, tolerando VO	Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol · Ceftriaxona 500 mg IM dose única (1 g se ≥150 kg) + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h + Metronidazol 500 mg VO 12/12 h · Mista	14 dias	Reavaliar em 48–72 h. Orientar abstinência até tratamento concluído/sintomas resolvidos e avaliação/tratamento de parceiros conforme IST.
Grave, vômitos, falha ambulatorial, gestante, dúvida cirúrgica ou abscesso	Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol · Ceftriaxona 1 g EV 24/24 h + Doxiciclina 100 mg EV/VO 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV/VO 12/12 h · VO/EV	EV até melhora clínica; completar 14 dias	Imagem pélvica se massa anexial, dor intensa, suspeita de abscesso ou ausência de resposta.
Alternativa parenteral clássica quando disponível	Cefoxitina/Cefotetan + Doxiciclina · Cefoxitina 2 g EV 6/6 h ou Cefotetan 2 g EV 12/12 h + Doxiciclina 100 mg 12/12 h · EV	EV até melhora	Escolher conforme disponibilidade local; manter anaeróbio se abscesso ou doença mais grave.

Sobre a duração: Completar 14 dias com doxiciclina + metronidazol/clindamicina conforme cenário.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a cefalosporina ou alternativa hospitalar	Clindamicina + Gentamicina · Clindamicina 900 mg EV 8/8 h + Gentamicina EV conforme peso/protocolo · EV	EV até melhora	Útil em quadros graves/abscesso; ajustar gentamicina por função renal e monitorização.
Gestante com suspeita de DIP	Internação + esquema EV definido com obstetrícia/infectologia · Evitar doxiciclina; individualizar conforme idade gestacional e gravidade · EV	Conforme diagnóstico e resposta	DIP na gestação é incomum, mas potencialmente grave; internar e revisar diferenciais obstétricos.

Sobre a duração: Completar 14 dias com esquema oral adequado.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ DIP moderada/grave ▪ vaginose associada ▪ abscesso tubo-ovariano ▪ odor fétido ▪ massa anexial	Metronidazol ou clindamicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

β-hCG é obrigatório em idade fértil

Excluir gestação ectópica, aborto, torção ovariana, apendicite e outras emergências antes de ancorar em DIP.

ATENÇÃO

Reavaliar em 48–72 h

Sem melhora exige internação, imagem, revisão diagnóstica e avaliação de abscesso tubo-ovariano.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor pélvica em idade fértil	Fazer β-hCG, avaliar abdome/pelve, gravidade, IST e diagnósticos cirúrgicos/obstétricos.
2	Suspeita mínima de DIP e sem emergência alternativa	Iniciar tratamento empírico; não esperar cultura/teste molecular se indisponível.
3	Critérios de internação ou falha	Internar, EV, imagem pélvica e ginecologia.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Gestação ▪ sepse/toxemia ▪ náuseas/vômitos impedindo VO ▪ falha ambulatorial ▪ abscesso tubo-ovariano ▪ dúvida cirúrgica ▪ dor intensa ou peritonismo
Gravidade	▪ Febre alta ▪ defesa abdominal ▪ massa anexial ▪ instabilidade ▪ dor desproporcional
Falha terapêutica	▪ Piora ou ausência de melhora em 48–72 h ▪ persistência de febre/dor ▪ massa anexial crescente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste de gonococo/clamídia quando disponível; HIV, sífilis e hepatites conforme risco; β-hCG obrigatório em idade fértil.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Direcionar por teste de gonococo/clamídia, cultura quando disponível e evolução clínica. ▪ Evitar quinolona empírica para DIP se gonorreia não foi excluída e há risco local de resistência.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona VO/EV	500 mg IM dose única; 1 g se ≥150 kg GRAVE 1 g EV 24/24 h em internação	Geral: Revisar função renal, peso, gestação e protocolo local antes da dose final.	
Doxiciclina VO/EV	100 mg VO 12/12 h por 14 dias GRAVE 100 mg EV/VO 12/12 h	Geral: Sem ajuste renal usual; evitar na gestação.	
Metronidazol VO/EV	500 mg VO 12/12 h por 14 dias GRAVE 500 mg EV/VO 12/12 h	Geral: Sem ajuste renal usual; cautela/ajuste em hepatopatia grave.	

10.2

Abscesso Tubo-Ovariano

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Complicação grave da DIP com massa anexial/inflamatória. Requer internação, antibiótico EV com cobertura para IST, Gram-negativos e anaeróbios, além de avaliação ginecológica para drenagem ou cirurgia se grande, roto, instável ou refratário.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol

Ceftriaxona 1 g EV 24/24 h + Doxiciclina 100 mg EV/VO 12/12 h + Metronidazol 500 mg EV/VO 12/12 h

VIA

EV

DURAÇÃO

EV até melhora; completar pelo menos 14 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Anaeróbios e flora vaginal mista	FREQUENTE	
Enterobacterales	MODERADO	
N. gonorrhoeae / C. trachomatis	CONTEXTUAL	
Streptococcus spp.	CONTEXTUAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Abscesso não roto, estável, sem choque	Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol · Ceftriaxona 1 g EV 24/24 h + Doxiciclina 100 mg 12/12 h + Metronidazol 500 mg 12/12 h · EV	EV até melhora; completar 14 dias	Internar. Solicitar USG/TC conforme disponibilidade. Reavaliar necessidade de drenagem se grande ou resposta lenta.
Ruptura, peritonite, sepse ou instabilidade	Piperacilina-tazobactam ± Doxiciclina · Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; manter Doxiciclina se cobertura de clamídia/IST necessária · EV	Conforme controle de foco	Acionar ginecologia imediatamente. Considerar UTI, laparoscopia/laparotomia ou drenagem.

Sobre a duração: Depois completar curso dirigido.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico ou alternativa clássica	Clindamicina + Gentamicina · Clindamicina 900 mg EV 8/8 h + Gentamicina EV conforme peso/protocolo · EV	EV até melhora	Monitorar função renal e níveis conforme protocolo.
Risco ESBL, internação recente, antibiótico recente ou choque	Meropenem ± Doxiciclina · Meropenem 1 g EV 8/8 h; associar Doxiciclina se IST ainda for hipótese relevante · EV	Conforme controle de foco e resposta	Reservar para risco real de resistência/gravidade; descalonar com cultura.

Sobre a duração: Completar 14 dias com clindamicina ou metronidazol + doxiciclina conforme tolerância.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	Abscesso tubo-ovariano suspeito/confirmado, especialmente se grande, sintomático, febre, dor importante ou falha clínica	Metronidazol, clindamicina ou betalactâmico/inibidor
ESBL	▪ Colonização prévia ▪ internação/antibiótico recente ▪ choque séptico com risco epidemiológico	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

REAVALIAR CONTROLE DE FOCO EM 48–72 H

Ausência de melhora em 48–72 h, coleção grande, ruptura ou instabilidade exige drenagem guiada ou cirurgia; não insistir apenas em troca de antibiótico.

ALERTA CRÍTICO

Ruptura é emergência cirúrgica

Peritonite, choque ou piora abrupta exigem ginecologia/cirurgia imediata e antibiótico amplo.

ATENÇÃO

Antibiótico isolado pode falhar

Abscessos grandes, persistentes ou refratários podem precisar de drenagem guiada ou cirurgia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Massa anexial + quadro infeccioso	Internar, iniciar EV, solicitar imagem e acionar ginecologia.
2	Estável	Antibiótico EV amplo e reavaliação em 24–48 h.
3	Ruptura/choque/falha	Controle de foco com drenagem/cirurgia; ampliar cobertura conforme risco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita/confirmação de abscesso tubo-ovariano, massa anexial infecciosa ou necessidade de terapia EV/avaliação ginecológica
UTI	▪ Choque ▪ peritonite ▪ rotura ▪ lactato elevado ▪ disfunção orgânica
Gravidade	▪ Massa grande ▪ dor intensa ▪ febre persistente ▪ imunossupressão

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▫ Sem melhora em 48–72 h ▫ crescimento da coleção ▫ febre persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se febre alta/sepse; cultura de material drenado quando houver controle de foco; testes de IST conforme cenário.
Controle de foco	Controle de foco com drenagem/cirurgia; ampliar cobertura conforme risco.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	1 g EV 24/24 h GRAVE 1–2 g EV 24/24 h conforme gravidade/protocolo	Geral: Revisar função renal, peso, gestação e protocolo local antes da dose final.	
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida em sepsse	<40 mL/min: Ajustar intervalo/dose conforme função renal.	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 1–2 g EV 8/8 h em infusão estendida conforme gravidade	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo.	

10.3

Endometrite Pós-parto / Pós-procedimento

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Infecção uterina pós-parto, pós-cesárea, pós-abortamento ou pós-procedimento, geralmente polimicrobiana. Suspeitar com febre, dor uterina, subinvolução, lóquios fétidos ou piora sistêmica. Avaliar retenção de produtos, abscesso pélvico, tromboflebite séptica e foco cirúrgico.

CONDUTA DE PARTIDA Clindamicina + Gentamicina Clindamicina 900 mg EV 8/8 h + Gentamicina EV conforme peso/protocolo	VIA EV DURAÇÃO Até 24–48 h afebril e melhora clínica; individualizar se complicação
---	---

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Anaeróbios	FREQUENTE	
Streptococcus spp. / Enterococcus spp.	FREQUENTE	
Enterobacterales	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus	CONTEXTUAL	Mais relevante em ferida operatória/dispositivo/cuidado de saúde.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Endometrite puerperal típica, especialmente pós-cesárea	Clindamicina + Gentamicina · Clindamicina 900 mg EV 8/8 h + Gentamicina EV conforme peso/ protocolo local · EV	Até 24–48 h afebril e clinicamente melhor	Não é obrigatório completar antibiótico VO se boa resposta e sem complicação, conforme protocolo.
Suspeita de Enterococcus ou falha parcial ao esquema inicial	Clindamicina + Gentamicina + Ampicilina · Adicionar Ampicilina 2 g EV 6/6 h · EV	Conforme resposta	Considerar quando febre persiste, cultura sugere enterococo ou quadro pós-instrumentação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse, foco cirúrgico, infecção hospitalar ou necessidade de esquema único amplo	Piperacilina-tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	Conforme foco e evolução	Avaliar retenção, abscesso, ferida operatória e necessidade de controle de foco.
Ferida operatória purulenta, colonização ou risco MRSA	Adicionar Vancomicina ao esquema de base · Vancomicina 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque se indicada · EV	Conforme cultura e foco	Não usar MRSA de rotina sem critério.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	- Endometrite pós-parto/pós-cesárea - lóquios fétidos - abscesso pélvico	Clindamicina, metronidazol ou betalactâmico/inibidor
MRSA	- Ferida purulenta - colonização prévia - internação prolongada - choque sem foco claro	Vancomicina
ESBL	- ESBL prévio - antibiótico/internação recente - seps hospitalar	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Procurar retenção/abscesso se não melhora

Febre persistente após 48–72 h exige imagem, revisão de foco e avaliação ginecológica.

ATENÇÃO

Não confundir com mastite/ITU/ferida operatória

No puerpério, febre pode ter múltiplos focos simultâneos.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre pós-parto/procedimento + dor uterina/lóquios fétidos	Internar, iniciar antibiótico EV e examinar ferida/mamas/urina.
2	Boa resposta	Manter até afebril/melhora sustentada; evitar prolongamento desnecessário se não complicada.
3	Sem resposta	USG/TC, avaliar retenção, abscesso, tromboflebite séptica ou foco cirúrgico.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita pós-parto/pós-procedimento com febre e dor uterina ▪ cesárea recente ▪ sepse ▪ falha ambulatorial
UTI	▪ Choque ▪ disfunção orgânica ▪ lactato elevado
Falha terapêutica	▪ Febre >48–72 h ▪ dor persistente ▪ sinais de abscesso ou retenção

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepse/febre alta; cultura de ferida ou material uterino se obtido; urina se sintomas ou dúvida de foco.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Clindamicina EV	900 mg EV 8/8 h GRAVE 900 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual.	
Gentamicina EV	Conforme peso/protocolo local GRAVE Dose estendida conforme protocolo, monitorar nível/função renal	Reduzido: Ajuste obrigatório; evitar se risco renal importante quando houver alternativa.	
Ampicilina EV	2 g EV 6/6 h GRAVE 2 g EV a cada 4–6 h conforme gravidade	<50 mL/min: Ajustar intervalo.	

10.4

Infecção Intra-amniótica / Corioamnionite

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Infecção suspeita/confirmada durante trabalho de parto ou com membranas rotas. O antibiótico intraparto reduz complicações maternas e neonatais. A infecção intra-amniótica isolada raramente é indicação de cesárea; a condução obstétrica e comunicação com neonatologia são obrigatórias.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina + Gentamicina

Ampicilina 2 g EV 6/6 h + Gentamicina EV conforme peso/protocolo

VIA

EV

DURAÇÃO

Intraparto; não continuar automaticamente no pós-parto

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Flora genital polimicrobiana	FREQUENTE	
Streptococcus do grupo B	FREQUENTE	
Enterobacterales	MODERADO	
Anaeróbios	MODERADO	Cobertura adicional é mais relevante em cesárea.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de infecção intra-amniótica intraparto	Ampicilina + Gentamicina · Ampicilina 2 g EV 6/6 h + Gentamicina conforme peso/protocolo · EV	Durante o trabalho de parto; reavaliar pós-parto	Associar antitérmico, hidratação, avaliação materno-fetal e comunicar neonatologia.
Cesárea em paciente com infecção intra-amniótica	Ampicilina + Gentamicina + Clindamicina · Ampicilina 2 g EV 6/6 h + Gentamicina conforme protocolo + Clindamicina 900 mg EV no momento da cesárea/cordão conforme protocolo · EV	Não prolongar automaticamente	Clindamicina adiciona anaeróbios no contexto de cesárea.

Sobre a duração: Continuar se febre persistente, bacteremia ou complicação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa institucional quando aminoglicosídeo não é desejável	Ampicilina-sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	Conforme parto e evolução	Checar protocolo obstétrico local e função renal.
Sepse, cuidado de saúde ou necessidade de cobertura ampla	Piperacilina-tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	Conforme foco, parto e evolução	Individualizar com obstetrícia/infectologia; considerar perfil local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Cesárea ▪ líquido fétido ▪ quadro grave ▪ infecção polimicrobiana provável	Clindamicina ou betalactâmico/inibidor

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PÓS-PARTO NÃO É PROLONGAMENTO AUTOMÁTICO

Após parto vaginal, não manter antimicrobiano de rotina se evolução favorável. Na cesariana, adicionar cobertura anaeróbia no momento definido pelo protocolo; continuar apenas por febre persistente, bacteremia ou complicação.

ALERTA CRÍTICO

Avisar neonatologia

Risco neonatal exige equipe preparada e comunicação antes do parto quando possível.

ATENÇÃO

Corioamnionite isolada raramente indica cesárea

A via de parto deve seguir critério obstétrico; antibiótico e suporte não substituem condução obstétrica.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre intraparto com critérios associados	Iniciar antibiótico EV, antitérmico e comunicar obstetrícia/neonatologia.
2	Cesárea	Adicionar anaeróbio conforme protocolo; não manter pós-parto automaticamente se estável.
3	Sepse materna	Bundle de seps, culturas se não atrasar e antibiótico amplo sem atrasar assistência obstétrica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda suspeita de infecção intra-amniótica
UTI	▪ Choque ▪ lactato elevado ▪ disfunção orgânica ▪ necessidade de vasopressor
Gravidade	▪ Febre materna associada a taquicardia fetal/materna ▪ líquido fétido ▪ dor uterina ▪ seps

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se seps; investigação obstétrica/neonatal conforme protocolo. Não atrasar antibiótico por cultura.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ampicilina EV	2 g EV 6/6 h GRAVE 2 g EV a cada 4–6 h conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar intervalo.	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Gentamicina EV	Conforme peso/protocolo GRAVE Dose estendida conforme protocolo	Reduzido: Ajuste obrigatório e monitorização.	
Clindamicina EV	900 mg EV quando indicada GRAVE 900 mg EV 8/8 h se manutenção necessária	Geral: Sem ajuste renal usual.	

10.5

Aborto Séptico / Infecção Pós-abortamento

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Emergência infecciosa com risco de choque, hemorragia, perfuração uterina e sepse fulminante. Tratamento exige antibiótico EV imediato, ressuscitação e controle de foco com esvaziamento uterino/drenagem/cirurgia quando indicado. Não retardar controle de foco por antibiótico isolado.

CONDUTA DE PARTIDA

Controle uterino urgente + antimicrobiano de amplo espectro guiado por gravidade

Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; associar vancomicina se MRSA/cuidado de saúde/choque sem foco claro

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme controle de foco e evolução

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Flora genital polimicrobiana	FREQUENTE	
Anaeróbios	FREQUENTE	
Enterobacterales	FREQUENTE	
Streptococcus pyogenes / Clostridium spp.	RARO	Pensar em choque tóxico, dor desproporcional, hemólise ou evolução fulminante.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Aborto séptico ou pós-abortamento infectado com sepse	Piperacilina-tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h · EV	Conforme controle de foco e resposta	Acionar ginecologia. Esvaziamento uterino/controle de foco é parte central do tratamento.
Choque tóxico, suspeita de Streptococcus/Clostridium ou dor desproporcional	Piperacilina-tazobactam + Clindamicina ± Vancomicina · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h + Clindamicina 900 mg EV 8/8 h; Vancomicina se MRSA/cuidado de saúde · EV	Conforme foco e evolução	Clindamicina como anti-toxina em suspeita de síndrome toxigênica.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco ESBL, choque refratário, internação/antibiótico recente	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1 g EV 8/8 h; considerar 2 g EV 8/8 h/infusão estendida em choque conforme protocolo · EV	Conforme controle de foco	Reservar para alto risco de resistência ou gravidade extrema; descalonar com cultura.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Clindamicina + Gentamicina ± Vancomicina · Clindamicina 900 mg EV 8/8 h + Gentamicina conforme protocolo; Vancomicina se MRSA/ enterococo resistente · EV	Conforme foco e cultura	Ideal discutir com infectologia; alto risco, não manejar apenas ambulatorial- mente.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	Todo aborto séptico	Piperacilina-tazobactam, clindamicina ou carbapenêmico
MRSA	▫ Cuidado de saúde ▫ colonização prévia ▫ choque grave sem foco definido	Vancomicina
ESBL	▫ Colonização ESBL ▫ antibiótico/internação recente ▫ choque com risco epidemiológico	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA**ALERTA CRÍTICO****ESVAZIAMENTO E CULTURA SÃO O EIXO**

Acionar ginecologia, colher sangue/material quando não atrasar e realizar esvaziamento/controle uterino. Adicionar vancomicina somente com risco de MRSA/assistência, dispositivo ou achado compatível — não por “choque sem foco”.

ALERTA CRÍTICO**Controle de foco é obrigatório**

Antibiótico isolado não resolve retenção infectada, perfuração, abscesso ou necrose.

ALERTA CRÍTICO**Tratar como sepse grave**

Culturas se não atrasar, antibiótico imediato, ressuscitação e ginecologia urgente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de aborto séptico	Acionar ginecologia, iniciar antibiótico EV amplo e bundle de sepse sem atraso.
2	Retenção uterina/foco	Controle de foco com esvaziamento/drenagem/cirurgia conforme avaliação.
3	Choque ou toxemia	UTI, vasopressor se necessário e ampliar cobertura conforme risco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de aborto séptico, instabilidade, dor importante, febre/toxemia ou necessidade de abordagem uterina
UTI	▫ Instabilidade ▫ lactato elevado ▫ disfunção orgânica ▫ choque ▫ sangramento importante
Gravidade	▫ Dor intensa ▫ corrimento fétido ▫ peritonite ▫ hipotensão ▫ confusão ▫ oligúria

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas, cultura de material uterino se obtido, lactato, hemograma, função renal/hepática/coagulograma e imagem quando indicada.
Controle de foco	Controle de foco com esvaziamento/drenagem/cirurgia conforme avaliação.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida em choque	<40 mL/min: Ajustar dose/intervalo.	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 1-2 g EV 8/8 h em infusão estendida conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo.	
Vancomicina EV	15-20 mg/kg EV a cada 8-12 h após ataque se indicado GRAVE 25-30 mg/kg EV ataque, depois guiar por AUC/nível	Qualquer redução: Ajustar por função renal e nível/AUC.	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

10.6

Mastite Puerperal / Abscesso Mamário

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026

Mastite lactacional cursa com dor, eritema, calor local e sintomas sistêmicos. O tratamento inclui esvaziamento mamário eficaz, analgesia e antibiótico quando bacteriana. Abscesso precisa de drenagem/aspiração além do antibiótico.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefalexina; oxacilina EV se internação

Cefalexina 500 mg VO 6/6 h

VIA

VO

DURAÇÃO

10-14 dias conforme resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus MSSA	FREQUENTE	
Streptococcus spp.	MODERADO	
MRSA comunitário	RISCO ESPECÍFICO	Cobrir se abscesso, recorrência, falha ou epidemiologia local.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mastite bacteriana leve/moderada, sem abscesso e sem risco MRSA	Cefalexina · 500 mg VO 6/6 h · VO	10–14 dias	Manter amamentação/esvaziamento quando possível; suporte local e analgesia.
Toxemia, falha VO, celulite extensa ou internação	Oxacilina ou Cefazolina · Oxacilina 2 g EV 4/4 h ou Cefazolina 2 g EV 8/8 h · EV	EV até melhora; completar 10–14 dias	Pesquisar abscesso se massa, flutuação ou resposta ruim.
Abscesso mamário	Drenagem/aspiração + antibiótico dirigido · Conduta/procedimento: drenagem/aspiração; antibiótico conforme risco MRSA e cultura · Procedimento	10–14 dias ou conforme resposta	Enviar cultura do material. Antibiótico isolado costuma falhar em coleção.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco MRSA, abscesso, falha a betalactâmico ou alergia	SMX-TMP ou Clindamicina · SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h ou Clindamicina 300–450 mg VO a cada 6–8 h · VO	10–14 dias	Evitar SMX-TMP em recém-nascido prematuro, icterícia significativa ou deficiência de G6PD; individualizar lactação.
MRSA grave ou internação	Vancomicina · 15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h após dose de ataque se indicada · EV	Conforme resposta/cultura	Descalonar se MSSA.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Abscesso ▪ falha a betalactâmico ▪ recorrência ▪ colonização/contato MRSA ▪ alta prevalência local	SMX-TMP, clindamicina ou vancomicina se grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

MANTER DRENAGEM DA MAMA

Manter amamentação/ordenha quando segura e tolerada. Solicitar ultrassom se massa, flutuação ou falha; drenar coleção e cultivar. Cobertura de MRSA depende de risco, cultura e gravidade.

ATENÇÃO**Abscesso exige drenagem**

Massa flutuante, coleção ao USG ou falha clínica devem levar a aspiração/drenagem e cultura.

INFORMAÇÃO

Esvaziamento mamário é terapêutico

Suspender amamentação/esvaziamento pode piorar estase; orientar caso a caso.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Mastite sem abscesso	Esvaziamento mamário + analgesia + antibiótico anti-MSSA se bacteriana.
2	Risco MRSA ou alergia	Escolher clindamicina/SMX-TMP conforme lactação, neonato e perfil local.
3	Massa/flutuação/falha	USG, cultura e drenagem/aspiração.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepsis/toxemia ▪ falha ambulatorial ▪ celulite extensa ▪ imunossupressão ▪ abscesso grande/complexo
Gravidade	▪ Febre alta ▪ calafrios ▪ taquicardia ▪ dor intensa ▪ necrose
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 24–48 h ▪ massa persistente ▪ piora do eritema

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de leite não é rotina em caso leve; colher material de abscesso, recorrência, grave ou falha terapêutica.
Controle de foco	▪ Esvaziamento mamário + analgesia + antibiótico anti-MSSA se bacteriana. ▪ USG, cultura e drenagem/aspiração.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefalexina VO	500 mg VO 6/6 h GRAVE Não indicada isolada para sepsis	<50 mL/min: Ajustar intervalo.	
Clindamicina VO/EV	300–450 mg VO a cada 6–8 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual.	
SMX-TMP VO	800/160 mg VO 12/12 h GRAVE Dose conforme peso em infecção grave	<30 mL/min: Ajustar/evitar conforme função renal e potássio.	

10.7

Bartholinite / Abscesso de Bartholin

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026

Abscesso/cisto infectado da glândula de Bartholin. A base do tratamento do abscesso é drenagem adequada, idealmente com Word catheter/marsupialização conforme recorrência. Antibiótico não é obrigatório em todo abscesso drenado simples; usar quando há celulite, IST, gestação, imunossupressão, recorrência ou sinais sistêmicos.

CONDUTA DE PARTIDA

Drenagem + antibiótico se critério

Incisão/drenagem ou Word catheter; antibiótico conforme celulite/IST/MRSA

VIA

Procedimento

DURAÇÃO

Antibiótico 5–7 dias se indicado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Flora vaginal/entérica polimicrobiana	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus / MRSA	RISCO ESPECÍFICO	
N. gonorrhoeae / C. trachomatis	CONTEXTUAL	Pesquisar/tratar se risco de IST.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Abscesso simples, sem celulite extensa e sem sinais sistêmicos	Drenagem/Word catheter · Conduta/procedimento: drenagem + analgesia/banho de assento · Procedimento	Sem antibiótico se drenagem adequada e baixo risco	Antibiótico isolado não substitui drenagem.
Celulite adjacente, febre, gestação, imunossupressão ou recorrência	Amoxicilina-clavulanato ou Cefalexina + Metronidazol · Amox-clav 875/125 mg VO 12/12 h ou Cefalexina 500 mg 6/6 h + Metronidazol 500 mg 12/12 h · VO	5–7 dias	Associar drenagem se houver coleção.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco MRSA ou abscesso purulento recorrente	SMX-TMP ou Clindamicina · SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h ou Clindamicina 300–450 mg VO a cada 6–8 h · VO	5–7 dias	Cobrir IST separadamente se risco.
Risco de gonococo/clamídia ou cervicite associada	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h por 7 dias · Mista	Dose única + 7 dias	Associar metronidazol se vaginose/tricomoníase ou DIP conforme quadro.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Recorrência ▪ abscesso purulento ▪ MRSA prévio ▪ falha a betalactâmico	SMX-TMP ou clindamicina

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Celulite extensa ▪ odor fétido ▪ polimicrobiana provável	Amoxicilina-clavulanato ou metronidazol associado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Drenagem é o centro do tratamento

Antibiótico sem drenagem tem alta chance de falha se houver coleção.

INFORMAÇÃO

Atenção em idade >40 anos

Massa nova/persistente de Bartholin em idade maior deve ter avaliação ginecológica para excluir neoplasia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Coleção dolorosa/flutuante	Drenar adequadamente; considerar Word catheter se disponível.
2	Crítérios para antibiótico	Escolher cobertura conforme celulite, IST, MRSA ou polimicrobiana.
3	Recorrência ou >40 anos	Encaminhar ginecologia para avaliação definitiva.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sepses ▪ celulite extensa ▪ imunossupressão importante ▪ falha de drenagem/controle ▪ dor intratável
Gravidade	▪ Febre ▪ extensão para períneo ▪ necrose ▪ dor desproporcional
Falha terapêutica	▪ Recorrência ▪ sem melhora após drenagem ▪ aumento da celulite

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura se recorrente, grave, falha, imunossupressão ou drenagem de material purulento; testes de IST conforme risco.
Controle de foco	Drenar adequadamente; considerar Word catheter se disponível.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-clavulanato VO	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não indicado isolado se sepse/necrose	<30 mL/min: Evitar formulação 875 mg; ajustar dose.	
Ceftriaxona IM	500 mg IM dose única se IST GRAVE 1 g se ≥150 kg	Geral: Revisar função renal, peso, gestação e protocolo local antes da dose final.	

10.8

Corrimento Vaginal/Cervicite — Escolher a Síndrome

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026

Abordagem sindrômica de corrimento vaginal/cervical no PS. Separar vaginite baixa de DIP, gestação, dor pélvica, sangramento, cervicite mucopurulenta e IST. Tratar conforme síndrome provável e testar gonococo/clamídia/sífilis/HIV quando indicado.

CONDUTA DE PARTIDA

Não há esquema único: diferenciar vaginose, tricomoníase e cervicite

Selecionar o ramo diagnóstico antes de prescrever

VIA

Conduta

DURAÇÃO

7 dias na maioria dos cenários

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Gardnerella/flora anaeróbia — vaginose bacteriana	FREQUENTE	
Trichomonas vaginalis	CONTEXTUAL	
Candida spp.	FREQUENTE	Prurido intenso, grumos, pH geralmente normal.
N. gonorrhoeae / C. trachomatis	CONTEXTUAL	Pensar em cervicite, dor pélvica, sangramento pós-coito/intermenstrual ou risco IST.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Vaginose bacteriana sintomática	Metronidazol · 500 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Opções tópicas podem ser usadas conforme disponibilidade; evitar tratar achado isolado sem sintomas exceto situações específicas.
Tricomoníase em mulher	Metronidazol · 500 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Tratar parceiros, evitar relação até tratamento concluído e sintomas resolvidos; testar outras IST.
Cervicite mucopurulenta/risco de gonococo e clamídia	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única (1 g se ≥150 kg) + Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h · Mista	Ceftriaxona dose única + doxiciclina 7 dias	Se gestante, substituir doxiciclina por azitromicina conforme protocolo.
Candidíase vulvovaginal não complicada	Fluconazol ouazol tópico · Fluconazol 150 mg VO dose única ouazol tópico conforme disponibilidade · VO	Dose única ou tópico 1–7 dias	Evitar fluconazol oral na gestação; preferirazol tópico por 7 dias.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Vaginose — opção tópica	Metronidazol gel ou Clindamicina creme · Metronidazol gel 0,75% 5 g intravaginal 24/24 h por 5 dias ou Clindamicina creme 2% à noite por 7 dias · Topica	5–7 dias	Escolher conforme disponibilidade, tolerância e gestação.
Tricomoníase em homem/parceiro	Metronidazol · 2 g VO dose única · VO	Dose única	Mulheres têm melhor resposta com 7 dias; tratar parceiros é fundamental.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cervicite/clamídia em gestante	Azitromicina ± Ceftriaxona · Azitromicina 1 g VO dose única; associar Ceftriaxona 500 mg IM dose única se risco de gonococo · Mista	Dose única	Testar e tratar parceiros; retorno e controle conforme protocolo pré-natal/IST.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▫ Vaginose bacteriana ▫ DIP associada ▫ odor fétido	Metronidazol ou clindamicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

METRONIDAZOL NÃO TRATA CERVICITE GONOCÓCICA/CLAMIDIANA

Não usar este quadro como prescrição única. Vaginose, tricomoníase e cervicite exigem diagnósticos, parceiros e esquemas diferentes.

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ALERTA CRÍTICO

Dor pélvica muda a conduta

Dor pélvica, febre ou dor à mobilização cervical devem acionar protocolo de DIP, não apenas vaginite.

ATENÇÃO

Gestação muda escolhas

Evitar doxiciclina e fluconazol oral de rotina; preferir opções seguras e articular pré-natal.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Corrimento sem dor pélvica/febre	Classificar síndrome: vaginose, candidíase, tricomoníase ou cervicite.
2	Cervicite ou risco IST	Tratar gonococo/clamídia conforme risco e coletar testes se disponíveis.
3	Dor pélvica/febre/gestação	Avaliar DIP, gestação ectópica e emergência ginecológica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Suspeita de DIP grave ▫ gestante com dor pélvica/febre ▫ sepse ▫ dor abdominal importante
Gravidade	▫ Febre ▫ dor pélvica ▫ sangramento importante ▫ peritonismo
Falha terapêutica	▫ Persistência/recorrência ▫ parceiros não tratados ▫ resistência ou diagnóstico incorreto

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT/testes para gonococo/clamídia quando disponíveis; teste de gravidez em idade fértil; HIV/sífilis/hepatites conforme risco; considerar microscopia/pH se disponível.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Metronidazol VO/EV	500 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE 500 mg EV/VO 12/12 h se DIP/infecção grave associada	Geral: Sem ajuste renal usual; cautela em hepatopatia grave.	
Ceftriaxona IM/EV	500 mg IM dose única; 1 g se ≥150 kg GRAVE 1 g EV/IM conforme cenário	Geral: Revisar função renal, peso, gestação e protocolo local antes da dose final.	
Azitromicina VO	1 g VO dose única para clamídia na gestante GRAVE Não é esquema para DIP grave isoladamente	Geral: Revisar função renal, peso, gestação e protocolo local antes da dose final.	

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/@@display-file/file

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 10 — GINECO/OBSTÉTRICO

- ACOG. Intrapartum Management of Intraamniotic Infection, Committee Opinion 712.
- CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.

CAPÍTULO

11

IST

9 quadros clínicos neste sistema

11.1	Uretrite / Cervicite — Abordagem Sindrômica Inicial	221
11.2	Gonorreia Não Complicada — Urogenital/Retal/Faríngea	223
11.3	Clamídia Não Complicada — Urogenital/Retal	226
11.4	Sífilis Adquirida — Primária/Secundária/Latente	228
11.5	Herpes Genital — Primeiro Episódio ou Recorrência	230
11.6	Tricomoníase — Adulto	232
11.7	Proctite por IST / Suspeita de LGV	234
11.8	Mycoplasma genitalium — Uretrite/Cervicite Persistente	236
11.9	Doxi-PEP — Prevenção Pós-Exposição de IST Bacteriana	238

11.1

Uretrite / Cervicite — Abordagem Síndrômica Inicial

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional **recomendada**

Síndrome de corrimento uretral/cervicite, disúria sexualmente associada ou exposição de risco. A decisão no PS deve separar quadro simples de DIP, epididimite, proctite, torção testicular ou doença sistêmica. Quando risco de gonococo é relevante ou o seguimento é incerto, tratar empiricamente gonococo e clamídia.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Doxiciclina

Ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h

VIA

IM

DURAÇÃO

Dose única + 7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Chlamydia trachomatis	FREQUENTE	
Neisseria gonorrhoeae	CONTEXTUAL	Cobrir se risco epidemiológico, seguimento incerto, cervicite purulenta ou alta prevalência local.
Mycoplasma genitalium	CONSIDERAR EM PERSISTÊNCIA/RECORRÊNCIA	
Trichomonas vaginalis	CONSIDERAR CONFORME SEXO, EXPOSIÇÃO E PREVALÊNCIA LOCAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Uretrite/cervicite com risco de gonococo, cervicite purulenta ou seguimento incerto	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h · IM/VO	Dose única + 7 dias	Se peso ≥150 kg, ceftriaxona 1 g IM. Se clamídia foi excluída por teste confiável, a doxiciclina pode ser omitida conforme protocolo.
Baixo risco de gonococo, teste disponível e provável uretrite não gonocócica/clamídia	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Reavaliar resultado e adicionar tratamento para gonococo se NAAT/cultura positivo ou risco reclassificado.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Gestação ou contraindicação à doxiciclina quando clamídia é provável	Azitromicina · 1 g VO dose única · VO	Dose única	Se gonococo possível, associar ceftriaxona. Gestante com clamídia exige controle de cura e retestagem conforme protocolo.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona indisponível para gonococo não complicado	Cefixima + Doxiciclina se clamídia não excluída · Cefixima 800 mg VO dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h por 7 dias · VO	Dose única + 7 dias	Alternativa inferior; evitar como solução de rotina para gonorreia faríngea quando houver ceftriaxona. A cefixima tem disponibilidade variável no Brasil — confirmar antes de contar com ela como plano B.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ATENÇÃO

Não perder diagnósticos complicados

Dor pélvica, febre, dor testicular, dor retal importante, lesões ulceradas ou toxemia mudam a síndrome e exigem outro fluxo.

INFORMAÇÃO

Parceiros e abstinência temporária

Orientar avaliação/tratamento de parceiros recentes e evitar relação sexual até completar tratamento, resolução de sintomas e parceiros tratados.

INFORMAÇÃO

Rastreo ampliado

Considerar HIV, sífilis, hepatites, gravidez e outras ISTs conforme exposição.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Corrimento/disúria/cervicite	Avaliar sinais de DIP, epididimite, torção, proctite e lesões ulceradas. Coletar NAAT para gonococo/ clamídia se disponível.
2	Risco de gonococo ou seguimento incerto	Tratar empiricamente com ceftriaxona + doxiciclina e orientar parceiros.
3	Persistência/recorrência	Checar adesão e reexposição; investigar M. genitalium, tricomônio e resistência gonocócica antes de repetir antibiótico empiricamente.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de DIP grave ou abscesso tubo-ovariano ▪ Dor testicular intensa com suspeita de torção ▪ Febre/toxemia ▪ Imunossupressão importante ▪ Proctite grave ou sangramento importante
Falha terapêutica	▪ Sintomas persistentes após 7 dias ▪ Reexposição por parceiro não tratado ▪ Suspeita de M. genitalium ▪ Suspeita de resistência gonocócica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT para gonococo/clamídia quando disponível; cultura e sensibilidade se suspeita de falha gonocócica; sorologias conforme exposição.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona IM	500 mg IM dose única GRAVE 1 g IM se peso ≥150 kg ou conforme síndrome complicada	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Doxiciclina VO Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Azitromicina VO	1 g VO dose única em clamídia na gestação GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condutas em IST dependem de disponibilidade de testes, prevalência local, rastreo de coinfeções, fluxo de notificação e tratamento de parceiros.
- Coletar NAAT/cultura/sorologias quando disponível, sem atrasar tratamento sintromico quando indicado.
- Orientar abstinência temporária, tratamento/avaliação de parceiros e retestagem quando aplicável.
- Investigar HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs conforme exposição e vulnerabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Urethritis and Cervicitis.
CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Gonococcal Infections.
CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Chlamydial Infections.
Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.
https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/@@display-file/file

11.2

Gonorreia Não Complicada — Urogenital/Retal/Faríngea

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção por *Neisseria gonorrhoeae* em sítio urogenital, retal ou faríngeo sem sinais de disseminação. Ceftriaxona IM é o tratamento preferencial; tratar clamídia junto se não foi excluída. Gonorreia faríngea exige maior atenção a falha e controle de cura.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Azitromicina — padrão Brasil/MS
Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Azitromicina 1 g VO dose única

VIA
IM

DURAÇÃO
Dose única

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria gonorrhoeae	DEFINIDOR	
Chlamydia trachomatis	COINFEÇÃO POSSÍVEL	Tratar se não excluída por teste confiável.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Gonorreia não complicada — protocolo Brasil/MS	Ceftriaxona + Azitromicina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Azitromicina 1 g VO dose única · IM/VO	Dose única	Coletar testes por sítio exposto quando disponíveis; faringe exige controle de cura conforme protocolo. Tratar parceiros e rastrear outras IST.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa internacional CDC, quando adotada institucionalmente	Ceftriaxona · 500 mg IM dose única (<150 kg) ou 1 g IM (≥150 kg); doxiciclina 100 mg 12/12 h por 7 dias se clamídia não excluída · IM	Dose única + 7 dias se necessário	Não misturar silenciosamente protocolos. Identificar no prontuário qual diretriz institucional foi aplicada.
Ceftriaxona indisponível ou alergia grave a cefalosporina	Gentamicina + Azitromicina · Gentamicina 240 mg IM dose única + Azitromicina 2 g VO dose única · IM/VO	Dose única	Esquema alternativo do CDC. A gentamicina isolada não é tratamento adequado para gonorreia; a azitromicina 2 g é parte obrigatória do esquema. Programar controle de cura.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ATENÇÃO

Faringe exige controle de cura

Realizar teste de cura em gonorreia faríngea no prazo definido pelo protocolo adotado e testar/retratar somente após avaliar reexposição, adesão e resistência.

ALERTA CRÍTICO

Suspeita de resistência ou falha

Persistência sem reexposição exige cultura, sensibilidade, notificação/apoio especializado e evitar repetir esquema às cegas.

INFORMAÇÃO

Clamídia associada

Adicionar doxiciclina se clamídia não foi excluída; na gestação, usar alternativa adequada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita/confirmada	Tratar com ceftriaxona na dose por peso e cobrir clamídia se não excluída.
2	Sítio faríngeo	Agendar controle de cura e reforçar abstinência/tratamento de parceiros.
3	Falha sem reexposição	Coletar cultura e sensibilidade, notificar/acionar referência e validar conduta institucional.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Artrite séptica ou infecção gonocócica disseminada ▪ Sepses ▪ DIP grave ▪ Abscesso tubo-ovariano ▪ Conjuntivite gonocócica hiperpurulenta

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Sintomas persistentes 3–5 dias sem reexposição ▪ Teste persistente positivo em faringe ▪ História de parceiro não tratado ou resistência local

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT por sítio exposto; cultura com teste de sensibilidade se falha terapêutica, suspeita de resistência ou necessidade epidemiológica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona IM	500 mg IM dose única GRAVE 1 g IM se ≥ 150 kg; doença disseminada exige outro esquema	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Gentamicina IM	240 mg IM dose única SEMPRE associada a azitromicina 2 g VO dose única GRAVE não indicada isoladamente	DRC importante: Evitar/validar risco de nefrotoxicidade.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de IST com maior risco de falha, resistência, gestação, acometimento neurológico/ocular/ótico ou necessidade de fluxo institucional específico.
- Validar protocolo local de IST/CCIH/infectologia quando houver falha terapêutica, resistência ou quadro complicado.
- Garantir notificação/seguimento quando indicado pelo fluxo municipal/estadual.
- Confirmar disponibilidade de testes confirmatórios, cultura/sensibilidade e terapia parenteral quando necessária.
- Gestantes, neurosífilis, sífilis ocular/ótica, doença disseminada e resistência gonocócica exigem condução protocolada.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC STI Treatment Guidelines — Gonococcal Infections Among Adolescents and Adults

Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/@@display-file/file

11.3

Clamídia Não Complicada — Urogenital/Retal

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Infecção por Chlamydia trachomatis sem DIP, epididimite grave ou LGV. Doxíciclina por 7 dias é preferencial em adultos não gestantes, especialmente para infecção retal. Gestação exige esquema seguro e controle de cura.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxíciclina

100 mg VO 12/12 h por 7 dias (adulto não gestante). Gestação ou contraindicação: azitromicina 1 g VO dose única

VIA

VO

DURAÇÃO

7 dias (doxíciclina) · dose única (azitromicina)

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Chlamydia trachomatis	DEFINIDOR	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Adulto não gestante	Doxíciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Preferencial, sobretudo em infecção retal. Orientar adesão completa.
Gestante ou impossibilidade de doxíciclina	Azitromicina · 1 g VO dose única · VO	Dose única	Padrão sintômico do PCDT brasileiro e opção segura na gestação; realizar controle de cura por NAAT cerca de 4 semanas depois.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Gestação ou contraindicação à doxíciclina	Azitromicina · 1 g VO dose única · VO	Dose única	Recomendado na gestação; realizar controle de cura por NAAT cerca de 4 semanas após tratamento e retestar em 3 meses.
Gestação, alternativa	Amoxicilina · 500 mg VO 8/8 h · VO	7 dias	Alternativa quando azitromicina não é adequada.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

DIVERGÊNCIA ENTRE PROTOCOLOS

O PCDT brasileiro utiliza azitromicina em abordagem ampla; CDC favorece doxíciclina por 7 dias, sobretudo na infecção retal. Usar diagnóstico, sítio, gestação, adesão e protocolo institucional.

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ATENÇÃO**Reinfecção é comum**

Tratar parceiros e retestar em cerca de 3 meses quando possível.

ATENÇÃO**Gestação muda o seguimento**

Gestante precisa de esquema seguro, controle de cura e retestagem.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	NAAT positivo ou forte suspeita	Tratar e orientar parceiros/abstinência temporária.
2	Gestação	Usar azitromicina ou amoxicilina conforme protocolo, controlar cura e retestar.
3	Persistência	Checar reexposição, adesão, gonococo, tricomonas e M. genitalium.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de DIP grave ▪ Epididimite grave/seps ▪ Gestante com dor pélvica importante ou complicação
Falha terapêutica	▪ Adesão incompleta ▪ Reexposição ▪ Infecção retal tratada com esquema menos efetivo ▪ Diagnóstico alternativo ou coinfeção

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT para clamídia; testar gonococo e outras ISTs conforme exposição.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Azitromicina VO Gestação: uso aceito	1 g VO dose única GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condutas em IST dependem de disponibilidade de testes, prevalência local, rastreamento de coinfeções, fluxo de notificação e tratamento de parceiros.
- Coletar NAAT/cultura/sorologias quando disponível, sem atrasar tratamento sintomático quando indicado.
- Orientar abstinência temporária, tratamento/avaliação de parceiros e retestagem quando aplicável.
- Investigar HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs conforme exposição e vulnerabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Chlamydial Infections.

Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf@@display-file/file

11.4

Sífilis Adquirida — Primária/Secundária/Latente

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Sífilis adquirida em adulto exige estadiamento correto, teste não treponêmico quantitativo basal e seguimento sorológico. Penicilina G benzatina é o tratamento de escolha para sífilis primária, secundária, latente recente e latente tardia. Gestação, neurosífilis, sífilis ocular/ótica e alergia à penicilina exigem fluxo especializado.

CONDUTA DE PARTIDA

Penicilina G Benzatina

2,4 milhões UI IM

VIA

IM

DURAÇÃO

Dose única se recente; se tardia/duração ignorada, 3 doses no total, uma por semana (3 semanas)

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Treponema pallidum	DEFINIDOR	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Primária, secundária ou latente recente	Penicilina G Benzatina · 2,4 milhões UI IM dose única · IM	Dose única	Registrar VDRL/RPR quantitativo basal e orientar seguimento sorológico.
Latente tardia ou duração ignorada	Penicilina G Benzatina · 2,4 milhões UI IM 1x/semana · IM	3 semanas	Total de 7,2 milhões UI. Evitar intervalos excessivos entre doses; gestantes exigem rigor maior no cronograma.
Neurosífilis, sífilis ocular ou ótica	Penicilina G cristalina · 18–24 milhões UI/dia EV, em 3–4 milhões UI a cada 4 h ou em infusão contínua · EV	10–14 dias	Ramo distinto: não tratar com penicilina benzatina. Avaliar punção lombar, oftalmologia/otorrinolaringologia e seguimento sorológico. Alguns protocolos acrescentam benzatina 2,4 milhões UI semanal por 3 semanas ao final.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia à penicilina, não gestante, sem neuro/ocular/ótica	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	14 dias se recente; 28 dias se tardia	Alternativa apenas quando seguimento é garantido e não há gestação/neuro/ocular/ótica.
Gestante ou suspeita de neurosífilis/ocular/ótica com alergia	Dessensibilização + penicilina · Conforme protocolo hospitalar · EV	Conforme estadiamento	Penicilina é necessária nesses cenários; validar fluxo especializado.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

REAÇÃO DE JARISCH-HERXHEIMER

Febre, calafrios, mialgia e piora transitória das lesões nas primeiras 24 h após a primeira dose de penicilina. É esperada, sobretudo na sífilis recente, e não caracteriza alergia — não suspender o tratamento. Orientar antitérmico e observação. Na gestante pode desencadear contrações e alterações do batimento cardíaco fetal: orientar procurar assistência obstétrica se isso ocorrer.

ALERTA CRÍTICO**NEUROLÓGICA, OCULAR OU ÓTICA É OUTRO RAMO**

Sintomas neurológicos, oculares ou auditivos exigem avaliação e esquema de neurosífilis, com especialistas quando indicado. Na gestação, penicilina é o tratamento adequado: alergia requer dessensibilização; não substituir por doxiciclina ou macrolídeo.

ALERTA CRÍTICO**Gestação**

Gestante com sífilis deve ser tratada com penicilina conforme estágio; alergia exige dessensibilização.

ALERTA CRÍTICO**Neuro/ocular/ótica**

Cefaleia intensa, alteração visual/auditiva, pares cranianos, meningismo ou déficit neurológico exigem avaliação específica e esquema diferente.

ATENÇÃO**Estadiamento incorreto muda duração**

Latente de duração ignorada deve ser tratada como tardia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Teste treponêmico/não treponêmico compatível	Estadiar, registrar título quantitativo basal e avaliar gestação/HIV/neuro/ocular/ótica.
2	Sífilis recente ou tardia	Aplicar penicilina G benzatina na duração correta conforme estágio.
3	Gestante, alergia ou sintomas neurológicos/oculares/óticos	Não improvisar esquema: acionar fluxo especializado para penicilina/dessensibilização ou tratamento EV.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de neurosífilis ▪ Sífilis ocular/ótica ▪ Gestante com alergia à penicilina ▪ Reação grave ou dúvida diagnóstica crítica
Falha terapêutica	▪ Não queda adequada de título no seguimento ▪ Aumento de quatro vezes no VDRL/RPR ▪ Reexposição ▪ Tratamento incompleto

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste treponêmico + não treponêmico quantitativo para seguimento; HIV e demais ISTs conforme contexto.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Penicilina G Benzatina IM Gestação: uso aceito	2,4 milhões UI IM GRAVE 3 doses no total, uma por semana (3 semanas), se tardia/duração ignorada	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Doxiciclina VO Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h GRAVE 14–28 dias conforme estágio	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de IST com maior risco de falha, resistência, gestação, acometimento neurológico/ocular/ótico ou necessidade de fluxo institucional específico.
- Validar protocolo local de IST/CCIH/infetologia quando houver falha terapêutica, resistência ou quadro complicado.
- Garantir notificação/seguimento quando indicado pelo fluxo municipal/estadual.
- Confirmar disponibilidade de testes confirmatórios, cultura/sensibilidade e terapia parenteral quando necessária.
- Gestantes, neurosífilis, sífilis ocular/ótica, doença disseminada e resistência gonocócica exigem condução protocolada.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Syphilis.
CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Latent Syphilis.
Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.
https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/@@display-file/file

11.5

Herpes Genital — Primeiro Episódio ou Recorrência

- LEVE
- AMBULATORIAL
- ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Infecção genital por HSV-1 ou HSV-2 com vesículas, úlceras dolorosas, disúria, linfonodomegalia ou recorrências. Antiviral reduz duração e sintomas, principalmente se iniciado precocemente. Doença disseminada, neurológica, retenção urinária importante, gestação complicada ou imunossupressão podem exigir EV/internação.

CONDUTA DE PARTIDA

Aciclovir

400 mg VO 8/8 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7–10 dias no primeiro episódio

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
HSV-2	FREQUENTE	
HSV-1	POSSÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Primeiro episódio clínico	Aciclovir · 400 mg VO 8/8 h · VO	7–10 dias	Pode estender se cicatrização incompleta.
Alternativa posológica	Valaciclovir · 1 g VO 12/12 h · VO	7–10 dias	Melhor comodidade posológica quando disponível.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Recorrência episódica	Valaciclovir · 500 mg VO 12/12 h por 3 dias ou 1 g VO 24/24 h por 5 dias · VO	3–5 dias	Iniciar nas primeiras 24 h ou pródromo.
Doença grave, disseminada, neurológica ou imunossuprimido importante	Aciclovir EV · 5–10 mg/kg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Ajustar função renal, hidratar e avaliar SNC/disseminação.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Gestação e lesão ativa

Gestante com herpes exige avaliação obstétrica; lesão ativa no parto muda conduta.

ALERTA CRÍTICO

Disseminado/neurológico

Febre alta, meningismo, retenção urinária, hepatite, pneumonite ou imunossupressão: considerar internação e aciclovir EV.

ATENÇÃO

Resistência em imunossuprimidos

Lesão progressiva apesar de antiviral adequado sugere resistência e requer especialista.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Lesão compatível	Iniciar antiviral se primeiro episódio, lesão extensa, dor importante ou recorrência precoce.
2	Recorrências frequentes	Considerar terapia supressiva ambulatorial e aconselhamento.
3	Grave/imunossuprimido	Internar, aciclovir EV, ajuste renal e investigação de disseminação/SNC.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	- Doença disseminada - Imunossupressão importante - Retenção urinária grave - Suspeita neurológica - Gestação com complicações
Falha terapêutica	- Lesões progressivas apesar de antiviral - Suspeita de resistência em imunossuprimido - Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	PCR/NAAT de lesão se dúvida diagnóstica; testar outras ISTs conforme exposição.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Aciclovir VO/EV	400 mg VO 8/8 h GRAVE 5–10 mg/kg EV 8/8 h	≥50 mL/min: Dose usual.; <50 mL/min: Ajustar intervalo/dose; garantir hidratação e evitar nefrotoxicidade.	
Valaciclovir VO	1 g VO 12/12 h no primeiro episódio GRAVE Não substitui aciclovir EV em doença grave	≥50 mL/min: Dose usual.; <50 mL/min: Ajustar intervalo/dose; garantir hidratação e evitar nefrotoxicidade.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condutas em IST dependem de disponibilidade de testes, prevalência local, rastreio de coinfeções, fluxo de notificação e tratamento de parceiros.
- Coletar NAAT/cultura/sorologias quando disponível, sem atrasar tratamento sintomático quando indicado.
- Orientar abstinência temporária, tratamento/avaliação de parceiros e retestagem quando aplicável.
- Investigar HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs conforme exposição e vulnerabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Genital Herpes.

11.6

Tricomoniase — Adulto

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Infecção por Trichomonas vaginalis. Em mulheres, metronidazol 500 mg VO 12/12 h por 7 dias é preferido; em homens, dose única pode ser usada. Tratar parceiros é essencial para evitar reinfeção.

CONDUTA DE PARTIDA

Metronidazol

Mulher: 500 mg VO 12/12 h por 7 dias (preferencial). Homem: 2 g VO dose única

VIA

VO

DURAÇÃO

7 dias na mulher · dose única no homem

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Trichomonas vaginalis	DEFINIDOR	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mulher — esquema preferencial	Metronidazol · 500 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Superior à dose única na mulher (CDC 2021). O PCDT brasileiro admite 2 g em dose única; quando a adesão for o fator limitante, registrar a escolha. Tratar parceiros e orientar abstinência.
Homem / parceiro	Metronidazol · 2 g VO dose única · VO	Dose única	Dose única mantém eficácia no homem. Tratar parceiros evita reinfeção.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mulher — alternativa CDC/ institucional	Metronidazol · 500 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Identificar o protocolo adotado; tem melhor eficácia em mulheres em dados do CDC.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	Protozoário sensível a nitroimidazólicos	Metronidazol ou tinidazol

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ATENÇÃO**Parceiros precisam tratar**

Sem tratamento dos parceiros, reinfecção é comum.

INFORMAÇÃO**Evitar álcool**

Orientar evitar álcool durante nitroimidazólico e por período após término conforme protocolo local.

ATENÇÃO**Persistência não é sempre resistência**

Antes de assumir resistência, checar adesão, vômitos, reinfecção e exposição não tratada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Diagnóstico provável/confirmado	Tratar paciente conforme sexo/gestação e orientar tratamento de parceiros.
2	Persistência	Confirmar adesão e reexposição antes de presumir resistência.
3	Recorrente	Reavaliar esquema, testagem e necessidade de referência.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Raro; considerar se DIP grave, gestação com complicações ou diagnóstico alternativo grave
Falha terapêutica	- Reexposição - Adesão incompleta - Resistência a nitroimidazol - Diagnóstico incorreto

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT é mais sensível quando disponível; microscopia pode ser usada, mas tem menor sensibilidade.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Metronidazol vo	mulher 500 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE homem 2 g VO dose única	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Condutas em IST dependem de disponibilidade de testes, prevalência local, rastreamento de coinfeções, fluxo de notificação e tratamento de parceiros.
- Coletar NAAT/cultura/sorologias quando disponível, sem atrasar tratamento sintomático quando indicado.
- Orientar abstinência temporária, tratamento/avaliação de parceiros e retestagem quando aplicável.
- Investigar HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs conforme exposição e vulnerabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Trichomoniasis.

Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf@@display-file/file

11.7

Proctite por IST / Suspeita de LGV

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Proctite infecciosa associada a IST pode envolver gonococo, clamídia, LGV, HSV e sífilis. Dor retal, descarga, sangramento, tenesmo, úlceras ou linfonodomegalia exigem avaliação dirigida. Suspeita de LGV requer doxiciclina por 21 dias.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Doxiciclina

Ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h

VIA

IM

DURAÇÃO

7 a 21 dias conforme suspeita de LGV

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria gonorrhoeae	FREQUENTE	
Chlamydia trachomatis	FREQUENTE	Sorotipos L1-L3 causam LGV.
HSV	CONSIDERAR SE ÚLCERAS/DOR INTENSA	
Treponema pallidum	CONSIDERAR SE ÚLCERA/LESÃO COMPATÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Proctite aguda com suspeita de IST sem critérios fortes de LGV	Ceftriaxona + Doxiciclina · Ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h · IM/VO	7 dias	Cobrir gonococo e clamídia; ampliar duração se LGV provável.
Suspeita de LGV: dor intensa, tenesmo, sangramento, linfonodos ou NAAT clamídia positivo com proctite	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	21 dias	Associar ceftriaxona se gonococo não excluído.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Úlceras dolorosas/perianais sugestivas de HSV	Adicionar Aciclovir/Valaciclovir · Aciclovir 400 mg VO 8/8 h ou valaciclovir 1 g VO 12/12 h · VO	7–10 dias se primeiro episódio	Não substitui cobertura para gonococo/ clamídia quando suspeita concomitante.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PROTOCOLO EXIBIDO: BRASIL/MS

A conduta principal segue o PCDT brasileiro. Recomendações CDC podem divergir e devem aparecer apenas como alternativa internacional identificada.

ATENÇÃO**Diferenciar de doença inflamatória intestinal e outras causas**

Sangramento, dor intensa e sintomas sistêmicos podem ter diagnósticos alternativos.

ALERTA CRÍTICO**LGV precisa de tratamento prolongado**

Não encerrar com 7 dias de doxiciclina se LGV for provável.

ATENÇÃO**Parceiros e rastreio**

Investigar HIV, sífilis, hepatites e tratar/avaliar parceiros.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Proctite aguda	Coletar NAAT retal para gonococo/clamídia se disponível, avaliar úlceras e sorologias.
2	Suspeita IST	Tratar gonococo/clamídia; prolongar doxiciclina para 21 dias se LGV provável.
3	Grave ou refratária	Reavaliar diagnóstico, complicações e necessidade de endoscopia/imagem/especialista.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Dor intensa/toxemia ▪ Sangramento importante ▪ Imunossupressão importante ▪ Suspeita de abscesso, megacólon ou diagnóstico abdominal grave
Falha terapêutica	▪ Persistência após esquema correto ▪ Reexposição ▪ LGV não reconhecida ▪ HSV/sífilis não tratados ▪ Diagnóstico não infeccioso

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT retal para gonococo/clamídia; cultura se falha gonocócica; PCR/NAAT HSV se úlcera; sorologia para sífilis/HIV/hepatites conforme exposição.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona IM	500 mg IM dose única GRAVE 1 g se ≥150 kg	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Doxiciclina VO	100 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE 21 dias se LGV provável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Gestação: evitar			

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de IST com maior risco de falha, resistência, gestação, acometimento neurológico/ocular/ótico ou necessidade de fluxo institucional específico.
- Validar protocolo local de IST/CCIH/infectologia quando houver falha terapêutica, resistência ou quadro complicado.
- Garantir notificação/seguimento quando indicado pelo fluxo municipal/estadual.
- Confirmar disponibilidade de testes confirmatórios, cultura/sensibilidade e terapia parenteral quando necessária.

• Gestantes, neurossífilis, sífilis ocular/ótica, doença disseminada e resistência gonocócica exigem condução protocolada.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Proctitis, Proctocolitis and Enteritis.
CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Lymphogranuloma Venereum.
Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.
https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/@@display-file/file

11.8

Mycoplasma genitalium — Uretrite/Cervicite Persistente

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Mycoplasma genitalium deve ser considerado em uretrite/cervicite persistente ou recorrente, especialmente após exclusão de reexposição, adesão inadequada, gonococo, clamídia e tricomoníase. A abordagem ideal é guiada por teste específico e resistência a macrolídeo quando disponível.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina → Moxifloxacino

Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h por 7 dias, seguida de moxifloxacino 400 mg VO 24/24 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7 dias + 7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Mycoplasma genitalium	ASSOCIADO A PERSISTÊNCIA/ RECORRÊNCIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
M. genitalium detectado ou alta suspeita, sem teste de resistência disponível	Doxiciclina → Moxifloxacino · Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h por 7 dias; depois moxifloxacino 400 mg VO 24/24 h · VO	14 dias no total	Evitar azitromicina 1 g dose única como estratégia para M. genitalium por risco de resistência.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Teste de resistência a macrolídeo disponível	Terapia guiada por resistência · Conforme resultado · VO	Conforme protocolo	Preferível quando disponível; validar com especialista/protocolo local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Não tratar persistência sem reavaliar

Antes de escalar, confirmar adesão, reexposição, gonococo, clamídia, tricomonas, prostatite/epididimite e causas não infecciosas.

ALERTA CRÍTICO

Moxifloxacino tem riscos

Avaliar QT, tendinopatia, interações, gestação e contraindicações.

ATENÇÃO**Resistência a macrolídeo**

Azitromicina dose única pode selecionar resistência e não deve ser usada de rotina para *M. genitalium* persistente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sintomas persistentes	Checar adesão/reexposição e excluir gonococo, clamídia, tricomonas e complicações.
2	<i>M. genitalium</i> provável/detectado	Preferir teste específico e resistência quando disponível; usar terapia sequencial conforme protocolo.
3	Falha ao esquema	Não repetir empiricamente; discutir com especialista e validar opções locais.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Raro; considerar se doença pélvica grave, dor testicular importante, sepse ou diagnóstico alternativo grave
Falha terapêutica	▪ Persistência após moxifloxacino ▪ Reexposição ▪ Adesão incompleta ▪ Resistência ▪ Diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT específico para <i>M. genitalium</i> quando disponível; teste de resistência a macrolídeo se disponível; repetir gonococo/clamídia/tricomonas conforme cenário.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO Gestação: evitar	100 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE Fase inicial da terapia sequencial	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	
Moxifloxacino VO Gestação: evitar	400 mg VO 24/24 h por 7 dias após doxíclina GRAVE Individualizar em falha	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de IST com maior risco de falha, resistência, gestação, acometimento neurológico/ocular/ótico ou necessidade de fluxo institucional específico.
- Validar protocolo local de IST/CCIH/infectologia quando houver falha terapêutica, resistência ou quadro complicado.
- Garantir notificação/seguimento quando indicado pelo fluxo municipal/estadual.
- Confirmar disponibilidade de testes confirmatórios, cultura/sensibilidade e terapia parenteral quando necessária.
- Gestantes, neurosífilis, sífilis ocular/ótica, doença disseminada e resistência gonocócica exigem condução protocolada.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — *Mycoplasma genitalium*.

11.9

Doxi-PEP — Prevenção Pós-Exposição de IST Bacteriana

LEVE

AMBULATORIAL

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Estratégia internacional de prevenção, não tratamento, para população elegível bem delimitada. A diretriz CDC 2024 recomenda decisão compartilhada para homens gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens e mulheres trans com sífilis, clamídia ou gonorreia nos 12 meses anteriores; não extrapolar automaticamente a outras populações.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina — somente após elegibilidade e decisão compartilhada

200 mg VO o mais cedo possível e até 72 h após relação oral, vaginal ou anal; máximo 200 mg em 24 h

VIA

VO

DURAÇÃO

Por evento; reavaliar necessidade a cada 3–6 meses

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Treponema pallidum e Chlamydia trachomatis	BENEFÍCIO PREVENTIVO DEMONSTRADO NA POPULAÇÃO ESTUDADA	
Neisseria gonorrhoeae	CONTEXTUAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
População elegível pela diretriz CDC 2024, após decisão compartilhada	Doxiciclina · 200 mg VO até 72 h após exposição; máximo 200 mg/24 h · VO	Por evento, com reavaliação em 3–6 meses	Tomar com água, permanecer ereto e separar de antiácidos/ferro/cálcio conforme orientação. Não substitui preservativo, vacinação, PrEP/PEP HIV nem rastreio.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

NÃO EXTRAPOLAR A TODAS AS PESSOAS

Evidência e recomendação atuais são específicas. Fora da população estudada, decidir somente com especialista/protocolo e explicitar incerteza; evitar na gestação.

ATENÇÃO

RESISTÊNCIA E MICROBIOMA

Discutir seleção de resistência, efeitos adversos e incertezas de longo prazo. Doxi-PEP não trata uma IST já estabelecida.

INFORMAÇÃO

SEGUIMENTO TRIMESTRAL

Rastrear gonococo e clamídia em todos os sítios expostos e sífilis a cada 3–6 meses, preferencialmente a cada 3 meses; revisar HIV, hepatites, vacinação e necessidade contínua.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Antes de prescrever	Confirmar população elegível, IST bacteriana nos últimos 12 meses, ausência de gestação/contraindicação e rastreio basal.
2	Decisão compartilhada	Explicar benefício por agente, resistência, efeitos adversos, máximo diário e medidas combinadas de prevenção.
3	A cada 3–6 meses	Testar sítios expostos, revisar adesão/eventos adversos, tratar IST diagnosticada e decidir continuidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ IST bacteriana apesar do uso ▪ Uso acima do máximo diário ▪ Intolerância ▪ Ausência de seguimento ▪ Possível resistência ou reinfeção

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	NAAT para gonococo/clamídia em todos os sítios expostos e sorologia para sífilis a cada 3–6 meses; HIV e hepatites conforme risco.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO Gestação: evitar	200 mg VO até 72 h após exposição; máximo 200 mg/24 h GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual; ajustar conforme antimicrobiano específico e função clínica.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de IST com maior risco de falha, resistência, gestação, acometimento neurológico/ocular/ótico ou necessidade de fluxo institucional específico.
- Validar protocolo local de IST/CCIH/infectologia quando houver falha terapêutica, resistência ou quadro complicado.
- Garantir notificação/seguimento quando indicado pelo fluxo municipal/estadual.
- Confirmar disponibilidade de testes confirmatórios, cultura/sensibilidade e terapia parenteral quando necessária.
- Gestantes, neurosífilis, sífilis ocular/ótica, doença disseminada e resistência gonocócica exigem condução protocolada.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC. Clinical Guidelines on Doxycycline Postexposure Prophylaxis, 2024. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7302a1.htm>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 11 — IST

- Ministério da Saúde. PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, 2022.
- CDC. Guidelines for the Use of Doxycycline Postexposure Prophylaxis, MMWR 2024.

12

Oftalmológico

9 quadros clínicos neste sistema

12.1	Conjuntivite Bacteriana — Adulto	241
12.2	Conjuntivite Gonocócica Hiperpurulenta	243
12.3	Ceratite Bacteriana / Úlcera de Córnea — Lente de Contato	245
12.4	Celulite Pré-septal / Periorbitária — Adulto	247
12.5	Celulite Orbitária — Adulto	249
12.6	Endoftalmite Pós-procedimento / Pós-trauma	252
12.7	Dacriocistite Aguda — Adulto	254
12.8	Herpes Zoster Oftálmico	256
12.9	Blefarite / Hordéolo / Calázio Infectado	258

12.1

Conjuntivite Bacteriana — Adulto

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional dispensável

Olho vermelho com secreção mucopurulenta e desconforto leve, geralmente autolimitado. No PS, o ponto crítico é não chamar de conjuntivite simples um quadro com dor importante, fotofobia, baixa visual, uso de lente de contato, trauma, corpo estranho, opacidade corneana ou alteração pupilar.

CONDUTA DE PARTIDA

Higiene e observação na maioria; colírio antibiótico quando bacteriana provável

Tobramicina 0,3% colírio, 1 gota 4/4 h a 6/6 h; quinolona tópica se usuário de lente de contato sem ceratite aparente

VIA

Topica

DURAÇÃO

5–7 dias quando indicado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus pneumoniae	POSSÍVEL	
Haemophilus influenzae	POSSÍVEL	
Adenovírus	MUITO COMUM NO GERAL	Viral é causa frequente; antibiótico não ajuda conjuntivite viral

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Quadro leve, sem sinais de gravidade e possível etiologia viral	Medidas locais · Higiene palpebral, compressas, lubrificante ocular e orientação de higiene · Conduta	Até melhora clínica	Evitar antibiótico indiscriminado; orientar retorno se dor, fotofobia ou baixa visual.
Conjuntivite bacteriana provável, sem sinais de alarme	Tobramicina 0,3% colírio · 1 gota no olho acometido 4/4 h a 6/6 h · Tópica	5–7 dias	Alternativas com apresentação brasileira: ciprofloxacino 0,3% colírio, azitromicina 1,5% colírio, ou pomada de oxite-traciclina + polimixina B / neomicina + polimixina B + bacitracina. Reavaliar se não melhorar em 48–72 h ou se surgirem sinais de alarme.
Usuário de lente de contato, olho vermelho sem úlcera aparente	Fluoroquinolona tópica · Moxifloxacino, ciprofloxacino ou ofloxacino colírio conforme apresentação · Topica	5–7 dias	Suspender lente. Dor, fotofobia, infiltrado ou baixa visual = tratar como ceratite/úlcera e acionar oftalmo.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa tópica quando disponível	Azitromicina colírio · Conforme apresentação local · Topica	Conforme bula/protocolo	Manter reavaliação se piora ou falha.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

EVITAR MARCAS E ANTIBIÓTICO AUTOMÁTICO

A maioria das conjuntivites agudas é viral ou autolimitada. Escolher princípio ativo e apresentação realmente disponíveis; dor, fotofobia, baixa visual, lente de contato ou hiperpurulência exigem outro ramo.

ALERTA CRÍTICO

Sinais de alarme não são conjuntivite simples

Dor intensa, fotofobia, baixa visual, opacidade/infiltrado corneano, trauma, corpo estranho, lente de contato, pupila alterada ou cefaleia/náuseas exigem outra abordagem.

ATENÇÃO

Não usar corticoide tópico sem oftalmo

Corticoide pode piorar herpes, fungo, úlcera corneana e aumentar risco de dano visual.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Olho vermelho	Medir acuidade visual quando possível e checar dor, fotofobia, lente de contato, trauma, córnea e pupilas.
2	Sem alarme	Higiene, lubrificação, evitar compartilhamento de toalhas e considerar antibiótico tópico apenas se bacteriana provável.
3	Alarme presente	Não tratar como conjuntivite simples; acionar oftalmologia e investigar ceratite, úlcera, uveíte, glaucoma, celulite ou endoftalmite.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de celulite orbitária ▪ Endoftalmite ▪ Úlcera de córnea grave ▪ Imunossupressão com infecção grave
Falha terapêutica	▪ Piora em 24–48 h ▪ Dor/fotofobia/baixa visual ▪ Secreção hiperpurulenta ▪ Acometimento corneano

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não é rotina em conjuntivite simples; coletar se hiperpurulenta, imunossuprimido, falha terapêutica ou suspeita de gonococo/clamídia.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Tobramicina colírio 0,3% Tópica	1 gota 4/4 h a 6/6 h por 5–7 dias GRAVE Não indicada para ceratite/úlcera — nesses casos, quinolona tópica em dose intensiva por oftalmologia	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	
Fluoroquinolona tópica Tópica	1 gota conforme apresentação GRAVE Em ceratite/úlcera, dose intensiva guiada por oftalmo	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Conjuntivite simples é geralmente padronizável, desde que sinais de alarme sejam excluídos.
- Confirmar ausência de dor, fotofobia, baixa visual, lente de contato com dor ou opacidade corneana
- Evitar corticoide sem oftalmologia
- Orientar retorno se piora

12.2

Conjuntivite Gonocócica Hiperpurulenta

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Conjuntivite hiperaguda com secreção purulenta abundante, quemose/edema palpebral, dor e risco de ceratite, ulceração e perfuração corneana. É emergência oftalmológica e também uma IST: coletar material quando possível, tratar sistemicamente e avaliar parceiros/sítios expostos.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona

1 g IM/EV dose única

VIA

IM

DURAÇÃO

Dose única; individualizar se doença disseminada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria gonorrhoeae	DEFINIDOR	Pode invadir córnea rapidamente
Chlamydia trachomatis	COINFECÇÃO POSSÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Conjuntivite hiperpurulenta suspeita/confirmada	Ceftriaxona · 1 g IM ou EV dose única · IM/EV	Dose única	Associar lavagem ocular com soro e avaliação oftalmológica urgente.
Clamídia não excluída	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Evitar na gestação; tratar parceiros e rastrear outras IST.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a cefalosporina ou ceftriaxona indisponível	Gentamicina + Azitromicina · Gentamicina 240 mg IM dose única + Azitromicina 2 g VO dose única · IM/VO	Dose única	Alternativa menos preferencial; envolver oftalmo/infectologia e acompanhar de perto.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Risco de perfuração corneana

Secreção hiperpurulenta, dor ou qualquer alteração corneana exigem oftalmo imediato.

ATENÇÃO**Tratar como IST**

Coletar NAAT/cultura conforme disponibilidade, rastrear HIV/sífilis/clamídia e tratar/encaminhar parceiros.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Hiperpurulenta	Suspeitar gonococo; coletar secreção para Gram/cultura/NAAT se disponível.
2	Tratamento imediato	Ceftriaxona sistêmica + lavagem ocular + oftalmo urgente.
3	IST associada	Tratar clamídia se não excluída, rastrear outras IST e orientar parceiros.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Acometimento corneano ▫ Dor/baixa visual ▫ Impossibilidade de avaliação oftalmológica rápida ▫ Doença disseminada
Falha terapêutica	▫ Persistência de secreção/dor ▫ Piora corneana ▫ Cultura com resistência

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Coletar secreção ocular para Gram/cultura e NAAT quando disponível; rastrear gonorreia/clamídia em sítios expostos.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona IM/EV	1 g IM/EV dose única GRAVE Individualizar se disseminada	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	
Doxiciclina VO	100 mg VO 12/12 h por 7 dias GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	
Gestação: evitar			

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadros oftalmológicos dependem de disponibilidade de exame ocular, lâmpada de fenda, cultura, colírios específicos, avaliação oftalmológica e fluxo local de encaminhamento.
- Confirmar acuidade visual e sinais de alarme antes de classificar como quadro simples
- Validar fluxo local de oftalmologia/retaguarda
- Checar disponibilidade de colírios/antibióticos tópicos
- Evitar corticoide ocular sem avaliação especializada

12.3

Ceratite Bacteriana / Úlcera de Córnea — Lente de Contato

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Dor ocular, fotofobia, baixa visual, lacrimejamento, infiltrado corneano ou defeito epitelial em usuário de lente de contato sugerem ceratite bacteriana. Pseudomonas é preocupação central. É urgência oftalmológica; não ocluir, não usar corticoide e suspender lente imediatamente.

CONDUTA DE PARTIDA

Fluoroquinolona tópica antipseudomonas intensiva

Moxifloxacino/ciprofloxacino/ofloxacino colírio em dose intensiva conforme oftalmologia

VIA

Topica

DURAÇÃO

Guiada por resposta e oftalmologia

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	MUITO IMPORTANTE	Especialmente lente de contato
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Serratia / Gram-negativos	POSSÍVEL	
Acanthamoeba	DIFERENCIAL	Dor desproporcional, exposição a água/lente, evolução arrastada
Fungos	DIFERENCIAL	Trauma vegetal, imunossupressão ou curso subagudo

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Úlcera periférica pequena sem sinais de ameaça visual, após avaliação oftalmo	Fluoroquinolona tópica · 1 gota de hora em hora inicialmente ou conforme oftalmologia · Topica	Individualizar	Suspender lente; não ocluir; reavaliação estreita.
Úlcera central, grande, profunda, hipópion, pós-cirúrgica ou ameaça visual	Vancomicina tópica fortificada + Ceftazidima/Tobramicina tópica fortificada · Esquema intensivo horário conforme oftalmologia/protocolo · Topica	Individualizar	Colher cultura/raspado quando indicado, sem atrasar tratamento em ameaça visual.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Esclerite, perfuração iminente, extensão extraocular ou infecção sistêmica	Antibiótico sistêmico adjuvante · Conforme agente e gravidade · VO/EV	Individualizar	Terapia sistêmica não substitui tratamento tópico intensivo e avaliação oftalmo.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Uso de lente de contato ▪ Água/lente ▪ Úlcera corneana rapidamente progressiva	Fluoroquinolona tópica antipseudomonas ou ceftazidima/tobramicina fortificada

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Risco local/colonização ▪ Falha terapêutica ▪ Úlcera grave com Gram positivo	Vancomicina tópica fortificada conforme oftalmo

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
URGÊNCIA OFTALMOLÓGICA

Retirar lente, não ocluir e iniciar quinolona tópica com atividade antipseudomonas conforme gravidade/protocolo. Úlcera central, grande ou profunda requer cultura e doses horárias definidas pelo oftalmologista.

ALERTA CRÍTICO
Úlcera de córnea ameaça visão

Dor + fotofobia + baixa visual/infiltrado em usuário de lente é emergência oftalmológica.

ALERTA CRÍTICO
Não usar corticoide ou tampão ocular

Corticoide/tampão podem piorar infecção corneana; suspender lente imediatamente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de ceratite	Suspender lente, medir acuidade visual, examinar córnea com fluoresceína se disponível e acionar oftalmo.
2	Úlcera grave/central	Raspado/cultura se possível e antibiótico tópico intensivo/fortificado conforme oftalmo.
3	Evolução atípica	Considerar fungo, Acanthamoeba, HSV e resistência; reavaliar diagnóstico.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Úlcera central/grande ▪ Hipópion ▪ Baixa visual ▪ Imunossupressão ▪ Impossibilidade de uso horário de colírio/seguimento ▪ Suspeita de perfuração
Falha terapêutica	▪ Piora em 24 h ▪ Aumento do infiltrado ▪ Persistência de dor/baixa visual ▪ Cultura resistente ou fungo/Acanthamoeba

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura/raspado corneano se úlcera central, grande, profunda, atípica, pós-cirúrgica, imunossuprimido, uso de corticoide, trauma vegetal ou falha terapêutica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Fluoroquinolona tópica Tópica	1 gota conforme apresentação; em úlcera, dose intensiva inicial guiada por oftalmo GRAVE Horário inicialmente conforme oftalmo	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina + Cefprozila/ Tobramicina tópicos fortificados Topica	Conforme preparo/protocolo oftalmológico GRAVE Horário inicialmente	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Urgência oftalmológica com risco de perda visual. Conduta depende de avaliação especializada, imagem/procedimento, cultura e disponibilidade institucional de tratamento tópico intensivo, intravítreo ou cirurgia.
- Acionar oftalmologia imediatamente
- Definir necessidade de TC, cultura, raspado corneano, intravítreo ou drenagem
- Validar antibióticos tópicos fortificados/intravítreos disponíveis
- Registrar acuidade visual inicial e sinais de gravidade

12.4

Celulite Pré-septal / Periorbitária — Adulto

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Infecção anterior ao septo orbitário com edema/eritema palpebral, sem proptose, sem dor à movimentação ocular, sem oftalmoplegia e sem baixa visual. Diferenciar de celulite orbitária é o ponto crítico.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5–7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus pyogenes	FREQUENTE	
Anaeróbios/origem odontogênica	SE FOCO DENTÁRIO/TRAUMA	
MRSA	CONFORME RISCO LOCAL	Abscesso, lesões purulentas, colonização ou prevalência elevada

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leve/moderada, adulto, sem sinais orbitários e bom seguimento	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Reavaliar em 24–48 h; orientar retorno imediato se sinais orbitários.
Risco de MRSA ou purulência	Amoxicilina-Clavulanato + Sulfametoxazol-Trimetoprim · Amox-clav 875/125 mg VO 12/12 h + SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	SMX-TMP cobre MRSA, mas manter betalactâmico para estreptococo/anaeróbios.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia betalactâmica ou necessidade de MRSA + estreptococo	Clindamicina · 300–450 mg VO a cada 6–8 h · VO	5–7 dias	Avaliar resistência local e risco de C. difficile.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Abscesso/purulência ▪ Colonização prévia ▪ Falha a betalactâmico ▪ Alta prevalência local	Adicionar SMX-TMP ou usar clindamicina conforme cenário

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Excluir celulite orbitária**

Proptose, dor à movimentação ocular, limitação ocular, diplopia, baixa visual, alteração pupilar ou febre/toxemia exigem TC e antibiótico EV.

ATENÇÃO**Reavaliação precoce**

Pré-septal ambulatorial precisa de reavaliação em 24–48 h.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Edema palpebral	Avaliar acuidade, motilidade, dor à movimentação, proptose, pupilas e febre/toxemia.
2	Sem sinais orbitários	Tratamento VO e retorno em 24–48 h.
3	Sinais orbitários ou dúvida	Tratar como orbitária: TC órbitas/seios da face, EV e oftalmo/ORL.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sinais orbitários ▪ Toxemia ▪ Imunossupressão ▪ Falha VO ▪ Impossibilidade de seguimento ▪ Abscesso palpebral importante
Falha terapêutica	▪ Piora em 24–48 h ▪ Febre persistente ▪ Surgimento de dor ocular/proptose/baixa visual

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não é rotina em pré-septal leve; coletar se drenagem de abscesso, ferida, imunossupressão ou falha terapêutica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam EV se inter- nação	<30 mL/min: Ajustar intervalo/dose	
SMX-TMP VO/EV	800/160 mg VO 12/12 h GRAVE Considerar EV se grave conforme protocolo	<30 mL/min: Ajustar dose/evitar conforme função renal	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadros oftalmológicos dependem de disponibilidade de exame ocular, lâmpada de fenda, cultura, colírios específicos, avaliação oftalmológica e fluxo local de encaminhamento.
- Confirmar acuidade visual e sinais de alarme antes de classificar como quadro simples
- Validar fluxo local de oftalmologia/retaguarda
- Checar disponibilidade de colírios/antibióticos tópicos
- Evitar corticoide ocular sem avaliação especializada

12.5

Celulite Orbitária — Adulto

CRÍTICA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção pós-septal, geralmente associada a sinusite, com risco de perda visual, abscesso subperiosteal/orbitário, trombose de seio cavernoso e extensão intracraniana. Requer imagem, antibiótico EV e avaliação urgente.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + Ceftriaxona + Metronidazol

Vancomicina EV por peso/AUC + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h. Com extensão intracraniana, usar dose meníngea: ceftriaxona 2 g EV 12/12 h

VIA

EV

DURAÇÃO

2–3 semanas total, individualizar

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae / viridans	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus incluindo MRSA	IMPORTANTE	
Anaeróbios	SINUSITE CRÔNICA/ ODONTOGÊNICA	
Gram-negativos	POSSÍVEL EM CONTEXTO ASSIS- TENCIAL/IMUNOS- SUPRESSÃO	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Celulite orbitária comunitária	Vancomicina + Ceftriaxona + Metronidazol · Vancomicina EV por peso/AUC + Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h (2 g 12/12 h apenas se houver extensão intracraniana) + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	2–3 semanas total	TC órbitas/seios da face com contraste; oftalmo e ORL.
Pós-trauma, saúde, imunossupressão ou risco de Pseudomonas	Vancomicina + Cefepime ou Piperacilina-Tazobactam · Vancomicina EV + Cefepime 2 g EV 8/8 h ou Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h · EV	Individualizar	Adicionar metronidazol se cefepime e necessidade de anaeróbios.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Levofloxacino + Metronidazol · Vancomicina EV + Levofloxacino 750 mg EV/VO 24/24 h + Metronidazol 500 mg EV 8/8 h · VO/EV	Individualizar	Usar com infectologia; avaliar riscos QT/tendão e resistência.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Celulite orbitária grave ▪ Abscesso ▪ Colonização/risco MRSA ▪ Pós-operatório/saúde	Vancomicina
ANAEROBIOS	▪ Sinusite crônica ▪ Origem odontogênica ▪ Abscesso ▪ Necrose	Metronidazol ou betalactâmico com inibidor
PSEUDOMONAS	▪ Imunossupressão ▪ Pós-trauma/pós-operatório ▪ Infecção relacionada a saúde	Cefepime ou piperacilina-tazobactam

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

PADRÃO E INTRACRANIANO SÃO ESQUEMAS DISTINTOS

Usar dose meníngea e cobertura adicional quando houver extensão intracraniana; não escrever ceftriaxona “12–24 h”. Acionar oftalmo + ORL e drenar quando houver abscesso, perda visual ou falha.

ALERTA CRÍTICO

Ameaça visual

Baixa visual, RAPD, oftalmoplegia, proptose ou dor intensa exigem avaliação imediata e possível drenagem.

ALERTA CRÍTICO

Não atrasar imagem e especialistas

Solicitar TC com contraste e acionar oftalmo/ORL; abscesso pode precisar drenagem.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita orbitária	Internar, coletar hemoculturas se febre/toxemia, iniciar EV e solicitar TC com contraste.
2	Abscesso/ameaça visual	Oftalmo/ORL para drenagem descompressiva quando indicada.
3	Melhora sustentada	Transicionar VO conforme culturas e completar duração individualizada.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de celulite orbitária ▪ Proptose ▪ Oftalmoplegia ▪ Baixa visual ▪ Abscesso ▪ Toxemia ▪ Imunossupressão
UTI	▪ Sepses/choque ▪ Rebaixamento ▪ Extensão intracraniana ▪ Risco de via aérea associado
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 24–48 h ▪ Piora visual ▪ Abscesso progressivo ▪ Febre persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se febre/toxemia; cultura de material drenado de seios/abscesso quando houver procedimento.
Controle de foco	Oftalmo/ORL para drenagem descompressiva quando indicada.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h ou AUC conforme protocolo GRAVE AUC 400–600 quando possível	Variável: Ajustar por função renal e nível/AUC	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 12/12 h se suspeita SNC/gravidade	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Urgência oftalmológica com risco de perda visual. Conduta depende de avaliação especializada, imagem/procedimento, cultura e disponibilidade institucional de tratamento tópico intensivo, intravítreo ou cirurgia.
- Acionar oftalmologia imediatamente
- Definir necessidade de TC, cultura, raspado corneano, intravítreo ou drenagem
- Validar antibióticos tópicos fortificados/intravítreos disponíveis
- Registrar acuidade visual inicial e sinais de gravidade

12.6

Endoftalmite Pós-procedimento / Pós-trauma

CRÍTICA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Dor ocular, baixa visual, hipópio, hiperemia intensa ou piora após cirurgia, injeção intravítrea ou trauma ocular. É emergência oftalmológica com risco de perda visual; tratamento central é intravítreo e/ou vitrectomia conforme avaliação especializada.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina intravítrea + Ceftazidima intravítrea

Conforme protocolo oftalmológico

VIA

Procedimento

DURAÇÃO

Guiada por resposta/culturas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus coagulase-negativo	FREQUENTE PÓS-OPERATÓRIO	
Staphylococcus aureus	IMPORTANTE	
Streptococcus spp.	POSSÍVEL	
Bacillus cereus	TRAUMA	Curso fulminante
Gram-negativos	POSSÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de endoftalmite	Vancomicina intravítrea + Ceftazidima intravítrea · Aplicação intravítrea por oftalmologia · Procedimento	Dose/repetição conforme resposta	Não substituir por colírio ou EV isolado; considerar vitrectomia conforme acuidade, agente e gravidade.
Pós-trauma aberto, extensão extraocular ou doença sistêmica associada	Vancomicina EV + Ceftazidima/Cefepime EV · Vancomicina EV por peso/AUC + Ceftazidima 2 g EV 8/8 h ou Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Individualizar	Sistêmico é adjuvante; intravítreo não deve atrasar.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita fúngica	Anfotericina B ou Voriconazol intravítreo/sistêmico · Conforme oftalmo/infectologia · Procedimento	Individualizar	Considerar em imunossuprimido, cirurgia/trauma vegetal ou fungemia.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Endoftalmite pós-procedimento/trauma ▪ Infecção grave intraocular	Vancomicina intravítrea
PSEUDOMONAS	▪ Gram-negativos/trauma/saúde ▪ Infecção intraocular grave	Ceftazidima intravítrea ou cefepime/ceftazidima EV como adjuvante

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

INTRAVÍTREO SOMENTE COM DOSE VALIDADA

É emergência oftalmológica. Confirmar doses intravítreas, preparo e punção/vitrectomia com protocolo e farmácia; “conforme protocolo” não autoriza preparo improvisado.

ALERTA CRÍTICO

Emergência oftalmológica absoluta

Não manejar apenas com colírio ou antibiótico sistêmico; precisa avaliação para intravítreo/vitrectomia.

ALERTA CRÍTICO

Baixa visual pós-cirurgia/injeção é alarme

Dor e perda visual após procedimento ocular exigem contato imediato com oftalmologia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Proteger olho, manter jejum se cirurgia possível e acionar oftalmo imediatamente.
2	Oftalmo disponível	Coleta de humor aquoso/vítreo e antibiótico intravítreo urgente.
3	Trauma aberto ou sistêmico	Adicionar antibiótico EV e profilaxias conforme trauma, sem substituir intravítreo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de endoftalmite ▪ Trauma ocular aberto ▪ Sepses/fungemia ▪ Impossibilidade de seguimento imediato
Falha terapêutica	▪ Piora visual ▪ Dor persistente ▪ Inflamação intraocular progressiva ▪ Cultura resistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Amostra de humor aquoso/vítreo para Gram/cultura antes do intravítreo quando possível, sem atrasar tratamento.
Controle de foco	Proteger olho, manter jejum se cirurgia possível e acionar oftalmo imediatamente.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina intravítrea Procedimento	Conforme protocolo oftalmológico GRAVE Conforme protocolo oftalmológico	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftazidima intravítrea Procedimento	Conforme protocolo oftalmológico GRAVE Conforme protocolo oftalmológico	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Urgência oftalmológica com risco de perda visual. Conduta depende de avaliação especializada, imagem/procedimento, cultura e disponibilidade institucional de tratamento tópico intensivo, intravítreo ou cirurgia.
- Acionar oftalmologia imediatamente
- Definir necessidade de TC, cultura, raspado corneano, intravítreo ou drenagem
- Validar antibióticos tópicos fortificados/intravítreos disponíveis
- Registrar acuidade visual inicial e sinais de gravidade

12.7

Dacriocistite Aguda — Adulto

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Infecção do saco lacrimal com dor, edema e eritema no canto medial inferior, frequentemente associada a obstrução nasolacrimal. Pode evoluir para abscesso, celulite pré-septal/orbitária ou recorrência.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina-Clavulanato

875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Anaeróbios	POSSÍVEL	
Gram-negativos	POSSÍVEL EM IDOSOS/SAÚDE	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Dacriocistite leve/moderada, sem sinais orbitários	Amoxicilina-Clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h · VO	7–10 dias	Compressas mornas, analgesia e avaliação oftalmo para obstrução/recorrência.
Toxemia, celulite extensa, imunossupressão ou falha VO	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	7–10 dias total	Avaliar drenagem se abscesso.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia betalactâmica	Clindamicina · 300–450 mg VO a cada 6–8 h ou 600–900 mg EV 8/8 h · VO/EV	7–10 dias	Cobertura limitada para alguns Gram-negativos; ajustar se grave.
Risco de MRSA/purulência	Adicionar SMX-TMP ou Vancomicina se grave · SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h ou Vancomicina EV por peso/AUC · VO/EV	Individualizar	Associar cobertura estreptocócica/anaeróbia quando necessário.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Purulência importante ▪ Abscesso ▪ Colonização prévia ▪ Falha terapêutica	SMX-TMP como adjuvante ou vancomicina se grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Não confundir com celulite orbitária

Dor à movimentação ocular, proptose, diplopia ou baixa visual mudam conduta.

ATENÇÃO

Recorrência exige correção anatômica

Antibiótico trata fase aguda, mas obstrução do ducto pode exigir procedimento oftalmológico.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Edema canto medial doloroso	Avaliar sinais orbitários e extensão facial.
2	Sem alarme	Amox-clav VO, compressas mornas e retorno precoce.
3	Abscesso/falha	Oftalmo para drenagem e avaliação de via lacrimal.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toxemia ▪ Celulite extensa ▪ Abscesso ▪ Sinais orbitários ▪ Imunossupressão ▪ Falha VO
Falha terapêutica	▪ Piora em 24–48 h ▪ Abscesso ▪ Febre persistente ▪ Recorrência

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de secreção se drenagem, abscesso, recorrência, imunossupressão ou falha terapêutica.
Controle de foco	Oftalmo para drenagem e avaliação de via lacrimal.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina-Clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h	<30 mL/min: Ajustar intervalo/dose	
Clindamicina VO/EV	300–450 mg VO a cada 6–8 h GRAVE 600–900 mg EV 8/8 h	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadros oftalmológicos dependem de disponibilidade de exame ocular, lâmpada de fenda, cultura, colírios específicos, avaliação oftalmológica e fluxo local de encaminhamento.
- Confirmar acuidade visual e sinais de alarme antes de classificar como quadro simples
- Validar fluxo local de oftalmologia/retaguarda
- Checar disponibilidade de colírios/antibióticos tópicos
- Evitar corticoide ocular sem avaliação especializada

12.8

Herpes Zoster Oftálmico

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Reativação do VZV no território V1 com vesículas dolorosas em frente/pálpebra/nariz e risco de ceratite, uveíte, neurite óptica e perda visual. Antiviral precoce reduz complicações; todo sinal ocular exige oftalmologia.

CONDUTA DE PARTIDA

Valaciclovir

1 g VO 8/8 h

VIA

VO

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus varicela-zoster	DEFINIDOR	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Imunocompetente, sem doença ocular grave, até 72 h ou lesões novas	Valaciclovir · 1 g VO 8/8 h · VO	7–10 dias	Alternativa: aciclovir 800 mg VO 5x/dia. Avaliação oftalmo se olho vermelho, dor ocular, fotofobia, baixa visual ou lesão nasal.
Imunossuprimido, disseminado, acometimento ocular grave ou incapacidade VO	Aciclovir · 10 mg/kg EV 8/8 h · EV	7–10 dias ou conforme evolução	Hidratar e ajustar função renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa VO	Famciclovir · 500 mg VO 8/8 h · VO	7 dias	Quando disponível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
ANTIVIRAL PRECOCE + OFTALMO

Iniciar antiviral sistêmico precocemente e garantir avaliação oftalmológica urgente. Não usar corticoide tópico sem supervisão do especialista.

ALERTA CRÍTICO**Sinal de Hutchinson**

Lesão em ponta/lateral do nariz sugere acometimento nasociliar e maior risco ocular.

ATENÇÃO**Corticoide ocular só com oftalmo**

Uveíte/ceratite pode precisar corticoide tópico, mas não iniciar sem avaliação especializada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Rash em V1	Iniciar antiviral precoce e examinar olho/acuidade visual.
2	Olho vermelho, dor ocular, fotofobia, baixa visual ou Hutchinson	Encaminhar oftalmo urgente.
3	Imunossuprimido/disseminado	Internar e usar aciclovir EV.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Imunossupressão importante ▪ Disseminado ▪ Comprometimento ocular grave ▪ Encefalite/meningite ▪ Incapacidade VO
Falha terapêutica	▪ Lesões novas após 72 h de antiviral ▪ Piora ocular ▪ Dor intensa persistente ▪ Baixa visual

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Diagnóstico geralmente clínico; PCR de lesão ou humor aquoso em casos atípicos/graves conforme oftalmo.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Valaciclovir VO	1 g VO 8/8 h por 7–10 dias GRAVE Não aplicável	<50 mL/min: Ajustar intervalo conforme função renal	
Aciclovir VO/EV	800 mg VO 5x/dia GRAVE 10 mg/kg EV 8/8 h	Reduzida: Ajustar dose/intervalo e hidratar	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadros oftalmológicos dependem de disponibilidade de exame ocular, lâmpada de fenda, cultura, colírios específicos, avaliação oftalmológica e fluxo local de encaminhamento.
- Confirmar acuidade visual e sinais de alarme antes de classificar como quadro simples
- Validar fluxo local de oftalmologia/retaguarda
- Checar disponibilidade de colírios/antibióticos tópicos
- Evitar corticoide ocular sem avaliação especializada

12.9

Blefarite / Hordéolo / Calázio Infectado

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional dispensável

Inflamação/infecção palpebral superficial. A maioria melhora com higiene palpebral e compressas mornas; antibiótico tópico ou sistêmico é reservado para blefarite bacteriana importante, celulite associada ou falha.

CONDUTA DE PARTIDA

Higiene palpebral + compressa morna

Compressas 10–15 min, 3–4x/dia

VIA

Procedimento

DURAÇÃO

7–14 dias conforme quadro

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Staphylococcus epidermidis	FREQUENTE	
Disfunção de glândulas de Meibômio	COMUM	Base inflamatória, nem sempre infecciosa

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Blefarite/hordéolo simples sem celulite	Medidas locais · Compressa morna + higiene palpebral · Conduta	7–14 dias	Não é antibiótico; não espremer. Reavaliar se progressão para celulite.
Blefarite anterior bacteriana ou secreção na margem palpebral	Tobramicina 0,3% pomada oftálmica · Aplicar na margem palpebral 1–2x/dia · Tópica	7–10 dias	No Brasil não há pomada oftálmica de eritromicina nem de bacitracina isolada. As opções com apresentação nacional são tobramicina 0,3% pomada e as associações oxitetraciclina + polimixina B ou neomicina + polimixina B + bacitracina.
Celulite palpebral associada	Cefalexina ou Amoxicilina-Clavulanato · Cefalexina 500 mg VO 6/6 h ou Amox-clav 875/125 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Avaliar sinais de pré-septal/orbitária.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Blefarite posterior/rosácea ocular recorrente	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h inicialmente, depois ajustar · VO	Semanas, com oftalmo	Não usar na gestação; mais adequado para manejo especializado/recorrente.
Abscesso/purulência com risco de MRSA	SMX-TMP · 800/160 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Associar cobertura estreptocócica se celulite difusa.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Abscesso palpebral ▪ Purulência ▪ Colonização prévia ▪ Falha a betalactâmico	SMX-TMP ou clindamicina conforme cenário

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Calázio não é necessariamente infecção

Nódulo palpebral crônico indolor costuma ser inflamatório/obstrutivo; antibiótico geralmente não resolve.

ALERTA CRÍTICO

Sinais orbitários mudam tudo

Dor à movimentação ocular, proptose, diplopia ou baixa visual não são hordéolo simples.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Lesão palpebral localizada	Compressas mornas e higiene; não espremer.
2	Margem palpebral infectada	Adicionar pomada antibiótica tópica.
3	Celulite ou falha	Antibiótico VO e oftalmo se abscesso, recorrência ou dúvida diagnóstica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Sinais orbitários ▪ Celulite extensa/toxemia ▪ Imunossupressão ▪ Abscesso grande com necessidade de drenagem
Falha terapêutica	▪ Sem melhora com compressas ▪ Recorrência frequente ▪ Progressão para celulite

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não é rotina; coletar se drenagem de abscesso, recorrência, imunossupressão ou falha terapêutica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Tobramicina pomada oftálmica 0,3% Tópica	Aplicar na margem palpebral 1–2×/dia por 7–10 dias GRAVE Não aplicável	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme antimicrobiano específico	
Cefalexina VO	500 mg VO 6/6 h por 5–7 dias GRAVE Não indicada para orbitária	<50 mL/min: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Blefarite/hordéolo simples é geralmente padronizável, desde que sinais de celulite orbitária sejam excluídos.
- Confirmar ausência de sinais orbitários
- Evitar antibiótico sistêmico sem celulite
- Orientar retorno se progressão

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 12 — OFTALMOLÓGICO

- American Academy of Ophthalmology. Preferred Practice Pattern — Conjunctivitis.
- American Academy of Ophthalmology. Preferred Practice Pattern — Bacterial Keratitis.
- CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 — Gonococcal Infections.
- American Academy of Ophthalmology. Herpes Zoster Ophthalmicus.
- American Academy of Ophthalmology. Preferred Practice Patterns, versão vigente.

13

Tropicais/Zoonoses

8 quadros clínicos neste sistema

13.1	Leptospirose — Leve/Moderada	261
13.2	Leptospirose Grave / Síndrome de Weil	263
13.3	Febre Maculosa / Rickettsiose — Suspeita Clínica	265
13.4	Malária Não Complicada — Abordagem Inicial	267
13.5	Malária Grave — Emergência	269
13.6	Febre Tifoide / Paratifoide	271
13.7	Brucelose — Adulto	273
13.8	Tétano Acidental Instalado — Tratamento em UTI	275

13.1

Leptospirose — Leve/Moderada

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Síndrome febril aguda após exposição a enchente, lama, esgoto, roedores ou água contaminada, com mialgia intensa, cefaleia, hiperemia conjuntival e sintomas gastrointestinais. No PS, a decisão crítica é separar forma leve de doença grave com icterícia, injúria renal, sangramento, dispneia ou instabilidade.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina ou Amoxicilina

Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5–7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Leptospira interrogans	DEFINIDOR	Espiroqueta associada a urina de roedores e água/lama contaminada

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leptospirose leve/moderada, sem critérios de gravidade	Doxiciclina · 100 mg VO 12/12 h · VO	5–7 dias	Iniciar quando suspeita clínico-epidemiológica for forte; não aguardar sorologia se quadro compatível.
Gestante, contraindicação a tetraciclina ou alternativa VO	Amoxicilina · 500 mg VO 8/8 h · VO	5–7 dias	Opção quando doxiciclina não é desejável; confirmar protocolo local em gestante.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Intolerância ou contraindicação às opções principais	Azitromicina · 500 mg VO 24/24 h · VO	3 dias	Alternativa possível em cenários selecionados; validar protocolo local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Procurar sinais de gravidade em toda suspeita

Ícterícia, oligúria/creatinina elevada, hemoptise, dispneia, plaquetopenia importante, hipotensão, sangramento ou alteração neurológica mudam a conduta para internação/EV.

INFORMAÇÃO

Sorologia pode vir negativa no início

O diagnóstico inicial é frequentemente clínico-epidemiológico; não atrasar tratamento quando a suspeita é forte.

ATENÇÃO

Notificação e vigilância

Considerar notificação e orientação epidemiológica conforme fluxo local, especialmente após enchentes/surtos.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Síndrome febril + exposição epidemiológica	Solicitar hemograma, plaquetas, creatinina/ureia, eletrólitos, bilirrubinas, TGO/TGP, CK e urina I; avaliar hidratação, sangramento e pulmão.
2	Sem gravidade	Tratar VO, hidratação, analgesia segura, evitar AINE se risco renal/plaquetopenia e orientar retorno precoce.
3	Qualquer gravidade	Internar, trocar para esquema EV, monitorar rim/pulmão/sangramento/hemodinâmica e notificar conforme fluxo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Icterícia ▪ Oligúria ou injúria renal ▪ Sangramento ▪ Dispneia/hemoptise ▪ Hipotensão ▪ Alteração de consciência ▪ Plaquetopenia importante ▪ Gestaçao com sinais sistêmicos relevantes
Falha terapêutica	▪ Piora clínica ▪ Surgimento de icterícia/IRA ▪ Febre persistente com instabilidade ▪ Dispneia ou sangramento ▪ Vômitos impedindo VO

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Sorologia/PCR conforme disponibilidade e tempo de doença; não atrasar tratamento quando suspeita é forte.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO	100 mg VO 12/12 h por 5–7 dias GRAVE Não é escolha preferencial na forma grave	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	
Amoxicilina VO	500 mg VO 8/8 h por 5–7 dias GRAVE Não é escolha preferencial na forma grave	<30 mL/min: Ajustar intervalo conforme função renal	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Doenças tropicais e zoonoses dependem de epidemiologia regional, disponibilidade de testes, notificação, medicamentos estratégicos e fluxos de vigilância.
- Checar protocolo municipal/estadual e Ministério da Saúde quando aplicável
- Avaliar necessidade de notificação compulsória e contato com vigilância epidemiológica
- Confirmar disponibilidade institucional do medicamento e fluxo de referência

13.2

Leptospirose Grave / Síndrome de Weil

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Forma grave de leptospirose com icterícia, injúria renal, hemorragia, acometimento pulmonar, choque ou disfunção orgânica. Deve receber antibiótico EV, suporte intensivo quando indicado, monitorização renal/pulmonar e vigilância para sangramento.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ou Penicilina G cristalina

Ceftriaxona 1–2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Leptospira interrogans	DEFINIDOR	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Leptospirose grave hospitalar	Ceftriaxona · 1–2 g EV 24/24 h · EV	7 dias	Boa opção prática no PS; ajustar conforme protocolo local, gravidade, peso e função hepática/renal.
Alternativa clássica para forma grave	Penicilina G cristalina · 1,5 milhão UI EV 6/6 h · EV	7 dias	Opção tradicional; checar disponibilidade e alergia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Azitromicina · 500 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	3–5 dias	Preferir discutir com infectologia em doença grave; validar protocolo local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Atenção ao pulmão

Hemorragia pulmonar/SDRA pode evoluir rapidamente; monitorar SpO₂, trabalho respiratório, gasometria e necessidade de UTI.

ALERTA CRÍTICO

Suporte é tão importante quanto antibiótico

Hidratação cautelosa, correção eletrolítica, suporte renal, manejo de sangramento e vasopressor quando indicado.

ATENÇÃO

Evitar excesso de volume

Na forma pulmonar ou renal grave, hidratação deve ser individualizada e reavaliada frequentemente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita grave	Coletar exames, iniciar ceftriaxona/penicilina EV e internar sem aguardar confirmação laboratorial.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Disfunção pulmonar/renal/hemodinâmica	Monitorizar em sala crítica/UTI, controlar balanço hídrico, eletrólitos, diurese, plaquetas e oxigenação.
3	Evolução	Reavaliar diariamente gravidade, necessidade de diálise, suporte ventilatório e diagnósticos diferenciais como dengue grave, hantavirose, sepse e malária.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Todos os casos graves
UTI	▪ Choque ▪ Insuficiência respiratória ▪ Hemoptise/hemorragia pulmonar ▪ IRA com indicação dialítica ▪ Rebaixamento ▪ Sangramento grave
Gravidade	▪ Icterícia ▪ Creatinina elevada/oligúria ▪ Sangramento ▪ Dispneia ▪ Hipotensão

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Sorologia/PCR conforme fase; hemoculturas se diagnóstico diferencial de sepse bacteriana. Não atrasar antibiótico EV.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	1–2 g EV 24/24 h por 7 dias GRAVE 2 g EV 24/24 h conforme gravidade/protocolo	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	
Penicilina G cristalina EV	1,5 milhão UI EV 6/6 h por 7 dias GRAVE Mesmo esquema; ajustar em disfunção renal importante conforme protocolo	DRC/IRA relevante: Ajustar intervalo conforme função renal e protocolo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

13.3

Febre Maculosa / Rickettsiose — Suspeita Clínica

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Síndrome febril aguda potencialmente fatal após exposição a carrapato/área de mata/capivara/cães, com cefaleia, mialgia intensa, exantema, sintomas gastrointestinais, plaquetopenia, hiponatremia ou disfunção orgânica. A prioridade é iniciar doxiciclina imediatamente na suspeita.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina

100 mg EV/VO 12/12 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

7 dias ou até 3 dias após afebril

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Rickettsia rickettsii	PRINCIPAL NO BRASIL	Pode evoluir rapidamente para choque e óbito
Outras rickettsioses	POSSÍVEL	Epidemiologia regional modifica risco

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de febre maculosa/ rickettsiose	Doxiciclina · 100 mg EV/VO 12/12 h · VO/EV	7 dias ou até 3 dias após afebril	Não aguardar sorologia. Em doença grave, usar EV se disponível ou VO/sonda se absorção adequada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Impossibilidade absoluta de doxiciclina	Cloranfenicol · 50–75 mg/kg/dia EV dividido 6/6 h · EV	7 dias	Alternativa menos preferida; risco maior de desfecho ruim. Discutir infectologia/ vigilância.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Não esperar exame

Sorologia costuma negativar no início. Atraso na doxiciclina aumenta mortalidade.

ALERTA CRÍTICO

Doxiciclina é a droga de escolha

Na suspeita relevante, doxiciclina deve ser priorizada inclusive em situações especiais pela gravidade da doença; validar exceções com especialista.

ATENÇÃO

Exantema pode faltar no começo

Ausência de exantema inicial não exclui febre maculosa/rickettsiose.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre + epidemiologia compatível	Iniciar doxiciclina imediatamente se suspeita relevante; coletar exames sem atrasar.
2	Gravidade ou incerteza com alto risco	Internar, monitorar plaquetas, sódio, função renal/hepática, lactato e sinais de choque.
3	Vigilância	Notificar conforme fluxo local e orientar investigação epidemiológica.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita moderada/alta ▪ Plaquetopenia ▪ Hiponatremia ▪ TGO/TGP elevadas ▪ Vômitos ▪ Exantema petequial ▪ Comorbidades ▪ Gestaçao
UTI	▪ Choque ▪ Rebaixamento ▪ Insuficiência respiratória ▪ IRA ▪ Sangramento ▪ Lactato elevado
Gravidade	▪ Confusão ▪ Hipotensão ▪ Dispneia ▪ Petéquias/púrpura ▪ Dor abdominal intensa

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Sorologia pareada/PCR conforme disponibilidade; não atrasar doxiciclina. Investigar dengue, leptospirose, meningococcemia, sepse, malária conforme contexto.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina VO/EV	100 mg EV/VO 12/12 h GRAVE 100 mg EV 12/12 h quando disponível; não atrasar se só VO/sonda	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

13.4

Malária Não Complicada — Abordagem Inicial

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Febre em pessoa que reside ou esteve em área endêmica, com calafrios, sudorese, cefaleia, mialgia, anemia ou plaquetopenia. O tratamento depende de espécie, peso, gestação, gravidade, G6PD e protocolo oficial vigente.

CONDUTA DE PARTIDA

Página de triagem: confirmar espécie, gravidade, peso, gestação e G6PD na tabela oficial do Ministério da Saúde

Usar tabela oficial atual

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Conforme espécie e protocolo

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Plasmodium vivax	FREQUENTE NO BRASIL	Exige estratégia para hipnozoítos com primaquina/tafenoquina quando permitida
Plasmodium falciparum	RISCO DE GRAVIDADE	Maior risco de doença grave e resistência
Plasmodium malariae/ovale	MENOS COMUM	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
P. vivax provável/confirmado, sem gravidade	Cloroquina + Primaquina · Conforme peso e protocolo do Ministério da Saúde · VO	Conforme protocolo	Primaquina exige atenção a G6PD, gestação e lactação; seguir tabela por peso.
P. falciparum provável/confirmado, sem gravidade	Terapia combinada baseada em artemisinina · Conforme peso e protocolo local · VO	Conforme protocolo	Não usar cloroquina para falciparum. Checar disponibilidade e protocolo oficial.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Dúvida de espécie, gestação, criança, comorbidade ou indisponibilidade do esquema	Encaminhar/referenciar para protocolo de malária · Conduta: confirmar espécie/gravidade e não atrasar diagnóstico, suporte e terapia indicada · Conduta	Individualizar	Malária tem tratamento por espécie/peso; usar tabela oficial atual.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

USAR A TABELA OFICIAL VIGENTE

O esquema muda por espécie, peso/idade, gestação, gravidade e deficiência de G6PD. Esta ficha não substitui a tabela oficial; acessar o link da referência antes de prescrever.

ALERTA CRÍTICO**Sempre procurar gravidade**

Alteração de consciência, convulsão, dispneia, choque, icterícia com disfunção, hipoglicemia, anemia grave, sangramento, IRA ou hiperparasitemia indicam malária grave.

ATENÇÃO**Tratamento depende de espécie e peso**

Não padronizar um único esquema para todas as malárias. Usar protocolo oficial vigente.

ATENÇÃO**Primaquina exige checagens**

Avaliar G6PD, gestação, lactação e contraindicações antes de primaquina/tafenoquina.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre + área endêmica	Solicitar gota espessa/teste rápido imediatamente e avaliar espécie/parasitemia.
2	Sem gravidade	Tratar conforme espécie e peso; garantir retorno e vigilância.
3	Gravidade ou dúvida	Internar e manejar como malária grave até exclusão.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Gestante ▪ Falciparum com risco ▪ Vômitos persistentes ▪ Comorbidades relevantes ▪ Dúvida diagnóstica com piora ▪ Impossibilidade de tratamento/seguimento
UTI	Qualquer critério de malária grave
Gravidade	▪ Rebaixamento ▪ Convulsão ▪ Choque ▪ Insuficiência respiratória ▪ Hipoglicemia ▪ Anemia grave ▪ IRA ▪ Icterícia com disfunção orgânica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Gota espessa é exame central; repetir se suspeita persistente e primeiro exame negativo. Teste rápido não substitui avaliação de gravidade/parasitemia quando disponível.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cloroquina + Primaquina VO	Conforme peso/protocolo para P. vivax GRAVE Não indicada isoladamente na malária grave	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	
Terapia combinada com artemisinina VO	Conforme peso/protocolo para P. falciparum GRAVE Malária grave requer artesunato EV	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Malária — diagnóstico e tratamento conforme protocolo e tabelas oficiais vigentes.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/malaria>

13.5

Malária Grave — Emergência

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Malária com disfunção orgânica, alteração neurológica, choque, insuficiência respiratória, hipoglicemia, anemia grave, IRA, sangramento ou alta parasitemia. Deve receber antimalárico parenteral urgente e suporte intensivo.

CONDUTA DE PARTIDA

Artesunato EV — imediato

2,4 mg/kg EV em 0 h, 12 h e 24 h e depois 24/24 h (crianças < 20 kg: 3 mg/kg). Confirmar espécie, peso, gestação e G6PD na tabela oficial do Ministério da Saúde para o esquema oral de continuidade

VIA

EV

DURAÇÃO

Mínimo 24 h e até poder completar esquema VO

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Plasmodium falciparum	PRINCIPAL RISCO DE GRAVIDADE	
Plasmodium vivax	TAMBÉM PODE COMPLICAR	Menos comum, mas possível

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Malária grave ou suspeita de malária grave	Artesunato · 2,4 mg/kg EV em 0 h, 12 h, 24 h e depois diariamente · EV	Mínimo 24 h	Não atrasar por confirmação completa se suspeita forte e paciente grave.

Sobre a duração: Até tolerar VO e completar esquema oral conforme espécie/protocolo.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Artesunato indisponível	Quinina/quinidina conforme protocolo local · Dose por peso conforme protocolo oficial, com ECG, glicemia e monitorização intensiva · EV	Até transição para VO	Maior toxicidade; exige ECG, glicemia e monitorização. Usar apenas conforme protocolo/referência.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**USAR A TABELA OFICIAL VIGENTE**

O esquema muda por espécie, peso/idade, gestação, gravidade e deficiência de G6PD. Esta ficha não substitui a tabela oficial; acessar o link da referência antes de prescrever.

ALERTA CRÍTICO**Artesunato EV urgente**

Malária grave é emergência; tratamento parenteral não deve atrasar.

ALERTA CRÍTICO**Monitorar hipoglicemia e anemia**

Checar glicemia seriada, hemoglobina, lactato, função renal, eletrólitos e sinais respiratórios.

ATENÇÃO**Completar tratamento oral**

Após melhora e tolerância VO, completar esquema oral conforme espécie/protocolo; artesunato EV isolado não encerra o tratamento.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de malária grave	Iniciar artesunato EV e coletar gota espessa/parasitemia sem atrasar terapia.
2	Disfunção orgânica	UTI, suporte hemodinâmico/respiratório, glicemia seriada, controle de convulsões e avaliação renal.
3	Melhora e tolera VO	Completar esquema oral conforme espécie e protocolo oficial; monitorar hemólise tardia após artesunato.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Malária confirmada/suspeita com gravidade, impossibilidade de tratamento VO, falha terapêutica, gestação ou necessidade de monitorização
UTI	Disfunção orgânica, alteração neurológica, choque, SDRA ou acidose/lactato alto
Gravidade	▫ Coma/convulsão ▫ Choque ▫ SDRA ▫ Hipoglicemia ▫ Anemia grave ▫ IRA ▫ Sangramento ▫ Acidose/lactato alto ▫ Hiperparasitemia

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Gota espessa/parasitemia seriada; avaliar coinfeções conforme contexto. Não atrasar artesunato em paciente grave.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Artesunato EV	2,4 mg/kg EV 0 h, 12 h, 24 h e depois diariamente GRAVE Mesmo esquema; iniciar imediatamente	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Malária — diagnóstico e tratamento conforme protocolo e tabelas oficiais vigentes.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/malaria>

13.6

Febre Tifoide / Paratifoide

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional **obrigatória**

Febre prolongada, sintomas gastrointestinais, cefaleia, toxemia, bradicardia relativa possível e história de água/alimento contaminado ou viagem. Resistência antimicrobiana é relevante; colher culturas antes do antibiótico quando possível.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ou Azitromicina

Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

10–14 dias conforme gravidade/resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Salmonella entérica sorovar Typhi	PRINCIPAL	
Salmonella Paratyphi	POSSÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Febre tifoide moderada/grave ou necessidade de internação	Ceftriaxona · 2 g EV 24/24 h · EV	10–14 dias	Colher hemoculturas antes se possível, sem atrasar em instáveis. Revisar viagem para áreas com XDR/resistência.
Quadro estável, possibilidade de tratamento VO e seguimento	Azitromicina · 1 g VO dose de ataque, depois 500 mg VO 24/24 h · VO	6 dias no total	Considerar resistência local, local de aquisição e gravidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sensibilidade conhecida a quinolona	Ciprofloxacino · 500 mg VO 12/12 h ou 400 mg EV 12/12 h · VO/EV	7–10 dias	Não usar empiricamente se resistência a quinolona for provável; preferir apenas com sensibilidade conhecida/provável.
Viagem/epidemiologia com suspeita de cepa XDR ou falha a ceftriaxona	Discutir carbapenêmico ou azitromicina conforme sensibilidade · Conforme cultura, gravidade e protocolo · VO/EV	Individualizar	Cenário de validação obrigatória por resistência.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Resistência muda escolha

Viagem para áreas com resistência a quinolonas ou XDR muda a terapia empírica e exige cultura/sensibilidade.

ALERTA CRÍTICO

Complicações abdominais

Dor abdominal intensa, peritonite, sangramento digestivo ou choque sugerem perfuração/hemorragia e exigem cirurgia/UTI.

INFORMAÇÃO

Cultura antes se possível

Hemocultura tem maior rendimento no início; não atrasar antibiótico se instável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Colher hemoculturas e considerar coprocultura; avaliar viagem, contato, resistência local e gravidade.
2	Grave/complicada	Ceftriaxona EV ou alternativa conforme risco de XDR; hidratação e avaliação abdominal seriada.
3	Resultado de cultura	Ajustar conforme sensibilidade, notificar conforme fluxo e orientar prevenção de transmissão.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toxemia ▪ Vômitos persistentes ▪ Desidratação ▪ Complicação abdominal ▪ Gestação ▪ Imunossupressão ▪ Falha ambulatorial ▪ Risco de resistência/XDR
UTI	▪ Choque ▪ Perfuração intestinal ▪ Sangramento importante ▪ Rebaixamento
Falha terapêutica	▪ Febre persistente >5 dias de tratamento ▪ Piora clínica ▪ Cultura com resistência ▪ Sinais abdominais

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se possível; coprocultura pode ajudar, especialmente após a primeira semana. Suspeita de XDR exige sensibilidade.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h por 10–14 dias GRAVE 2 g EV 24/24 h	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Azitromicina VO	1 g VO ataque, depois 500 mg VO 24/24 h GRAVE Preferir EV ceftriaxona ou terapia guiada se grave/XDR	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

13.7

Brucelose — Adulto

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Zoonose associada a leite não pasteurizado, contato com animais/abatedouro/veterinária, com febre ondulante, sudorese, artralgia, dor lombar, hepatoesplenomegalia ou sintomas focais. Tratamento exige combinação prolongada para reduzir recidiva e avaliação ativa de doença focal.

CONDUTA DE PARTIDA

Doxiciclina + Rifampicina

Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h + Rifampicina 600–900 mg VO/dia

VIA

VO

DURAÇÃO

Pelo menos 6 semanas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Brucella spp.	DEFINIDOR	B. abortus, melitensis, suis e canis conforme exposição

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Brucelose não complicada	Doxiciclina + Rifampicina · Doxi 100 mg VO 12/12 h + Rifampicina 600–900 mg VO 24/24 h · VO	Pelo menos 6 semanas	Checar interações da rifampicina, função hepática e adesão.
Doença mais grave, focal ou alto risco de recidiva	Doxiciclina + Gentamicina · Doxi 100 mg VO 12/12 h por 6 semanas + Gentamicina 5 mg/kg EV/IM 24/24 h por 7–14 dias · Mista	6 semanas + aminoglicosídeo 7–14 dias	Considerar doença focal, osteoarticular, endovascular ou conforme infectologia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Contraindicação a doxiciclina ou situação especial	Rifampicina + Sulfametoxazol-Trimetoprima · Rifampicina 600–900 mg/dia + SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h · VO	6 semanas ou mais	Especialmente em gestação/criança conforme especialista; individualizar.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Procurar foco complicado

Dor lombar, déficit neurológico, sopro, febre persistente ou artrite focal sugerem espondilodiscite, neurobrucelose ou endocardite.

ALERTA CRÍTICO

Endocardite por *Brucella* é grave

Suspeitar se sopro, insuficiência cardíaca, hemocultura persistente ou prótese valvar.

ATENÇÃO

Atenção a rifampicina

Rifampicina tem múltiplas interações, reduz eficácia de anticoncepcionais e exige cautela hepática.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita epidemiológica	Solicitar sorologia/culturas conforme disponibilidade e avaliar foco focal; avisar laboratório se cultura por biossegurança.
2	Não complicada	Tratar com combinação por pelo menos 6 semanas, checar interações e orientar adesão rigorosa.
3	Focal/complicada	Internar ou referenciar; prolongar terapia conforme foco e especialista.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita de endocardite ▪ Neurobrucelose ▪ Espondilodiscite grave ▪ Instabilidade ▪ Gestação com doença grave ▪ Falha/recidiva
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ Recidiva ▪ Foco osteoarticular/endovascular não tratado ▪ Baixa adesão

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e sorologia conforme disponibilidade; avisar laboratório se suspeita de <i>Brucella</i> por biossegurança.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Doxiciclina + Rifampicina VO	Doxi 100 mg 12/12 h + Rifa 600–900 mg/dia por pelo menos 6 semanas GRAVE Considerar adicionar aminoglicosídeo conforme gravidade	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	HEPÁTICO Monitorar hepatotoxicidade da rifampicina
Gentamicina IM/EV	5 mg/kg EV/IM 24/24 h por 7–14 dias GRAVE Mesmo, com monitorização	DRC/IRA: Ajustar dose/intervalo e monitorar níveis quando disponível	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Doenças tropicais e zoonoses dependem de epidemiologia regional, disponibilidade de testes, notificação, medicamentos estratégicos e fluxos de vigilância.
- Checar protocolo municipal/estadual e Ministério da Saúde quando aplicável

- Avaliar necessidade de notificação compulsória e contato com vigilância epidemiológica
- Confirmar disponibilidade institucional do medicamento e fluxo de referência

13.8

Tétano Acidental Instalado — Tratamento em UTI

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Suspeitar em trismo, rigidez, espasmos dolorosos, disfagia ou disautonomia após ferimento contaminado ou vacinação desconhecida/incompleta. O manejo exige neutralização de toxina, limpeza/desbridamento do foco, vacinação, metronidazol e suporte intensivo.

CONDUTA DE PARTIDA

Metronidazol + Imunoglobulina antitetânica + suporte
Metronidazol 500 mg EV/VO 6/6 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Clostridium tetani	DEFINIDOR	Produce toxina tetanospasmina em ferimentos contaminados/anaeróbios

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Tétano clínico suspeito/confirmado	Metronidazol · 500 mg EV/VO 6/6 h · VO/EV	7–10 dias	Associar imunoglobulina antitetânica, limpeza/desbridamento do ferimento, vacinação e suporte em ambiente monitorizado.
Neutralização de toxina não ligada	Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) · 3.000–6.000 UI IM no tétano instalado, em dose única, aplicada em massa muscular diferente da vacina. Na profilaxia após ferimento a dose é 250–500 UI. Onde só houver soro antitetânico heterólogo (SAT), seguir a dose e o teste de sensibilidade do protocolo · IM	Dose única	Aplicar em local diferente da vacina; não substitui vacinação e não neutraliza toxina já ligada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativa ao metronidazol se necessário	Penicilina G cristalina · 2–4 milhões UI EV 4/4 h a 6/6 h · EV	7–10 dias	Metronidazol é frequentemente preferido; usar conforme protocolo.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	Ferimento contaminado, tecido desvitalizado, corpo estranho ou necrose	Metronidazol + desbridamento

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**NÃO CONFUNDIR TRATAMENTO COM PROFILAXIA**

Tétano clínico requer UTI, controle de via aérea/espasmos/disautonomia, limpeza e desbridamento, antimicrobiano, neutralização com IGHAT ou SAT conforme protocolo brasileiro e vacinação ativa em local distinto.

ALERTA CRÍTICO**Doença clínica é UTI**

Risco de laringoespasma, insuficiência respiratória e instabilidade autonômica.

ATENÇÃO**Vacinar mesmo após doença**

Tétano clínico não garante imunidade; completar esquema vacinal.

ATENÇÃO**Antibiótico não previne tétano em ferimento**

Profilaxia de tétano depende de limpeza do ferimento, vacina e imunoglobulina quando indicada; antibiótico é para tétano clínico/infecção bacteriana associada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	Internar em ambiente monitorizado, reduzir estímulos, avaliar via aérea e iniciar controle de espasmos.
2	Ferimento/foco	Limpeza ampla, retirada de corpo estranho e desbridamento se necessário.
3	Terapia específica	Metronidazol + imunoglobulina antitetânica + vacinação; suporte ventilatório/hemodinâmico conforme evolução.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Todo tétano clínico
UTI	▪ Trismo/espasmos ▪ Disfagia ▪ Disautonomia ▪ Rigidez generalizada ▪ Risco respiratório
Gravidade	▪ Espasmos frequentes ▪ PA/FC lábeis ▪ Hipóxia ▪ Rigidez torácica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Diagnóstico é clínico; cultura do ferimento não exclui nem confirma de forma confiável.
Controle de foco	Limpeza ampla, retirada de corpo estranho e desbridamento se necessário.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 6/6 h por 7–10 dias GRAVE 500 mg EV 6/6 h	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	
Imunoglobulina humana antitetânica IM	Dose única conforme protocolo local GRAVE Dose única; não atrasar	Geral: Sem ajuste renal usual ou ajustar conforme fármaco específico	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Quadro de alto risco ou medicamento dependente de fluxo institucional, vigilância epidemiológica, referência especializada ou protocolo oficial atualizado.
- Acionar infectologia/CCIH ou referência regional quando disponível
- Checar protocolo oficial vigente e disponibilidade do fármaco
- Notificar vigilância epidemiológica quando aplicável
- Documentar gravidade, critérios de internação/UTI, culturas/exames e plano de reavaliação

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Tétano Acidental — vigilância, profilaxia e tratamento.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tetano-acidental>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 13 — TROPICAIS/ZOONOSES

- Ministério da Saúde — leptospirose: tratamento na suspeita e hospitalização imediata em casos graves.
- CDC — RMSF/rickettsioses: doxiciclina é tratamento de escolha e não deve aguardar confirmação laboratorial.
- CDC/WHO — malária grave: artesunato parenteral urgente e transição para esquema oral conforme espécie/protocolo.
- CDC — febre tifoide/paratifoide: resistência antimicrobiana deve guiar escolha e fluoroquinolona não deve ser empírica quando resistência é provável.
- CDC — brucelose: combinação com doxiciclina e rifampicina por pelo menos 6 semanas nos casos não complicados.
- CDC — tétano: limpeza/desbridamento, TIG, vacinação e suporte; antibiótico não substitui controle do ferimento e suporte intensivo.
- Ministério da Saúde. Malária — diagnóstico e tratamento, versão vigente.
- Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde, 6ª edição.

14

Pediatria

11 quadros clínicos neste sistema

Confirmar peso atual, idade exata, dose máxima, função renal/hepática, alergias e protocolo local. Neonato/lactente jovem deve seguir fluxo pediátrico específico.

14.1	PAC Pediátrica — >3 meses	279
14.2	Otite Média Aguda — Pediátrica	282
14.3	Sinusite Bacteriana Aguda — Pediátrica	284
14.4	Faringoamigdalite Estreptocócica — Pediátrica	286
14.5	ITU Febril — Lactente após Período Neonatal e Criança	288
14.6	Celulite / Erisipela — Pediátrica	291
14.7	Impetigo / Ectima — Pediátrico	293
14.8	Meningite Bacteriana — Pediátrica (>1 mês)	295
14.9	Sepse / Choque Séptico — Pediátrico	297
14.10	Osteomielite / Artrite Séptica — Pediátrica	300
14.11	Mordedura Humana/Animal — Pediátrica	302

14.1

PAC Pediátrica — >3 meses

MODERADA AMBULATORIAL PEDIÁTRICO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional **recomendada**

Pneumonia adquirida na comunidade em criança maior de 3 meses. A maioria dos pré-escolares tem etiologia viral, mas quando a suspeita bacteriana é relevante, o alvo principal é pneumococo. Avaliar idade, vacinação, hipoxemia, esforço respiratório, hidratação e capacidade de seguimento.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina

80–90 mg/kg/dia VO dividido 12/12 h ou 8/8 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias se resposta rápida; 7–10 dias se grave/complicada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL BACTERIANO	Alvo da amoxicilina em criança imunizada com PAC típica
Vírus respiratórios	MUITO FREQUENTES	Especialmente pré-escolares; antibiótico nem sempre é necessário
Mycoplasma pneumoniae	ESCOLARES/ ADOLESCENTES	Curso subagudo, tosse persistente, sintomas extrapulmonares
Staphylococcus aureus	MENOS COMUM	Considerar pós-influenza, necrose, derrame/empiema ou gravidade

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Criança >3 meses, suspeita bacteriana, sem gravidade	Amoxicilina · 80–90 mg/kg/dia VO dividido 12/12 h ou 8/8 h; máximo usual 4 g/dia · VO	5 dias se boa resposta; 7–10 dias se grave/complicada	Não usar antibiótico se quadro claramente viral e sem sinais de pneumonia bacteriana. Reavaliar em 48–72 h.
Escolar/adolescente com suspeita de atípico	Azitromicina · 10 mg/kg VO D1, depois 5 mg/kg/dia D2-D5; máximo 500 mg D1 e 250 mg/dia · VO	5 dias	Pode ser associada a betalactâmico se dúvida entre típica e atípica.
Internação, imunização adequada, sem risco de MRSA/ Pseudomonas	Ampicilina ou Penicilina cristalina · Ampicilina 150–200 mg/kg/dia EV dividido 6/6 h · EV	5–7 dias se boa resposta	Trocar para VO quando estável, afebril/ melhorando, sem hipoxemia progressiva e aceitando dieta.
Grave, não imunizado, complicação, UTI ou falha ambulatorial	Ceftriaxona ou Cefotaxima + cobertura seletiva anti-MRSA · Ceftriaxona 50–100 mg/kg/dia EV 24/24 h + vancomicina/clindamicina se critério · EV	7–10 dias	Cobertura anti-MRSA não é automática: considerar necrose, empiema, pós-influenza, choque, colonização/infecção prévia ou alta prevalência local.

Sobre a duração: Individualizar se necrose, empiema ou bacteremia. Individualizar se complicação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não anafilática a penicilina	Cefuroxima axetil ou Cefdinir · Cefuroxima axetil 30 mg/kg/dia VO 12/12 h; cefdinir 14 mg/kg/dia VO 1–2×/dia · VO	5–7 dias	No Brasil, a cefalosporina oral de alternativa mais disponível é a cefuroxima axetil (comprimido de 250 e 500 mg e suspensão). O cefdinir existe apenas como suspensão oral pediátrica; cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável e podem não ser encontradas. Confirmar no formulário local antes de prescrever.
Alergia grave/anafilaxia a betalactâmico	Azitromicina ou Levofloxacin em cenário selecionado · Azitromicina conforme peso; levofloxacin apenas se necessário e com avaliação especializada · VO/EV	5–7 dias	Em criança, evitar fluoroquinolona salvo necessidade; discutir casos graves.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Pneumonia necrosante ▪ Empiema ▪ Choque ▪ Pós-influenza ▪ Colonização/infecção prévia por MRSA	Vancomicina EV ou Clindamicina se sensibilidade local favorável e sem bacteremia grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

DERRAME PARAPNEUMÔNICO: ATUALIZAÇÃO FOCAL DE 2026

Atualização focal IDSA/PIDS 2026: observar derrame pequeno não complicado; drenar derrame moderado com desconforto respiratório, derrame grande ou empiema; quando a drenagem está indicada, preferir dreno com fibrinolítico intrapleural como primeira abordagem em vez de cirurgia imediata, conforme condições locais e especialista.

ALERTA CRÍTICO**Hipoxemia muda o caso**

SpO₂ baixa para idade/altitude, gemência, tiragem importante, apneia, cianose, exaustão ou incapacidade de hidratar indicam avaliação hospitalar.

INFORMAÇÃO

Pré-escolar nem sempre precisa antibiótico

Em quadro viral típico, sem consolidação clínica/radiológica e sem gravidade, antibiótico pode ser desnecessário.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de PAC	Avaliar idade, vacinação, saturação, trabalho respiratório, hidratação e comorbidades.
2	Sem gravidade	Tratar VO quando suspeita bacteriana; orientar retorno em 24–48 h se piora.
3	Gravidade ou complicação	Internar, coletar exames/culturas conforme caso e iniciar EV.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Hipoxemia ▪ Esforço respiratório moderado/importante ▪ Desidratação ou vômitos ▪ Lactente jovem ▪ Doença de base ▪ Falha terapêutica ▪ Derrame pleural/empiema

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Insuficiência respiratória ▪ Choque ▪ Apneia ▪ Rebaixamento ▪ Necrose/empiema grave
Falha terapêutica	▪ Piora ou febre persistente após 48–72 h ▪ Aumento do esforço respiratório ▪ Hipoxemia ▪ Derrame/complicação

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemocultura se internado grave, complicação, UTI ou falha; painel viral conforme sazonalidade/disponibilidade.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	80–90 mg/kg/dia VO dividido 12/12 h ou 8/8 h GRAVE Não é esquema para UTI	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	TETO Máximo usual 4 g/dia
Ceftriaxona EV	50 mg/kg/dia EV 24/24 h GRAVE 100 mg/kg/dia EV em casos graves, conforme protocolo	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	TETO 2 g/dia usual; individualizar em grave

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA/PIDS. Community-acquired Pneumonia in Infants and Children — atualização sobre derrame parapneumônico, 2026.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/community-acquired-pneumonia-in-infants-and-children/>

14.2

Otite Média Aguda — Pediátrica

LEVE AMBULATORIAL PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Infecção da orelha média em criança com otalgia, febre, irritabilidade e membrana timpânica abaulada ou otorreia aguda. A decisão entre observação e antibiótico depende da idade, lateralidade, gravidade, otorreia e segurança de seguimento.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina

80–90 mg/kg/dia VO dividido 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5–10 dias conforme idade/gravidade

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	FREQUENTE	
Haemophilus influenzae não tipável	FREQUENTE	Beta-lactamase pode justificar amoxicilina-clavulanato
Moraxella catarrhalis	FREQUENTE	Produtora de betalactamase

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
OMA sem conjuntivite purulenta, sem amoxicilina recente	Amoxicilina · 80–90 mg/kg/dia VO 12/12 h · VO	<2 anos ou grave: 10 dias	Analgesia é obrigatória. Considerar observação em casos leves com seguimento seguro.
Amoxicilina nos últimos 30 dias, conjuntivite purulenta ou falha inicial	Amoxicilina + Clavulanato · até 70 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h (suspensão 400/57 mg/5 mL); completar com amoxicilina isolada para atingir 80–90 mg/kg/dia · VO	7–10 dias	Escolha quando houver maior chance de H. influenzae/Moraxella produtores de betalactamase. No Brasil não existe a suspensão 14:1 (600/42,9 mg/5 mL): com a suspensão 400/57 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de amoxicilina levaria o clavulanato a ~12,8 mg/kg/dia. Manter o clavulanato em até 10 mg/kg/dia e completar a amoxicilina com o produto isolado.
Vômitos, impossibilidade VO ou falha importante	Ceftriaxona · 50 mg/kg IM/EV 24/24 h · IM/EV	1 dose se impossibilidade VO	Reavaliar clinicamente; falha após 48–72 h exige checar diagnóstico, adesão e complicações.

Sobre a duração: 2–5 anos leve/moderada: 7 dias; ≥6 anos leve: 5–7 dias. 3 dias em falha terapêutica conforme reavaliação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não grave a penicilina	Cefuroxima axetil ou Cefdinir · Cefuroxima axetil 30 mg/kg/dia VO 12/12 h; cefdinir 14 mg/kg/dia VO 1–2×/dia · VO	5–10 dias conforme idade/gravidade	No Brasil, a cefalosporina oral de alternativa mais disponível é a cefuroxima axetil (comprimido de 250 e 500 mg e suspensão). O cefdinir existe apenas como suspensão oral pediátrica; cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável e podem não ser encontradas. Confirmar no formulário local antes de prescrever.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Clindamicina · 30–40 mg/kg/dia VO dividido 8/8 h · VO	7–10 dias	Não cobre bem <i>H. influenzae</i> /Moraxella; reavaliar se falha.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

DOSE ALTA DE AMOXICILINA-CLAVULANATO NO BRASIL

A dose alta descrita nas diretrizes norte-americanas (90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato) depende da suspensão 600/42,9 mg/5 mL, na proporção 14:1, que não existe no Brasil. Com a suspensão disponível aqui (400/57 mg/5 mL, proporção 7:1), 90 mg/kg/dia de amoxicilina levariam o clavulanato a cerca de 12,8 mg/kg/dia, acima do que se tolera. A forma correta de chegar a 80–90 mg/kg/dia é dar até 70 mg/kg/dia pela suspensão combinada e completar com amoxicilina isolada.

ATENÇÃO

DISPONIBILIDADE NO BRASIL

A cefalosporina oral de alternativa com apresentação mais estável no Brasil é a cefuroxima axetil. O cefdinir existe aqui apenas como suspensão oral pediátrica; cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável. Priorizar amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato e escolher a alternativa pelo tipo de alergia e pelo formulário do serviço.

ATENÇÃO

Diagnóstico exige otoscopia compatível

Hiperemia isolada da membrana timpânica não confirma OMA; procurar abaulamento, nível líquido ou otorreia aguda.

ALERTA CRÍTICO

Complicações exigem avaliação urgente

Mastoidite, paralisia facial, sinais meníngeos, toxicidade ou protrusão auricular mudam conduta.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Otalgia/febre	Confirmar OMA por otoscopia e tratar dor.
2	Indicação de antibiótico	Escolher amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato conforme risco de betalactamase.
3	Falha 48–72 h	Reavaliar diagnóstico/complicação e trocar esquema.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Toxicidade ▫ Mastoidite ▫ Complicação intracraniana suspeita ▫ Imunossupressão importante ▫ Falha grave com vômitos/desidratação
Falha terapêutica	▫ Persistência de febre/otalgia após 48–72 h ▫ Otorreia persistente ▫ Piora clínica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não rotineiras; cultura de otorreia se recorrente, falha ou imunossuprimido.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	80–90 mg/kg/dia VO 12/12 h GRAVE Usar amoxicilina-clavulanato ou ceftriaxona se falha/gravidade	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Amoxicilina + Clavulanato VO	até 70 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h (suspensão 400/57 mg/5 mL) GRAVE completar com amoxicilina isolada até 80–90 mg/kg/dia, mantendo o clavulanato em até 10 mg/kg/dia	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.3 Sinusite Bacteriana Aguda — Pediátrica

MODERADA

AMBULATORIAL

PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional **recomendada**

Rinossinusite bacteriana em criança sugerida por sintomas persistentes >10 dias sem melhora, início grave com febre alta/secreção purulenta por ≥3 dias, ou piora bifásica após quadro viral. O objetivo é tratar bactéria provável sem antibiótico para resfriado viral comum.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina + Clavulanato

45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h; 80–90 mg/kg/dia se risco de resistência ou gravidade — com a suspensão brasileira 400/57 mg/5 mL, até 70 mg/kg/dia e o restante com amoxicilina isolada

VIA

VO

DURAÇÃO

10 dias ou até 7 dias após melhora; individualizar

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	FREQUENTE	
Haemophilus influenzae	FREQUENTE	
Moraxella catarrhalis	FREQUENTE	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sinusite bacteriana persistente, grave ou com piora bifásica	Amoxicilina ± Clavulanato · 45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h; se risco de resistência ou gravidade, 80–90 mg/kg/dia — com a suspensão brasileira 400/57 mg/5 mL, dar até 70 mg/kg/dia pelo clavulanato e completar com amoxicilina isolada · VO	10–14 dias; reavaliar se piora ou sem melhora em 72 h	Em doença persistente sem gravidade pode haver observação por 3 dias se seguimento seguro; antibiótico imediato se início grave ou piora.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Toxicidade, complicação orbitária/intracraniana ou incapacidade VO	Ceftriaxona ou Ampicilina-Sulbactam · Ceftriaxona 50–75 mg/kg/dia EV 24/24 h ou Ampicilina-Sulbactam 200 mg/kg/dia EV dividido 6/6 h · EV	10–14 dias; individualizar se complicação	Imagem e ORL/Oftalmo/Neuro conforme complicação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não grave a penicilina	Cefuroxima axetil ou Cefdinir · Cefuroxima axetil 30 mg/kg/dia VO 12/12 h; cefdinir 14 mg/kg/dia VO 1–2×/dia · VO	10 dias	No Brasil, a cefalosporina oral de alternativa mais disponível é a cefuroxima axetil (comprimido de 250 e 500 mg e suspensão). O cefdinir existe apenas como suspensão oral pediátrica; cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável e podem não ser encontradas. Confirmar no formulário local antes de prescrever.
Alergia grave a betalactâmico	Levofloxacino · Dose pediátrica por peso/idade, máximo 750 mg/dia · VO/EV	10 dias	Reservar para necessidade real; discutir com pediatria/infectologia quando possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

DISPONIBILIDADE NO BRASIL

A cefalosporina oral de alternativa com apresentação mais estável no Brasil é a cefuroxima axetil. O cefdinir existe aqui apenas como suspensão oral pediátrica; cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável. Priorizar amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato e escolher a alternativa pelo tipo de alergia e pelo formulário do serviço.

ALERTA CRÍTICO

Sinais orbitários/intracranianos

Edema palpebral importante, proptose, dor à movimentação ocular, diplopia, cefaleia intensa, vômitos, alteração neurológica ou rigidez de nuca exigem avaliação urgente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sintomas nasais	Diferenciar viral de bacteriana: >10 dias, início grave ou piora bifásica.
2	Sem gravidade	Tratar VO e reavaliar em 72 h se sem melhora.
3	Complicação	Internar, antibiótico EV e imagem/avaliação especializada.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Complicação orbitária/intracraniana ▪ Toxicidade ▪ Vômitos/incapacidade VO ▪ Imunossupressão ▪ Falha com piora
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 72 h ▪ Piora após início ▪ Sinais orbitários/neurológicos

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não rotineira em caso simples; cultura de material sinusal/coleção se complicação ou cirurgia.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina + Clavulanato VO	45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h GRAVE 80–90 mg/kg/dia de amoxicilina: até 70 mg/kg/dia pela suspensão 400/57 mg/5 mL e o restante com amoxicilina isolada, mantendo o clavulanato em até 10 mg/kg/dia	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Ceftriaxona EV	50–75 mg/kg/dia EV 24/24 h GRAVE 75–100 mg/kg/dia EV conforme gravidade/protocolo	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.4

Faringoamigdalite Estreptocócica — Pediátrica

LEVE AMBULATORIAL PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Faringoamigdalite por Streptococcus pyogenes em crianças, geralmente acima de 3 anos, com febre, odinofagia, exsudato, adenite cervical anterior e ausência de tosse. Evitar antibiótico em quadro viral típico; testar quando probabilidade clínica for compatível.

CONDUTA DE PARTIDA	VIA
Amoxicilina ou Penicilina V	VO
Amoxicilina 50 mg/kg VO 24/24 h ou 25 mg/kg 12/12 h	DURAÇÃO
	10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes / Grupo A	PRINCIPAL BACTERIANO	Prevenir febre reumática e complicações supurativas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Teste positivo ou forte indicação conforme protocolo	Amoxicilina · 50 mg/kg VO 24/24 h ou 25 mg/kg VO 12/12 h; máximo 1 g/dia · VO	10 dias	Não tratar quadro viral típico sem teste/critério.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Baixa adesão, vômitos ou preferência por dose única	Penicilina G benzatina · <27 kg: 600.000 UI IM dose única; ≥27 kg: 1.200.000 UI IM dose única · IM	Dose única	Opção eficaz quando adesão ao VO é incerta.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia não anafilática	Cefalexina · 20 mg/kg/dose VO 12/12 h; máximo 500 mg/dose · VO	10 dias	Evitar se anafilaxia imediata a betalactâmico.
Alergia grave a betalactâmico	Azitromicina ou Clindamicina · Azitro 12 mg/kg VO 24/24 h por 5 dias; Clinda 7 mg/kg/dose VO 8/8 h por 10 dias · VO	5–10 dias	Considerar resistência local a macrolídeos.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Evitar antibiótico em quadro viral

Tosse, coriza, rouquidão, conjuntivite ou úlceras orais sugerem etiologia viral.

ALERTA CRÍTICO

Abscesso peritonsilar

Trismo, voz abafada, desvio de úvula, sialorreia ou toxemia exigem avaliação específica.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor de garganta	Avaliar sinais virais e probabilidade de GÁS; testar se indicado.
2	GÁS confirmado/provável conforme protocolo	Tratar por 10 dias ou benzatina dose única.
3	Sinais de complicação	Investigar abscesso, hidratação e necessidade de hospital.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Incapacidade de hidratar ▪ Suspeita de abscesso ▪ Toxicidade ▪ Via aérea ameaçada
Falha terapêutica	▪ Persistência de febre/dor após 48–72 h ▪ Piora unilateral ▪ Trismo ou sialorreia

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste rápido/cultura conforme disponibilidade e protocolo; não testar quadro viral típico.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina VO	50 mg/kg VO 24/24 h ou 25 mg/kg 12/12 h por 10 dias GRAVE Não se aplica	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	TETO 1 g/dia
Penicilina G benzatina IM	<27 kg: 600.000 UI IM; ≥27 kg: 1.200.000 UI IM GRAVE Não se aplica	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.5

ITU Febril — Lactente após Período Neonatal e Criança

MODERADA HOSPITALAR PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional **recomendada**

Infecção urinária febril em lactentes/crianças deve ser tratada como pielonefrite provável, especialmente com febre sem foco, vômitos, dor lombar/abdominal ou toxemia. A coleta correta de urina antes do antibiótico é essencial quando não atrasa cuidado em criança grave.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ou Cefalexina/Cefixima conforme gravidade

Ceftriaxona 50–75 mg/kg/dia EV/IM 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Escherichia coli	PRINCIPAL	
Klebsiella spp.	MENOS COMUM	
Proteus mirabilis	MAIS COMUM EM MENINOS	Associado a urina alcalina/cálculo
Enterococcus spp.	SELECIONADO	Considerar em uropatia, instrumentação ou cultura prévia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Febril, lactente pequeno, vômitos, toxemia ou necessidade hospitalar	Ceftriaxona · 50 mg/kg/dia EV/IM 24/24 h; considerar 75 mg/kg/dia se grave conforme protocolo · IM/EV	7–10 dias total	Coletar EAS/urocultura antes se possível. Trocar para VO após melhora clínica, cultura disponível e boa aceitação.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Criança estável, aceitando VO, sem toxemia	Cefalexina ou Cefixima · Cefalexina 50–100 mg/kg/dia VO 6/6 h ou Cefixima 8 mg/kg/dia VO 24/24 h · VO	7–10 dias	Escolher conforme o padrão local e o antibiograma prévio. A cefixima tem disponibilidade variável no Brasil; cefalexina e cefuroxima axetil são as opções orais mais constantes.
Cistite afebril em criança maior	Cefalexina ou Nitrofurantoína · Cefalexina 50 mg/kg/dia VO 6/6 h; Nitrofurantoína 5–7 mg/kg/dia VO 6/6 h · VO	3–5 dias	Nitrofurantoína não serve para pielonefrite/febre.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco alto de ESBL ou cultura prévia	Ertapenem ou Meropenem · Ertapenem 15 mg/kg EV 12/12 h; Meropenem 20 mg/kg EV 8/8 h · EV	7–10 dias	Reservar para risco real/cultura; descalonar assim que possível.
Alergia grave a betalactâmico	Aminoglicosídeo conforme protocolo · Gentamicina 5–7,5 mg/kg EV/IM 24/24 h · IM/EV	Individualizar	Monitorar rim/nível se curso prolongado; discutir alternativa por cultura.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ Internação/antibiótico recente ▪ Uropatia complexa ▪ Cateterismo intermitente ▪ Falha a cefalosporina	Ertapenem ou meropenem, com descalonamento por cultura

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

RECÉM-NASCIDO EXIGE CAMINHO NEONATAL

Não extrapolar ceftriaxona para o período neonatal. Idade, hiperbilirrubinemia, uso de cálcio EV, sepse/meningite e protocolo neonatal definem cefotaxima/alternativas e internação.

ALERTA CRÍTICO

Urina deve ser coletada corretamente

Em lactente sem controle esfinteriano, saco coletor não confirma ITU para cultura; preferir cateterismo ou punção conforme protocolo.

ATENÇÃO

Nitrofurantoína não trata pielonefrite

Não usar em febre/comprometimento sistêmico.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre sem foco/urinária	Coletar urina tipo I e urocultura por método adequado antes do antibiótico se não atrasar cuidado.
2	Grave ou lactente pequeno	Iniciar ceftriaxona EV/IM e internar/observar.
3	Resultado de cultura	Descalonar e completar 7–10 dias conforme resposta.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ <3 meses ▪ Toxicidade ▪ Vômitos/incapacidade VO ▪ Desidratação ▪ Seps ▪ Uropatia conhecida ▪ Falha terapêutica ▪ Sem seguimento seguro
UTI	▪ Choque ▪ Rebaixamento ▪ Disfunção orgânica
Falha terapêutica	▪ Febre persistente 48–72 h ▪ Piora clínica ▪ Cultura resistente ▪ Suspeita de abscesso/obstrução

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urina I + urocultura antes do antibiótico quando viável; hemocultura em lactente pequeno, toxemia ou internação grave.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona IM/EV	50 mg/kg/dia EV/IM 24/24 h GRAVE 75 mg/kg/dia em gravidade conforme protocolo	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	TETO 2 g/dia usual; individualizar em infecção grave
Cefalexina VO	50–100 mg/kg/dia VO dividido 6/6 h GRAVE Não para sepse	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.6

Celulite / Erisipela — Pediátrica

MODERADA AMBULATORIAL PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Infecção cutânea não purulenta em criança, geralmente por estreptococos beta-hemolíticos e MSSA. Diferenciar de abscesso, mordedura, celulite orbitária, fasciite, artrite séptica e osteomielite.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefalexina

50 mg/kg/dia VO dividido 6/6 h

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias se resposta rápida; 7–10 dias se grave/complicada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus MSSA	FREQUENTE	
MRSA comunitário	RISCO ESPECÍFICO	Mais provável se purulência/abscesso ou história prévia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Celulite não purulenta, sem gravidade	Cefalexina · 50 mg/kg/dia VO 6/6 h · VO	5–7 dias	Elevar membro, analgesia e marcar bordas se útil.
Extensa, febre, lactente ou falha VO	Cefazolina ou Oxacilina · Cefazolina 100 mg/kg/dia EV 8/8 h ou Oxacilina 150–200 mg/kg/dia EV 6/6 h · EV	5–7 dias; transição VO quando melhora	Reavaliar foco profundo se dor intensa ou limitação funcional.
Purulência, abscesso associado ou MRSA provável	Clindamicina ou SMX-TMP associado a betalactâmico · Clindamicina 30–40 mg/kg/dia EV/VO 8/8 h · VO/EV	5–7 dias	Se abscesso, drenagem é central. SMX-TMP cobre MRSA, mas estreptococo é menos previsível.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Clindamicina · 30–40 mg/kg/dia EV/VO dividido 8/8 h · VO/EV	5–7 dias	Ver resistência local e tolerância gastro-intestinal.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Abscesso/purulência ▪ MRSA prévio ▪ Contato domiciliar com MRSA ▪ Falha a betalactâmico ▪ Lesão pós-trauma com pus	Clindamicina ou SMX-TMP; vancomicina se grave/choque

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**Dor desproporcional é alarme**

Dor intensa, toxicidade, bolhas, anestesia cutânea, crepitação ou progressão rápida sugerem infecção necrosante.

ATENÇÃO**Pesquisar abscesso**

Se flutuação ou falha, US pode ajudar; antibiótico isolado falha se houver coleção.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Celulite	Definir purulenta vs não purulenta e procurar porta de entrada/abscesso.
2	Sem gravidade	Cefalexina VO e reavaliação se piora/sem melhora.
3	Grave ou falha	Internar, EV, imagem se foco profundo e cobertura MRSA se critérios.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Toxicidade ▪ Lactente pequeno ▪ Imunossupressão ▪ Face/órbita/mão ▪ Falha VO ▪ Suspeita de foco profundo ▪ Sem seguimento
UTI	▪ Choque ▪ Necrosante suspeita ▪ Sepse
Falha terapêutica	▪ Progressão após 24–48 h ▪ Febre persistente ▪ Abscesso ▪ Dor desproporcional

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura se drenagem/pus, recorrência, imunossupressão ou internação grave; hemocultura se toxemia/seps.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefalexina VO	50 mg/kg/dia VO 6/6 h GRAVE Não usar isolada em grave	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Clindamicina VO/EV	30–40 mg/kg/dia EV/VO 8/8 h GRAVE 40 mg/kg/dia EV a cada 6–8 h	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.

- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.7

Impetigo / Ectima — Pediátrico

LEVE AMBULATORIAL PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Infecção superficial da pele comum em crianças, com crostas melicéricas, bolhas ou lesões ulceradas no ectima. O tratamento depende da extensão, surtos, recorrência e suspeita de MRSA.

CONDUTA DE PARTIDA

Mupirocina tópica ou Cefalexina VO

Cefalexina 50 mg/kg/dia VO 6/6 h se múltiplas lesões

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias se resposta rápida; 7–10 dias se grave/complicada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Streptococcus pyogenes	FREQUENTE	
MRSA comunitário	RISCO ESPECÍFICO	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Poucas lesões, localizado	Mupirocina tópica · Aplicar 2–3×/dia sobre as lesões · Tópica	5 dias	
Múltiplas lesões, ectima, surto ou acometimento extenso	Cefalexina · 50 mg/kg/dia VO 6/6 h · VO	7 dias	Cobertura MSSA/estreptococo.
Suspeita de MRSA ou falha a cefalexina	Clindamicina ou SMX-TMP · Clindamicina 30–40 mg/kg/dia VO 8/8 h; SMX-TMP 8–12 mg/kg/dia de TMP VO 12/12 h · VO	5–7 dias	SMX-TMP tem cobertura estreptocócica menos confiável; avaliar associação conforme caso.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a betalactâmico	Clindamicina · 30–40 mg/kg/dia VO 8/8 h · VO	5–7 dias	Boa opção se sensibilidade local favorável.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Falha a betalactâmico ▪ Surto/recorrência ▪ Contato com MRSA ▪ Lesões purulentas	Clindamicina ou SMX-TMP conforme padrão local

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

Higiene e controle de transmissão

Cobrir lesões, lavar mãos, evitar compartilhar toalhas e afastar de contato próximo até melhora conforme regras locais.

ATENÇÃO

Ectima é mais profundo

Lesões ulceradas/crostosas profundas geralmente exigem antibiótico oral.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Lesões localizadas	Tratamento tópico e medidas de higiene.
2	Extenso/ectima	Antibiótico VO com cobertura MSSA/estreptococo.
3	Recorrência/falha	Cultura se possível e avaliar MRSA/colonização/escabiose.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Celulite extensa ▪ Toxicidade ▪ Imunossupressão ▪ Neonato ▪ Falha com piora importante
Falha terapêutica	▪ Progressão após 48–72 h ▪ Recorrência frequente ▪ Suspeita de MRSA ou escabiose associada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não rotineira em caso simples; coletar se surto, falha, MRSA suspeito ou imunossupressão.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefalexina VO	50 mg/kg/dia VO 6/6 h GRAVE Não aplicável	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Mupirocina tópica	aplicar 2–3×/dia por 5 dias GRAVE não aplicável	Uso tópico: sem ajuste renal	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

14.8

Meningite Bacteriana — Pediátrica (>1 mês)

CRÍTICA

UTI

PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Emergência pediátrica. Separar lactente de 1–3 meses, em que GBS/Listeria e ampicilina podem ser necessários conforme protocolo, de criança >3 meses, em geral com ceftriaxona + vancomicina até microbiologia. Recém-nascido segue protocolo neonatal próprio.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona + Vancomicina

Ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV 12/12 h + Vancomicina 60 mg/kg/dia EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme agente: geralmente 7–21 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria meningitidis	IMPORTANTE	
Streptococcus pneumoniae	IMPORTANTE	Risco de resistência; justifica vancomicina empírica em muitos cenários
Haemophilus influenzae tipo b	MENOR EM VACINADOS	Considerar se não vacinado
Listeria/GBS/Gram-negativos	LACTENTES JOVENS	Cobertura muda em <1–3 meses conforme protocolo

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Criança >1 mês com suspeita de meningite bacteriana	Ceftriaxona + Vancomicina · Ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV 12/12 h + Vancomicina 60 mg/kg/dia EV 6/6 h · EV	Ajustar por agente	Coletar hemocultura/LCR se não atrasar. Dexametasona conforme protocolo antes/junto ao antibiótico em cenários selecionados.
Lactente pequeno conforme protocolo local (<1–3 meses)	Ampicilina + Cefotaxima/Ceftriaxona · Ampicilina 200–300 mg/kg/dia EV + cefalosporina de 3ª geração em dose meníngea · EV	Ajustar por agente e idade	Cobrir Listeria/GBS conforme idade. Em neonato, evitar ceftriaxona quando houver risco de hiperbilirrubinemia, cálcio EV ou outras contraindicações; seguir protocolo neonatal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + esquema alternativo especializado · Individualizar imediatamente com infectologia/pediatria · EV	Conforme agente	Não atrasar antibiótico; alternativas dependem de idade, agente provável e reação.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

IDADE MUDA A COBERTURA

De 1–3 meses, mostrar ampicilina/cobertura de GBS-Listeria antes da tabela; acima de 3 meses, seguir o ramo pediátrico usual. Nunca tratar o neonato por este quadro.

ALERTA CRÍTICO**Não atrasar antibiótico**

Se instável ou punção lombar atrasada, coletar hemocultura e iniciar antibiótico imediatamente.

ALERTA CRÍTICO**Isolamento e notificação**

Suspeita meningocócica exige precaução por gotículas, notificação e profilaxia de contatos conforme vigilância.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica	ABC, acesso venoso, glicemia, hemocultura e antibiótico imediato se grave.
2	Estável sem contraindicação	Realizar punção lombar antes do antibiótico se não atrasar.
3	Resultado microbiológico	Ajustar esquema, duração e profilaxia de contatos.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Suspeita de meningite bacteriana, necessidade de antibiótico EV, isolamento/notificação ou investigação hospitalar
UTI	▫ Rebaixamento ▫ Convulsão persistente ▫ Choque ▫ Insuficiência respiratória ▫ Hipertensão intracraniana suspeita
Gravidade	▫ Petéquias/púrpura ▫ Alteração neurológica ▫ Sepses ▫ Fontanela abaulada ▫ Convulsão

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemocultura antes do antibiótico se possível e sem atrasar tratamento; LCR com celularidade, glicose, proteína, Gram, cultura/PCR conforme disponibilidade.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	100 mg/kg/dia EV dividido 12/12 h GRAVE Dose meníngea: 100 mg/kg/dia	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	TETO 4 g/dia
Vancomicina EV	60 mg/kg/dia EV dividido 6/6 h GRAVE Ajustar por nível/AUC e função renal	DRC/IRA: Ajustar por nível terapêutico e função renal	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Meningite pediátrica depende de idade exata, dose meníngea, contraindicação de ceftriaxona em neonatos, fluxo de isolamento/notificação e protocolo de UTI/pediatria.

- Confirmar faixa etária/neonato
- Usar dose meníngea e dose máxima
- Coletar culturas sem atrasar antibiótico
- Aplicar isolamento/profilaxia de contatos quando indicado
- Validar dexametasona e ajuste por agente

14.9

Sepse / Choque Séptico — Pediátrico

CRÍTICA UTI PEDIÁTRICO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Síndrome infecciosa com disfunção orgânica, hipoperfusão ou choque em criança. A prioridade é reconhecimento precoce, antibiótico EV rápido, ressuscitação guiada por perfusão e controle de foco.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona ou Cefepime/Piperacilina-Tazobactam conforme foco/risco

Ceftriaxona 75–100 mg/kg/dia EV; ajustar ao foco

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme foco e culturas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae / meningococo	COMUNITÁRIOS IMPORTANTES	
Staphylococcus aureus	PELE/OSSO/PNEUMONIA GRAVE	
Enterobactérias	URINÁRIO/ABDOMINAL	
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Hospitalização, imunossupressão, dispositivo, queimadura, neutropenia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse comunitária sem foco claro e sem risco de Pseudomonas	Ceftriaxona · 75–100 mg/kg/dia EV 24/24 h ou dividido 12/12 h conforme foco · EV	Reavaliar em 24–48 h; duração conforme foco e culturas	Adicionar vancomicina apenas se suspeita de MRSA, meningite com pneumococo resistente, cateter/dispositivo, pele grave ou choque grave.
Choque, hospitalar, imunossuprimido, dispositivo ou risco de Pseudomonas	Cefepime ou Piperacilina-Tazobactam ± Vancomicina · Cefepime 150 mg/kg/dia EV 8/8 h ou Pip-Tazo 300 mg/kg/dia de piperacilina EV 6/6 h · EV	Conforme foco/cultura; reavaliar diariamente	Adicionar vancomicina se cateter, pele/ partes moles grave, pneumonia necrosante, MRSA provável ou instabilidade extrema. Descalonar assim que culturas permitirem.
Foco abdominal provável	Ceftriaxona + Metronidazol ou Piperacilina-Tazobactam · Ceftriaxona 75 mg/kg/dia EV + Metronidazol 30 mg/kg/dia EV 8/8 h · EV	Conforme controle de foco	Controle de foco cirúrgico/intervencionista é decisivo.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco alto de ESBL/CRE ou choque com colonização conhecida	Meropenem · 20–40 mg/kg EV 8/8 h · EV	Conforme foco/cultura	Reservar para risco real; descalonar assim que possível.
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Vancomicina ± Metronidazol · Aztreonam 120 mg/kg/dia EV a cada 6–8 h + Vancomicina por peso/nível · EV	Conforme foco	Esquema de contingência; discutir imediatamente.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Cateter/dispositivo ▪ Pele/partes moles grave ▪ Pneumonia necrosante/pós-influenza ▪ Colonização MRSA ▪ Choque sem foco	Vancomicina EV; linezolida em cenários selecionados
PSEUDOMONAS	▪ Hospitalização recente ▪ Neutropenia/imunossupressão ▪ Queimadura ▪ Dispositivo invasivo ▪ Colonização prévia	Cefepime ou piperacilina-tazobactam; meropenem se ESBL/choque com risco
ANAEROBIOS	▪ Foco abdominal ▪ Aspiração ▪ Necrose ▪ Infecção pélvica	Metronidazol associado ou piperacilina-tazobactam

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
APLICAR DIRETRIZ PEDIÁTRICA

Tempos, volume, vasoativo e avaliação de disfunção orgânica devem seguir protocolo pediátrico/neonatal. A atualização adulta SSC 2026 não deve ser transferida automaticamente.

ALERTA CRÍTICO
Antibiótico na primeira hora se choque

Em suspeita de choque séptico, iniciar antimicrobiano EV o mais rápido possível após culturas se não atrasar.

ALERTA CRÍTICO
Dose pediátrica sempre por peso

Confirmar peso, dose máxima adulta e função renal antes de repetir doses.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de sepse/choque	ABC, oxigênio, acesso IV/IO, glicemia, lactato se disponível, culturas sem atrasar antibiótico.
2	Choque provável	Antibiótico EV na primeira hora, fluidos/vasoativos conforme protocolo pediátrico e monitorização.
3	Após estabilização	Buscar foco, controle de fonte, ajustar por cultura e descalonar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda sepse provável

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ Lactato elevado/hipoperfusão persistente ▪ Necessidade de vasoativo ▪ Insuficiência respiratória ▪ Rebaixamento ▪ Disfunção orgânica
Falha terapêutica	▪ Instabilidade persistente ▪ Foco não controlado ▪ Culturas resistentes ▪ Febre/choque persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se não atrasar; culturas do foco, urina, LCR, secreções ou cateter conforme apresentação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	75–100 mg/kg/dia EV GRAVE 100 mg/kg/dia conforme foco/meningite	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Cefepime EV	150 mg/kg/dia EV dividido 8/8 h GRAVE 50 mg/kg EV 8/8 h	DRC/IRA: Ajustar intervalo conforme função renal	
Vancomicina EV	40–60 mg/kg/dia EV dividido 6/6 h GRAVE Ajustar por nível/AUC	DRC/IRA: Ajustar por nível terapêutico	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Sepse pediátrica exige protocolo institucional de reconhecimento, antibiótico na primeira hora quando choque, ressuscitação, UTI e antimicrobianos por risco local.
- Acionar protocolo pediátrico de sepse
- Confirmar peso, acesso IV/IO e dose máxima
- Coletar culturas sem atrasar antibiótico
- Validar risco de *Pseudomonas*/MRSA/ESBL
- Reavaliar descalonamento e controle de foco

14.10

Osteomielite / Artrite Séptica — Pediátrica

GRAVE HOSPITALAR PEDIÁTRICO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Infecção osteoarticular em criança com dor localizada, claudicação/recusa de apoio, febre, limitação articular ou dor óssea. Staphylococcus aureus é o principal agente; drenagem articular e avaliação ortopédica são essenciais na artrite séptica.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefazolina ou Oxacilina

Cefazolina 100–150 mg/kg/dia EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Individualizar por foco, patógeno, drenagem e resposta; curso não complicado com melhora rápida e biomarcadores em queda pode ser mais curto que faixas fixas tradicionais

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus MSSA/MRSA	PRINCIPAL	
Kingella kingae	CRIANÇAS PEQUENAS	Especialmente 6 meses a 4 anos
Streptococcus pyogenes	POSSÍVEL	
Salmonella spp.	RISCO ESPECÍFICO	Doença falciforme

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem risco de MRSA, estável	Cefazolina ou Oxacilina · Cefazolina 100–150 mg/kg/dia EV 8/8 h ou Oxacilina 150–200 mg/kg/dia EV 6/6 h · EV	Inicial EV; total conforme foco/resposta	Transição para VO quando melhora clínica, PCR caindo e cultura orienta.
MRSA provável, grave, abscesso, necrose ou sepse	Vancomicina ou Clindamicina · Vancomicina 60 mg/kg/dia EV 6/6 h; Clindamicina 40 mg/kg/dia EV/VO a cada 6–8 h · VO/EV	Individualizar	Escolher conforme gravidade e resistência local; bacteremia grave favorece vancomicina inicial.
Artrite séptica provável	Antibiótico EV + drenagem articular · Esquema antiestafilocócico conforme risco local · EV	2–4 semanas total	Punção/drenagem e cultura antes do antibiótico se criança estável; não atrasar se sepse.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Clindamicina ou Vancomicina · Clinda 40 mg/kg/dia; Vanco por peso/nível · EV	Conforme foco	Considerar linezolida em casos selecionados e com especialista.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ MRSA comunitário prevalente ▪ Infecção prévia/colonização ▪ Abscesso ▪ Necrose ▪ Sepses ▪ Falha a cefazolina/oxacilina	Vancomicina ou clindamicina conforme gravidade/sensibilidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

DURAÇÃO GUIADA POR RESPOSTA

Não fixar duração longa para toda criança. Cultura, drenagem, ausência de complicação, melhora clínica e PCR em queda apoiam transição oral e curso mais curto conforme diretriz pediátrica.

ALERTA CRÍTICO**Artrite séptica é urgência ortopédica**

Articulação quente/dolorosa com limitação importante exige punção/drenagem e antibiótico.

ATENÇÃO**Quadril é alto risco**

Dor no quadril, recusa de marcha ou posição antálgica em criança exige avaliação rápida.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Dor óssea/articular + febre ou recusa de apoio	Solicitar hemograma, PCR/VHS, hemocultura, imagem e ortopedia.
2	Artrite suspeita	Punção/drenagem para análise/cultura se possível antes do antibiótico.
3	Após culturas	Iniciar EV, ajustar por cultura e planejar transição VO/duração.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Suspeita inicial de osteomielite/artrite séptica com necessidade de antibiótico EV, imagem ou drenagem ▪ Dor intensa ▪ Febre ▪ Recusa de apoio ▪ PCR elevada ▪ Necessidade de imagem/drenagem
UTI	▪ Choque ▪ Sepses ▪ Infecção multifocal ▪ Necrose
Falha terapêutica	▪ Febre/dor persistente ▪ PCR não cai ▪ Abscesso não drenado ▪ Bacteremia persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemocultura; cultura de líquido articular, osso ou abscesso quando houver punção, drenagem ou abordagem.
Controle de foco	Punção/drenagem para análise/cultura se possível antes do antibiótico.

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefazolina EV	100–150 mg/kg/dia EV 8/8 h GRAVE 150 mg/kg/dia EV	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Clindamicina VO/EV	30–40 mg/kg/dia EV/VO dividido a cada 6–8 h GRAVE 40 mg/kg/dia EV	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA/PIDS. Acute Hematogenous Osteomyelitis in Pediatrics, 2021.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/bone-and-joint-infections/>

14.11

Mordedura Humana/Animal — Pediátrica

MODERADA

AMBULATORIAL

PEDIÁTRICO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional **recomendada**

Mordeduras em crianças exigem limpeza abundante, avaliação de profundidade, tendão, articulação, face/mão/genitais, tétano e raiva. Antibiótico é profilático em alto risco ou terapêutico quando já há infecção.

CONDUTA DE PARTIDA

Amoxicilina + Clavulanato

25–45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

Profilaxia 3–5 dias; infecção 5–10 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pasteurella multocida	MORDEDURA DE GATO/CÃO	
Streptococcus spp.	FREQUENTE	
Staphylococcus aureus	FREQUENTE	
Anaeróbios orais	FREQUENTE	

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Eikenella corrodens	MORDEDURA HUMANA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Mordedura de alto risco sem infecção estabelecida	Amoxicilina + Clavulanato · 25–45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h · VO	3–5 dias	Alto risco: mão, face, genital, gato, profunda, esmagamento, articulação/tendão, imunossupressão. Irrigação abundante e avaliação de raiva/tétano são tão importantes quanto o antibiótico.
Mordedura infectada, celulite, linfangite ou secreção	Amoxicilina + Clavulanato · 45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h · VO	5–10 dias	Se extensa, febre, mão profunda ou falha: internar e usar EV.
Infecção grave, mão profunda, articulação/tendão ou necessidade cirúrgica	Ampicilina-Sulbactam · 200 mg/kg/dia de ampicilina EV dividido 6/6 h · EV	7–14 dias conforme profundidade	Avaliar cirurgia/ortopedia/plástica conforme local.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Clindamicina + SMX-TMP · Clinda 30–40 mg/kg/dia 8/8 h + SMX-TMP 8–12 mg/kg/dia de TMP 12/12 h · VO	3–10 dias conforme profilaxia/infecção	Cobrir anaeróbios + Pasteurella/MRSA; ajustar conforme gravidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Toda mordedura humana ▪ Mordedura profunda ▪ Infecção estabelecida ▪ Lesão em mão/face	Amoxicilina-clavulanato VO ou ampicilina-sulbactam EV

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

RAIVA E TÉTANO — FLUXO BRASIL

Além da ferida e do antibiótico, aplicar o fluxograma brasileiro de raiva conforme animal/exposição e revisar profilaxia antitetânica por idade, calendário e tipo de ferimento.

ALERTA CRÍTICO

Raiva e tétano

Avaliar profilaxia antirrábica e vacinação antitetânica conforme animal, ferida e calendário.

ATENÇÃO

Mão é alto risco

Mordedura em mão pode envolver tendão/articulação e exige limiar baixo para avaliação especializada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Mordedura	Irrigar abundantemente, examinar profundidade, função neurovascular e estruturas nobres.
2	Alto risco ou infectada	Iniciar amoxicilina-clavulanato e orientar retorno precoce.
3	Risco de raiva/tétano	Aplicar protocolo de profilaxia e notificação conforme vigilância.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Mão profunda ▪ Face extensa ▪ Articulação/tendão/osso ▪ Febre/toxicidade ▪ Imunossupressão ▪ Falha VO ▪ Necessidade de cirurgia
Falha terapêutica	▪ Progressão em 24–48 h ▪ Dor importante ▪ Limitação funcional ▪ Secreção/abscesso

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura se infecção purulenta, abscesso, falha terapêutica, imunossupressão ou internação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Amoxicilina + Clavulanato VO	25–45 mg/kg/dia de amoxicilina VO 12/12 h GRAVE Usar EV se grave	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	
Ampicilina-Sulbactam EV	200 mg/kg/dia de ampicilina EV 6/6 h GRAVE 200–300 mg/kg/dia EV conforme gravidade	Geral: Dose sempre por peso atual; revisar função renal quando EV, sepse, desidratação, DRC, uso de aminoglicosídeo/vancomicina/aciclovir ou curso prolongado	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Pediatria exige validação por idade, peso atual, dose máxima, função renal/hepática, calendário vacinal, disponibilidade local e protocolo institucional.
- Confirmar idade exata: neonato, lactente jovem e criança maior têm fluxos diferentes
- Usar protocolo pediátrico/local para meningite, sepse, neonatos, UTI e antimicrobianos restritos
- Reavaliar cultura, foco e resposta clínica em 24–72 h para descalonamento

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Fluxograma da Profilaxia da Raiva Humana, versão vigente.

Ministério da Saúde. Tétano Acidental — vigilância, profilaxia e tratamento.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/raiva/fluxograma-da-profilaxia-da-raiva-humana-cartaz>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tetano-acidental>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 14 — PEDIATRIA

- IDSA/PIDS. Community-acquired Pneumonia in Infants and Children, atualização de 2026.
- AAP. Diagnosis and Management of Acute Otitis Media, versão vigente.
- AAP. Acute Bacterial Sinusitis in Children, versão vigente.
- CDC. Clinical Guidance for Group A Streptococcal Pharyngitis, versão vigente.
- Surviving Sepsis Campaign. Pediatric Sepsis and Septic Shock, versão vigente.
- IDSA/PIDS. Acute Hematogenous Osteomyelitis in Pediatrics, 2021.
- IDSA/PIDS. Community-acquired Pneumonia in Infants and Children — atualização sobre derrame parapneumônico, 2026.

15

Imunossuprimidos

9 quadros clínicos neste sistema

15.1	Febre Neutropênica — Alto Risco / Internação	306
15.2	Febre Neutropênica — Baixo Risco / Possível Ambulatorial	309
15.3	Febre em Asplenia / Hipoesplenia	311
15.4	Candidemia / Candidíase Invasiva	313
15.5	Pneumocistose — PJP/PCP em HIV ou Imunossupressão	315
15.6	Nocardiose — Pulmonar/Cutânea/Disseminada	317
15.7	Febre em Transplantado de Órgão Sólido	319
15.8	Doença por CMV — Imunossuprimido/Transplantado	322
15.9	Febre Persistente na Neutropenia — Suspeita de Fungo Invasivo	324

15.1

Febre Neutropênica — Alto Risco / Internação

CRÍTICA HOSPITALAR ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Febre em paciente com neutropenia profunda, prolongada, instabilidade, mucosite importante, pneumonia, dor abdominal/perianal, alteração neurológica, disfunção orgânica ou comorbidades. É emergência infecciosa: iniciar betalactâmico antipseudomonas EV imediatamente após culturas, sem aguardar confirmação de foco.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefepime ou Piperacilina-Tazobactam

Cefepime 2 g EV 8/8 h ou Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Até estabilidade, culturas e recuperação medular; individualizar por foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	CRÍTICO	Cobertura empírica obrigatória em neutropenia febril de alto risco.
Enterobacterales	FREQUENTE	E. coli, Klebsiella e Enterobacter; avaliar ESBL conforme colonização, internação e antibiótico recente.
Staphylococcus aureus / MRSA	SELETIVO	Vancomicina apenas se critério clínico: cateter, pele/partes moles, pneumonia, choque ou colonização.
Streptococcus viridans	IMPORTANTE	Mucosite grave e profilaxia com quinolona aumentam risco.
Candida / fungos filamentosos	APÓS PERSISTÊNCIA	Considerar em febre persistente após 4–7 dias de antibiótico amplo, neutropenia prolongada ou achado radiológico.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alto risco, estável, sem foco abdominal/perianal	Cefepime · 2 g EV 8/8 h · EV	Até estabilidade e definição por culturas/foco	Monoterapia antipseudomonas adequada em muitos pacientes de alto risco estáveis. Coletar hemoculturas antes se não atrasar.
Alto risco com mucosite, foco abdominal/perianal ou necessidade de anaeróbios	Piperacilina-Tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida se grave · EV	Até estabilidade e definição por culturas/foco	Cobre Pseudomonas e anaeróbios; útil em mucosite intensa, foco abdominal ou perianal.
Choque, ESBL provável, colonização por resistente ou falha de cefepime/pip-tazo	Meropenem · 1–2 g EV 8/8 h; usar 2 g 8/8 h se choque/SNC · EV	Conforme foco e cultura	Reservar para instabilidade, ESBL provável/confirmado ou falha terapêutica; reavaliar descalonamento diariamente.
Adicionar MRSA/Gram positivo resistente apenas se critério	Vancomicina associada ao betalactâmico antipseudomonas · Dose de ataque 25 mg/kg EV; manutenção conforme peso/função renal e monitorização · EV	Reavaliar em 48–72 h; suspender se sem evidência	Indicações: choque, pneumonia, infecção de cateter, pele/partes moles, mucosite grave com instabilidade ou colonização por MRSA.
Choque séptico com risco de Gram-negativo resistente	Adicionar Amicacina em dose única/curta · 15–20 mg/kg EV, ajustar por função renal e nível se mantida · EV	Preferir dose única ou curto período até cultura/estabilidade	Não é rotina. Considerar apenas em choque ou risco elevado de resistência, com monitorização renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Aztreonam + Vancomicina · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + Vancomicina conforme peso/função renal · EV	Conforme foco/cultura	Alternativa menos ideal; envolver infec-tologia/CCIH e reavaliar se alergia é verdadeira. Em sepse grave, discutir dessensibilização ou betalactâmico seguro.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Neutropenia febril de alto risco ▪ Choque ou instabilidade ▪ Profilaxia prévia com quinolona	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem
MRSA	▪ Cateter infectado ▪ Pele/partes moles ▪ Pneumonia ▪ Choque ▪ Colonização por MRSA	Vancomicina
ESBL	▪ Colonização por ESBL ▪ Infecção prévia por ESBL ▪ Uso recente de cefalosporina/carbapenêmico ▪ Choque séptico	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
ANTIBIÓTICO IMEDIATO

Neutropenia febril de alto risco é emergência. Culturas são importantes, mas não devem atrasar antibiótico.

ATENÇÃO
VANCOMICINA NÃO É ROTINA

Adicionar apenas se houver critério clínico; suspender em 48–72 h se culturas/avaliação não sustentarem.

ATENÇÃO
FEBRE PERSISTENTE

Febre após 4–7 dias exige reavaliação sistemática: foco oculto, resistência, cateter e fungo invasivo.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre + neutropenia conhecida ou provável	Classificar risco imediatamente; avaliar sinais vitais, foco, dispositivos, mucosite, abdome/períneo e acesso venoso.
2	Antes do antibiótico, se não atrasar	Coletar 2 pares de hemoculturas, incluindo cateter se presente, culturas de foco e exames conforme quadro.
3	Alto risco	Iniciar cefepime 2 g EV 8/8 h ou pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h.
4	Choque/ESBL provável	Usar meropenem; considerar vancomicina apenas se critério e aminoglicosídeo curto se choque/resistência.
5	Reavaliação 48–72 h	Descalonar conforme culturas; suspender vancomicina se sem indicação; procurar foco se febre persiste.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Neutropenia esperada >7 dias ▪ ANC <100 ▪ Instabilidade hemodinâmica ▪ Pneumonia ▪ Dor abdominal/perianal ▪ Mucosite grave ▪ Disfunção renal/hepática ou orgânica ▪ Sem suporte ambulatorial confiável
UTI	▪ Choque séptico ▪ Lactato elevado com hipoperfusão ▪ Insuficiência respiratória ▪ Rebaixamento de consciência ▪ Necessidade de vasopressor
Falha terapêutica	▪ Febre persistente 72–96 h ▪ Piora hemodinâmica ▪ Cultura com resistência ▪ Novo foco ▪ Suspeita de fungo invasivo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas periféricas e de cateter se presente; culturas do foco suspeito; não atrasar antibiótico em paciente instável.
Controle de foco	Classificar risco imediatamente; avaliar sinais vitais, foco, dispositivos, mucosite, abdome/períneo e acesso venoso.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60: 2 g 8/8 h; 30-60: 2 g 12/12 h; <30: Ajustar conforme clearance	
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h em infusão estendida	>40: 4,5 g 6/6 h; 20-40: 2,25–3,375 g 6/6 h; <20: 2,25 g 8/8 h	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	>50: 1–2 g 8/8 h; 26-50: 1–2 g 12/12 h; <26: Ajustar conforme clearance	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA Febrile Neutropenia
 ASCO/IDSA outpatient fever and neutropenia
 Surviving Sepsis Campaign

15.2

Febre Neutropênica — Baixo Risco / Possível Ambulatorial

MODERADA AMBULATORIAL ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Paciente com neutropenia febril, clinicamente estável, sem foco grave, sem comorbidade descompensada, neutropenia esperada curta e retorno confiável. Manejo ambulatorial só deve ocorrer após estratificação formal de baixo risco, observação inicial e plano claro de reavaliação.

CONDUTA DE PARTIDA

Ciprofloxacino + Amoxicilina-Clavulanato

Cipro 750 mg VO 12/12 h + Amoxi-Clav 875/125 mg VO 12/12 h

VIA

VO

DURAÇÃO

Reavaliar em 24–48 h; individualizar conforme evolução

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	
Pseudomonas aeruginosa	RISCO ESPECÍFICO	Risco aumenta com internação recente, profilaxia com quinolona ou colonização.
Streptococcus spp.	FREQUENTE	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Baixo risco confirmado, estável, tolera VO, bom suporte e retorno garantido	Ciprofloxacino + Amoxicilina-Clavulanato · Cipro 750 mg VO 12/12 h + Amoxi-Clav 875/125 mg VO 12/12 h · VO	Reavaliar em 24–48 h	Somente após estratificação formal de baixo risco e observação inicial. Não usar se profilaxia prévia com quinolona ou suspeita de resistência.
Dúvida de baixo risco, foco incerto ou logística ruim	Cefepime EV inicial e observação · Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Até definir segurança para alta ou internação	Na dúvida, tratar como alto risco e manter observação/internação.

Sobre a duração: Manter conforme evolução e recuperação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia a penicilina no esquema VO	Ciprofloxacino + Clindamicina · Cipro 750 mg VO 12/12 h + Clinda 300–450 mg VO a cada 6–8 h · VO	Reavaliar precocemente	Alternativa apenas para baixo risco; revisar risco de C. difficile, resistência local e exposição prévia a quinolona.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Neutropenia febril mesmo em baixo risco ▪ Sem profilaxia prévia com quinolona ▪ Baixa resistência local	Ciprofloxacino no esquema combinado ambulatorial

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ALTA EXIGE BAIXO RISCO VALIDADO

Confirmar estabilidade, MASCC adequado e CISNE quando aplicável, ausência de foco que exija internação, função orgânica, adesão, cuidador/telefone e retorno rápido. Dar primeira dose sem atraso e observar antes da alta conforme protocolo.

ATENÇÃO

BAIXO RISCO PRECISA SER FORMAL

Não chamar de baixo risco apenas porque o paciente parece bem. Usar escore/critério institucional e garantir retorno.

ALERTA CRÍTICO

QUALQUER INSTABILIDADE MUDA A CONDUTA

Hipotensão, hipoxemia, confusão, dor abdominal, pneumonia ou mucosite grave tornam o caso alto risco.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Neutropenia febril aparentemente estável	Aplicar estratificação formal de baixo risco e revisar critérios de exclusão.
2	Baixo risco confirmado	Observar inicialmente, colher culturas e iniciar esquema VO se elegível.
3	Alta ambulatorial	Garantir retorno em 24–48 h e orientação de retorno imediato se piora.
4	Qualquer dúvida	Tratar como alto risco e internar/observar com betalactâmico antipseudomonas EV.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Qualquer instabilidade ▪ Pneumonia ▪ Dor abdominal/perianal ▪ Mucosite importante ▪ Sem suporte familiar ▪ Sem retorno em 24–48 h ▪ Profilaxia prévia com quinolona ▪ Colonização por resistente
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ Piora clínica ▪ Intolerância VO ▪ Nova queixa focal ▪ Cultura positiva resistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se possível; urina, imagem ou culturas adicionais conforme foco. Não liberar sem plano de contato/retorno.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ciprofloxacino vo	750 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar como monoterapia em alto risco	>50: 750 mg 12/12 h; <50: Ajustar intervalo	
Amoxicilina-Clavulanato vo	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Não aplicável para alto risco	>30: 875/125 mg 12/12 h; <30: Evitar 875 mg; ajustar formulação	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão que pode ser conduzido com protocolo padronizado, mas ainda exige adaptação ao risco individual, ao suporte ambulatorial e à epidemiologia local.
- Confirmar critérios formais de baixo risco antes de manejo ambulatorial.
- Garantir retorno precoce, acesso ao hospital e reavaliação em 24–48 horas.
- Revisar profilaxia prévia com quinolona, colonização por resistentes e culturas anteriores.
- Ajustar doses para função renal/hepática e interações medicamentosas.

REFERÊNCIA DO QUADRO

ASCO/IDSA outpatient fever and neutropenia

15.3

Febre em Asplenia / Hipoesplenia

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Febre em paciente asplênico/hipoesplênico é emergência pelo risco de sepse fulminante por encapsulados. Mesmo quadro inicial pouco exuberante pode evoluir rapidamente. Priorizar culturas, ceftriaxona precoce e internação/observação conforme gravidade e suporte.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona

2 g EV 24/24 h; 2 g EV 12/12 h se meningite suspeita

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme foco/culturas; reavaliar diariamente

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	CRÍTICO	
Neisseria meningitidis	CRÍTICO	
Haemophilus influenzae	IMPORTANTE	
Capnocytophaga canimorsus	MORDEDURA CÃO/GATO	Risco aumentado em asplenia, alcoolismo e imunossupressão.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Febre sem foco, estável	Ceftriaxona · 2 g EV 24/24 h · EV	Até culturas e estabilidade; completar conforme foco	Não aguardar deterioração. Avaliar internação mesmo se aparentemente bem.
Choque, meningite suspeita ou quadro muito grave	Ceftriaxona + Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 12/12 h + Vancomicina carga 25 mg/kg EV · EV	Conforme foco/culturas	Acionar protocolo sepse; considerar dexametasona se meningite pneumocócica suspeita antes/junto ao antibiótico.
Febre após mordedura ou contato com cão/gato	Ampicilina-Sulbactam · 3 g EV 6/6 h · EV	Conforme foco	Cobrir Capnocytophaga, Pasteurella e anaeróbios. Avaliar raiva/tétano conforme exposição.

Sobre a duração: Geralmente 7–14 dias se infecção estabelecida.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Vancomicina + Levofloxacino · Vanco conforme peso + Levo 750 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	Conforme foco/culturas	Alternativa; envolver infectologia pela criticidade e revisar segurança de cefalosporina se alergia não anafilática.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
RISCO DE SEPSE FULMINANTE

Febre em asplenia nunca deve ser banalizada, mesmo com exame inicial pouco exuberante.

INFORMAÇÃO

PREVENÇÃO APÓS FASE AGUDA

Revisar vacinação pneumococo/meningococo/Hib, educação para febre e plano de antibiótico de resgate conforme protocolo.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Asplenia + febre	Triagem imediata, sinais vitais, acesso venoso, lactato se grave e culturas.
2	Sem foco claro	Ceftriaxona EV precoce e observação/internação conforme risco.
3	Choque/meningite	Ceftriaxona em dose meníngea + vancomicina e protocolo seps.
4	Mordedura/contato com cão ou gato	Cobrir Capnocytophaga/Pasteurella/anaeróbios e avaliar profilaxias.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre objetiva ▪ Calafrios ▪ Aspecto toxêmico ▪ Hipotensão ▪ Sem suporte domiciliar ▪ Mordedura associada
UTI	▪ Choque ▪ Meningite suspeita ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se não atrasar; culturas conforme foco. Em meningite suspeita, não atrasar antibiótico por punção/TC.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h GRAVE 2 g EV 12/12 h se meningite	Geral: Geralmente não requer ajuste renal isolado	
Ampicilina-Sulbactam EV	3 g EV 6/6 h GRAVE 3 g EV 6/6 h	>30: 3 g 6/6 h; <30: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão que pode ser conduzido com protocolo padronizado, mas ainda exige adaptação ao risco individual, ao suporte ambulatorial e à epidemiologia local.
- Confirmar critérios formais de baixo risco antes de manejo ambulatorial.
- Garantir retorno precoce, acesso ao hospital e reavaliação em 24–48 horas.
- Revisar profilaxia prévia com quinolona, colonização por resistentes e culturas anteriores.
- Ajustar doses para função renal/hepática e interações medicamentosas.

REFERÊNCIA DO QUADRO

CDC asplenia vaccination and infection prevention
Surviving Sepsis Campaign

15.4

Candidemia / Candidíase Invasiva

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção fúngica sistêmica grave associada a CVC, nutrição parenteral, cirurgia abdominal, UTI, antibiótico amplo, imunossupressão ou foco abdominal. Tratamento inicial preferencial com equinocandina, hemoculturas seriadas, busca de foco profundo e controle de fonte.

CONDUTA DE PARTIDA

Micafungina

100 mg EV 24/24 h

VIA

EV

DURAÇÃO

14 dias após primeira hemocultura negativa e resolução dos sintomas, se sem foco profundo

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Candida albicans	FREQUENTE	
Candida glabrata	RELEVANTE	Maior risco de resistência a azóis.
Candida parapsilosis	CATETER/TPN	
Candida tropicalis	IMUNOSSUPRIMIDOS	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Candidemia suspeita ou confirmada em hospitalizado	Micafungina · 100 mg EV 24/24 h · EV	14 dias após clearance de hemocultura se sem foco profundo	Preferida na maioria dos hospitalizados, críticos ou com exposição prévia a azol.
Alternativa de equinocandina	Anidulafungina · 200 mg EV dose de ataque, depois 100 mg EV 24/24 h · EV	14 dias após hemocultura negativa se sem foco profundo	Boa opção em disfunção hepática/renal; ajustar conforme protocolo local.
Step-down se estável, isolado sensível e hemoculturas negativas	Fluconazol · 800 mg ataque, depois 400 mg EV/VO 24/24 h · VO/EV	Completar 14 dias após clearance	Usar apenas se Candida sensível, paciente estável, boa absorção e sem suspeita de foco profundo/endovascular.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**CANDIDEMIA É MANEJO POR ESPÉCIE E FOCO**

Repetir hemoculturas até clareamento, avaliar retirada de cateter e focos profundos, identificar espécie/sensibilidade e contar duração do clareamento. Transição para azul requer estabilidade e suscetibilidade; *C. auris* e possível resistência de *C. parapsilosis* exigem conduta específica.

ATENÇÃO**CANDIDA AURIS E PARAPSILOSIS RESISTENTE MUDAM A ESCOLHA**

A diretriz global de candidíase de 2025 (ECMM/ISHAM/ASM) trata especificamente de *Candida auris* e de *Candida parapsilosis* resistente a fluconazol, temas pouco cobertos pela IDSA de 2016. *Candida auris* exige notificação, precaução de contato e isolamento: a transmissão hospitalar é o principal risco. Solicitar identificação de espécie e antifungograma sempre, e não presumir sensibilidade a fluconazol pela espécie. Discutir com CCIH e infectologia antes de definir o esquema quando houver suspeita de espécie resistente.

ALERTA CRÍTICO**HEMOCULTURAS SERIADAS**

Repetir hemoculturas diariamente ou em dias alternados até documentar clearance; a duração conta após a primeira negativa.

ALERTA CRÍTICO**CONTROLE DE FOCO**

Remover CVC se provável fonte e seguro; procurar abdome, urina, próteses, endocardite e focos profundos se persistência.

INFORMAÇÃO**AValiação OFTALMOLÓGICA**

Considerar avaliação oftalmológica, especialmente em sintomas oculares ou conforme protocolo local.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Candidemia suspeita/confirmada	Iniciar equinocandina e revisar fontes: CVC, abdome, urina, próteses e endovascular.
2	CVC possível fonte	Remover se seguro e enviar cultura conforme protocolo.
3	Seguimento	Hemoculturas seriadas até negativação; investigar persistência se continua positiva.
4	Após identificação/sensibilidade	Descalonar para fluconazol se elegível.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Toda candidemia ▫ Instabilidade ▫ CVC/TPN ▫ Imunossupressão ▫ Foco abdominal
UTI	▫ Choque séptico ▫ Falência orgânica ▫ Candidemia persistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas seriadas até negativação; cultura de CVC se removido; culturas/imagem conforme foco. Persistência >3-5 dias exige busca ativa de foco profundo/endovascular.
Marco da duração	Contar a duração a partir da primeira hemocultura negativa, após controle do foco, salvo complicação que defina outro marco.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100 mg EV 24/24 h	Geral: Não requer ajuste renal	
Anidulafungina EV	200 mg ataque; 100 mg EV 24/24 h GRAVE Mesmo esquema	Geral: Não requer ajuste renal	
Fluconazol VO/EV	800 mg ataque; 400 mg/dia GRAVE 800 mg ataque; 400–800 mg/dia conforme foco	>50: Dose usual; <50: Reduzir manutenção em 50%	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA Candidiasis 2016

IDSA. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis, 2016. <https://www.idsociety.org/practice-guideline/candidiasis/>

Cornely OA et al. Global guideline for the diagnosis and management of candidiasis: ECMM/ISHAM/ASM, 2025. doi:10.1016/S1473-3099(24)00749-7. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39956121/>

15.5

Pneumocistose — PJP/PCP em HIV ou Imunossupressão

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Pneumonia oportunista por *Pneumocystis jirovecii* em HIV avançado, transplante, corticoide prolongado ou imunossupressores. Suspeitar com dispneia progressiva, tosse seca, hipoxemia, LDH elevada e infiltrado intersticial/vidro fosco. Avaliar gravidade pela oxigenação para decidir corticoide adjuvante.

CONDUTA DE PARTIDA

Sulfametoxazol-Trimetoprim

TMP 15–20 mg/kg/dia EV/VO dividido a cada 6–8 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

21 dias em HIV; geralmente 14–21 dias em não HIV

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	PRINCIPAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PJP moderada/grave ou hipoxemia	Sulfametoxazol-Trimetoprim · TMP 15–20 mg/kg/dia dividido a cada 6–8 h · VO/EV	21 dias em HIV; 14–21 dias em não HIV	Usar EV se grave, vômitos ou absorção duvidosa. Ajustar por função renal e monitorar toxicidade.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PaO ₂ <70 mmHg em ar ambiente ou gradiente A-a ≥35	Prednisona adjuvante · 40 mg VO 12/12 h dias 1–5; 40 mg/dia dias 6–10; 20 mg/dia dias 11–21 · VO	21 dias	Iniciar preferencialmente nas primeiras 72 h em PJP moderada/grave. Usar equivalente EV se não tolera VO.
PJP leve, sem hipoxemia, tolera VO	Sulfametoxazol-Trimetoprim VO · TMP 15–20 mg/kg/dia dividido · VO	21 dias em HIV	Mesmo em doença leve, garantir seguimento próximo e reavaliar oxigenação.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia/intolerância grave a sulfa ou falha	Clindamicina + Primaquina · Clinda 600 mg EV/VO a cada 6–8 h + Primaquina 30 mg base VO/dia · Mista	21 dias	Checkar G6PD antes de primaquina quando possível; acompanhar meta-hemoglobina se suspeita.
Doença grave sem opção de TMP-SMX	Pentamidina · 4 mg/kg EV 24/24 h · EV	21 dias	Maior toxicidade; monitorar glicemia, PA, eletrólitos, renal e pancreatite.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
AVALIAR OXIGENAÇÃO

Gasometria ou oximetria orienta gravidade; corticoide é indicado na doença moderada/grave por critério de oxigenação.

ATENÇÃO
TMP-SMX EM DOSE ALTA

Monitorar potássio, creatinina, citopenias, hepatotoxicidade e reações cutâneas.

INFORMAÇÃO

PESQUISAR COINFEÇÕES

Em HIV/transplante, considerar TB, CMV, fungos, pneumonias bacterianas e outras causas de vidro fosco.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita clínica/radiológica	Avaliar saturação, gasometria se moderada/grave, HIV/imunossupressão e diferenciais.
2	Moderada/grave	Iniciar TMP-SMX em dose alta e corticoide se critério de oxigenação.
3	Alergia ou toxicidade	Escolher alternativa conforme gravidade, G6PD e disponibilidade.
4	Evolução	Monitorar potássio, creatinina, hemograma e necessidade ventilatória.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Hipoxemia ▪ FR elevada ▪ Comorbidade ▪ Diagnóstico incerto ▪ Imunossupressão intensa
UTI	▪ Insuficiência respiratória ▪ Necessidade de VNI/IOT ▪ Choque

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Escarro induzido ou BAL para PCR/imunofluorescência se disponível; não atrasar tratamento se suspeita forte e hipoxemia.

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sulfametoxazol-Trimetoprim VO/EV	TMP 15–20 mg/kg/dia dividido GRAVE Mesmo esquema EV se grave	>30: Dose usual; 15-30: Reduzir 50%; <15: Evitar ou ajustar com especialista	
Clindamicina + Primaquina VO/EV	Clinda 600 mg a cada 6–8 h + Primaquina 30 mg base/dia GRAVE Mesmo esquema	Geral: Sem ajuste renal relevante para clindamicina; checar G6PD para primaquina	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

NIH HIV Opportunistic Infections - Pneumocystis Pneumonia

15.6

Nocardiose — Pulmonar/Cutânea/Disseminada

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção oportunista por Nocardia em transplantados, uso prolongado de corticoide, doença pulmonar estrutural, neoplasia ou imunossupressão celular. Pode ser pulmonar, cutânea, disseminada ou SNC. Pesquisar acometimento cerebral especialmente em casos graves, disseminados ou imunossuprimidos.

CONDUTA DE PARTIDA

Sulfametoxazol-Trimetoprim

TMP 10–15 mg/kg/dia dividido

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Prolongada: geralmente 6–12 meses; SNC/disseminada pode exigir ≥12 meses

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Nocardia asteroides complex	FREQUENTE	
Nocardia farcinica	IMPORTANTE	Maior risco de resistência e doença disseminada.
Nocardia nova complex	POSSÍVEL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Doença cutânea ou pulmonar leve, sem SNC e estável	Sulfametoxazol-Trimetoprim · TMP 10–15 mg/kg/dia dividido · VO/EV	6–12 meses	Solicitar cultura prolongada, identificação de espécie e sensibilidade. Ajustar conforme antibiograma.
Doença grave, disseminada ou SNC suspeito/confirmado	TMP-SMX + Meropenem ou Imipenem ± Amicacina · TMP 10–15 mg/kg/dia + Mero 2 g EV 8/8 h; considerar Amicacina 15–20 mg/kg/dia · EV	Indução até melhora; total prolongado	Imagem de SNC é mandatória em doença grave/disseminada. Amicacina deve ser curta e monitorada por nefro/ototoxicidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alternativas conforme sensibilidade/intolerância	Linezolida, Minociclina, Ceftriaxona ou Carbapenêmico · Individualizar conforme antibiograma · VO/EV	Prolongada	Não tratar empiricamente sem considerar resistência da espécie. Linezolida exige monitorar citopenias/neuropatia.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
IMAGEAR O SNC MESMO SEM SINTOMAS

Em nocardiose pulmonar invasiva ou disseminada, realizar imagem de SNC. Doença grave, cerebral ou disseminada costuma exigir combinação inicial até identificação e sensibilidade.

ALERTA CRÍTICO
PESQUISAR SNC

Nocardiose em imunossuprimido pode acometer cérebro mesmo com poucos sintomas neurológicos.

ATENÇÃO
CULTURA E ESPÉCIE IMPORTAM

A suscetibilidade varia por espécie; avisar laboratório da suspeita para incubação adequada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de nocardiose	Coletar material para cultura/biópsia e avisar laboratório.
2	Imunossuprimido ou doença grave	Solicitar imagem de SNC e tórax; iniciar esquema combinado se grave.
3	Identificação/sensibilidade	Descalonar e planejar duração prolongada com seguimento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Imunossupressão significativa ▪ Pulmonar extensa ▪ Disseminada ▪ SNC suspeito ▪ Instabilidade
UTI	▪ Choque ▪ Insuficiência respiratória ▪ SNC com efeito de massa

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de escarro/BAL/biópsia/abscesso; pedir identificação de espécie e sensibilidade. Imagem cerebral em imunossuprimidos, disseminada ou doença grave.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sulfametoxazol-Trimetoprim VO/EV	TMP 10–15 mg/kg/dia GRAVE TMP 15 mg/kg/dia em grave/SNC	>30: Dose usual; <30: Ajustar	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h se SNC	>50: Dose usual; <50: Ajustar intervalo	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Nocardiosis reviews and transplant infectious disease practice

15.7

Febre em Transplantado de Órgão Sólido

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Febre em transplantado exige abordagem por tempo pós-transplante, órgão, imunossupressão, profilaxias, exposição hospitalar e risco de infecção oportunista. Não presumir infecção comunitária simples. Avaliar rejeição, toxicidade medicamentosa e interação com imunossupressores.

CONDUTA DE PARTIDA

Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime conforme foco

Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h ou Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme foco, culturas e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales / Pseudomonas	FREQUENTE	Especialmente foco urinário, abdominal, pulmonar ou hospitalar.
Staphylococcus aureus / MRSA	SELETIVO	Cateter, pele, pneumonia, colonização ou choque.
CMV	DEPENDENTE DO TEMPO/RISCO	

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Fungos oportunistas	RISCO ESPECÍFICO	Candida, Aspergillus, Cryptococcus conforme órgão, tempo e imunossupressão.
Pneumocystis jirovecii	SE PROFILAXIA AUSENTE/FALHA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Febre com foco bacteriano provável, sem choque	Piperacilina-Tazobactam ou Cefepime · Pip-Tazo 4,5 g EV 6/6 h ou Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Conforme foco	Escolher conforme foco: abdominal/urinário com anaeróbio favorece pip-tazo; pulmonar/hospitalar pode favorecer cefepime + coberturas dirigidas.
Choque, ESBL ou infecção hospitalar grave	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h; Vanco se critério · EV	Conforme foco/culturas	Adicionar vancomicina apenas se cateter, pneumonia, pele, colonização MRSA ou choque com risco. Considerar antifúngico se risco alto/abdominal/TPN.
Síndrome viral, leucopenia, colite, pneumonite ou suspeita de CMV	Ganciclovir se doença grave/invasiva provável · 5 mg/kg EV 12/12 h ajustado à função renal · EV	Conforme carga viral/resposta	Não iniciar de forma automática em toda febre; integrar PCR, órgão acometido e equipe de transplante.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Foco pulmonar/urinário/hospitalar ▪ Internação recente ▪ Colonização	Cefepime, pip-tazo ou meropenem
MRSA	▪ Cateter ▪ Pneumonia grave ▪ Pele/partes moles ▪ Colonização ▪ Choque	Vancomicina ou linezolida conforme foco
ESBL	▪ Colonização/infecção prévia por ESBL ▪ Antibiótico recente ▪ Choque ▪ Internação prolongada	Meropenem

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**ENVOLVER EQUIPE DE TRANSPLANTE**

Imunossupressão, interações, rejeição e infecção oportunista precisam de decisão conjunta.

ATENÇÃO**TEMPO PÓS-TRANSPLANTE MUDA O RACIOCÍNIO**

Primeiro mês: nosocomiais/cirúrgicas; 1–6 meses: oportunistas; tardio: comunitárias e oportunistas conforme imunossupressão.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Transplantado febril	Definir órgão, tempo pós-transplante, imunossupressores, profilaxias, rejeição recente e colonizações.
2	Suspeita bacteriana/seps	Coletar culturas e iniciar antibiótico conforme foco e risco MDR.
3	Síndrome viral/leucopenia/colite/pneumonia	Solicitar CMV PCR e investigar órgão; tratar se doença provável/grave.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
4	Reavaliação	Descalonar por culturas e ajustar imunossupressão com equipe responsável.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre em transplantado recente ▪ Disfunção orgânica ▪ Imunossupressão intensa ▪ Foco pulmonar/abdominal ▪ Sem diagnóstico claro
UTI	▪ Choque ▪ Hipoxemia ▪ Falência orgânica ▪ Sepses grave

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas, urina, culturas de foco, imagem direcionada, CMV PCR conforme síndrome, revisão de culturas/colonização prévias e profilaxias.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-Tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h infusão estendida	>40: Dose usual; <40: Ajustar	
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h	>60: Dose usual; <60: Ajustar	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 1–2 g EV 8/8 h	>50: Dose usual; <50: Ajustar	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

AST Infectious Diseases Community of Practice
IDSA AMR guidance

15.8

Doença por CMV — Imunossuprimido/Transplantado

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Doença por citomegalovírus em transplantados, HIV avançado ou imunossuprimidos pode causar síndrome viral, colite, pneumonite, hepatite, retinite ou doença invasiva. PCR/carga viral ajuda, mas doença de órgão pode exigir confirmação por imagem, endoscopia, biópsia ou avaliação especializada.

CONDUTA DE PARTIDA

Separar monitoramento/preemptivo, síndrome por CMV e doença de órgão

5 mg/kg EV 12/12 h ajustado à função renal

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Até melhora clínica e controle/queda sustentada da carga viral; individualizar

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Citomegalovírus	PRINCIPAL	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Doença invasiva, hospitalizado, grave ou absorção duvidosa	Ganciclovir · 5 mg/kg EV 12/12 h · EV	Individualizar por resposta e carga viral	Ajustar à função renal. Monitorar neutropenia, plaquetas e creatinina.
Estável, doença leve ou step-down com boa absorção	Valganciclovir · 900 mg VO 12/12 h · VO	Conforme resposta/carga viral	Usar se boa absorção gastrointestinal e estabilidade clínica; ajustar à função renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Resistência/intolerância grave a ganciclovir	Foscarnet · Individualizar conforme função renal e protocolo · EV	Conforme resposta	Alta nefrotoxicidade e distúrbios eletrolíticos; infectologia/transplante obrigatório.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DNAEMIA ISOLADA NÃO É DOENÇA DE ÓRGÃO

Interpretar carga viral pelo tipo de transplante, risco, tendência e estratégia do serviço. Doença de órgão exige evidência clínica/histológica quando aplicável; coordenar antiviral, toxicidade e ajuste de imunossupressão.

ATENÇÃO

PCR POSITIVO NÃO É SEMPRE DOENÇA

Interpretar carga viral junto com síndrome clínica e órgão acometido; doença de órgão pode precisar de confirmação tecidual.

ALERTA CRÍTICO

TOXICIDADE HEMATOLÓGICA

Ganciclovir/valganciclovir podem causar neutropenia e trombocitopenia; monitorar hemograma.

ATENÇÃO**AJUSTE RENAL OBRIGATÓRIO**

Subdose favorece falha/resistência; sobredose aumenta toxicidade.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de CMV	Definir síndrome: viral, colite, pneumonite, hepatite, retinite ou invasiva.
2	Doença grave/invasiva	Iniciar ganciclovir EV ajustado à função renal e discutir com equipe responsável.
3	Estável e absorção adequada	Considerar valganciclovir VO ou step-down.
4	Falha/toxicidade	Rever resistência, dose renal, imunossupressão e alternativas como foscarnet.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Pneumonite ▪ Colite grave ▪ Retinite com risco visual ▪ Citopenias graves ▪ Transplantado recente ▪ Absorção duvidosa
UTI	▪ Insuficiência respiratória ▪ Choque ▪ Doença multiorgânica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	CMV PCR/carga viral seriada; biópsia/endoscopia/imagem conforme órgão; avaliação oftalmológica se sintomas visuais; excluir coinfeções bacterianas/fúngicas.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ganciclovir EV	5 mg/kg EV 12/12 h GRAVE 5 mg/kg EV 12/12 h	>70: 5 mg/kg 12/12 h; 50-69: 2,5 mg/kg 12/12 h; <50: Ajustar conforme clearance	
Valganciclovir VO	900 mg VO 12/12 h GRAVE Não usar se absorção duvidosa/instável	>60: 900 mg 12/12 h; <60: Ajustar conforme clearance	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

International CMV transplant consensus guidelines
AST Infectious Diseases Community of Practice

15.9

Febre Persistente na Neutropenia — Suspeita de Fungo Invasivo

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Revisão parcial · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Neutropênico de alto risco com febre persistente ou recorrente após 4–7 dias de antibiótico antipseudomonas adequado deve ser reavaliado para foco oculto, resistência bacteriana, cateter e infecção fúngica invasiva. A escolha antifúngica depende do fenótipo: Aspergillus, Candida, Mucorales e profilaxia prévia.

CONDUTA DE PARTIDA

Alto risco com febre persistente após investigação: estratégia empírica ou preemptiva guiada por TC/ biomarcadores

Vori 6 mg/kg EV 12/12 h por 2 doses, depois 4 mg/kg EV 12/12 h; ou Mica 100 mg EV/dia; ou Anfo lipossomal 5 mg/kg/dia

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme diagnóstico, foco, resposta e recuperação imune

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Aspergillus spp.	ALTO RISCO	Neutropenia prolongada, nódulos pulmonares, sinal do halo, galactomanana positiva.
Candida spp.	CATETER/TPN/ ABDOMINAL	
Mucorales	ESPECIAL	Diabetes, deferoxamina, lesão necrótica, sinusite invasiva; não responde a voriconazol.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de aspergilose invasiva	Voriconazol · 6 mg/kg EV 12/12 h por 2 doses, depois 4 mg/kg EV 12/12 h · EV	Prolongada; mínimo semanas e guiada por resposta	Solicitar TC tórax, galactomanana e broncoscopia se possível. Monitorar interações, hepatotoxicidade e nível sérico se disponível.
Risco de Candida/candidemia	Micafungina · 100 mg EV 24/24 h · EV	Conforme candidemia/ foco	Preferir se instável, CVC/TPN, cirurgia abdominal ou colonização por Candida.
Suspeita de mucormicose	Anfotericina B lipossomal · 5 mg/kg EV 24/24 h; doses maiores em SNC conforme protocolo · EV	Prolongada + cirurgia se indicada	Emergência; voriconazol não cobre Mucorales. Avaliar desbridamento precoce e controle de imunossupressão/ hiperglicemia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Aspergilose ou mucormicose quando disponível/adequado	Isavuconazol · Ataque 200 mg EV/VO 8/8 h por 6 doses; depois 200 mg/dia · VO/EV	Prolongada conforme foco	Alternativa conforme disponibilidade, interações, espécie e protocolo local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

ANTIFÚNGICO NÃO É AUTOMÁTICO EM TODO NEUTROPÊNICO

Restringir terapia empírica ao alto risco após tempo e investigação apropriados. Onde houver TC seriada, galactomanana e avaliação especializada, estratégia preemptiva pode reduzir exposição sem omitir doença invasiva.

ALERTA CRÍTICO

REAVALIAR FOCO ANTES DE “SÓ TROCAR”

Repetir exame físico, culturas, TC tórax/seios/abdome conforme sintomas e revisar cateteres, antibiótico e profilaxia prévia.

ATENÇÃO

MUCOR NÃO É COBERTO POR VORICONAZOL

Se suspeita de mucormicose, usar anfotericina lipossomal ou agente ativo e controle cirúrgico.

ATENÇÃO

INTERAÇÕES IMPORTANTES

Azóis interagem com imunossupressores, anticoagulantes e vários fármacos; monitorar toxicidade e níveis quando aplicável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre persistente 4–7 dias	Reavaliar foco, culturas, cateteres, antibiótico atual, profilaxia antifúngica e epidemiologia.
2	Achado pulmonar/sinusal	TC e biomarcadores; iniciar antifúngico conforme fenótipo de suspeita.
3	Necrose/sinusite invasiva	Anfotericina lipossomal + avaliação cirúrgica urgente.
4	Candidemia/risco abdominal ou CVC	Equinocandina e controle de foco/cateter.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Neutropenia prolongada ▪ Febre persistente ▪ Achado pulmonar/sinusal ▪ Instabilidade ▪ CVC/TPN
UTI	▪ Choque ▪ Hipoxemia ▪ Doença fúngica invasiva extensa

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas, culturas de foco, TC dirigida, galactomanana/beta-D-glucana conforme disponibilidade, broncoscopia/BAL ou biópsia se possível; revisar profilaxia antifúngica prévia.
Controle de foco	Equinocandina e controle de foco/cateter.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Voriconazol EV	6 mg/kg 12/12 h 2 doses; depois 4 mg/kg 12/12 h GRAVE Mesmo esquema EV	Geral: Sem ajuste por função renal; atenção veículo EV em DRC	

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Micafungina EV	100 mg EV/dia GRAVE 100 mg EV/dia	Geral: Não requer ajuste renal	
Anfotericina B lipossomal EV	3–5 mg/kg EV/dia GRAVE 5–10 mg/kg EV/dia conforme foco	Geral: Não ajustar, mas monitorar nefrotoxicidade/eletrolitos	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Cenário de imunossupressão, alto risco de deterioração e forte dependência de microbiologia local, disponibilidade de antimicrobianos restritos, CCIH/ infectologia e protocolos do serviço.
- Validar protocolo local de neutropenia/transplante/imunossupressão sempre que disponível.
- Coletar culturas rapidamente, mas não atrasar terapia em choque, sepse, neutropenia febril de alto risco ou doença oportunista grave.
- Revisar colonização prévia, antibióticos recentes, profilaxias em uso, dispositivos, cateteres e internações recentes.
- Ajustar dose para função renal/hepática, peso, interações, citopenias, imunossupressores e toxicidade cumulativa.
- Considerar infectologia/CCIH e equipe assistente de oncologia, hematologia ou transplante em cenários graves ou com antimicrobianos de reserva.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA Aspergillosis
IDSA Candidiasis
ECMM/MSG mucormycosis guideline

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 15 — IMUNOSSUPRIMIDOS

- IDSA. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis, 2016.
- Cornely OA et al. Global guideline for candidiasis: ECMM/ISHAM/ASM, 2025. doi:10.1016/S1473-3099(24)00749-7.
- NIH. Opportunistic Infections Guidelines, versão vigente.

16

Sepse/Sistêmicas

1 quadros clínicos neste sistema

16.1 Seps e Choque Séptico — Abordagem Inicial

328

16.1

Sepse e Choque Séptico — Abordagem Inicial

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Síndrome tempo-dependente. Em choque séptico ou alta probabilidade de sepsse, iniciar antimicrobiano EV imediatamente, idealmente dentro da primeira hora, após culturas se isso não atrasar. A escolha deve ser guiada por foco provável, gravidade, exposição hospitalar, colonização prévia, antimicrobianos recentes, risco de MRSA/Pseudomonas/ESBL/carbapenemase KPC e necessidade de controle de foco.

CONDUTA DE PARTIDA

Antimicrobiano EV guiado por foco provável e risco MDR

Ex.: piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; associar vancomicina apenas se risco de MRSA/cateter/pele/dispositivo/pneumonia grave hospitalar

VIA

EV

DURAÇÃO

Reavaliar diariamente; em geral 4–7 dias se controle de foco adequado e boa resposta, prolongando conforme foco/complicação

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	FREQUENTE	E. coli, Klebsiella spp.; foco urinário, abdominal, biliar e hospitalar. Avaliar risco de ESBL/KPC.
Staphylococcus aureus	FREQUENTE EM FOCOS SELECIONADOS	Pele/partes moles, cateter, bacteremia, pneumonia pós-influenza, dispositivos; diferenciar MSSA/MRSA.
Streptococcus pneumoniae	RELEVANTE EM FOCO PULMONAR COMUNITÁRIO	PAC grave, meningite, bacteremia comunitária.
Pseudomonas aeruginosa	DEPENDENTE DE RISCO	Hospitalização, DPOC/bronquiectasias, antibiótico recente, PAV/HAP, imunossupressão, colonização prévia.
Enterococcus spp.	DEPENDENTE DE FOCO	Abdominal hospitalar, biliar, urinário complicado, pós-operatório, próteses/dispositivos.
Anaeróbios	DEPENDENTE DE FOCO	Abdominal, pélvico, aspiração, necrose, mordeduras e infecções odontogênicas profundas.
Candida spp.	SELECIONADO	Choque séptico abdominal, nutrição parenteral, cirurgia abdominal recente, CVC, pancreatite, colonização multifocal, imunossupressão.

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse grave/choque séptico sem foco definido — abordagem inicial	Piperacilina-tazobactam ± Vancomicina · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida pelo protocolo; adicionar vancomicina somente se risco de MRSA e individualizar dose de ataque/manutenção por peso, TFG e AUC/nível · EV	Reavaliar em 24–72 h	Não usar vancomicina de rotina em todo paciente. Cobertura deve ser suficientemente ampla no início, mas descalonada assim que houver dados clínicos/microbiológicos.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse/choque com risco relevante de ESBL ou Gram-negativo MDR	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida; vancomicina se critério específico para MRSA/dispositivo/cateter · EV	Reavaliar em 24–72 h	Usar quando há colonização/infeção prévia por ESBL, antibiótico recente de amplo espectro, internação recente, origem hospitalar, choque grave ou alta prevalência local. CRE/KPC exige protocolo institucional/CCIH.
Foco pulmonar comunitário grave sem risco validado de MRSA/Pseudomonas	Ceftriaxona + Azitromicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + azitromicina 500 mg EV/VO 24/24 h · EV	Em geral 5–7 dias se estabilidade clínica e sem complicação	Adicionar vancomicina/linezolida apenas se risco de MRSA. Trocar para cefepime/pip-tazo/meropenem se risco de Pseudomonas/MDR.
Foco pulmonar hospitalar, PAV/HAP ou risco de Pseudomonas/MDR	Cefepime ou Piperacilina-tazobactam ± Vancomicina · Cefepime 2 g EV 8/8 h ou pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h; associar vancomicina se risco de MRSA · EV	Em geral 7 dias se boa resposta e sem complicação	Escolher conforme antibiograma local, colonização prévia, antibiótico recente e gravidade. Dupla cobertura antipseudomonal é seletiva, não automática.
Urossepse / pielonefrite grave sem risco MDR	Ceftriaxona · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h em sepse grave/bacteremia; ajustar após urocultura/hemocultura · EV	Geralmente 7 dias se boa resposta	Vancomicina não é rotina em urossepse. Procurar obstrução, cálculo, abscesso, cateter e necessidade de desobstrução/controle de foco.
Sepse de foco abdominal/biliar com necessidade de controle de fonte	Piperacilina-tazobactam OU ceftriaxona + metronidazol · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h OU ceftriaxona 2 g EV 24/24 h + metronidazol 500 mg EV 8/8 h · EV	Após controle adequado de fonte, geralmente 4 dias; prolongar se fonte não controlada ou complicação	Não associar metronidazol a pip-tazo de rotina. Prioridade: cirurgia, drenagem percutânea, CPRE, colecistostomia ou remoção de foco quando indicado.
Sepse por pele/partes moles grave, fasciite ou síndrome toxigênica	Piperacilina-tazobactam + Vancomicina + Clindamicina · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vancomicina individualizada por AUC/nível + clindamicina 900 mg EV 8/8 h · EV	Individualizar	Cirurgia/desbridamento imediato é decisivo. Clindamicina é útil quando há suspeita de Streptococcus pyogenes ou Clostridium por efeito antitoxina.
Choque séptico com alto risco de candidemia/infeção fúngica invasiva	Equinocandina associada ao esquema antibacteriano do foco provável · Micafungina 100 mg EV 24/24 h; alternativas: anidulafungina ou caspofungina conforme disponibilidade · EV	Se candidemia confirmada: pelo menos 14 dias após primeira hemocultura negativa e resolução dos sinais atribuíveis	Considerar em TPN, cirurgia abdominal recente, perfuração/anastomose, pancreatite, CVC, colonização multifocal, imunossupressão ou choque sem explicação. Exige controle de foco/CVC e hemoculturas seriadas.

Sobre a duração: Manter até controle cirúrgico, estabilidade clínica e ausência de novas necroses. 10–14 dias se foco complicado, abscesso, obstrução ou resposta lenta. Ajustar por cultura, sensibilidade, foco e controle de fonte. Geralmente 4–7 dias se foco controlado e resposta adequada.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave imediata a betalactâmico — sepse sem foco	Aztreonam + Vancomicina ± Metronidazol · Aztreonam 2 g EV a cada 6–8 h + vancomicina individualizada por AUC/nível; adicionar metronidazol 500 mg EV 8/8 h se foco abdominal/pélvico/anaeróbio · EV	Reavaliar em 24–72 h; ajustar por foco e cultura	Aztreonam cobre Gram-negativos aeróbios, mas não cobre Gram-positivos nem anaeróbios. Avaliar cuidadosamente história de alergia; em choque, discutir dessensibilização/alternativas com CCIH/infectologia quando necessário.
CRE/KPC, Pseudomonas DTR, CRAB ou outro MDR confirmado/suspeito	Terapia dirigida por sensibilidade e protocolo CCIH · Definir conforme organismo, CIM, sítio, função renal, disponibilidade e protocolo institucional · EV	Individualizar por foco, bacteremia, controle de fonte e resposta	Pode envolver ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam, cefiderocol, polimixina, aminoglicosídeo ou combinações. Não padronizar sem antibiograma/CCIH.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização ou infecção prévia por MRSA ▪ Pneumonia grave hospitalar ou pós-influenza com necrose ▪ Cateter/dispositivo intravascular ou material protético como foco provável ▪ Infecção grave de pele/partes moles, fasciite ou abscesso extenso ▪ Hemocultura com cocos Gram-positivos em cachos ou bacteremia por <i>S. aureus</i> até sensibilidade	Vancomicina EV com dose de ataque/manutenção individualizadas por AUC/nível; linezolid pode ser opção em pneumonia/MRSA conforme cenário e protocolo
PSEUDOMONAS	▪ PAV/HAP ou internação recente com antibiótico EV ▪ Colonização/infecção prévia por <i>Pseudomonas</i> ▪ DPOC grave, bronquiectasias ou fibrose cística ▪ Neutropenia ou imunossupressão relevante ▪ Choque séptico com origem hospitalar ou foco urinário/pulmonar de alto risco	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem conforme risco, foco e antibiograma local
ANAEROBIOS	▪ Foco abdominal, pélvico ou biliar complicado ▪ Aspiração com abscesso/necrose/empiema ▪ Fasciite, mionecrose, mordedura ou infecção odontogênica/cervical profunda ▪ Perfuração de víscera oca ou abscesso drenável	Piperacilina-tazobactam ou carbapenêmico; se ceftriaxona/cefepime, associar metronidazol
ESBL	▪ ESBL prévio ou colonização por Enterobacterales MDR ▪ Uso recente de cefalosporina, quinolona ou carbapenêmico ▪ Internação recente, institucionalização, hemodiálise ou origem hospitalar ▪ Choque séptico com foco urinário/abdominal e alta prevalência local de ESBL	Meropenem em sepse grave/choque; ertapenem pode ser opção em paciente estável sem <i>Pseudomonas</i> , conforme foco e sensibilidade

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

TEMPO DO ANTIMICROBIANO — SSC 2026

Choque séptico ou sepse provável/definida: iniciar imediatamente, idealmente em até 1 h. Possível sepse sem choque: investigação rápida; se a preocupação persistir, iniciar em até 3 h.

ALERTA CRÍTICO

Choque séptico ou alta probabilidade de sepse: antibiótico imediato

Iniciar antimicrobiano EV amplo, idealmente em até 1 hora, após hemoculturas se isso não atrasar. Se coleta atrasar, antibiótico vem primeiro.

ATENÇÃO

Possível sepse sem choque: investigação rápida e tempo limitado

Quando a probabilidade de infecção é incerta e não há choque, fazer investigação clínica/laboratorial rápida. Se a preocupação com infecção persistir, iniciar antimicrobiano em até 3 horas da suspeita; evitar tratar SIRS, febre, leucocitose ou lactato isolados.

ALERTA CRÍTICO

Controle de fonte salva vida

Drenar abscesso, desobstruir via urinária/biliar, remover cateter infectado, desbridar necrose e operar abdome quando indicado. Antibiótico sem controle de foco frequentemente falha.

ATENÇÃO

Cobertura ampla inicial não significa cobertura eterna

Reavaliar em 24–72 h: culturas, foco, resposta, toxicidade, função renal e possibilidade de descalonamento ou suspensão se infecção não se confirmar.

ATENÇÃO

Vancomicina não é universal

Usar quando houver risco de MRSA, cateter/dispositivo, pele/partes moles grave, pneumonia hospitalar grave ou Gram-positivo em cultura. Suspender se MRSA for improvável/excluído.

INFORMAÇÃO

Duração curta quando possível

Na maioria das infecções controladas e com boa resposta, cursos mais curtos são suficientes. Endocardite, osteomielite, meningite, abscesso não drenado, *S. aureus* bacteremia e imunossupressão podem exigir duração maior.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Reconhecer choque séptico/alta probabilidade de sepse	Ativar protocolo institucional, monitorização, acesso venoso calibroso, lactato, hemoculturas e antimicrobiano EV imediato.
2	Antes do antibiótico, se não atrasar	Coletar 2 pares de hemoculturas de sítios distintos e culturas do foco provável: urina, secreção, escarro, LCR, bile, líquido ascítico, ponta/cateter conforme cenário.
3	Definir foco provável em minutos	Classificar como pulmonar, urinário, abdominal/biliar, pele/partes moles, SNC, cateter/dispositivo, ginecológico, odontogênico ou sem foco.
4	Escolher esquema empírico	Cobrir foco provável + gravidade + risco MDR. Não adicionar MRSA, <i>Pseudomonas</i> , anaeróbio, ESBL ou antifúngico sem critério clínico/epidemiológico.
5	Choque ou lactato alto	Reposição volêmica, vasopressor precoce se necessário e reavaliação hemodinâmica. Este guia não substitui protocolo de sepse/UTI.
6	Controle de fonte	Acionar cirurgia, urologia, endoscopia, radiologia intervencionista, ortopedia, ORL, odontologia, ginecologia ou infectologia conforme foco.
7	Reavaliação em 24–72 h	Checar culturas, imagem, evolução, lactato, função renal/hepática, toxicidade, dose e necessidade real de manter cobertura ampla.
8	Descalonamento	Reduzir espectro, suspender vancomicina/antipseudomonal/antifúngico se critérios não se confirmarem e definir duração por foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Necessidade de vasopressor para manter PAM ≥ 65 mmHg apesar de reposição volêmica adequada ▪ Lactato persistentemente elevado ou ≥ 4 mmol/L ▪ Insuficiência respiratória, necessidade de ventilação ou hipoxemia grave ▪ Rebaixamento de consciência, oligúria, lesão renal aguda, coagulopatia ou disfunção de múltiplos órgãos ▪ Necessidade de controle de foco emergencial ou monitorização intensiva
Gravidade	▪ Hipotensão, lactato elevado ou hipoperfusão periférica ▪ SOFA aumentado em relação ao basal ou disfunção orgânica nova ▪ Imunossupressão, asplenia, neutropenia, transplante, DRC/hemodiálise ou cirrose ▪ Suspeita de foco profundo: abdome, SNC, endocardite, fasciite, cateter, prótese ou obstrução urinária/biliar
Falha terapêutica	▪ Choque persistente ou lactato sem queda nas primeiras horas ▪ Febre ou instabilidade persistente >48–72 h sem explicação ▪ Cultura com patógeno resistente ou cobertura inadequada ▪ Foco não controlado: abscesso, cateter, necrose, obstrução, material infectado ▪ Diagnóstico alternativo: TEP, pancreatite, DRESS, doença autoimune, neoplasia, febre medicamentosa

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Idealmente 2 pares de hemoculturas antes do primeiro antibiótico se não atrasar; culturas dirigidas ao foco provável. Não atrasar antimicrobiano em choque séptico/alta probabilidade de sepse. Repetir hemoculturas em <i>S. aureus</i> , candidemia, endocardite, cateter/dispositivo ou bacteremia persistente.
Controle de foco	▪ Classificar como pulmonar, urinário, abdominal/biliar, pele/partes moles, SNC, cateter/dispositivo, ginecológico, odontogênico ou sem foco. ▪ Acionar cirurgia, urologia, endoscopia, radiologia intervencionista, ortopedia, ORL, odontologia, ginecologia ou infectologia conforme foco.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.

EIXO	CONDUTA
Descalçamento	- Reavaliar em 24–72 h com culturas, foco, imagem, lactato, estabilidade hemodinâmica e toxicidade. - Suspender vancomicina se MRSA/cateter/dispositivo/Gram-positivo relevante forem improváveis ou excluídos. - Reduzir carbapenêmico/antipseudomonal quando cultura e foco permitirem. - Suspender antifúngico empírico se risco de Candida não se confirmar e culturas/biomarcadores forem negativos conforme contexto. - Definir duração por foco: curta quando controle de fonte adequado; prolongada em endocardite, osteomielite, meningite, bacteremia por <i>S. aureus</i>, abscesso não drenado e imunossupressão.
Transição EV → VO	- Choque persistente, lactato sem queda ou nova disfunção orgânica apesar de tratamento inicial. - Cultura com patógeno resistente ou foco não coberto pelo esquema inicial. - Suspeita de foco não controlado exigindo drenagem, cirurgia, retirada de cateter ou desobstrução. - Toxicidade medicamentosa, lesão renal, neurotoxicidade ou interação relevante. - Diagnóstico infeccioso não confirmado após investigação e paciente estável: considerar suspender antibiótico.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-tazobactam EV Gestação: uso aceito	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida em choque/UTI	>40 mL/min: 4,5 g 6/6 h; 20–40 mL/min: 2,25–3,375 g 6/6 h conforme protocolo; <20 mL/min: Ajustar intervalo/dose conforme protocolo renal	
Cefepime EV Gestação: uso aceito	2 g EV a cada 8–12 h conforme foco e função renal GRAVE 2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida em choque/risco Pseudomonas	>60 mL/min: 2 g 8/8 h em infecção grave/Pseudomonas; 30–60 mL/min: Ajustar intervalo conforme protocolo; <30 mL/min: Ajuste obrigatório; risco de neurotoxicidade	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h; usar 2 g EV 8/8 h em SNC, choque/MDR selecionado ou protocolo local GRAVE 1–2 g EV 8/8 h, preferir infusão estendida quando indicado	>50 mL/min: 1–2 g 8/8 h conforme foco; 26–50 mL/min: Ajustar intervalo conforme protocolo; <26 mL/min: Ajuste obrigatório	Usar se indicado; revisar gestação e protocolo local
Vancomicina EV Gestação: uso aceito	Dose de ataque e manutenção individualizadas por peso real, função renal em tendência e AUC/nível GRAVE Em choque/infecção grave com risco de MRSA, definir dose de ataque e alvo farmacocinético pelo protocolo/AUC	>50 mL/min: Manutenção individualizada; monitorar nível/AUC conforme protocolo; 30–50 mL/min: Ajustar intervalo e monitorar nível; <30 mL/min/hemodiálise: Dose guiada por nível/protocolo	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100 mg EV 24/24 h; discutir dose maior em cenários específicos conforme protocolo	Geral: Não requer ajuste renal usual	Monitorar enzimas hepáticas Usar se benefício superar risco; discutir infectologia/obstetrícia se gestante

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Sepse/choque séptico depende de protocolo institucional, antibiograma local, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos, fluxos de controle de foco e recursos de UTI.
- Ativar protocolo institucional de sepse e registrar horários críticos.
- Consultar CCIH/infectologia nos cenários MDR, candidemia, neutropenia, transplante, endocardite, meningite, prótese/dispositivo ou falha terapêutica.
- Usar antibiograma local para decidir MRSA, Pseudomonas, ESBL, CRE/KPC, CRAB e VRE.
- Confirmar dose por peso, função renal/hepática, hemodiálise, alergias, gestação e interações.
- Garantir controle de fonte e reavaliação formal em 24–72 h.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines, 2026.

IDSA Guidance on Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections 2024

ATS/IDSA HAP/VAP Guidelines

IDSA Candidiasis Guidelines

IDSA Catheter-Related Bloodstream Infection Guidelines

Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock, 2026.

<https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 16 — SEPSE/SISTÊMICAS

- Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines, 2026.

17

Profilaxias/Exposições

10 quadros clínicos neste sistema

Antes da alta, registrar tempo da exposição, risco, status vacinal/sorológico, primeira dose quando indicada e plano de seguimento.

17.1	PEP HIV — Pós-exposição Sexual/Ocupacional	335
17.2	Hepatite B — Profilaxia Pós-exposição	337
17.3	Raiva — Profilaxia Pós-exposição	338
17.4	Profilaxia do Tétano após Ferimento — Brasil	341
17.5	Meningococo — Quimioprofilaxia de Contatos	343
17.6	Coqueluche — Profilaxia de Contatos de Alto Risco	345
17.7	Influenza — Profilaxia Pós-exposição em Alto Risco	346
17.8	Acidente Biológico Ocupacional — Sangue/Material Perfurocortante	348
17.9	Asplenia/Hipoesplenia — Febre e Profilaxia	350
17.10	Profilaxia Antibiótica Cirúrgica — Princípios Básicos	352

17.1

PEP HIV — Pós-exposição Sexual/Ocupacional

GRAVE AMBULATORIAL TODOS

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Profilaxia pós-exposição ao HIV após exposição sexual, ocupacional ou violência sexual, idealmente iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras horas e não depois de 72 horas. No PS, a decisão deve ser rápida, com primeira dose ainda no atendimento quando indicada.

CONDUTA DE PARTIDA

Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir
— padrão Brasil/SUS

TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + DTG 50 mg VO 24/24 h

VIA

VO

DURAÇÃO

28 dias; iniciar o mais rápido possível e no máximo até 72 h

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
HIV-1/HIV-2	ALVO DA PROFI-LAXIA	Risco depende do tipo de exposição, fonte, carga viral e presença de sangue/secreção infectante

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Exposição de risco dentro da janela de PEP — Brasil/SUS	TDF/3TC + Dolutegravir · TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + Dolutegravir 50 mg VO 24/24 h · VO	28 dias	Iniciar imediatamente quando indicada; não aguardar sorologias da fonte se isso atrasar a primeira dose. Reavaliar função renal, interações e seguimento.
Alternativa quando dolutegravir não for adequado/disponível	TDF/3TC + Raltegravir · TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + Raltegravir 400 mg VO 12/12 h · VO	28 dias	Confirmar a alternativa no PCDT vigente conforme interações, gestação e função renal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
DRC, gestação, interação importante ou esquema complexo	Esquema individualizado de PEP · Definir com infectologia/protocolo · VO	28 dias	Não atrasar primeira dose se risco alto; ajustar depois conforme exames.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

PADRÃO BRASIL/SUS

Esquema preferencial: TDF/3TC 300/300 mg 1x/dia + DTG 50 mg 1x/dia por 28 dias. Não aguardar exames se isso atrasar a primeira dose; verificar contraindicação ao TDF e interações do DTG.

ALERTA CRÍTICO

Tempo é decisivo

Iniciar o quanto antes quando indicada, idealmente <24 h e até 72 h. Exposições tardias ou complexas exigem avaliação especializada e documentação do motivo da decisão.

ATENÇÃO**Não esquecer HBV/HCV/IST/gravidez**

Exposição sexual ou ocupacional deve acionar pacote de avaliação, não apenas PEP HIV.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Exposição potencial	Caracterizar material, via, tempo, fonte e status vacinal/sorológico do exposto.
2	PEP indicada	Dar primeira dose no PS, solicitar HIV, HBV, HCV, função renal/hepática, gravidez quando aplicável e agendar seguimento.
3	Seguimento	Reavaliar tolerância, adesão e sorologias conforme protocolo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Violência sexual com necessidade de proteção/avaliação multiprofissional ▫ Exposição com lesões graves ou comorbidade relevante
Gravidade	▫ Fonte sabidamente HIV positiva sem supressão viral ▫ Exposição percutânea profunda ▫ Contato com sangue em mucosa/pele não íntegra ▫ Violência sexual
Falha terapêutica	▫ Vômitos/intolerância que impeçam adesão ▫ Perda de seguimento ▫ Soroconversão ou sintomas compatíveis

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Solicitar testes basais para HIV, HBsAg/anti-HBs/anti-HBc conforme protocolo, anti-HCV, função renal/hepática e gravidez quando aplicável.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
TDF/3TC + Dolutegravir vo	TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + DTG 50 mg VO 24/24 h por 28 dias GRAVE Mesma dose; não atrasar	<50 mL/min: Ajustar conforme fármaco, função renal e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia com janela de oportunidade, seguimento obrigatório ou adaptação por risco individual.
- Confirmar tempo desde exposição e se ainda há benefício clínico esperado.
- Checar idade, peso, gestação/lactação, função renal/hepática, interações e alergias.
- Garantir primeira dose quando indicada e plano de seguimento documentado.
- Orientar sinais de alarme e retorno programado.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. PCDT para Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, versão vigente.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/p/profilaxia-pós-exposição-de-risco-peg-a-infeccao-pelo-hiv>

17.2

Hepatite B — Profilaxia Pós-exposição

MODERADA AMBULATORIAL TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Profilaxia pós-exposição ao HBV depende do status vacinal, anti-HBs do exposto e HBsAg da fonte. No PS, identificar rapidamente quem precisa de vacina, HBIG ou ambos, aplicando em sítios anatômicos diferentes quando usados juntos.

CONDUTA DE PARTIDA

Vacina hepatite B ± HBIG

HBIG 0,06 mL/kg IM quando indicada + vacina hepatite B IM

VIA

IM

DURAÇÃO

Esquema vacinal conforme calendário/protocolo

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus da hepatite B	ALVO DA PROFILAXIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Não vacinado/incompleto e fonte HBsAg positiva ou desconhecida de alto risco	Vacina hepatite B + HBIG · HBIG 0,06 mL/kg IM + iniciar/completar vacina hepatite B · IM	Esquema vacinal completo	Aplicar em sítios diferentes; seguir protocolo institucional.
Não vacinado/incompleto e fonte negativa ou risco menor	Vacina hepatite B · Iniciar ou completar esquema · IM	Conforme calendário	Registrar e garantir retorno para doses subsequentes.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Não respondedor vacinal exposto a fonte HBsAg positiva	HBIG · HBIG 0,06 mL/kg IM; considerar segunda dose conforme protocolo · IM	Dose única ou esquema específico	Discutir com CCIH/infectologia quando não respondedor conhecido.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Anti-HBs muda conduta

Pessoa previamente vacinada com anti-HBs adequado geralmente não precisa de profilaxia.

INFORMAÇÃO

Aplicar em sítios distintos

Quando vacina e HBIG forem usadas juntas, aplicar em locais anatômicos diferentes.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Exposição a sangue/fluido potencialmente infectante	Checar vacinação, anti-HBs do exposto e HBsAg da fonte.
2	Profilaxia indicada	Aplicar vacina ± HBIG conforme status; registrar dose e retorno.
3	Seguimento	Completar esquema e repetir sorologia conforme protocolo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Fonte HBsAg positiva ▪ Exposto não vacinado ▪ Não respondedor vacinal ▪ Imunossupressão

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Sorologias HBV do exposto e fonte; associar avaliação de HIV/HCV quando acidente biológico.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
HBIG + Vacina hepatite B IM	HBIG 0,06 mL/kg IM quando indicada + vacina IM GRAVE Mesma estratégia	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia com janela de oportunidade, seguimento obrigatório ou adaptação por risco individual.
- Confirmar tempo desde exposição e se ainda há benefício clínico esperado.
- Checar idade, peso, gestação/lactação, função renal/hepática, interações e alergias.
- Garantir primeira dose quando indicada e plano de seguimento documentado.
- Orientar sinais de alarme e retorno programado.

17.3

Raiva — Profilaxia Pós-exposição

GRAVE

AMBULATORIAL

TODOS

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Profilaxia após mordedura, arranhadura ou contato de mucosa/pele não íntegra com saliva de animal potencialmente transmissor. A decisão depende do animal, circunstância, região, possibilidade de observação e orientação da vigilância/zoonoses.

CONDUTA DE PARTIDA

Vacina antirrábica ± soro antirrábico (SAR) ou imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR) — fluxo Brasil

Vacina nos dias 0, 3, 7 e 14 quando indicada; SAR 40 UI/kg ou IGHAR 20 UI/kg, infiltrando na(s) lesão(ões), conforme fluxo do Ministério da Saúde

VIA

IM

DURAÇÃO

Esquema conforme status vacinal e risco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus da raiva	ALVO DA PROFILAXIA	Doença quase sempre fatal após início dos sintomas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cão ou gato passível de observação, conforme tipo de acidente e condição do animal	Observação por 10 dias ± vacina conforme fluxograma · Avaliar acidente leve/grave e condição do animal; encerrar ou completar profilaxia conforme evolução do animal e vigilância · Conduta	10 dias de observação	Se o animal desaparecer, morrer ou apresentar sinais de raiva, reclassificar imediatamente. Não observar mamífero silvestre como se fosse cão/gato.
Exposição grave com indicação de soro/imunoglobulina em pessoa não previamente vacinada	Vacina + SAR ou IG HAR · Vacina dias 0, 3, 7 e 14 + SAR 40 UI/kg OU IG HAR 20 UI/kg; infiltrar o máximo possível dentro/ao redor da lesão, idealmente no dia 0 e até o 7º dia após iniciar vacina · IM	Esquema completo conforme protocolo	Vacina e imunobiológico passivo em locais anatômicos diferentes. Imunossuprimido exige avaliação específica e controle sorológico conforme protocolo.
Pessoa previamente vacinada adequadamente	Vacina antirrábica sem SAR/IG HAR · Reforços conforme fluxograma vigente e comprovação do esquema prévio · IM	Esquema abreviado	Em imunocompetente previamente vacinado, não administrar SAR/IG HAR. Imunocomprometido exige aplicação da Nota Técnica vigente e decisão da vigilância, inclusive quanto a imunização passiva e sorologia.
Pessoa imunocomprometida com exposição relevante	Fluxo especializado: vacina + avaliação de SAR/IG HAR e sorologia · A Nota Técnica Conjunta nº 35/2026 orienta soro + vacina sistematicamente e sorologia após o esquema; conciliar com vacinação prévia e tipo de exposição junto à vigilância · Conduta	Conforme esquema e controle sorológico	O acompanhamento médico é indispensável. Realizar sorologia a partir do 14º dia após a última dose, conforme a nota técnica; não extrapolar o fluxo do imunocompetente.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

IMUNOCOMPROMETIDO TEM FLUXO PRÓPRIO

A Nota Técnica Conjunta nº 35/2026 orienta imunização passiva e vacina de forma sistemática no imunocomprometido, com exame sorológico após o esquema e acompanhamento médico; conciliar histórico vacinal e reexposição com a vigilância.

ALERTA CRÍTICO

Lavar ferida imediatamente

Irrigação vigorosa com água e sabão é parte central da profilaxia.

ALERTA CRÍTICO

Raiva é fatal

Quando indicada, profilaxia não deve ser adiada por burocracia ou espera de sintomas.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Toda exposição	Lavar imediatamente com água e sabão; avaliar local, profundidade, animal, circunstância, região e vacinação prévia.
2	Cão/gato observável	Aplicar o fluxograma de observação por 10 dias e reclassificar se desaparecer, adoecer ou morrer.
3	Mamífero silvestre, morcego ou acidente grave	Acionar vigilância/zoonoses e iniciar vacina ± SAR/IG HAR sem atraso quando indicado.
4	Imunobiológico passivo	SAR 40 UI/kg ou IG HAR 20 UI/kg, infiltrado na lesão; não exceder a dose e não aplicar no mesmo local da vacina.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Ferida extensa/profunda ▪ Infecção secundária grave ▪ Necessidade cirúrgica ▪ Vulnerabilidade social importante
Gravidade	▪ Morcego ▪ Animal silvestre ▪ Animal desaparecido ou morto ▪ Ataque não provocado ▪ Imunossuprimido

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não depende de cultura. Acionar vigilância/zoonoses para avaliação do animal e notificação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vacina antirrábica ± SAR/IGHAR IM	Vacina conforme fluxo; SAR 40 UI/kg ou IGHAR 20 UI/kg GRAVE Não atrasar quando indicado	Conferir bula/protocolo.	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia dependente de protocolo oficial, vigilância epidemiológica, CCIH/saúde ocupacional ou padronização institucional.
- Confirmar protocolo local vigente antes da alta ou prescrição definitiva.
- Registrar tempo da exposição, tipo de exposição, status vacinal/sorológico e conduta orientada.
- Acionar vigilância epidemiológica, CCIH, saúde ocupacional ou equipe cirúrgica quando aplicável.
- Garantir retorno, doses subsequentes e documentação para rastreabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Fluxograma da Profilaxia da Raiva Humana, versão vigente.

Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta nº 35/2026 — indicação e uso do soro antirrábico no SUS.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/raiva/fluxograma-da-profilaxia-da-raiva-humana-cartaz>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pni/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-conjunta-no-35-2026-cggi-cgici-dpni-cgzha-dedt-svsa-ms-e-cgzha-dedt-svsa-ms>

17.4

Profilaxia do Tétano após Ferimento — Brasil

MODERADA AMBULATORIAL TODOS

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Profilaxia antitetânica baseada no tipo de ferida e histórico vacinal. Feridas sujas, puntiformes, com saliva, solo, necrose, esmagamento, queimadura ou congelamento têm maior risco; antibiótico não substitui vacina/TIG.

CONDUTA DE PARTIDA

Vacina dT/dTpa ± TIG
TIG 250 UI IM quando indicada + vacina conforme histórico

VIA
IM

DURAÇÃO
Dose imediata + completar calendário

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Clostridium tetani	ALVO DA PROFILAXIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Ferida suja/maior e vacinação desconhecida ou <3 doses	Vacina antitetânica + TIG · TIG 250 UI IM + dT/dTpa IM · IM	Dose imediata + completar esquema	Aplicar em locais diferentes; antibiótico não substitui profilaxia antitetânica.
Ferida limpa menor e vacinação desconhecida ou <3 doses	Vacina antitetânica · dT/dTpa IM · IM	Completar esquema	TIG geralmente não é necessária em ferida limpa menor.
Esquema completo, mas reforço vencido	Vacina antitetânica · dT/dTpa IM · IM	Dose de reforço	Intervalo para reforço depende do tipo de ferida e tempo desde última dose.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

PROFILAXIA NÃO TRATA TÉTANO INSTALADO
Classificar o ferimento e revisar número/data das doses. Quando indicada imunização passiva, usar IGHT ou SAT conforme protocolo, além de vacina e cuidado local.

ATENÇÃO

Antibiótico não previne tétano
A prevenção é desbridamento/limpeza + vacina ± TIG conforme indicação.

ALERTA CRÍTICO

Ferida suja + vacinação incerta
Esse é o cenário clássico para vacina + TIG.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Ferimento	Classificar ferida como limpa menor ou suja/maior; checar número de doses e data do último reforço.
2	Indicação de vacina/TIG	Aplicar imediatamente conforme risco, em sítios diferentes se ambos usados.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
3	Ferida contaminada	Irrigar, remover corpo estranho/tecido desvitalizado e avaliar antibiótico por infecção/mordedura, não por tétano.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Ferida suja/contaminada ▪ Puntura profunda ▪ Esmagamento/necrose ▪ Queimadura ▪ Mordedura ▪ Vacinação incerta ou incompleta

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não há cultura para decisão de profilaxia. Registrar histórico vacinal e tipo de ferida.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
dT/dTpa ± TIG IM	TIG 250 UI IM quando indicada + vacina IM GRAVE Mesma dose	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia dependente de protocolo oficial, vigilância epidemiológica, CCIH/saúde ocupacional ou padronização institucional.
- Confirmar protocolo local vigente antes da alta ou prescrição definitiva.
- Registrar tempo da exposição, tipo de exposição, status vacinal/sorológico e conduta orientada.
- Acionar vigilância epidemiológica, CCIH, saúde ocupacional ou equipe cirúrgica quando aplicável.
- Garantir retorno, doses subsequentes e documentação para rastreabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. Tétano Acidental — vigilância, profilaxia e tratamento.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tetano-acidental>

17.5

Meningococo — Quimioprofilaxia de Contatos

GRAVE AMBULATORIAL TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Profilaxia para contatos próximos de doença meningocócica invasiva, incluindo domicílio, creche e exposição direta a secreções orais. Deve ser feita rapidamente após identificação do caso índice, idealmente nas primeiras 24 horas.

CONDUTA DE PARTIDA

Rifampicina ou Ciprofloxacino ou Ceftriaxona

Ciprofloxacino 500 mg VO dose única em adulto

VIA

VO

DURAÇÃO

Dose única ou 2 dias conforme esquema

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Neisseria meningitidis	ALVO DA PROFILAXIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Adulto contato próximo, sem contraindicação e resistência local não relevante	Ciprofloxacino · 500 mg VO dose única · VO	Dose única	Verificar resistência local e contraindicações.
Contato próximo — alternativa clássica	Rifampicina · 600 mg VO 12/12 h · VO	2 dias	Atenção a interações, contraceptivos, hepatopatia e coloração de secreções.
Gestante ou quando VO não é adequado	Ceftriaxona · 250 mg IM dose única em adulto · IM	Dose única	Opção preferida em gestantes em muitos protocolos.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Área com resistência a ciprofloxacino e outras opções inadequadas	Azitromicina · 500 mg VO dose única · VO	Dose única	Usar conforme orientação de vigilância/protocolo local.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Profilaxia é para contato próximo

Não é indicada para todo contato casual; foco em domicílio, creche e exposição a secreções orais.

ATENÇÃO

Acionar vigilância

Doença meningocócica exige notificação e orientação de contatos.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Caso índice de meningococo	Identificar contatos próximos e acionar vigilância epidemiológica.

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
2	Contato elegível	Administrar quimioprofilaxia o mais cedo possível, preferencialmente <24 h após identificação do caso; se o contato estiver sintomático, investigar doença invasiva.
3	Contato sintomático	Não fazer apenas profilaxia: avaliar como possível doença invasiva.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Contato domiciliar ▪ Creche ▪ Beijo/exposição direta a secreção oral ▪ Intubação/aspiração sem proteção adequada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não é necessário exame do contato assintomático para decidir profilaxia; caso índice exige investigação/notificação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ciprofloxacino VO	500 mg VO dose única em adulto GRAVE Não se aplica	<50 mL/min: Ajustar conforme fármaco, função renal e protocolo local	
Rifampicina VO	600 mg VO 12/12 h por 2 dias em adulto GRAVE Não se aplica	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	
Ceftriaxona IM	250 mg IM dose única em adulto GRAVE Não se aplica	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia dependente de protocolo oficial, vigilância epidemiológica, CCIH/saúde ocupacional ou padronização institucional.
- Confirmar protocolo local vigente antes da alta ou prescrição definitiva.
- Registrar tempo da exposição, tipo de exposição, status vacinal/sorológico e conduta orientada.
- Acionar vigilância epidemiológica, CCIH, saúde ocupacional ou equipe cirúrgica quando aplicável.
- Garantir retorno, doses subsequentes e documentação para rastreabilidade.

17.6

Coqueluche — Profilaxia de Contatos de Alto Risco

- MODERADA
- AMBULATORIAL
- TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Profilaxia pós-exposição para contatos domiciliares e pessoas de alto risco ou que convivem com alto risco, especialmente lactentes, gestantes no fim da gestação e imunocomprometidos; priorizar dentro da janela recomendada após início da tosse do caso índice.

CONDUTA DE PARTIDA

Azitromicina

500 mg VO no D1, depois 250 mg VO 24/24 h D2-D5 em adultos

VIA

VO

DURAÇÃO

5 dias

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Bordetella pertussis	ALVO DA PROFI-LAXIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Contato elegível para profilaxia	Azitromicina · 500 mg VO D1, depois 250 mg VO 24/24 h D2-D5 · VO	5 dias	Em crianças, dose é por peso; checar protocolo pediátrico.
Alternativa macrolídeo	Claritromicina · 500 mg VO 12/12 h · VO	7 dias	Atenção a QT/interações.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Contraindicação a macrolídeo	Sulfametoxazol-trimetoprim · 800/160 mg VO 12/12 h · VO	14 dias	Evitar em algumas situações especiais; revisar idade/gestação.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Priorizar alto risco

Lactentes e gestantes são os grupos mais críticos para prevenção de desfechos graves.

INFORMAÇÃO

Vacinação deve ser revisada

Profilaxia não substitui atualização vacinal quando indicada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Caso suspeito/confirmado	Identificar contatos domiciliares e contatos de alto risco.
2	Contato elegível	Prescrever macrolídeo e orientar sinais de alerta.
3	Contato sintomático	Avaliar como caso provável, isolar conforme orientação e notificar quando aplicável.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Contato domiciliar ▪ Lactente ▪ Gestante ▪ Imunossuprimido ▪ Profissional/cuidador de lactente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	PCR/cultura no caso suspeito conforme tempo de sintomas e disponibilidade; contato assintomático não depende de exame.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Azitromicina VO	Adulto: 500 mg D1, depois 250 mg D2-D5 GRAVE Não se aplica	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia com janela de oportunidade, seguimento obrigatório ou adaptação por risco individual.
- Confirmar tempo desde exposição e se ainda há benefício clínico esperado.
- Checar idade, peso, gestação/lactação, função renal/hepática, interações e alergias.
- Garantir primeira dose quando indicada e plano de seguimento documentado.
- Orientar sinais de alarme e retorno programado.

17.7

Influenza — Profilaxia Pós-exposição em Alto Risco

MODERADA AMBULATORIAL TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Profilaxia antiviral pode ser considerada após exposição próxima em pessoas de alto risco para complicações, surtos institucionais ou quando vacinação é ausente/recente e risco é elevado. Se já houver sintomas, não é profilaxia: avaliar tratamento antiviral.

CONDUTA DE PARTIDA

Oseltamivir

75 mg VO 24/24 h em adultos

VIA

VO

DURAÇÃO

7 dias após última exposição

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus influenza A/B	ALVO DA PROFILAXIA	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Exposição de alto risco com indicação de profilaxia	Oseltamivir · 75 mg VO 24/24 h · VO	7 dias após última exposição	Em instituição/surto, duração pode mudar conforme controle do surto, última exposição e orientação da CCIH/vigilância.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Contato já sintomático	Oseltamivir tratamento · 75 mg VO 12/12 h · VO	5 dias	Sintomático não é profilaxia: tratar se indicado.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Profilaxia não é para todos

Reservar para alto risco, surtos ou orientação epidemiológica; vacinação segue central.

INFORMAÇÃO

Ajuste renal

Oseltamivir exige ajuste em DRC.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Exposição a influenza	Avaliar risco individual, vacinação, tempo da exposição e existência de surto.
2	Profilaxia indicada	Prescrever oseltamivir profilático e orientar início de tratamento se sintomas.
3	Sintomas surgem	Trocar para dose terapêutica se ainda indicado.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	- Idoso frágil - Gestante/puerpério - Imunossuprimido - Doença cardiopulmonar importante - Instituição de longa permanência - Surto hospitalar

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Teste de influenza conforme disponibilidade, surto e impacto na conduta.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Oseltamivir vo	75 mg VO 24/24 h para profilaxia em adulto GRAVE Tratamento: 75 mg VO 12/12 h	<50 mL/min: Ajustar conforme fármaco, função renal e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia com janela de oportunidade, seguimento obrigatório ou adaptação por risco individual.
- Confirmar tempo desde exposição e se ainda há benefício clínico esperado.

- Checar idade, peso, gestação/lactação, função renal/hepática, interações e alergias.
- Garantir primeira dose quando indicada e plano de seguimento documentado.
- Orientar sinais de alarme e retorno programado.

17.8

Acidente Biológico Ocupacional — Sangue/Material Perfurocortante

GRAVE AMBULATORIAL TODOS

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Abordagem integrada de exposição ocupacional a sangue ou fluidos potencialmente infectantes, incluindo HIV, HBV e HCV. O PS deve documentar o acidente, classificar risco, iniciar profilaxia quando indicada e garantir seguimento ocupacional/laboratorial.

CONDUTA DE PARTIDA

Avaliação integrada HIV/HBV/HCV; PEP HIV com TDF/3TC + DTG quando indicada

TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + DTG 50 mg VO 24/24 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

28 dias; iniciar o mais rápido possível e no máximo até 72 h

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
HIV	RISCO DEPENDENTE DA EXPOSIÇÃO	
HBV	PREVENÍVEL POR VACINA/HBIG	
HCV	SEM PEP ANTIVIRAL PADRONIZADA; EXIGE SEGUIMENTO	

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Exposição ocupacional com indicação de PEP HIV — Brasil/SUS	TDF/3TC + Dolutegravir · TDF/3TC 300/300 mg VO 24/24 h + DTG 50 mg VO 24/24 h · VO	28 dias	Iniciar imediatamente se indicada; coletar exames sem atrasar.
Risco HBV conforme status vacinal/sorologia	Vacina hepatite B ± HBIG · HBIG 0,06 mL/kg IM quando indicada + vacina · IM	Conforme calendário	Checar anti-HBs e HBsAg da fonte.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco HCV	Sem PEP antiviral de rotina · Conduta: seguimento laboratorial conforme protocolo; tratar se infecção confirmada · Conduta	Conforme protocolo	Fazer sorologia/PCR conforme protocolo e tratar infecção se confirmada.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO
PADRÃO BRASIL/SUS

Esquema preferencial: TDF/3TC 300/300 mg 1x/dia + DTG 50 mg 1x/dia por 28 dias. Não aguardar exames se isso atrasar a primeira dose; verificar contraindicação ao TDF e interações do DTG.

ALERTA CRÍTICO
Registrar e iniciar rápido

Não perder janela de PEP HIV; documentar tipo de material, profundidade, fonte e tempo.

ATENÇÃO
HCV é seguimento, não PEP

Não há profilaxia antiviral rotineira pós-exposição para HCV; acompanhamento é essencial.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Acidente	Lavar local, não espremer agressivamente, registrar hora e mecanismo.
2	Risco HIV/HBV/HCV	Coletar sorologias da fonte/exposto e iniciar PEP/profilaxia HBV quando indicada.
3	Alta	Garantir retorno, notificação ocupacional e seguimento laboratorial.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Agulha oca ▪ Sangue visível ▪ Lesão profunda ▪ Fonte HIV/HBV/HCV positiva ou desconhecida de alto risco ▪ Mucosa/pele não íntegra

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	HIV, HBV, HCV da fonte e exposto; função renal/hepática se PEP; gravidez quando aplicável. Programar seguimento sorológico conforme protocolo institucional.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
TDF/3TC + Dolutegravir VO	TDF/3TC 300/300 mg + DTG 50 mg VO 1x/dia por 28 dias GRAVE Não atrasar primeira dose	<50 mL/min: Ajustar conforme fármaco, função renal e protocolo local	
HBIG + vacina hepatite B IM	Conforme status vacinal/sorológico GRAVE Não se aplica	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia dependente de protocolo oficial, vigilância epidemiológica, CCIH/saúde ocupacional ou padronização institucional.
- Confirmar protocolo local vigente antes da alta ou prescrição definitiva.
- Registrar tempo da exposição, tipo de exposição, status vacinal/sorológico e conduta orientada.
- Acionar vigilância epidemiológica, CCIH, saúde ocupacional ou equipe cirúrgica quando aplicável.
- Garantir retorno, doses subsequentes e documentação para rastreabilidade.

REFERÊNCIA DO QUADRO

Ministério da Saúde. PCDT para Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, versão vigente.
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/p/profilaxia-pos-exposicao-de-risco-pep-a-infeccao-pelo-hiv>

17.9

Asplenia/Hipoesplenia — Febre e Profilaxia

GRAVE HOSPITALAR TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Paciente asplênico ou hipoesplênico tem risco de sepse fulminante por encapsulados. Febre deve ser tratada como potencial emergência, com antibiótico precoce, avaliação hospitalar e revisão de vacinação/plano de ação.

CONDUTA DE PARTIDA

Ceftriaxona
2 g EV 24/24 h em adulto febril

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme foco/culturas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Streptococcus pneumoniae	PRINCIPAL RISCO	
Neisseria meningitidis	IMPORTANTE	
Haemophilus influenzae	IMPORTANTE	
Capnocytophaga canimorsus	MORDEDURA CÃO/ GATO	Risco aumentado em asplenia

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Asplênico febril sem foco claro ou com toxemia	Ceftriaxona · 2 g EV 24/24 h · EV	Conforme foco/culturas	Não atrasar em paciente tóxico; coletar culturas se possível antes, sem atrasar.
Asplênico com mordedura de cão/gato	Amoxicilina-clavulanato · 875/125 mg VO 12/12 h ou esquema EV se grave · VO/EV	3–5 dias profilaxia ou 7–14 se infecção	Cobrir Capnocytophaga e anaeróbios; limiar baixo para internação se febre.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Levofloxacino ± metronidazol · Levofloxacino 750 mg EV/VO 24/24 h ± Metronidazol 500 mg 8/8 h · VO/EV	Individualizar	Discutir com infectologia; cenário de alto risco.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Febre em asplenia é emergência
Pode evoluir para sepse fulminante; antibiótico deve ser precoce.

ATENÇÃO

Vacinas e plano de ação
Alta deve reforçar vacinação pneumococo/meningococo/Hib/influenza e orientação de procurar PS rapidamente em febre.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Asplênico febril	Avaliar sepse, colher culturas e iniciar ceftriaxona precocemente.
2	Mordedura/ferida	Cobrir Capnocytophaga/anaeróbios e avaliar raiva/tétano.
3	Alta/seguimento	Checar vacinação, educação e plano de emergência.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Febre ▪ Toxemia ▪ Hipotensão ▪ Mordedura com sinais sistêmicos ▪ Imunossupressão associada
UTI	▪ Choque ▪ Lactato elevado ▪ Disfunção orgânica
Gravidade	▪ Asplenia anatômica/funcional ▪ Febre sem foco ▪ Mordedura ▪ Vacinação incompleta

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas antes do antibiótico se não atrasar; culturas conforme foco.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	2 g EV 24/24 h em adulto febril GRAVE 2 g EV 24/24 h; associar conforme foco/sepse	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	
Amoxicilina-clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Usar EV se grave	<50 mL/min: Ajustar conforme fármaco, função renal e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia com janela de oportunidade, seguimento obrigatório ou adaptação por risco individual.
- Confirmar tempo desde exposição e se ainda há benefício clínico esperado.
- Checar idade, peso, gestação/lactação, função renal/hepática, interações e alergias.
- Garantir primeira dose quando indicada e plano de seguimento documentado.
- Orientar sinais de alarme e retorno programado.

17.10

Profilaxia Antibiótica Cirúrgica — Princípios Básicos

MODERADA HOSPITALAR TODOS

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Princípios gerais de profilaxia cirúrgica: antibiótico correto, dose no tempo adequado antes da incisão, ajuste por peso, redose se cirurgia prolongada/perda sanguínea e suspensão precoce. Não substitui técnica cirúrgica e controle de foco.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefazolina

2 g EV até 60 min antes da incisão; 3 g se peso elevado conforme protocolo

VIA

EV

DURAÇÃO

Dose única ou até 24 h conforme procedimento

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus/MSSA	ALVO COMUM EM CIRURGIA LIMPA	
Estreptococos	COMUM	
Gram-negativos/anaeróbios	DEPENDEM DO SÍTIO	Abdominal/colônica exige cobertura específica

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cirurgia limpa/ortopédica/ cardiovascular sem indicação de cobertura anaeróbia	Cefazolina · 2 g EV até 60 min antes da incisão · EV	Dose única; redose intra-operatória se indicado	Redose se cirurgia longa ou grande perda sanguínea; ajustar por peso conforme protocolo.
Cirurgia colorretal/intra-abdominal com anaeróbios	Cefazolina + Metronidazol · Cefazolina 2 g EV + Metronidazol 500 mg EV · EV	Dose pré-incisão; redose conforme protocolo	Pode variar conforme protocolo institucional.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alergia grave a betalactâmico	Clindamicina ou Vancomicina ± cobertura Gram-negativa conforme sítio · Clindamicina 900 mg EV ou Vancomicina 15 mg/kg EV · EV	Dose pré-incisão; redose conforme protocolo	Escolha depende de sítio cirúrgico, MRSA e protocolo local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Colonização por MRSA ▪ Alta prevalência institucional ▪ Prótese/dispositivo em paciente de risco	Adicionar/usar vancomicina conforme protocolo
ANAEROBIOS	▪ Cirurgia colorretal ▪ Perfuração/contaminação abdominal ▪ Sítio com flora anaeróbia	Metronidazol associado ou esquema com anaeróbio

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO**Tempo importa**

Dose deve estar em nível tecidual adequado no momento da incisão.

ATENÇÃO**Não prolongar sem indicação**

Profilaxia prolongada aumenta *C. difficile* e resistência; geralmente suspender em até 24 h quando profilaxia pura.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Procedimento programado/urgente	Definir sítio, flora esperada, alergias, MRSA, peso e função renal.
2	Antes da incisão	Administrar dose no tempo correto e registrar horário.
3	Cirurgia prolongada	Redosar conforme meia-vida, duração e sangramento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Prótese/material implantável ▪ Cirurgia contaminada ▪ Colonização por MRSA ▪ Alergia complexa ▪ Insuficiência renal

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Profilaxia não exige cultura; se já há infecção estabelecida, tratar como terapia, não profilaxia.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefazolina EV	2 g EV pré-incisão; 3 g conforme peso/ protocolo GRAVE Redose intraoperatória conforme duração/perda sanguínea	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	
Metronidazol EV	500 mg EV quando anaeróbios necessários GRAVE Redose conforme protocolo	Geral: Sem ajuste renal usual; checar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Profilaxia dependente de protocolo oficial, vigilância epidemiológica, CCIH/saúde ocupacional ou padronização institucional.
- Confirmar protocolo local vigente antes da alta ou prescrição definitiva.
- Registrar tempo da exposição, tipo de exposição, status vacinal/sorológico e conduta orientada.
- Acionar vigilância epidemiológica, CCIH, saúde ocupacional ou equipe cirúrgica quando aplicável.
- Garantir retorno, doses subsequentes e documentação para rastreabilidade.

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 17 — PROFILAXIAS/EXPOSIÇÕES

- CDC. HIV Post-exposure Prophylaxis, versão vigente.
- CDC. Viral Hepatitis — HBV Post-exposure Prophylaxis.
- CDC. Rabies — Post-exposure Prophylaxis.
- CDC. Tetanus — Wound Management.
- CDC. Meningococcal Disease — chemoprophylaxis, MMWR 2024.
- CDC. Pertussis — Postexposure Antimicrobial Prophylaxis.
- CDC. Influenza Antiviral Medications — Summary for Clinicians.
- Ministério da Saúde. PCDT de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, versão vigente.
- Ministério da Saúde. Fluxograma da Profilaxia da Raiva Humana e Nota Técnica Conjunta nº 35/2026.

18

Hospitalares

12 quadros clínicos neste sistema

18.1	Febre Hospitalar Sem Foco Definido — Adulto Internado	356
18.2	PAV / Pneumonia Hospitalar com Risco de MDR	359
18.3	Bacteremia Hospitalar / Hemocultura Positiva Sem Foco Claro	361
18.4	Infecção de Cateter de Hemodiálise / Acesso Dialítico	364
18.5	ITU Hospitalar / CAUTI com Risco de MDR	366
18.6	Infecção Intra-abdominal Hospitalar / Peritonite Terciária	369
18.7	Enterobacterales ESBL — Suspeita ou Confirmação	371
18.8	Enterobacterales Resistentes a Carbapenêmicos — Tratamento por Carbapenemase	374
18.9	Pseudomonas MDR/DTR — Suspeita ou Confirmação	377
18.10	Enterococcus / VRE — Infecção Hospitalar Relevante	380
18.11	Stenotrophomonas maltophilia — Infecção Hospitalar	382
18.12	Acinetobacter baumannii Resistente a Carbapenêmico — CRAB	384

18.1

Febre Hospitalar Sem Foco Definido — Adulto Internado

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Abordagem síndrome da febre nova em paciente internado, com ênfase em não prescrever antibiótico automaticamente quando estável, investigar foco, revisar dispositivos e reconhecer rapidamente sepse/choque.

CONDUTA DE PARTIDA

Sem antibiótico automático se estável; cobertura ampla apenas se sepse, choque, imunossupressão ou foco grave provável

Investigar primeiro se estável; se instável, iniciar betalactâmico antipseudomonal ± anti-MRSA conforme risco local

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Reavaliar em 24–48 h; duração conforme foco identificado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Bacteremia relacionada a cateter	FREQUENTE EM INTERNADOS COM CVC	Considerar especialmente com calafrios, instabilidade ou febre durante manipulação do cateter
Pneumonia hospitalar	CONTEXTUAL	Considerar se novo infiltrado, piora de oxigenação ou secreção purulenta
ITU associada a dispositivo	CONTEXTUAL	Piúria/bacteriúria isolada em sondado não define infecção
Causas não infecciosas	COMUNS	Trombose, TEP, febre medicamentosa, transfusão, pancreatite, atelectasia não explicam tudo, mas devem ser lembradas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Paciente estável, sem sepse, sem neutropenia e sem foco claro	Observação ativa + investigação · Conduta: não iniciar antibiótico empírico automaticamente; procurar foco e reavaliar · Conduta	Reavaliação seriada	Colher culturas se indicado, retirar dispositivos desnecessários e procurar foco antes de ampliar antibiótico.
Sepse/choque, imunossupressão ou forte suspeita de infecção grave	Vancomicina + Cefepime ou Piperacilina-tazobactam · Vancomicina dose de carga + Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h · EV	Até definição do foco; descalonar em 48–72 h	Escolher conforme epidemiologia local, colonização prévia e foco provável.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque séptico, colonização ESBL/CRE ou uso recente de amplo espectro	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h + Vancomicina se risco de MRSA/CVC/pele · EV	Reavaliar em 24–48 h	Evitar manter carbapenêmico sem evidência de Gram-negativo resistente.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▫ CVC ▫ hemodíalise ▫ colonização MRSA ▫ infecção de pele/ferida ▫ choque séptico	Vancomicina ou linezolida conforme foco
PSEUDOMONAS	▫ Internação prolongada ▫ UTI ▫ antibiótico recente ▫ ventilação mecânica ▫ colonização prévia	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem
ESBL	▫ Colonização ESBL ▫ uso recente de cefalosporina/carbapenêmico ▫ infecção urinária/intra-abdominal prévia por ESBL	Meropenem se grave/invasiva

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Não tratar febre isolada automaticamente

Em paciente estável, antibiótico sem foco aumenta resistência, *C. difficile* e eventos adversos.

ALERTA CRÍTICO

Sepse muda a lógica

Se houver hipoperfusão, hipotensão, lactato elevado ou disfunção orgânica, iniciar antibiótico empírico amplo rapidamente.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre nova	Confirmar sinais vitais, SOFA/qSOFA quando útil, revisar dispositivos, antibióticos prévios e foco provável.
2	Estável	Investigar antes de tratar: hemoculturas conforme contexto, urina se sintomas/dispositivo, imagem se foco respiratório/abdominal.
3	Instável	Colher culturas sem atrasar antibiótico, iniciar cobertura ampla e reavaliar para descalonamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Já internado; avaliar necessidade de transferência de unidade conforme instabilidade
UTI	▫ Choque ▫ hipoxemia grave ▫ lactato elevado ▫ necessidade de vasopressor ▫ rebaixamento
Gravidade	▫ Sepse/choque ▫ neutropenia ▫ transplante ▫ CVC ▫ ventilação mecânica
Falha terapêutica	▫ Persistência febril com piora clínica ▫ culturas positivas sem ajuste ▫ foco não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas periféricas e de cateter quando houver CVC/suspeita de bacteremia; culturas guiadas por foco. Evitar urocultura sem sintomas ou indicação clínica em sondado assintomático.
Controle de foco	▪ Confirmar sinais vitais, SOFA/qSOFA quando útil, revisar dispositivos, antibióticos prévios e foco provável. ▪ Investigar antes de tratar: hemoculturas conforme contexto, urina se sintomas/dispositivo, imagem se foco respiratório/abdominal.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Suspende antibiótico se infecção bacteriana não se confirmar e paciente estiver estável ▪ Retirar anti-MRSA se não houver evidência de MRSA/CVC/pele ou cultura compatível ▪ Reduzir espectro em 48–72 h conforme culturas e evolução
Transição EV → VO	Trocar para VO apenas após foco definido, estabilidade e opção oral adequada

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Conduta hospitalar que deve ser adaptada ao perfil microbiológico local, gravidade, culturas disponíveis, dispositivos e protocolos assistenciais.
- Revisar microbiologia local e colonização prévia
- Colher culturas adequadas antes do antibiótico quando não atrasar tratamento
- Retirar ou trocar dispositivos desnecessários quando aplicável
- Reavaliar em 24–72 h para descalonar ou suspender se infecção não se confirmar

18.2

PAV / Pneumonia Hospitalar com Risco de MDR

GRAVE UTI ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

HAP/VAP deve combinar gravidade, risco de MDR, qualidade da amostra respiratória e antibiograma local. O objetivo é cobrir adequadamente no início quando grave, mas descalonar assim que culturas e evolução permitirem.

CONDUTA DE PARTIDA

Betalactâmico antipseudomonal ± anti-MRSA conforme risco validado e microbiologia local
Cefepime 2 g EV 8/8 h ou piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; acrescentar vancomicina/linezolida apenas se risco de MRSA

VIA

EV

DURAÇÃO

7 dias se boa resposta clínica e sem complicação/foco não controlado

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa	IMPORTANTE EM UTI/VAP	Risco aumenta com ventilação, antibiótico recente e colonização
Enterobacterales	FREQUENTE	Inclui ESBL conforme epidemiologia
Staphylococcus aureus MRSA	RISCO ESPECÍFICO	Cobrir se risco clínico/local
Acinetobacter baumannii	DEPENDENTE DA UTI	Suspeitar conforme surto/colonização

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
HAP/VAP sem choque e sem alto risco de MDR	Cefepime ou Piperacilina-tazobactam · Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h · EV	7 dias	Ajustar ao antibiograma local e cultura respiratória.
Risco de MRSA	Vancomicina ou Linezolida + betalactâmico antipseudomonas · Vancomicina conforme AUC/nível OU Linezolida 600 mg EV/VO 12/12 h + betalactâmico antipseudomonas conforme cenário · VO/EV	7 dias	Descontinuar anti-MRSA se culturas negativas e baixa probabilidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque, ESBL prévio ou alto risco de Gram-negativo resistente	Meropenem ± Vancomicina/Linezolida · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida · EV	7 dias se resposta	Avaliar dupla cobertura antipseudomonas se choque e alta resistência local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▫ VAP ▫ UTI ▫ antibiótico EV nos últimos 90 dias ▫ colonização prévia ▫ alta prevalência local	Cefepime, piperacilina-tazobactam, meropenem ou outro conforme sensibilidade
MRSA	▫ Colonização MRSA ▫ alta prevalência local ▫ antibiótico EV recente ▫ choque ▫ pneumonia necrosante	Vancomicina ou linezolida
ESBL	▫ ESBL prévio ▫ uso recente de cefalosporina/carbapenêmico ▫ choque séptico	Meropenem se grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

DUPLA COBERTURA ANTIBACTERIANA NÃO É AUTOMÁTICA

Usar dois antipseudomonas apenas diante de alto risco de mortalidade, resistência local relevante ou exposição/colonização que justifique; descalonar com microbiologia.

ALERTA CRÍTICO

Usar antibiograma local

Em HAP/VAP, a escolha empírica deve refletir a microbiologia da unidade.

ATENÇÃO

Reavaliar em 48–72 h

Descalonamento é parte do tratamento, não etapa opcional.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de HAP/VAP	Confirmar novo infiltrado + sinais clínicos; colher cultura respiratória antes do antibiótico se não atrasar.
2	Escolha empírica	Cobrir Pseudomonas e MRSA conforme critérios e epidemiologia local.
3	48-72 h	Descalonar, ajustar dose, avaliar resposta e complicações.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▫ Ventilação mecânica ▫ choque ▫ hipoxemia grave ▫ necessidade de vasopressor
Gravidade	▫ Choque ▫ SDRA ▫ bacteremia ▫ MDR prévio
Falha terapêutica	▫ Piora de oxigenação ▫ febre/leucocitose persistente ▫ cultura com resistência ▫ complicação pleural

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Amostra respiratória preferencialmente antes do antibiótico, hemoculturas se grave/sepse, revisar culturas prévias e colonização de UTI.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	- Reavaliar diariamente - Suspender anti-MRSA se cultura/risco não sustentarem - Reduzir dupla antipseudomonal assim que houver antibiograma ou estabilidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Linezolida VO/EV	600 mg EV/VO 12/12 h GRAVE 600 mg EV/VO 12/12 h	Geral: Sem ajuste renal usual; revisar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.3

Bacteremia Hospitalar / Hemocultura Positiva Sem Foco Claro

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Hemocultura positiva em internado exige diferenciar contaminação de bacteremia verdadeira, localizar foco, avaliar dispositivos e repetir culturas quando agente de alto risco ou persistência clínica.

CONDUTA DE PARTIDA

Conduta por Gram, estabilidade, provável foco e possibilidade de contaminação

Vancomicina conforme peso/nível + Cefepime 2 g EV 8/8 h

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Depende do agente/foco; reavaliar com culturas

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	CLINICAMENTE RELEVANTE QUANDO CONFIRMADO	Nunca considerar automaticamente contaminante
Estafilococos coagulase-negativos	FREQUENTE	Pode ser contaminante ou real se CVC/prótese/dispositivo

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales/Pseudomonas	IMPORTANTE EM HOSPITAL	Foco urinário, abdominal, respiratório ou cateter
Candida spp.	EM UTI/DISPOSITIVOS	Suspeitar com nutrição parenteral, cirurgia abdominal, CVC, antibiótico amplo

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Paciente instável ou bacteremia provável sem foco definido	Vancomicina + Cefepime · Vancomicina dose de carga se grave + Cefepime 2 g EV 8/8 h · EV	Até identificação; depois direcionar	Cobrir MRSA e Gram-negativos hospitalares enquanto investiga foco.
Alto risco de candidemia/choque em UTI	Equinocandina + antibacteriano conforme cenário · Miconazole 100 mg EV 24/24 h ou equivalente · EV	Conforme candidemia se confirmada	Remover/trocar CVC quando possível se candidemia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESBL/CRE prévio, choque ou Gram-negativo resistente provável	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h + Vancomicina se risco de Gram-positivo · EV	Direcionar por cultura	Se CRE suspeito/confirmado, usar droga ativa conforme sensibilidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ S. aureus em hemocultura ▪ CVC ▪ hemodiálise ▪ prótese/dispositivo ▪ choque	Vancomicina; daptomicina se não pulmonar e sensível/adequado
PSEUDOMONAS	▪ UTI ▪ neutropenia ▪ cateter ▪ antibiótico recente ▪ colonização	Cefepime, piper-tazo ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ bacteremia urinária/abdominal grave ▪ uso recente de cefalosporina	Meropenem se invasiva/grave

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO**HEMOCULTURA POSITIVA NÃO TEM ESQUEMA UNIVERSAL**

Vancomicina + cefepime pode ser apropriada no paciente instável, mas não deve ser resposta automática a todo resultado. S. aureus, Candida e Gram-negativos verdadeiros exigem ação; contaminantes prováveis exigem correlação e repetição quando indicada.

ALERTA CRÍTICO**S. aureus em sangue é sempre sério**

Exige repetição de hemoculturas, busca de foco e avaliação para endocardite conforme contexto.

ATENÇÃO**Distinuir contaminante de bacteremia real**

Número de frascos, tempo para positivar, agente e contexto clínico mudam conduta.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Hemocultura positiva	Identificar agente, número de frascos, tempo de positividade e sinais clínicos.
2	Bacteremia provável	Repetir hemoculturas, avaliar cateter/dispositivos e iniciar/ajustar terapia.
3	Agente identificado	Direcionar antibiótico, definir duração e pesquisar foco/endocardite se indicado.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▫ Choque ▫ lactato elevado ▫ necessidade de vasopressor ▫ candidemia com instabilidade
Gravidade	▫ S. aureus ▫ Candida ▫ Gram-negativo MDR ▫ prótese/dispositivo ▫ persistência de hemocultura positiva
Falha terapêutica	▫ Hemocultura persistente positiva ▫ foco não removido ▫ endocardite/abscesso não identificado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Duas amostras periféricas quando possível; culturas de cateter se suspeita; repetir hemoculturas em S. aureus, Candida, Gram-negativo persistente, endocardite ou instabilidade.
Controle de foco	Repetir hemoculturas, avaliar cateter/dispositivos e iniciar/ajustar terapia.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▫ Diferenciar contaminante de patógeno verdadeiro ▫ Direcionar por Gram/cultura/sensibilidade ▫ Remover foco/dispositivo quando indicado ▫ Definir duração conforme agente, foco e clareamento microbiológico

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme AUC/nível GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se choque	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100–150 mg EV 24/24 h conforme cenário	Geral: Sem ajuste renal usual; revisar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação

- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.4

Infecção de Cateter de Hemodiálise / Acesso Dialítico

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Suspeita de bacteremia relacionada a cateter de hemodiálise, com alto risco de *S. aureus*, Gram-negativos e complicações. O manejo depende de culturas, estabilidade e decisão de retirada/troca do acesso.

CONDUTA DE PARTIDA

Vancomicina + cefepime/ceftazidima ajustados à diálise, conforme protocolo local

Vancomicina pós-diálise conforme nível + Cefazidima 1–2 g pós-diálise ou Cefepime ajustado

VIA

EV

DURAÇÃO

Específica por patógeno, clareamento de hemoculturas, retirada/salvamento do acesso e complicações; não usar 2–6 semanas como faixa genérica

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus/MRSA	MUITO RELEVANTE	Maior risco de endocardite e complicações metastáticas
Estafilococos coagulase-negativos	FREQUENTE	Pode estar ligado ao cateter
Gram-negativos	RISCO ESPECÍFICO	Inclui Pseudomonas conforme unidade
Candida spp.	MENOS COMUM, GRAVE	Geralmente exige retirada do cateter

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Suspeita de bacteremia relacionada a cateter de hemodiálise	Vancomicina + Cefazidima ou Cefepime · Vancomicina conforme nível/pós-diálise + Cefazidima 1–2 g pós-diálise OU Cefepime ajustado · EV	Direcionar por cultura	Coletar hemoculturas periféricas e do cateter antes se possível.
Choque, túnel infectado, pus no sítio ou complicação	Vancomicina + Meropenem · Vancomicina + Meropenem ajustado à diálise · EV	Conforme agente e retirada do cateter	Remoção do cateter é fortemente considerada em <i>S. aureus</i> , Candida, túnel/ bolsa ou instabilidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
VRE conhecido/suspeito ou alergia/intolerância relevante	Daptomicina ou Linezolida + Gram-negativo ativo · Daptomicina 8–10 mg/kg EV conforme intervalo/diálise OU Linezolida 600 mg 12/12 h · EV	Conforme agente	Daptomicina não serve para pneumonia; monitorar CPK.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Hemodiálise ▪ cateter tunelizado ▪ sítio purulento ▪ colonização MRSA	Vancomicina; daptomicina se adequado
PSEUDOMONAS	▪ Choque ▪ UTI ▪ Gram-negativo prévio ▪ alta resistência local	Cefepime, ceftazidima, piper-tazo ou meropenem ajustados

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

S. aureus/Candida geralmente não permite complacência

Pesquisar endocardite, focos metastáticos e necessidade de retirar cateter.

ATENÇÃO

Dose pós-diálise

Ajuste deve considerar modalidade, residual renal e nível sérico quando aplicável.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Colher hemoculturas periféricas e do cateter; examinar túnel, orifício e acesso.
2	Iniciar terapia	Cobrir MRSA e Gram-negativos; ajustar à diálise.
3	Cultura positiva	Decidir retirada/troca/salvamento, lock antibiótico quando aplicável e investigar complicações.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ hipercalemia/complicação dialítica associada ▪ sepse grave
Gravidade	▪ S. aureus ▪ Candida ▪ túnel infectado ▪ bacteremia persistente ▪ prótese/dispositivo
Falha terapêutica	▪ Febre persistente ▪ hemocultura positiva após 48–72 h ▪ dor lombar/óssea ▪ sopro novo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas periféricas e do cateter/linhas quando possível; cultura de ponta se removido; repetir culturas se S. aureus, Candida, persistência ou instabilidade.
Controle de foco	Decidir retirada/troca/salvamento, lock antibiótico quando aplicável e investigar complicações.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Direcionar por cultura ▪ Considerar remoção obrigatória em S. aureus, Candida, Pseudomonas, túnel infectado, sepse grave ou bacteremia persistente ▪ Ajustar dose pós-diálise conforme protocolo

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina em hemodiálise EV	Dose de carga 20–25 mg/kg; manutenção pós-diálise conforme nível/protocolo GRAVE Dose de ataque se grave, alvo por AUC/nível	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Ceftazidima/Cefepime EV	Dose pós-diálise conforme protocolo GRAVE Ajustar gravidade e sensibilidade	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.5

ITU Hospitalar / CAUTI com Risco de MDR

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

ITU hospitalar/infecção urinária associada a cateter (CAUTI) com risco de MDR deve evitar tratamento de bacteriúria isolada, priorizar troca/remoção de sonda, cultura adequada e escolha empírica conforme risco real de ESBL/Enterobacterales resistentes a carbapenêmicos (CRE)/Pseudomonas.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefepime/piperacilina-tazobactam ou meropenem conforme gravidade e risco de ESBL; agente para CRE apenas se suspeita forte/confirmada

Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h

VIA

EV

DURAÇÃO

7 dias se resposta rápida; 10–14 dias se resposta lenta/ bacteremia

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
E. coli/Klebsiella/Enterobacter	FREQUENTES	ESBL/AmpC conforme histórico
Pseudomonas aeruginosa	RISCO HOSPITALAR	Sonda, urologia, antibiótico prévio
Enterococcus spp.	CONTEXTUAL	Mais relevante em manipulação urológica, cateter e cultura dirigida
Candida spp.	COLONIZAÇÃO COMUM	Candidúria isolada raramente exige tratamento

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CAUTI/ITU hospitalar sem choque, empírico antes do antibiograma	Cefepime ou Piperacilina-tazobactam · Cefepime 2 g EV 8/8 h OU Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h em infusão estendida de 4 h · EV	7 dias se resposta rápida	Esquema empírico. Se o antibiograma revelar ESBL, ver o quadro específico: cefepime deve ser evitado e pip-tazo não serve fora do trato urinário. Trocar ou remover a sonda antes da urocultura sempre que possível.
ESBL prévio, choque ou falha a cefalosporina	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; 2 g 8/8 h se grave/ sepsse conforme protocolo · EV	7–14 dias	Descalonar para VO se sensível e paciente estável.

Sobre a duração: Quando o foco for controlado (remoção da sonda) e não houver mais estase nem material implantado, é razoável tratar como cistite não complicada, CONTANDO O DIA 1 A PARTIR DO CONTROLE DE FONTE.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CRE/KPC confirmado ou fortemente suspeito	Ceftazidima-avibactam ou outro agente ativo · 2,5 g EV 8/8 h, ajustar renal; confirmar sensibilidade · EV	7–14 dias	Preferir orientação da CCIH/infectologia; evitar polimixina se há opção betalactâmica ativa.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Sonda prolongada ▪ urologia ▪ UTI ▪ Pseudomonas prévia	Cefepime, piper-tazo, meropenem ou agente conforme cultura
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ uso recente de cefalosporina/quinolona ▪ internação prolongada	Meropenem se grave; opção oral se sensível e estável

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DISPOSITIVO E CONTROLE DE FOCO

Retirar ou trocar o cateter quando indicado e colher cultura de urina de amostra adequada; duração de 7 dias costuma bastar na resposta rápida, prolongando apenas por resposta lenta, foco não controlado ou complicação.

INFORMAÇÃO

O QUE CONTA COMO ITU COMPLICADA

ITU complicada é a que ocorre associada a anormalidade estrutural ou funcional do trato geniturinário, ou qualquer ITU em adolescente ou adulto do sexo masculino. Em geral, tratar com os mesmos agentes e pelas mesmas durações da pielonefrite. Quando o foco é controlado — por exemplo, remoção da sonda — e não há mais estase urinária nem material implantado, é razoável usar agentes e duração de cistite não complicada, contando o dia 1 a partir do dia do controle de fonte.

ATENÇÃO

ANTIBIÓTICO EMPÍRICO INATIVO MUDA A CONTAGEM

Se o antibiograma mostrar que o esquema empírico era inativo, trocar para agente ativo e contar o curso completo a partir do início da terapia ativa. Exceção: em cistite não complicada com melhora clínica, não é necessário repetir urocultura, trocar o esquema nem estender o curso.

ATENÇÃO

Não tratar bacteriúria assintomática em sondado

Febre sem foco não basta para culpar urina sem avaliação clínica.

INFORMAÇÃO

Trocar a sonda

Em CAUTI, trocar/remover cateter melhora cultura e controle de foco.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de CAUTI	Avaliar sintomas/sinais sistêmicos; trocar/remover sonda se possível antes da coleta.
2	Terapia empírica	Cobrir conforme risco de Pseudomonas/ESBL e gravidade.
3	Cultura disponível	Descalonar e considerar transição VO se sensível/estável.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Seps ▫ obstrução ▫ pielonefrite ▫ bacteremia ▫ MDR sem opção oral
UTI	▫ Choque ▫ lactato elevado ▫ vasopressor
Gravidade	▫ Obstrução ▫ bacteremia ▫ imunossupressão ▫ CRE/KPC
Falha terapêutica	▫ Febre persistente 48–72 h ▫ obstrução/abscesso ▫ cultura resistente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urocultura após troca de sonda quando possível; hemoculturas se seps, pielonefrite grave ou bacteremia provável.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▫ Não tratar bacteriúria/piúria isolada em sondado sem quadro clínico ▫ Descalonar conforme urocultura ▫ Trocar para VO apenas se estabilidade e sensibilidade confirmada

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Cefepime EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, infusão estendida se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h se grave, conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação

- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.6

Infecção Intra-abdominal Hospitalar / Peritonite Terciária

GRAVE UTI ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Infecção intra-abdominal hospitalar/pós-operatória exige controle de fonte. Antibiótico sem drenagem, revisão cirúrgica ou controle de anastomose costuma falhar.

CONDUTA DE PARTIDA

Meropenem ou betalactâmico amplo conforme risco local; considerar antifúngico apenas em alto risco ou Candida significativa

Meropenem 1–2 g EV 8/8 h; associar conforme risco de MRSA/Enterococcus/Candida

VIA

EV

DURAÇÃO

4–7 dias após controle adequado de fonte; prolongar apenas se fonte não controlada, bacteremia ou complicação

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales ESBL/AmpC	COMUM EM HOSPITALAR	Especialmente antibiótico prévio e pós-operatório
Enterococcus spp.	RELEVANTE EM HOSPITALAR	Considerar em pós-operatório, transplante, valvopatia, choque
Anaeróbios	FREQUENTES	Cobertura obrigatória em foco colônico/perfuração
Candida spp.	RISCO EM UTI/ CIRURGIA	Considerar em perfuração alta, TPN, choque, culturas positivas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção intra-abdominal hospitalar grave/pós-operatória	Meropenem · 1–2 g EV 8/8 h · EV	4–7 dias após controle de fonte	Controle de fonte é decisivo: drenagem, cirurgia ou revisão de anastomose.
Choque, TPN, cirurgia abdominal recente ou Candida em cultura	Meropenem + Equinocandina · Meropenem + Micafungina 100 mg EV 24/24 h ou equivalente · EV	Conforme controle e cultura	Reavaliar antifúngico conforme culturas e evolução.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Enterococcus/MRSA relevante ou pós-operatório de alto risco	Adicionar Vancomicina · Vancomicina conforme peso/nível · EV	Conforme cultura/foco	Não usar vancomicina de rotina em toda infecção comunitária; aqui o contexto é hospitalar.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Perfuração intestinal ▪ foco colônico ▪ abscesso ▪ peritonite	Meropenem ou piper-tazo; se cefepime, associar metronidazol
ESBL	▪ Hospitalar ▪ antibiótico recente ▪ ESBL prévio ▪ choque	Meropenem
MRSA	▪ MRSA prévio ▪ ferida operatória/pele ▪ cateter ▪ choque com risco	Vancomicina

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Sem controle de fonte, antibiótico falha

Abscesso, deiscência, necrose ou perfuração exigem drenagem/cirurgia.

ATENÇÃO

Duração depende do controle

Após controle adequado, cursos curtos costumam bastar; sem controle, febre persistente não se resolve com troca aleatória.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita	Avaliar TC com contraste se possível, lactato e necessidade de cirurgia/drenagem.
2	Grave/hospitalar	Iniciar cobertura ampla com anaeróbios e MDR conforme risco; não atrasar controle de fonte.
3	Pós-controle	Reavaliar 24–48 h, descalonar por cultura e limitar duração se boa resposta.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ peritonite difusa ▪ falência orgânica ▪ lactato elevado
Gravidade	▪ Pós-operatório ▪ anastomose ▪ abscesso múltiplo ▪ MDR ▪ Candida
Falha terapêutica	▪ Persistência de febre/leucocitose ▪ dor/peritonite ▪ coleção não drenada ▪ débito purulento

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura de líquido/coleção intra-abdominal durante drenagem/cirurgia; hemoculturas se sepse/choque.
Controle de foco	Avaliar TC com contraste se possível, lactato e necessidade de cirurgia/drenagem.

EIXO	CONDUTA
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▪ Reduzir espectro conforme cultura profunda ▪ Suspende antifúngico se Candida não sustentada ▪ Reavaliar imagem/controle de fonte se febre persistente

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100 mg EV 24/24 h; ajustar conforme espécie/sítio	Geral: Sem ajuste renal usual; revisar bula/protocolo para situação especial	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.7

Enterobacterales ESBL — Suspeita ou Confirmação

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

ESBL deve ser interpretado conforme sítio e gravidade. Infecção invasiva, bacteremia, pielonefrite grave ou choque geralmente exigem carbapenêmico; cistite baixa pode ter opções poupadoras se sensíveis.

CONDUTA DE PARTIDA

Meropenem em infecção invasiva/grave; opções orais apenas se sítio apropriado e sensibilidade confirmada

Meropenem 1–2 g EV 8/8 h conforme gravidade e sítio

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme sítio; descalonar se possível

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
E. coli ESBL	FREQUENTE EM ITU	Pode permitir opção oral se sensível e quadro não complicado
Klebsiella pneumoniae ESBL	HOSPITALAR IMPORTANTE	Maior cautela em bacteremia e infecção grave
Proteus mirabilis ESBL	MENOS COMUM	Avaliar sensibilidade

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Bacteremia, pielonefrite grave, pneumonia, intra-abdominal grave ou choque	Meropenem · 1–2 g EV 8/8 h · EV	Conforme foco	Preferir carbapenêmico em infecção invasiva/grave por ESBL.
Cistite não complicada por ESBL sensível	Nitrofurantoína ou TMP-SMX (preferenciais) · Nitrofurantoína 100 mg VO 12/12 h por 5 dias; OU TMP-SMX 800/160 mg VO 12/12 h por 3 dias · VO	3–5 dias conforme o agente	Nitrofurantoína e TMP-SMX são os preferenciais. Ciprofloxacino, levofloxacino e carbapenêmicos funcionam, mas ficam como alternativa: preservá-los para infecções com menos opção. Fosfomicina oral em dose única é alternativa EXCLUSIVAMENTE para E. coli, pelo gene fosA em K. pneumoniae e outros; ensaio randomizado mostrou mais falha clínica que nitrofurantoína. Amoxicilina-clavulanato não é preferencial nesta indicação.
Pielonefrite ou ITU complicada por ESBL	TMP-SMX, Ciprofloxacino ou Levofloxacino (preferenciais); carbapenêmico se resistência ou toxicidade impedir · TMP-SMX 800/160 mg VO 12/12 h; OU Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12 h ou 500 mg VO 12/12 h; OU Levofloxacino 750 mg EV/VO 24/24 h. Se necessário carbapenêmico: Ertapenem 1 g EV 24/24 h, ou Meropenem 1 g EV 8/8 h se paciente crítico ou hipoalbuminêmico · VO/EV	7 dias em geral	Se um carbapenêmico foi iniciado e o antibiograma mostra sensibilidade a TMP-SMX ou fluoroquinolona, transicionar para via oral é preferível a completar o curso com carbapenêmico. Nitrofurantoína e fosfomicina NÃO servem aqui: não atingem concentração no parênquima renal.

Sobre a duração: Contar o dia 1 a partir do início da terapia ativa.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Paciente estável, foco controlado e isolado sensível	TMP-SMX ou fluoroquinolona · TMP-SMX 800/160 mg VO 12/12 h ou ciprofloxacino/levofloxacino conforme sensibilidade · VO	Completar curso por foco	Usar apenas se sensibilidade confirmada e boa biodisponibilidade.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ESBL	- ESBL documentado - colonização - falha a cefalosporina - bacteremia por Enterobacterales resistente	Meropenem para infecção grave/invasiva

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

CUTI PODE TER OPÇÃO NÃO CARBAPENÊMICA

Se suscetível e clinicamente apropriado, TMP-SMX, ciprofloxacino ou levofloxacino podem ser preferidos na cUTI; reservar carbapenêmico para resistência, toxicidade, gravidade ou impossibilidade de opção eficaz.

ALERTA CRÍTICO

CEFEPIME: EVITAR EM ESBL MESMO COM ANTIBIOGRAMA SENSÍVEL

Não usar cefepime em pielonefrite, ITU complicada ou infecção invasiva por ESBL, ainda que o antibiograma relate sensibilidade. ESBLs hidrolisam cefepime e a leitura de CIM é pouco reprodutível. Um braço de ensaio clínico com cefepime foi encerrado precocemente por sinal de falha, apesar de todos os isolados terem CIM de 1–2 µg/mL. Exceção: se cefepime foi iniciado empiricamente para cistite não complicada e houve melhora, não é preciso trocar nem estender.

ALERTA CRÍTICO**PIPERACILINA-TAZOBACTAM: NÃO USAR FORA DO TRATO URINÁRIO**

Não indicada para infecção por ESBL fora do trato urinário, mesmo com sensibilidade demonstrada. Razões: a proporção de 8:1 entre piperacilina e tazobactam limita a inibição; o teste de CIM é pouco reprodutível na presença de ESBL ou OXA-1; e há regrowth em inóculo alto, como em abscessos. Em ensaio randomizado, a mortalidade em 30 dias foi de 12% com pip-tazo contra 4% com meropenem. Em pielonefrite e ITU complicada é aceitável manter se já iniciada e houve melhora, ciente do risco teórico de falha microbiológica. Em cistite não complicada, não precisa trocar.

INFORMAÇÃO**Descalonar é possível**

Se estável, sensível e foco adequado, transição oral pode ser apropriada em alguns sítios.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Risco/isolado ESBL	Identificar sítio e gravidade; revisar culturas prévias.
2	Infecção grave	Usar carbapenêmico e controlar foco.
3	Melhora e sensibilidade	Descalonar para opção oral/mais estreita quando seguro.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Infecção invasiva ▪ pielonefrite grave ▪ bacteremia ▪ sem opção oral
UTI	▪ Choque ▪ sepse grave
Gravidade	▪ Bacteremia ▪ pneumonia ▪ intra-abdominal ▪ imunossupressão
Falha terapêutica	▪ Persistência de bacteremia ▪ foco não controlado ▪ droga sem atividade

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do foco com sensibilidade; hemoculturas em invasiva/sepse; revisar histórico de ESBL e antibiótico recente.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Step-down para TMP-SMX ou fluoroquinolona apenas se sensível, estável e foco adequado ▪ Evitar nitrofurantoína/fosfomicina em pielonefrite ou bacteremia ▪ Reduzir carbapenêmico quando houver opção segura

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h se grave/meningite/ pneumonia conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
TMP-SMX VO	800/160 mg VO 12/12 h GRAVE Dose conforme peso/sítio	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
IDSA. Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections, 2025.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/complicated-urinary-tract-infections/>

18.8

Enterobacterales Resistentes a Carbapenêmicos — Tratamento por Carbapenemase

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Enterobacterales resistentes a carbapenêmicos (CRE) é um fenótipo, não um único mecanismo. Identificar carbapenemase KPC, OXA-48-like ou metalo-betalactamase muda o tratamento; não presumir que meropenem ou ceftazidima-avibactam cubram todos os mecanismos.

CONDUTA DE PARTIDA

Agente dirigido ao mecanismo: KPC, OXA-48-like ou MBL

Ceftazidima-avibactam 2,5 g EV 8/8 h, ajustar renal

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme sítio e controle de foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Klebsiella pneumoniae KPC/CRE	HOSPITALAR IMPORTANTE	Mecanismo local determina melhor droga
E. coli/Enterobacter CRE	RISCO ESPECÍFICO	Confirmar sensibilidade
Metallo-betalactamase	RISCO ESPECÍFICO	Ceftaz-avibactam isolado não cobre MBL; considerar associação com aztreonam

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Carbapenemase tipo KPC confirmada ou provável	Meropenem-vaborbactam (preferido), Ceftazidima-avibactam ou Imipenem-relebactam · Meropenem-vaborbactam 4 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; OU Ceftazidima-avibactam 2,5 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; OU Imipenem-cilastatina-relebactam 1,25 g EV 6/6 h. Ajustar todos por função renal · EV	7–14 dias conforme foco, resposta e controle de fonte	Os três são preferenciais, mas a diretriz favorece levemente meropenem-vaborbactam, depois ceftazidima-avibactam, depois imipenem-relebactam — por desfechos clínicos e por menor emergência de resistência (menos de 5% com meropenem-vaborbactam contra 10–20% com ceftazidima-avibactam). Monoterapia ativa basta na maioria dos cenários. Se o paciente recebeu ceftazidima-avibactam recentemente e volta séptico, preferir outro betalactâmico novo até sair o antibiograma.
Carbapenemase tipo OXA-48-like confirmada ou provável	Ceftazidima-avibactam (preferido); Cefiderocol como alternativa · Ceftazidima-avibactam 2,5 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; alternativa: Cefiderocol 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h. Ajustar por função renal · EV	7–14 dias conforme foco, resposta e controle de fonte	NÃO usar meropenem-vaborbactam nem imipenem-relebactam neste cenário, AINDA QUE O ANTIBIOGRAMA RELATE SENSIBILIDADE: vaborbactam e relebactam não inibem enzimas OXA-48-like. Mais de 95% dos isolados OXA-48-like são sensíveis a ceftazidima-avibactam e a cefiderocol.
Suspeita/confirmada metalo-betalactamase	Ceftazidima-avibactam + Aztreonam · Ceftazidima-avibactam 2,5 g EV 8/8 h + Aztreonam 2 g EV 8/8 h, ajustar renal · EV	Conforme foco	Usar com suporte da CCIH/infectologia; confirmar mecanismo quando possível.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sensibilidade a meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam ou cefiderocol	Novo betalactâmico ativo conforme antibiograma · Conforme bula/protocolo e função renal · EV	Conforme foco	Escolha depende do mecanismo de resistência e sítio.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
KPC	KPC identificada ou fortemente provável	Meropenem-vaborbactam, ceftazidima-avibactam ou imipenem-relebactam conforme sítio/disponibilidade
MBL	NDM, VIM, IMP ou outra MBL	Ceftazidima-avibactam + aztreonam simultâneos, ou cefiderocol; aztreonam-avibactam quando disponível
CRE	CRE sem mecanismo conhecido	Obter teste de carbapenemase e sensibilidade; discutir infectologia/CCIH

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

SENSÍVEL NO ANTIBIOGRAMA NÃO SIGNIFICA UTILIZÁVEL

Em OXA-48-like, meropenem-vaborbactam e imipenem-relebactam NÃO devem ser usados mesmo quando o antibiograma relatar sensibilidade in vitro: vaborbactam e relebactam não inibem essas enzimas. Identificar o mecanismo de resistência é o que define a droga, não apenas o disco.

ATENÇÃO

CONDUTA MUDA CONFORME O MECANISMO

KPC, OXA-48-like e metalo-betalactamases (NDM, VIM, IMP) exigem condutas diferentes. Solicitar identificação da carbapenemase por teste molecular ou antigênico sempre que disponível. Sem o mecanismo, discutir com CCIH/infectologia antes de escolher o betalactâmico novo.

ALERTA CRÍTICO**Não usar meropenem isolado se CRE verdadeiro**

Escolher droga ativa baseada em mecanismo/sensibilidade; envolver CCIH/infectologia.

ATENÇÃO**Polimixina não deve ser reflexo automático**

Quando há betalactâmico novo ativo, tende a ser preferível por eficácia/toxicidade.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita CRE	Checar culturas prévias, colonização e antibiograma local; acionar CCIH.
2	Infecção grave	Iniciar agente ativo provável sem atrasar; controlar foco.
3	Mecanismo/sensibilidade disponível	Ajustar para melhor betalactâmico ativo e evitar toxicidade desnecessária.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ bacteremia ▪ pneumonia grave ▪ controle de foco pendente
Gravidade	▪ CRE em sangue ▪ pneumonia ▪ intra-abdominal ▪ imunossuprimido
Falha terapêutica	▪ Cultura persistentemente positiva ▪ resistência emergente ▪ foco não drenado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura com antibiograma ampliado e, se disponível, mecanismo de carbapenemase; hemoculturas se invasiva.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Usar monoterapia ativa quando apropriado e sensibilidade sustentada ▪ Evitar polimixina/aminoglicosídeo se houver betalactâmico ativo menos tóxico ▪ Reavaliar necessidade de combinação após susceptibilidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftazidima-avibactam EV	2,5 g EV 8/8 h GRAVE 2,5 g EV 8/8 h, considerar infusão prolongada	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Aztreonam EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV a cada 6–8 h conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes

- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco
- Disponibilidade (variável): Confirmar registro sanitário, apresentação, formulário institucional e estoque antes de escolher o ramo. Se indisponível, usar a alternativa explicitada e validar com CCIH/infectologia e farmácia.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>

18.9

Pseudomonas MDR/DTR — Suspeita ou Confirmação

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Pseudomonas MDR/resistência de difícil tratamento (DTR) exige antibiograma atualizado, avaliação de foco e otimização farmacodinâmica. Dupla cobertura é principalmente empírica em choque/alta resistência e deve ser retirada quando possível.

CONDUTA DE PARTIDA

Novo betalactâmico ativo selecionado por sítio e antibiograma

Pneumonia/infecção grave: usar dose alta específica da bula para ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam, imipenem-relebactam ou cefiderocol; ITU e outros sítios têm doses próprias

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme sítio; 7 dias para VAP se boa resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pseudomonas aeruginosa MDR/DTR	HOSPITALAR/UTI	Resistência pode emergir durante terapia; confirmar CIM/sensibilidade

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Não sensível a carbapenêmico, mas sensível a betalactâmico tradicional (cefepime, ceftazidima, pip-tazo)	Betalactâmico tradicional ativo, em dose alta e infusão estendida · Cefepime 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; OU Ceftazidima 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; OU Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h em infusão de 4 h. Ajustar por função renal · EV	7–14 dias conforme foco, resposta e controle de fonte	Quando o isolado resiste a carbapenêmico mas é sensível a um betalactâmico tradicional, a diretriz mantém preferência pelo tradicional em dose alta e infusão estendida, preservando os betalactâmicos novos. A repetição do antibiograma antes de usar o agente tradicional deixou de ser enfatizada, dada a frequência desse perfil.
Pielonefrite ou ITU complicada por Pseudomonas DTR	Betalactâmico novo ativo; aminoglicosídeo em dose única diária como alternativa · Conforme antibiograma. Alternativa: Tobramicina 7 mg/kg EV 24/24 h OU Amicacina 15–20 mg/kg EV 24/24 h, ajustadas por função renal, com monitorização de nível sérico · EV	7–14 dias conforme resposta e controle de fonte	Tobramicina e amicacina em dose única diária entraram como alternativas nesta indicação, pela atividade prolongada no córtex renal e pela conveniência da dose diária. Monitorar função renal; o risco de nefrotoxicidade depende da duração.
Pseudomonas DTR sensível a novo betalactâmico	Ceftolozano-tazobactam ou Ceftazidima-avibactam · Ceftolozano-tazobactam 3 g EV 8/8 h para pneumonia; ajustar por sítio/renal · EV	Conforme foco	Escolher conforme antibiograma e disponibilidade.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sensível a imipenem-relebactam ou cefiderocol	Imipenem-relebactam ou Cefiderocol · Conforme bula/protocolo e função renal · EV	Conforme foco	Evitar terapia empírica sem discutir com CCIH quando resistência extrema.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque séptico com risco de Pseudomonas antes da cultura	Dois antipseudomonas de classes diferentes · Betalactâmico antipseudomonas + aminoglicosídeo/quinolona conforme risco local · EV	Descalonar assim que houver cultura	Dupla cobertura é empírica em choque/ alta resistência; não manter se não necessária.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▫ Pseudomonas prévia ▫ VAP ▫ bronquiectasias ▫ queimadura ▫ neutropenia ▫ UTI ▫ antibiótico recente	Agente antipseudomonas ativo conforme antibiograma

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

A DOSE DEPENDE DO SÍTIO

Não aplicar “dose conforme sítio” sem abrir a posologia correspondente. Pneumonia costuma exigir exposição maior; ajustar por função renal e depuração aumentada.

ALERTA CRÍTICO

Antibiograma manda

Pseudomonas MDR exige escolha dirigida; repetir cultura se falha.

ATENÇÃO

Dose otimizada é essencial

Usar infusão estendida e dose adequada ao sítio, especialmente pneumonia.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Risco de Pseudomonas MDR	Revisar culturas prévias e antibiograma da unidade.
2	Grave/choque	Iniciar cobertura antipseudomonas ativa provável, considerando dupla cobertura até cultura.
3	Resultado disponível	Direcionar para agente ativo, otimizar PK/PD e limitar duração conforme foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▫ Choque ▫ VAP grave ▫ neutropenia ▫ bacteremia
Gravidade	▫ DTR/MDR ▫ pneumonia ▫ bacteremia ▫ queimadura extensa

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Falha terapêutica	▪ Piora apesar de sensibilidade ▪ CIM elevada ▪ foco não controlado ▪ resistência emergente

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do foco com sensibilidade; hemoculturas se invasiva; revisar culturas antigas, colonização e exposição a carbapenêmico/cefepime/piper-tazo.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Suspende segundo antipseudomonal se cultura permitir ▪ Otimizar infusão/dose do betalactâmico ativo ▪ Diferenciar colonização respiratória de pneumonia verdadeira

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftolozano-tazobactam EV	1,5 g EV 8/8 h; pneumonia 3 g EV 8/8 h GRAVE Pneumonia/seps: usar dose de sítio grave conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Cefiderocol EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, infusão prolongada conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco
- Disponibilidade (variável): Confirmar registro sanitário, apresentação, formulário institucional e estoque antes de escolher o ramo. Se indisponível, usar a alternativa explicitada e validar com CCIH/infectologia e farmácia.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>

18.10

Enterococcus / VRE — Infecção Hospitalar Relevante

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Enterococcus/enterococo resistente à vancomicina (VRE) deve ser tratado apenas quando agente patogênico relevante, não colonização. A escolha depende de espécie, sensibilidade à ampicilina, foco, bacteremia persistente e suspeita de endocardite.

CONDUTA DE PARTIDA

Ampicilina se sensível; linezolida ou daptomicina em VRE/invasiva conforme foco

Ampicilina 2 g EV 4/4 h se sensível; Linezolida 600 mg 12/12 h ou Daptomicina 8–12 mg/kg EV conforme sítio

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme sítio; bacteremia geralmente 7–14 dias após clareamento se não complicada

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterococcus faecalis	FREQUENTE	Muitas vezes sensível a ampicilina
Enterococcus faecium/VRE	HOSPITALAR	Resistência à vancomicina e ampicilina é comum em E. faecium

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Enterococcus sensível a ampicilina em infecção relevante	Ampicilina · 2 g EV 4/4 h · EV	Conforme foco	Preferir ampicilina se sensível; associar conforme endocardite/sítio quando indicado.
VRE bacteremia ou infecção invasiva	Linezolida ou Daptomicina · Linezolida 600 mg EV/VO 12/12 h OU Daptomicina 8–12 mg/kg EV 24/24 h · VO/EV	Conforme foco e clareamento	Daptomicina não deve ser usada para pneumonia.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Endocardite, bacteremia persistente ou alto inóculo	Daptomicina em dose alta ± betalactâmico sinérgico · Daptomicina 10–12 mg/kg EV 24/24 h, ajustar renal · EV	Semanas conforme endocardite/foco	Discutir com infectologia; monitorar CPK.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

DAPTOMICINA NÃO TRATA PNEUMONIA

O surfactante pulmonar inativa a daptomicina. Selecionar tratamento por espécie, suscetibilidade e sítio; bacteremia/endocardite e pneumonia exigem estratégias diferentes.

ATENÇÃO

Enterococcus em urina pode ser colonização

Tratar apenas se quadro clínico compatível ou cenário especial.

ALERTA CRÍTICO**Bacteremia persistente exige foco**

Pesquisar endocardite, cateter, abscesso e material infectado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Enterococcus isolado	Definir se colonização ou infecção; identificar espécie e sensibilidade.
2	Infecção invasiva	Escolher ampicilina se sensível; se VRE, linezolida/daptomicina conforme sítio.
3	Bacteremia	Repetir hemoculturas, remover cateter se fonte e pesquisar endocardite quando indicado.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Bacteremia ▪ endocardite suspeita ▪ infecção intra-abdominal hospitalar ▪ sem opção oral
UTI	▪ Choque ▪ endocardite complicada ▪ falência orgânica
Gravidade	▪ VRE ▪ bacteremia persistente ▪ prótese/dispositivo ▪ imunossupressão
Falha terapêutica	▪ Hemocultura positiva persistente ▪ dose inadequada ▪ foco não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas seriadas se bacteremia; cultura do foco; ecocardiograma se bacteremia persistente, prótese, sopro, embolia ou alto risco.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Preferir ampicilina se sensível ▪ Evitar daptomicina para pneumonia ▪ Investigar endocardite em bacteremia persistente ou alto risco

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Linezolida VO/EV	600 mg EV/VO 12/12 h GRAVE 600 mg EV/VO 12/12 h	Geral: Sem ajuste renal usual; revisar bula/protocolo para situação especial	
Daptomicina EV	8–10 mg/kg EV 24/24 h GRAVE 10–12 mg/kg EV 24/24 h em bacteremia/endocardite conforme especialista	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação

- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco

18.11

Stenotrophomonas maltophilia — Infecção Hospitalar

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Stenotrophomonas é frequentemente colonizante em via aérea de paciente grave. Tratar apenas quando houver síndrome infecciosa compatível, amostra confiável e ausência de explicação alternativa.

CONDUTA DE PARTIDA

Cefiderocol em infecção invasiva; alternativas conforme sensibilidade, disponibilidade e infectologia

Cefiderocol 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h, com ajuste renal; alternativa: aztreonam-avibactam associado a segundo agente ativo

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

7–14 dias conforme foco e imunossupressão

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Stenotrophomonas maltophilia	HOSPITALAR OPORTUNISTA	Resistente intrinsecamente a muitos betalactâmicos, incluindo carbapenêmicos

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção invasiva verdadeira, com colonização excluída	Cefiderocol · 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h; ajustar por função renal e depuração aumentada · EV	7–14 dias conforme foco, controle de fonte e resposta	Opção preferencial IDSA 2026, reconhecendo evidência clínica limitada. Confirmar sensibilidade, disponibilidade e protocolo institucional.
Cefiderocol indisponível/ inadequado ou resistência/ intolerância	Aztreonam-avibactam + segundo agente ativo · Dose conforme produto/protocolo e função renal; associar TMP-SMX, levofloxacino ou minociclina em dose alta conforme sensibilidade · EV	Conforme foco e resposta	Se usada ceftazidima-avibactam + aztreonam como substituição operacional, coordenar administração simultânea e validar com farmácia/infectologia.
Melhora clínica sustentada e agente oral suscetível	TMP-SMX, levofloxacino ou minociclina como componente/transição · TMP-SMX por TMP 8–12 mg/kg/dia; levofloxacino 750 mg/dia; minociclina em dose alta conforme protocolo · VO/EV	Completar conforme foco	Monoterapia somente após melhora sustentada e com sensibilidade/ documentação; monitorar toxicidade e resistência emergente.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

MONOTERAPIA NÃO É CONDUTA INICIAL

Em infecção moderada, grave ou invasiva, iniciar com dois agentes ativos. A monoterapia com TMP-SMX como partida genérica não é sustentada pela diretriz vigente. Descalonar para agente único apenas após melhora sustentada, controle de foco e antibiograma favorável.

ATENÇÃO

COLONIZAÇÃO É MAIS COMUM QUE INFECÇÃO

Isolamento em aspirado traqueal ou ponta de cateter frequentemente representa colonização. Tratar apenas quando quadro clínico, radiológico e laboratorial sustentarem infecção verdadeira. Não usar ceftazidima isolada como opção dirigida: a orientação laboratorial vigente desaconselha inclusive testá-la para este agente.

ALERTA CRÍTICO

Carbapenêmico não cobre *Stenotrophomonas*

Escalonar para meropenem pode piorar seleção sem tratar o patógeno.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Isolamento microbiológico	Diferenciar colonização de infecção verdadeira e garantir identificação/sensibilidade confiáveis.
2	Infecção invasiva	Preferir cefiderocol; se indisponível/inadequado, usar alternativa da IDSA 2026 com infectologia.
3	Melhora sustentada	Considerar transição/descalonamento para agente único suscetível e monitorar toxicidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Pneumonia ▪ bacteremia ▪ imunossupressão ▪ sem opção oral segura
UTI	▪ Choque ▪ VAP grave ▪ neutropenia
Gravidade	▪ Bacteremia ▪ pneumonia ▪ neutropenia ▪ transplante
Falha terapêutica	▪ Persistência de cultura positiva com clínica ▪ resistência ▪ foco/dispositivo não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do sítio com sensibilidade; hemoculturas se sepse; repetir cultura se falha clínica ou dúvida entre colonização e infecção.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Confirmar infecção antes de tratar isolamento respiratório ▪ Evitar carbapenêmico como escalonamento para <i>Stenotrophomonas</i> ▪ Ajustar TMP-SMX por função renal e toxicidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
TMP-SMX VO/EV	TMP 8–12 mg/kg/dia dividido a cada 6–8 h GRAVE TMP 10–15 mg/kg/dia em grave conforme especialista	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Levofloxacino VO/EV	750 mg EV/VO 24/24 h GRAVE 750 mg EV/VO 24/24 h	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco
- Disponibilidade (variável): Confirmar registro sanitário, apresentação, formulário institucional e estoque antes de escolher o ramo. Se indisponível, usar a alternativa explicitada e validar com CCIH/infectologia e farmácia.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>

18.12

Acinetobacter baumannii Resistente a Carbapenêmico — CRAB

CRÍTICA UTI ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos (CRAB) é patógeno de UTI/surtos com alta chance de colonização respiratória. Confirmar infecção verdadeira, acionar CCIH e usar esquema ativo conforme sensibilidade e disponibilidade institucional.

CONDUTA DE PARTIDA

Ramo por disponibilidade: sulbactam-durlobactam + carbapenêmico; se indisponível, ampicilina-sulbactam em alta dose + segundo agente

Sulbactam-durlobactam 1 g/1 g EV 6/6 h + Meropenem 2 g EV 8/8 h, ambos em infusão estendida; se indisponível, ampicilina-sulbactam 27 g/dia + segundo agente ativo

VIA

EV

DURAÇÃO

Conforme sítio e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Acinetobacter baumannii CRAB	UTI/SURTOS HOSPITALARES	Frequentemente multirresistente; colonização respiratória é comum

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção confirmada por CRAB — esquema preferencial da diretriz	Sulbactam-durlobactam + Meropenem (ou Imipenem-cilastatina) · Sulbactam-durlobactam 1 g/1 g EV 6/6 h em infusão de 3 h + Meropenem 2 g EV 8/8 h em infusão estendida de 3 h; ajustar ambos por função renal · EV	7–14 dias conforme foco, resposta e controle de fonte	Esquema preferencial da IDSA. VERIFICAR REGISTRO E DISPONIBILIDADE NA ANVISA ANTES DE PRESCREVER: se indisponível no serviço, usar o esquema alternativo abaixo. Sempre com CCIH/infectologia. Doses renais, concentração, estabilidade e diluição devem ser validadas com bula do produto e farmácia clínica; não usar esta síntese como instrução autônoma de preparo.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CRAB sem acesso ao esquema preferencial — alternativa adotada por indisponibilidade	Ampicilina-sulbactam em alta dose + pelo menos um segundo agente ativo · Ampicilina-sulbactam 27 g/dia (18 g de ampicilina + 9 g de sulbactam), ou seja 9 g EV a cada 8 h em infusão estendida de 4 h, OU 4,5 g EV a cada 4 h; diluir em 100–250 mL de SF 0,9%. Associar um segundo agente ativo conforme antibiograma: minociclina 200 mg EV de ataque e 100 mg EV 12/12 h, OU polimixina B, OU cefiderocol se disponível. Ajuste renal: ClCr 15–29 mL/min, reduzir para 9 g a cada 12 h; ClCr < 15 mL/min ou hemodiálise, 9 g a cada 24 h com dose após a sessão · EV	7–14 dias conforme foco, resposta e controle de fonte	ALTERNATIVA, não primeira linha da diretriz: adotada quando sulbactam-durlobactam não está disponível no país ou no serviço. A monoterapia com ampicilina-sulbactam não é esquema recomendado — associar sempre pelo menos um segundo agente ativo. Doses renais, concentração, estabilidade e diluição devem ser validadas com bula do produto e farmácia clínica; não usar esta síntese como instrução autônoma de preparo.
Pneumonia ou bacteremia por CRAB com poucas opções ativas	Terapia combinada guiada por antibiograma · Manter a base com sulbactam (preferencialmente sulbactam-durlobactam; se indisponível, ampicilina-sulbactam 27 g/dia) e associar cefiderocol 2 g EV 8/8 h em infusão de 3 h, OU minociclina 100 mg EV 12/12 h, OU polimixina B com dose de ataque de 2–2,5 mg/kg seguida de 1,25–1,5 mg/kg EV 12/12 h · EV	7–14 dias conforme foco e resposta	Reavaliar diariamente e descalonar assim que o antibiograma permitir. Evitar combinações tóxicas sem plano definido. Doses renais, concentração, estabilidade e diluição devem ser validadas com bula do produto e farmácia clínica; não usar esta síntese como instrução autônoma de preparo.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem alternativas betalactâmicas ativas	Polimixina/colistina conforme protocolo · Dose de ataque/manutenção conforme função renal e protocolo · EV	Conforme foco	Alto risco de nefro/neurotoxicidade; usar quando necessário e monitorar.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

CONFIRMAR DISPONIBILIDADE ANTES DE EXIBIR COMO PRIMEIRA LINHA

O formulário institucional deve informar se sulbactam-durlobactam está registrado/padronizado. Se indisponível, mostrar diretamente a alternativa com alta dose de sulbactam e segundo agente.

ATENÇÃO

ESQUEMA PREFERENCIAL PODE NÃO ESTAR DISPONÍVEL NO BRASIL

A diretriz internacional traz sulbactam-durlobactam associado a meropenem ou imipenem-cilastatina como esquema preferencial. Verificar registro na ANVISA e disponibilidade no serviço. Quando indisponível, usar ampicilina-sulbactam em alta dose (27 g/dia) associada a pelo menos um segundo agente ativo, reconhecendo que se trata de alternativa adotada por indisponibilidade, e não da primeira linha da diretriz.

ALERTA CRÍTICO

Colonização respiratória é comum

Tratar CRAB em aspirado traqueal apenas se quadro clínico/radiológico sustentar infecção.

ATENÇÃO

Discutir com CCIH

CRAB exige estratégia local, controle de surto e escolha por sensibilidade.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Isolamento de Acinetobacter	Diferenciar colonização de infecção; revisar sítio e qualidade da amostra.
2	Infecção provável	Escolher esquema ativo conforme sensibilidade e protocolo; otimizar dose.
3	UTI/surto	Acionar CCIH para precauções, rastreamento e controle institucional.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ VAP grave ▪ choque ▪ bacteremia ▪ queimado grave
Gravidade	▪ CRAB invasivo ▪ pneumonia ▪ bacteremia ▪ MDR extremo
Falha terapêutica	▪ Sem melhora clínica ▪ resistência ▪ foco não controlado ▪ dose subótima

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Cultura do sítio com antibiograma ampliado; hemoculturas se invasiva; vigilância institucional conforme CCIH em surto/colonização.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Diferenciar colonização de infecção ▪ Evitar polimixina se houver opção ativa menos tóxica ▪ Monitorar nefro/neurotoxicidade e necessidade real de combinação

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sulbactam-durlobactam EV	1 g/1 g EV 6/6 h em infusão de 3 h GRAVE 1 g/1 g EV 6/6 h em infusão de 3 h	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Ampicilina-sulbactam dose alta EV	Dose conforme componente sulbactam e protocolo GRAVE 27 g/dia (9 g EV 8/8 h em infusão estendida)	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h em infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	
Colistina/Polimixina EV	Conforme formulação e protocolo GRAVE Dose de ataque se indicada; monitorar toxicidade	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Módulo hospitalar/MDR altamente dependente de antibiograma institucional, CCIH, disponibilidade de antimicrobianos de reserva, dose otimizada por função renal/diálise e resultado microbiológico.
- Consultar protocolo da CCIH e antibiograma local antes de consolidar terapia
- Confirmar culturas, sítio infeccioso, colonização prévia e antimicrobianos recentes
- Verificar disponibilidade institucional de fármacos de reserva e critérios de liberação
- Ajustar dose por função renal, diálise, peso, gravidade e estratégia de infusão
- Reavaliar diariamente para descalonamento, suspensão ou controle de foco
- Disponibilidade (variável): Confirmar registro sanitário, apresentação, formulário institucional e estoque antes de escolher o ramo. Se indisponível, usar a alternativa explicitada e validar com CCIH/infectologia e farmácia.

REFERÊNCIA DO QUADRO

IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 18 — HOSPITALARES

- IDSA. Antimicrobial-resistant Gram-negative Infections Guidance, 2026.
- ATS/IDSA. Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia, 2016.
- IDSA. Intravascular Catheter-related Infection, 2009.
- Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines, 2026.

19

Síndromes Práticas

14 quadros clínicos neste sistema

Este tópico orienta raciocínio e stewardship. Antes de prescrever, confirmar foco, gravidade, culturas, alergias, função renal/hepática, gestação e necessidade de controle de fonte.

19.1	Febre Sem Foco — Adulto Imunocompetente Estável	389
19.2	Febre no Idoso Frágil — Sem Foco Claro	391
19.3	Sepse Sem Foco Definido — Adulto	393
19.4	Choque Séptico Sem Foco Definido — Abordagem Imediata	396
19.5	Hemocultura Positiva — Interpretação Inicial no PS/Enfermaria	399
19.6	Falha Terapêutica em 48–72 h de Antibiótico	402
19.7	Alergia a Betalactâmico — Decisão Antibiótica no Plantão	404
19.8	Culturas Antes do Antibiótico — Quando Colher	407
19.9	Quando NÃO Prescrever Antibiótico — Decisão Negativa	409
19.10	Descalonamento e Duração Curta — Stewardship no Plantão	411
19.11	Ajuste Renal / Hemodiálise — Antibióticos no Plantão	413
19.12	Antibiótico na Gestante/Lactante — Abordagem Inicial	415
19.13	Antibiótico Antes de Transferência/Regulação — PS	417
19.14	PCR / Procalcitonina / Leucocitose — Como Não Supertratar	420

19.1

Febre Sem Foco — Adulto Imunocompetente Estável

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Síndrome frequente no PS em paciente sem instabilidade, sem imunossupressão e sem foco infeccioso evidente. O objetivo é evitar antibiótico automático, identificar sinais de gravidade, orientar retorno e investigar conforme duração, epidemiologia e exame físico.

CONDUTA DE PARTIDA

Sem antibiótico empírico se estável, sem foco e sem imunossupressão

Conduta: sinais vitais, exame completo, sintomáticos, exames apenas se mudarem conduta e retorno se alarme

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Reavaliar em 24–48 h ou antes se piora

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Vírus respiratórios/sistêmicas	COMUM	Causas virais são frequentes quando não há foco bacteriano claro
Infecção bacteriana inicial sem foco	POSSÍVEL	Rastrear sinais de sepse, meningite, pneumonia, pielonefrite, celulite e abdome agudo
Causas não infecciosas	DIFERENCIAL	Drogas, trombose, doença inflamatória, neoplasia e febre factícia devem entrar no diferencial conforme contexto

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Estável, exame físico sem foco e sem critérios de gravidade	Não iniciar antibiótico empírico · Conduta: sintomáticos, investigação dirigida e orientação formal de retorno · Conduta	Reavaliar em 24–48 h se persistir ou antes se piorar	Evitar antibiótico para febre isolada em paciente estável. Procurar foco, estratificar risco e orientar retorno claro.
Febre persistente, comorbidade relevante ou exame duvidoso	Exames dirigidos antes de antibiótico · Hemograma, função renal/hepática, urina, RX/US/TC conforme clínica · VO/EV	Conforme evolução	Antibiótico depende de foco provável ou instabilidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Surgimento de sepse, hipotensão, confusão, hipoxemia ou foco grave	Cobertura empírica conforme foco provável · Escolher no quadro específico; se choque sem foco, usar esquema de sepse · EV	Conforme foco	Não atrasar antibiótico se critérios de sepse/choque.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Febre isolada não é indicação automática de antibiótico

Sem foco e sem gravidade, antibiótico pode trazer dano e mascarar diagnóstico.

ALERTA CRÍTICO

Procurar sinais de alarme

Hipotensão, hipoxemia, confusão, rigidez de nuca, dor abdominal intensa, petéquias, imunossupressão ou piora rápida mudam a conduta.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Febre sem foco	Checar sinais vitais, perfusão, consciência, saturação, exame completo de pele, pulmão, abdome, urinário e SNC.
2	Estável	Evitar antibiótico empírico; solicitar exames apenas se mudarem conduta.
3	Alta	Orientar retorno imediato se piora, dispneia, confusão, hipotensão, rigidez de nuca, vômitos persistentes ou surgimento de foco.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Instabilidade hemodinâmica ▫ hipoxemia ▫ rebaixamento ▫ imunossupressão ▫ suspeita de foco grave ▫ incapacidade de retorno
UTI	▫ Choque ▫ lactato elevado com hipoperfusão ▫ necessidade de vasopressor ▫ insuficiência respiratória
Gravidade	▫ Sinais de sepse ▫ petéquias/púrpura ▫ meningismo ▫ dor abdominal com irritação peritoneal ▫ idoso frágil
Falha terapêutica	▫ Febre persistente >72 h sem diagnóstico ▫ piora clínica ▫ novo foco ▫ alteração laboratorial progressiva

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Não colher culturas de rotina em adulto estável sem foco; colher conforme foco, internação, sepse ou imunossupressão.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	Suspender antibiótico se iniciado sem foco e investigação não sustenta infecção bacteriana
Transição EV → VO	Não se aplica sem antibiótico iniciado

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sem antibiótico inicial Conduta	Não indicado se estável e sem foco GRAVE Se sepse/choque, ver o capítulo 16 — Sepse	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.2

Febre no Idoso Frágil — Sem Foco Claro

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

No idoso, infecção grave pode se apresentar com pouca febre, confusão, queda, inapetência ou piora funcional. A conduta exige limiar mais baixo para investigação e observação, mas ainda evitando tratar bacteriúria ou colonização sem síndrome clínica.

CONDUTA DE PARTIDA

Conduta guiada por foco e gravidade

Se estável: investigar e observar; se sepse/foco provável: colher culturas pertinentes e iniciar conforme foco

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Reavaliar em 24–48 h

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Pneumonia	FREQUENTE	Pode cursar sem tosse evidente; avaliar saturação e imagem se suspeita
ITU sintomática/pielonefrite	FREQUENTE	Não confundir bacteriúria assintomática com infecção
Infecção de pele/partes moles	FREQUENTE	Examinar dorso, períneo, pés, úlceras e dispositivos
Infecção abdominal/biliar	IMPORTANTE	Dor pode ser discreta; avaliar colestase, náuseas, alteração de sensório

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Idoso estável, sem sepse e sem foco definido	Observação + investigação dirigida · Conduta: não iniciar antibiótico apenas por idade, EAS alterado ou bacteriúria isolada · Conduta	Reavaliação curta	Valorizar delirium, queda e piora funcional como possíveis sinais de infecção, mas procurar foco.
Foco provável ou sinais sistêmicos	Antibiótico conforme foco provável · Escolher módulo específico; ajustar função renal e peso · VO/EV	Conforme foco	No idoso, revisar interações, QT, risco de C. difficile, função renal, risco de delirium e objetivos de cuidado.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse sem foco claro	Ceftriaxona ou Piperacilina-tazobactam ± Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h se comunitário sem risco MDR; Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h se risco hospitalar/abdome/Pseudomonas; associar vancomicina se MRSA/CVC/pele · EV	Descalonar em 48–72 h	Individualizar por origem comunitária vs hospitalar e risco MDR.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	- Úlcera/ferida infectada - CVC - hemodíalise - colonização MRSA - pneumonia grave com risco	Vancomicina ou linezolida conforme foco

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
PSEUDOMONAS	▪ Internação recente ▪ antibiótico recente ▪ dispositivo urinário/respiratório ▪ colonização prévia	Cefepime ou piperacilina-tazobactam conforme foco

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Bacteriúria assintomática é comum

Não tratar urocultura positiva isolada sem síndrome urinária/sistêmica compatível.

ALERTA CRÍTICO

Delirium pode ser sinal de sepse

Confusão aguda com instabilidade ou disfunção orgânica exige abordagem de sepse.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Idoso febril/confuso	Avaliar sinais vitais, hidratação, medicações, funcionalidade basal e exame completo.
2	Sem foco e estável	Investigar de forma dirigida e observar; não tratar exames isolados.
3	Instável ou foco provável	Colher culturas se possível e iniciar antibiótico conforme foco/risco MDR.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Fragilidade ▪ delirium ▪ queda recorrente ▪ hipotensão ▪ desidratação ▪ impossibilidade de retorno ▪ comorbidade descompensada
UTI	▪ Choque ▪ hipoxemia ▪ vasopressor ▪ lactato elevado ▪ rebaixamento grave
Gravidade	▪ Instabilidade ▪ novo delirium ▪ taquipneia ▪ oligúria ▪ lesão renal aguda
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ cultura resistente ▪ foco não controlado ▪ diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas se sepse/internação/foco invasivo; urocultura apenas se sintomas urinários, sepse sem foco ou indicação clara.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Retirar vancomicina se sem critério de MRSA ▪ Reduzir espectro conforme cultura e foco ▪ Suspender se causa não infecciosa provável

EIXO	CONDUTA
Transição EV → VO	Trocar para VO quando estável, afebril/melhorando, foco controlado e opção oral adequada

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	1–2 g EV 24/24 h conforme foco GRAVE 2 g EV 24/24 h; meningite exige posologia própria	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.3

Sepse Sem Foco Definido — Adulto

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Sepse sem foco ainda definido exige busca rápida de foco e antimicrobiano compatível com a epidemiologia, sem transformar ausência inicial de foco em indicação automática de carbapenêmico, vancomicina ou antifúngico.

CONDUTA DE PARTIDA

Antimicrobiano guiado pelo foco mais provável e risco microbiológico; anti-MRSA apenas se critério

Píp-tazo 4,5 g EV 6/6 h; associar vancomicina se risco de MRSA/CVC/pele/pneumonia grave

VIA

EV

DURAÇÃO

Reavaliar em 48–72 h; duração conforme foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Enterobacterales	COMUM	Focos urinário, abdominal e bacteremia primária
Staphylococcus aureus	IMPORTANTE	Pele, cateter, endocardite, bacteremia sem foco
Streptococcus pneumoniae	POSSÍVEL	Foco respiratório pode não estar claro inicialmente
Anaeróbios	CONFORME ABDOME/ASPIRAÇÃO	Cobrir se suspeita abdominal, necrose ou aspiração

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse comunitária sem foco e sem risco MDR	Ceftriaxona ± Vancomicina · Ceftriaxona 2 g EV 24/24 h; associar vancomicina se risco de MRSA, CVC, pele ou meningite/endocardite em diferencial · EV	Reavaliar em 24–48 h	Se suspeita abdominal, preferir ceftriaxona + metronidazol ou pip-tazo.
Sepse grave, hospitalar ou foco abdominal/urinário/pulmonar incerto	Piperacilina-tazobactam ± Vancomicina · Pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h + vancomicina se critério · EV	Descalonar em 48–72 h	Boa opção quando precisa cobrir G-, anaeróbios e Pseudomonas; não cobre MRSA.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque, ESBL prévio ou alto risco de MDR	Meropenem ± Vancomicina · Meropenem 1–2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida + vancomicina se MRSA/CVC/pele · EV	Descalonar assim que culturas permitirem	Evitar carbapenêmico se baixo risco de ESBL/MDR.
Alergia grave imediata a betalactâmico	Aztreonam + Vancomicina ± Metronidazol · Aztreonam 2 g EV 8/8 h + vancomicina; adicionar metronidazol 500 mg EV 8/8 h se suspeita abdominal/anaeróbios · EV	Reavaliar em 24–48 h	Aztreonam não cobre Gram-positivos nem anaeróbios; associar coberturas conforme foco e revisar alergia se infecção crítica.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▫ CVC ▫ hemodiálise ▫ pele/partes moles ▫ pneumonia grave ▫ colonização MRSA ▫ choque sem foco	Vancomicina ou linezolida conforme foco
PSEUDOMONAS	▫ Hospitalar ▫ UTI ▫ antibiótico recente ▫ neutropenia ▫ bronquiectasia ▫ colonização prévia	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem
ESBL	▫ ESBL prévio ▫ internação/ATB recente ▫ ITU recorrente com resistência ▫ choque séptico	Meropenem se infecção invasiva grave
ANAEROBIOS	▫ Abdome ▫ aspiração ▫ necrose ▫ abscesso ▫ infecção perineal	Pip-tazo, carbapenêmico ou ceftriaxona + metronidazol

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Não atrasar antibiótico se alta probabilidade de sepse/choque

Culturas são importantes, mas não devem atrasar antimicrobiano em instabilidade.

ATENÇÃO

Descalonamento obrigatório

Cobertura ampla inicial deve ser revista em 24–72 h com culturas, imagem e evolução.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Suspeita de sepse	Avaliar perfusão, lactato, disfunções, coletar hemoculturas e culturas dirigidas se não atrasar antibiótico.
2	Escolha empírica	Definir origem comunitária vs hospitalar, risco de MRSA/Pseudomonas/ESBL e provável foco oculto.
3	Reavaliação	Rever em 24–72 h para foco, cultura, imagem, controle de fonte e descalonamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Toda sepse com disfunção orgânica deve ser internada
UTI	▪ Choque ▪ vasopressor ▪ lactato elevado persistente ▪ hipoxemia grave ▪ rebaixamento ▪ oligúria
Gravidade	▪ Hipotensão ▪ confusão ▪ taquipneia ▪ lactato elevado ▪ plaquetopenia ▪ IRA ▪ hiperbilirrubinemia
Falha terapêutica	▪ Sem melhora em 48–72 h ▪ cultura resistente ▪ foco não drenado ▪ diagnóstico alternativo

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas 2 pares antes do antibiótico se possível e sem atrasar tratamento, além de urina, escarro, líquido/abscesso, LCR ou culturas de dispositivo conforme foco provável.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Reduzir espectro conforme culturas ▪ Suspende vancomicina se sem MRSA/Gram-positivo relevante ▪ Evitar manter carbapenêmico sem ESBL/CRE ou necessidade clara
Transição EV → VO	Trocar para VO apenas após estabilidade, foco definido/controlado, cultura compatível e boa absorção oral

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Piperacilina-tazobactam EV	4,5 g EV 6/6 h GRAVE 4,5 g EV 6/6 h, considerar infusão estendida	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, considerar infusão estendida em choque/MDR	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

REFERÊNCIA DO QUADRO

Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock, 2026.

<https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026>

19.4

Choque Séptico Sem Foco Definido — Abordagem Imediata

CRÍTICA

UTI

ADULTO

Verificado · Guideline · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Cenário de maior urgência: hipotensão/hipoperfusão com infecção provável e foco ainda indefinido. A prioridade é antibiótico amplo imediato, ressuscitação, culturas sem atraso relevante e busca ativa de controle de fonte.

CONDUTA DE PARTIDA

Betalactâmico amplo guiado por epidemiologia ± anti-MRSA/antifúngico somente se risco específico

Exemplo sem risco de ESBL/CRE: piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6/6 h; usar meropenem se risco forte de ESBL e agente dirigido se CRE; adicionar vancomicina apenas com risco de MRSA

VIA

EV

DURAÇÃO

Reavaliar diariamente; descalonar em 48–72 h

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Gram-negativos entéricos	FREQUENTES	Urinário/abdominal/biliar oculto
Staphylococcus aureus/MRSA	IMPORTANTE	Cateter, pele, endocardite, pneumonia necrosante
Pseudomonas aeruginosa	RISCO CONFORME CONTEXTO	UTI, antibiótico recente, bronquiectasia, hospitalar
Candida spp.	SELECIONADO	Considerar em TPN, cirurgia abdominal recente, colonização múltipla, imunossupressão

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque comunitário sem foco, sem colonização resistente e sem risco específico de MRSA	Piperacilina-tazobactam · 4,5 g EV 6/6 h; otimizar infusão conforme protocolo · EV	Reavaliar em 24 h e definir duração pelo foco	Não adicionar vancomicina apenas porque há choque sem foco. Examinar pele, cateteres, coração, pulmão, abdome e trato urinário.
Choque com ESBL prévia/alto risco validado, sem CRE conhecida	Meropenem · 1 g EV 8/8 h; otimizar dose/infusão conforme sítio, CIM, função renal e protocolo · EV	Reavaliar em 24 h e descalonar	CRE/KPC/MBL exige agente dirigido; meropenem isolado não é cobertura universal.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Choque com risco alto e específico de candidíase invasiva	Micafungina + Meropenem + Vancomicina · Micafungina 100 mg EV 24/24 h + meropenem + vancomicina · EV	Se candidemia: 14 dias após clareamento e controle de foco	Nutrição parenteral, cirurgia abdominal recente/fuga anastomótica, pancreatite necrosante, colonização multifocal, imunossupressão ou candidemia prévia. Definir plano de suspensão se investigação negativa.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ CVC/dispositivo com suspeita de infecção ▪ Pele/partes moles ou pneumonia necrosante ▪ Colonização/infecção MRSA prévia ▪ Hemodiálise ou assistência à saúde com epidemiologia compatível	Vancomicina
PSEUDOMONAS	▪ UTI/hospitalar ▪ neutropenia ▪ antibiótico recente ▪ colonização prévia ▪ bronquiectasia	Cefepime, pip-tazo ou meropenem
ESBL	▪ ESBL prévio ▪ carbapenêmico/cefalosporina recente ▪ ITU recorrente resistente ▪ choque hospitalar	Meropenem
ANAEROBIOS	▪ Abdome ▪ períneo ▪ necrose ▪ aspiração ▪ abscesso	Pip-tazo ou carbapenêmico

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

AUSÊNCIA DE FOCO NÃO DEFINE COBERTURA

Choque exige antimicrobiano imediato, mas vancomicina, carbapenêmico e equinocandina dependem de risco epidemiológico específico e devem ter plano de retirada.

ALERTA CRÍTICO

Antibiótico imediato

Choque séptico é indicação de antibiótico amplo assim que reconhecido, sem aguardar definição completa do foco.

ALERTA CRÍTICO

Controle de fonte

Coleção, abdome, obstrução urinária/biliar, cateter infectado e necrose exigem controle de foco precoce.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Reconhecimento	Identificar choque/hipoperfusão, colher lactato e culturas sem atrasar antibiótico.
2	Primeira hora	Iniciar antibiótico amplo, ressuscitação volêmica conforme caso e vasopressor se necessário.
3	Fonte	Buscar foco com exame, imagem, urina, tórax, abdome, pele, cateteres e avaliar drenagem/retirada de dispositivo.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Internação em ambiente monitorizado/UTI
UTI	▫ Todo choque séptico ▫ vasopressor ▫ lactato persistente ▫ hipoxemia grave ▫ IRA/oligúria
Gravidade	▫ Hipotensão ▫ hipoperfusão ▫ lactato elevado ▫ vasopressor ▫ disfunção múltipla
Falha terapêutica	▫ Choque persistente ▫ lactato não reduz ▫ cultura resistente ▫ foco não controlado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas 2 pares e culturas do foco provável, mas não atrasar antibioticoterapia no choque.
Controle de foco	Buscar foco com exame, imagem, urina, tórax, abdome, pele, cateteres e avaliar drenagem/retirada de dispositivo.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	▫ Rever diariamente ▫ Retirar anti-MRSA/antifúngico/carbapenêmico se não sustentados ▫ Ajustar conforme cultura e foco
Transição EV → VO	Sem troca para VO na fase de choque; considerar após estabilidade completa e foco controlado

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Meropenem EV	1 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 8/8 h, infusão estendida se possível	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100–150 mg EV 24/24 h conforme cenário	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

REFERÊNCIA DO QUADRO

Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock, 2026.
IDSA. Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections, 2026.
<https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026>
<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>

19.5

Hemocultura Positiva — Interpretação Inicial no PS/Enfermaria

GRAVE HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional obrigatória

Roteiro prático para diferenciar contaminação de bacteremia verdadeira, identificar resultados que exigem ação imediata e direcionar investigação de foco, repetição de culturas e avaliação de endocardite/cateter.

CONDUTA DE PARTIDA

Conduta por Gram, estabilidade, provável foco e possibilidade de contaminação

Não tratar resultado isolado; integrar Gram, número de frascos, tempo de positividade, foco, cateter/prótese e estado clínico

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Conforme agente/foco; reavaliar diariamente

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Staphylococcus aureus	CLINICAMENTE RELEVANTE QUANDO CONFIRMADO	Nunca considerar contaminante; exige busca de foco, repetição de culturas e avaliação de endocardite
Gram-negativo em hemocultura	GERALMENTE RELEVANTE	Pensar urinário, abdominal/biliar, cateter, pneumonia ou translocação
Candida spp.	GRAVE	Candidemia exige tratamento sistêmico, retirada de cateter se possível e avaliação de complicações
Estafilococo coagulase-negativo	MUITAS VEZES CONTAMINANTE	Pode ser verdadeiro se CVC, prótese, múltiplos frascos positivos ou imunossupressão

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Hemocultura com S. aureus ou cocos G+ em cachos com paciente doente	Vancomicina até sensibilidade · Vancomicina carga se grave; ajustar por nível/AUC · EV	Mínimo 14 dias para bacteremia não complicada	Repetir hemoculturas, procurar foco, avaliar ecocardiograma e não subestimar.
Bacilo Gram-negativo em hemocultura	Cefepime, piperacilina-tazobactam ou meropenem conforme risco · Cefepime 2 g EV 8/8 h OU pip-tazo 4,5 g EV 6/6 h OU meropenem se ESBL/choque · EV	Geralmente 7–14 dias conforme foco e resposta	Buscar foco urinário/abdominal/biliar e descalonar pelo antibiograma.

Sobre a duração: Mais se foco/endocardite.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Provável contaminante em paciente estável	Não ampliar automaticamente · Conduta: repetir culturas, correlacionar com clínica e procurar contaminante antes de escalar · Conduta	Observação	CoNS em 1 frasco, Corynebacterium ou Bacillus podem ser contaminantes, exceto se prótese/CVC/imunossupressão.
Levedura/Candida na hemocultura	Equinocandina · Micafungina 100 mg EV 24/24 h ou equivalente · EV	14 dias após primeira cultura negativa e resolução clínica	Retirar CVC se possível, repetir culturas e avaliar olho/focos conforme protocolo.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Cocos G+ em cachos ▪ S. aureus ▪ CVC ▪ hemodiálise ▪ prótese/dispositivo	Vancomicina até sensibilidade
ESBL	▪ GNB com ESBL prévio ▪ choque ▪ ITU/abdominal com resistência prévia ▪ uso recente de cefalosporina	Meropenem se grave/invasiva

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

HEMOCULTURA POSITIVA NÃO TEM ESQUEMA UNIVERSAL

Vancomicina + cefepime pode ser apropriada no paciente instável, mas não deve ser resposta automática a todo resultado. S. aureus, Candida e Gram-negativos verdadeiros exigem ação; contaminantes prováveis exigem correlação e repetição quando indicada.

ALERTA CRÍTICO

S. aureus em sangue nunca é contaminante

Exige tratamento, repetição de culturas e investigação de foco/endocardite.

ATENÇÃO

Não tratar contaminante sem contexto

Antibiótico desnecessário para contaminante aumenta dano e confunde evolução.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Resultado positivo	Checar Gram, número de frascos, tempo de positividade, quadro clínico e presença de cateter/próteses.
2	Provável bacteremia verdadeira	Iniciar/ajustar antibiótico, repetir culturas e procurar foco.
3	Agente crítico	S. aureus, Candida e GNB exigem abordagem ativa e desescalamento por sensibilidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Bacteremia verdadeira ▪ S. aureus ▪ Candida ▪ GNB ▪ instabilidade ▪ prótese/dispositivo

CATEGORIA	CRITÉRIOS
UTI	▪ Choque ▪ hipoxemia ▪ vasopressor ▪ disfunção orgânica
Gravidade	▪ S. aureus ▪ Candida ▪ persistência de culturas positivas ▪ prótese valvar/articular ▪ CVC
Falha terapêutica	▪ Hemocultura persistentemente positiva ▪ febre persistente ▪ foco não controlado ▪ antibiótico sem sensibilidade

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Repetir hemoculturas em S. aureus, Candida, endocardite suspeita, bacteremia persistente, CVC ou piora clínica.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Ajustar por identificação e sensibilidade ▪ Suspender se contaminante provável e paciente estável ▪ Trocar vancomicina por betalactâmico se MSSA e sem alergia relevante
Transição EV → VO	Bacteremia por S. aureus/Candida geralmente exige fase EV; avaliar VO apenas em cenários específicos e com especialista/protocolo

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Micafungina EV	100 mg EV 24/24 h GRAVE 100–150 mg EV 24/24 h conforme cenário	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.6

Falha Terapêutica em 48–72 h de Antibiótico

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Checklist para paciente que não melhora após 48–72 h de antibiótico. O erro comum é apenas “ampliar cobertura”; a abordagem correta é confirmar diagnóstico, dose, foco, drenagem, resistência, complicação e causas não infecciosas.

CONDUTA DE PARTIDA

Reavaliação estruturada antes de ampliar

Checar diagnóstico, foco oculto, cultura, dose/PK, adesão/absorção, controle de fonte, complicação e diagnóstico alternativo

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Reavaliar diariamente

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Patógeno resistente	POSSÍVEL	ESBL, MRSA, Pseudomonas, Enterococcus, anaeróbios ou fungos conforme foco
Foco não controlado	COMUM	Abscesso, empiema, obstrução urinária/biliar, necrose, corpo estranho, cateter
Diagnóstico alternativo	IMPORTANTE	TEP, neoplasia, autoimune, febre medicamentosa, sangramento, pancreatite

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Estável, sem deterioração rápida	Não ampliar automaticamente · Conduta: revisar diagnóstico, culturas, imagem, dose, adesão e controle de foco · Conduta	Reavaliar em 24 h	Febre pode persistir em alguns focos mesmo com terapia adequada; valorizar tendência clínica.
Piora clínica, sepse ou novo foco	Ampliar conforme foco/risco + controlar fonte · Escolher o esquema do quadro específico; considerar MRSA/Pseudomonas/ESBL/ anaeróbios · EV	Conforme novo diagnós-tico	Ampliação sem drenagem/controle de foco, dose adequada e diagnóstico correto tende a falhar.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Risco de fungo invasivo ou candidemia	Equinocandina conforme cenário · Micafungina 100 mg EV 24/24 h ou equivalente · EV	Conforme foco/candi-demia	Reservar para risco compatível: TPN, cirurgia abdominal, colonização, choque, imunossupressão.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▫ Pele/partes moles ▫ CVC ▫ hemodiálise ▫ pneumonia grave ▫ colonização prévia	Vancomicina/linezolida/daptomicina conforme foco
PSEUDOMONAS	▫ Hospitalar/UTI ▫ antibiótico recente ▫ bronquiectasia ▫ neutropenia ▫ colonização	Cefepime, pip-tazo, meropenem ou droga guiada por cultura

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▫ Abdome ▫ aspiração ▫ necrose ▫ abscesso ▫ períneo	Metronidazol associado ou betalactâmico com cobertura anaeróbia
ESBL	▫ ESBL prévio ▫ falha com cefalosporina ▫ GNB resistente ▫ choque	Carbapenêmico se infecção invasiva

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Falha não é sinônimo de antibiótico fraco

Dose errada, foco fechado, diagnóstico incorreto e adesão/absorção explicam muitos casos.

ALERTA CRÍTICO

Controle de fonte salva mais que escalonamento isolado

Abscesso, empiema, obstrução e necrose precisam de drenagem/procedimento.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Sem resposta	Confirmar diagnóstico e foco; revisar sinais vitais, evolução, culturas e imagem.
2	Antibiótico atual	Checar dose, intervalo, função renal, via, biodisponibilidade, adesão e penetração no sítio.
3	Persistência	Procurar foco não controlado, resistência, complicação ou diagnóstico alternativo antes de apenas ampliar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Falha ambulatorial com piora ▫ necessidade de EV ▫ comorbidade ▫ foco profundo
UTI	▫ Choque ▫ hipoxemia ▫ rebaixamento ▫ vasopressor
Gravidade	▫ Piora hemodinâmica ▫ aumento de lactato ▫ novo órgão disfuncional ▫ bacteremia persistente
Falha terapêutica	▫ Febre e marcadores sem queda ▫ dor/pus persistente ▫ cultura resistente ▫ imagem com coleção

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Repetir culturas se piora, bacteremia, foco profundo, febre persistente com instabilidade ou antes de escalonamento relevante.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▫ Após identificação de causa, reduzir cobertura ▫ Suspende antibiótico se diagnóstico não infeccioso

EIXO	CONDUTA
Transição EV → VO	Trocar EV/VO conforme estabilidade, foco e droga com boa biodisponibilidade

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Conduta dirigida Conduta	Depende do foco e cultura GRAVE Se instável, ampliar conforme capítulos 16 e 18	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.7

Alergia a Betalactâmico — Decisão Antibiótica no Plantão

MODERADA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Ferramenta para classificar história de alergia e evitar tanto exposição insegura quanto uso desnecessário de esquemas inferiores. Separar intolerância, reação tardia leve, reação imediata IgE e reação cutânea grave é decisivo.

CONDUTA DE PARTIDA

Estratificar reação antes de substituir

História detalhada: droga, tempo, sintomas, gravidade, tratamento recebido e reexposição

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Decisão imediata + registro claro

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Intolerância/efeito adverso	MUITO COMUM	Náusea, diarreia isolada e cefaleia não são alergia IgE
Reação imediata IgE	MENOS COMUM	Urticária, angioedema, broncoespasmo, hipotensão em minutos-horas
Reação cutânea grave	RARA E CRÍTICA	SJS/TEN, DRESS, AGEP: evitar betalactâmicos relacionados e discutir especialista

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
História vaga, intolerância ou rash remoto leve	Preferir betalactâmico adequado se baixo risco · Usar droga de escolha do foco; considerar observação/teste conforme protocolo local · VO/EV	Conforme infecção	Evita esquemas mais tóxicos/menos eficazes.
Reação imediata compatível com IgE/anafilaxia	Alternativa não betalactâmica ou aztreonam + coberturas necessárias · Ex.: aztreonam 2 g EV 8/8 h + vancomicina ± metronidazol conforme foco · EV	Conforme foco	Se infecção crítica e betalactâmico essencial, discutir dessensibilização/protocolo.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
SJS/TEN, DRESS ou reação grave tardia	Evitar betalactâmicos relacionados · Escolher alternativa com infectologia/alergologia conforme foco · Conduta	Conforme infecção	Não fazer desafio no PS nesses casos.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Alternativa precisa cobrir Gram+ resistente ▪ pele grave ▪ CVC ▪ pneumonia grave	Vancomicina, linezolida ou daptomicina conforme foco
PSEUDOMONAS	▪ Sepses hospitalar ▪ neutropenia ▪ Pseudomonas provável	Aztreonam pode cobrir G- incluindo Pseudomonas, mas precisa complementar G+/anaeróbios
ANAEROBIOS	Abdome, aspiração, necrose, períneo	Metronidazol se alternativa sem anaeróbios

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

SJS/TEN/DRESS não é alergia “leve”

Evitar reexposição e não fazer desafio em ambiente inadequado.

ATENÇÃO

Registrar a reação real

Anotar “alergia a penicilina” sem descrição prejudica tratamentos futuros.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Relato de alergia	Definir droga, tempo da reação, sintomas, necessidade de adrenalina/internação e reexposições toleradas.
2	Baixo risco	Considerar betalactâmico indicado conforme protocolo local, com observação se necessário.
3	Alto risco	Escolher alternativa que cubra G+, G-, anaeróbios e Pseudomonas conforme foco; registrar claramente.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Infecção que exige EV e alternativa complexa ▪ história de anafilaxia com necessidade de betalactâmico ▪ reação cutânea grave
UTI	Sepses/choque com alergia limitante e necessidade de esquema amplo
Gravidade	▪ Anafilaxia prévia ▪ SJS/TEN/DRESS ▪ infecção crítica sem alternativa adequada
Falha terapêutica	▪ Uso de alternativa sem cobertura do foco ▪ toxicidade ▪ resistência

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Conforme foco; culturas ajudam a reduzir exposição a alternativas mais tóxicas.
Controle de foco	Definir droga, tempo da reação, sintomas, necessidade de adrenalina/internação e reexposições toleradas.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	- Se cultura permite, trocar para opção mais estreita e segura - Reavaliar rótulo de alergia após fase aguda
Transição EV → VO	Trocar para VO com alternativa segura e ativa quando estável e foco controlado

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Aztreonam EV	2 g EV 8/8 h GRAVE 2 g EV 6/6 h apenas em Pseudomonas grave (teto de 8 g/dia)	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Vancomicina EV	15–20 mg/kg EV conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Metronidazol VO/EV	500 mg EV/VO 8/8 h GRAVE 500 mg EV 8/8 h	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.8

Culturas Antes do Antibiótico — Quando Colher

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 15/08/2026 · validação institucional recomendada

Resumo prático para colher culturas quando elas mudam conduta, sem atrasar antibiótico em sepse/choque. A coleta adequada permite descalonamento, evita tratamento às cegas e reduz erro diagnóstico.

CONDUTA DE PARTIDA

Coletar culturas antes do antimicrobiano quando seguro, sem atrasar terapia urgente

Hemoculturas 2 pares em sepse, bacteremia suspeita, endocardite, meningite, CVC ou infecção grave

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Antes da primeira dose se não atrasar

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Bacteremia	MAIOR EM SEPSE/ FOCO INVASIVO	Hemoculturas são mais úteis antes do antibiótico
Colonização	COMUM EM URINA/FERIDAS	Cultura sem síndrome clínica pode induzir erro
Patógeno resistente	CONFORME RISCO	Culturas são essenciais se MDR, hospitalar ou falha terapêutica

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sepse, choque, meningite, endocardite, infecção hospitalar grave	Colher culturas imediatamente · 2 pares de hemocultura + culturas do foco; não atrasar antibiótico se instável · Conduta	Antes da primeira dose	Em choque, coleta deve ser rápida e não postergar tratamento.
Infecção leve ambulatorial típica	Cultura geralmente não necessária · Conduta: tratar clinicamente quando quadro bacteriano típico ou observar se provável viral/não bacteriano · Conduta	Conforme caso	Ex.: cistite simples típica, celulite leve sem pus, sinusite leve podem não exigir cultura.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Falha terapêutica ou recorrência	Colher antes de trocar/ampliar · Conduta: cultura do foco e hemoculturas se sinais sistêmicos, antes do novo esquema quando possível · Conduta	Antes do novo esquema	Aumenta chance de terapia direcionada.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Cultura não é diagnóstico isolado

Urina, escarro e ferida podem refletir colonização; correlacionar com clínica.

ALERTA CRÍTICO**Não atrasar antibiótico no choque**

A coleta é desejável, mas não deve atrasar antibiótico em instabilidade.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Antes de antibiótico	Perguntar se cultura mudará conduta: sepse, internação, foco profundo, falha, MDR ou imunossupressão.
2	Amostra	Colher do sítio correto e antes da primeira dose quando possível.
3	Resultado	Usar para descalonar, não apenas para ampliar.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▫ Culturas positivas com bacteremia verdadeira ▫ sepse ▫ foco profundo ▫ MDR
UTI	▫ Choque ▫ vasopressor ▫ insuficiência respiratória
Gravidade	▫ S. aureus/Candida em sangue ▫ meningite ▫ endocardite ▫ necrose ▫ abscesso profundo
Falha terapêutica	▫ Cultura colhida após antibiótico sem crescimento ▫ amostra inadequada ▫ colonização tratada como infecção

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas em sepse/choque, endocardite, meningite, bacteremia suspeita, CVC, infecção grave, imunossupressão e antes de escalonamento relevante.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▫ Usar cultura para estreitar espectro ▫ Ignorar colonização se sem síndrome clínica
Transição EV → VO	Não se aplica

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Não se aplica Conduta	Culturas são ferramenta diagnóstica GRAVE No choque, colher rápido e iniciar antibiótico	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos

- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.9

Quando NÃO Prescrever Antibiótico — Decisão Negativa

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional **recomendada**

Tópico de stewardship para situações comuns em que antibiótico costuma ser prescrito sem benefício. Útil para segurança do paciente, redução de resistência e comunicação clara na alta.

CONDUTA DE PARTIDA

Não prescrever antibiótico quando quadro não sugere bactéria tratável

Orientar evolução esperada, medidas sintomáticas e sinais de retorno

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Reavaliar se piora ou sinais de alarme

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Infecções virais de vias aéreas	MUITO COMUM	Resfriado, bronquite aguda e odinofagia viral não se beneficiam de antibiótico
Colonização/bacteriúria assintomática	COMUM	Não tratar, exceto gestação e antes de alguns procedimentos urológicos
Ferida limpa sem infecção	COMUM	Antibiótico não substitui limpeza, curativo e sinais de alarme

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
IVAS viral/bronquite aguda sem pneumonia	Não usar antibiótico · Conduta: sintomáticos, hidratação e retorno se sinais de alarme · Conduta	Evolução clínica	Explicar que secreção colorida isolada não prova bactéria.
Bacteriúria/piúria sem sintomas	Não tratar na maioria dos pacientes · Conduta: não prescrever apenas por EAS/urocultura positiva sem sintomas urinários · Conduta	Não se aplica	Exceções clássicas: gestação e procedimento urológico com sangramento de mucosa.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Surgem sinais de foco bacteriano/gravidade	Reavaliar e tratar conforme módulo específico · Escolher esquema pelo foco e gravidade · VO/ EV	Conforme foco	Decisão negativa exige instrução clara de retorno.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Antibiótico também causa dano

Eventos adversos, alergia, C. difficile, interação medicamentosa e resistência são riscos reais.

INFORMAÇÃO

Alta bem orientada é tratamento

Explicar duração esperada e sinais de retorno reduz insegurança e retorno inadequado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Pedido/expectativa de antibiótico	Explicar diagnóstico provável, por que antibiótico não ajuda e quais sinais exigem retorno.
2	Sem foco bacteriano	Prescrever sintomáticos e orientações objetivas.
3	Dúvida	Preferir reavaliação programada em vez de antibiótico “preventivo”.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Se surgirem critérios de gravidade ou foco bacteriano complicado
UTI	Não se aplica sem gravidade
Gravidade	▫ Hipoxemia ▫ sepse ▫ dor intensa progressiva ▫ imunossupressão ▫ desidratação grave
Falha terapêutica	▫ Piora após conduta sintomática ▫ novo foco ▫ febre persistente com sinais sistêmicos

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Evitar culturas sem indicação, pois resultados positivos por colonização induzem tratamento desnecessário.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	Suspender antibiótico iniciado sem indicação após reavaliação segura
Transição EV → VO	Não se aplica

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sem antibiótico Conduta	Não indicado GRAVE Se houver gravidade, reclassificar e usar o quadro específico do foco	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.10

Descalonamento e Duração Curta — Stewardship no Plantão

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Estratégia para reduzir espectro, toxicidade e duração sem comprometer segurança. Deve ser aplicada após estabilização, cultura, controle de foco e revisão diagnóstica.

CONDUTA DE PARTIDA

Reduzir espectro conforme cultura e foco

Reavaliar em 24–72 h: parar, estreitar, trocar VO ou manter se justificado

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Menor duração efetiva conforme foco e resposta

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Patógeno identificado	IDEAL	Permite reduzir espectro para droga mais estreita
Culturas negativas	FREQUENTE	Se paciente melhora e foco não bacteriano provável, considerar suspensão
Foco controlado	DETERMINANTE	Drenagem/retirada de dispositivo encurta tratamento

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Cultura identifica agente sensível	Trocar para droga mais estreita · Ex.: meropenem -> ceftriaxona/cefazolina conforme sensibilidade e foco · Conduta	Conforme foco; evitar prolongar sem motivo	Registrar racional do descalonamento.
Paciente estável, absorção oral e opção VO adequada	Switch EV -> VO · Escolher droga com boa biodisponibilidade e sensibilidade · Conduta	Completar duração total	Não trocar para VO em choque, bacteremia complicada, endocardite, meningite ou foco não controlado sem critério.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Diagnóstico bacteriano improvável	Suspender antibiótico · Conduta: interromper e observar clinicamente quando bactéria for improvável · Conduta	Não se aplica	Suspensão é uma forma válida de stewardship quando a hipótese bacteriana não se sustenta e o paciente está seguro.

ALERTAS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO

Antibiotic timeout

Revisar indicação, espectro, dose, via e duração em 48–72 h.

ATENÇÃO

Não manter cobertura “por garantia”

Cobertura prolongada amplia toxicidade e seleção de resistência.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	48–72 h de antibiótico	Perguntar: ainda precisa? qual foco? qual agente? qual menor espectro? pode VO? qual duração final?
2	Melhora + dados disponíveis	Estreitar ou suspender conforme cultura e diagnóstico.
3	Alta	Registrar duração total e critérios de retorno.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Depende do foco inicial
UTI	Não descalonar de forma insegura em choque não controlado
Gravidade	▪ Bacteremia persistente ▪ foco fechado ▪ endocardite/meningite ▪ imunossupressão grave
Falha terapêutica	▪ Piora após descalonamento ▪ cultura tardia resistente ▪ foco não drenado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Culturas e identificação microbiológica facilitam descalonamento; ausência de cultura exige reavaliação clínica rigorosa.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Parar se sem infecção bacteriana ▪ Estreitar por cultura ▪ Retirar anti-MRSA/antipseudomonas/anaeróbio quando sem critério ▪ Trocar EV para VO se adequado
Transição EV → VO	Estável, afebril ou melhorando, sem vômitos/íleo, foco controlado, droga VO ativa e boa adesão

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Estratégia de descalonamento Conduta	Não é droga específica GRAVE Se grave, descalonar apenas com estabilidade e dados adequados	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.11

Ajuste Renal / Hemodiálise — Antibióticos no Plantão

MODERADA HOSPITALAR ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Checklist para evitar subdose em sepse e toxicidade em insuficiência renal. Em infecção grave, dose de ataque costuma ser necessária; manutenção deve ser ajustada por função renal, diálise e farmacocinética da droga.

CONDUTA DE PARTIDA

Dose de ataque quando grave + manutenção ajustada

Calcular função renal, peso, diálise e intervalo; revisar em 24 h

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Durante todo tratamento

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Subdose inicial	RISCO EM SEPSE	Aumenta falha terapêutica; dose de ataque não deve ser omitida quando indicada
Acúmulo/toxicidade	RISCO EM DRC/IRA	Vancomicina, aminoglicosídeos, cefepime, aciclovir e TMP-SMX exigem atenção
Hemodiálise	SITUAÇÃO ESPECIAL	Doses pós-HD e tipo de diálise mudam a conduta

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção grave/sepse com DRC/IRA	Fazer dose de ataque quando indicada · Ex.: vancomicina carga 25–30 mg/kg; betalactâmico em dose plena inicial conforme gravidade · EV	Dose inicial; depois ajustar manutenção	Ajuste renal geralmente afeta manutenção, não a necessidade de atingir nível inicial em sepse.
Após estabilização/dose inicial	Ajustar manutenção por CrCl/diálise · Usar protocolo local/bula/farmácia clínica para intervalo e dose · Conduta	Revisar diariamente se IRA dinâmica	Cefepime, aciclovir, vancomicina e aminoglicosídeos exigem atenção especial por neuro/nefrotoxicidade.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Alto risco de toxicidade	Preferir alternativa menos nefrotóxica quando possível · Evitar aminoglicosídeo se alternativa eficaz; monitorar vancomicina · Conduta	Conforme foco	Não sacrificar cobertura essencial em choque; monitorar e ajustar.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Não subdosar sepse por medo da creatinina

Dose inicial adequada é fundamental; ajuste deve ser planejado para manutenção.

ATENÇÃO

Revisar função renal diariamente

IRA muda rapidamente; dose correta hoje pode ser tóxica amanhã.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Antes da prescrição	Ver peso, creatinina, tendência renal, diálise, alergias e gravidade.
2	Infecção grave	Prescrever dose inicial eficaz e planejar ajuste da manutenção.
3	Seguimento	Revisar diariamente CrCl, diálise, níveis quando disponíveis e sinais de toxicidade.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ DRC/IRA com infecção moderada/grave ▪ necessidade de EV ▪ toxicidade ou monitorização
UTI	▪ Choque ▪ IRA grave com sepse ▪ necessidade de terapia renal substitutiva
Gravidade	▪ Sepse ▪ IRA progressiva ▪ oligúria ▪ níveis tóxicos ▪ neurotoxicidade
Falha terapêutica	▪ Subdose ▪ droga não ajustada ▪ toxicidade limitante ▪ diálise não considerada

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Culturas ajudam a reduzir exposição a drogas nefrotóxicas e estreitar cobertura.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Reduzir nefrotoxicidade assim que cultura permitir ▪ Evitar aminoglicosídeo prolongado sem necessidade
Transição EV → VO	Trocar para VO quando foco permitir e houver droga segura para função renal

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Vancomicina EV	15–20 mg/kg manutenção conforme nível/AUC GRAVE Dose de ataque 25–30 mg/kg se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	Definir dose de ataque, peso de dose e manutenção pela indicação e função renal. Usar AUC quando sustentado (especialmente MRSA invasivo) e protocolo institucional; meningite e outros sítios exigem interpretação própria.
Cefepime EV	2 g EV a cada 8–12 h conforme foco GRAVE 2 g EV 8/8 h se grave, ajustar manutenção	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Aciclovir EV	10 mg/kg EV 8/8 h em encefalite, ajustar renal GRAVE 10 mg/kg EV 8/8 h; hidratar e ajustar CrCl	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.

- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.12

Antibiótico na Gestante/Lactante — Abordagem Inicial

MODERADA

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Roteiro de segurança para escolher antibiótico em gestantes e lactantes, equilibrando risco materno-fetal e necessidade de tratar infecções bacterianas. Infecção grave na gestante deve ser tratada prontamente; o erro é tanto atrasar tratamento quanto usar droga evitável sem necessidade.

CONDUTA DE PARTIDA

Preferir betalactâmicos seguros quando adequados

Escolher por foco; revisar idade gestacional, alergias e risco fetal

VIA

VO/EV

DURAÇÃO

Conforme foco

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Infecções urinárias/respiratórias/pele	FREQUENTES	Selecionar droga pelo foco e segurança gestacional
Listeria monocytogenes	CENÁRIO ESPECIAL	Considerar em meningite/sepsse gestacional; ampicilina é peça-chave
Anaeróbios/infecção pélvica	CONFORME OBSTÉTRICO	Corioamnionite, endometrite e aborto séptico exigem esquemas próprios

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Infecção bacteriana comum com opção segura	Penicilinas/cefalosporinas conforme foco · Ex.: ceftriaxona, cefalexina, amoxicilina-clavulanato conforme indicação · VO/EV	Conforme foco	Em geral são opções preferenciais quando ativas e sem alergia relevante.
Sepsse/infecção grave na gestante	Não atrasar antibiótico adequado · Usar esquema do foco com revisão obstétrica; considerar ampicilina se Listeria em SNC/sepsse compatível · Conduta	Conforme foco	Risco materno de não tratar costuma superar risco teórico de muitas drogas.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Droga com maior cautela/evitar se alternativa	Evitar quinolonas, tetraciclina e aminoglicosídeos prolongados quando possível · Usar somente se benefício superar risco e sem alternativa melhor · Conduta	Menor duração efetiva	Nitrofurantoína e TMP-SMX dependem de trimestre, deficiência de G6PD, tipo de infecção e protocolo local.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
ANAEROBIOS	▪ Infecção obstétrica/pélvica ▪ aborto séptico ▪ endometrite ▪ corioamnionite	Esquemas obstétricos específicos com anaerobicida quando indicado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Sepse na gestante é emergência materna

Não atrasar antibiótico apropriado por receio genérico; individualizar droga.

ATENÇÃO

Revisar idade gestacional

Algumas drogas têm cautelas diferentes por trimestre e periparto.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Gestante com infecção	Definir foco, gravidade, idade gestacional, alergias e necessidade de avaliação obstétrica.
2	Infecção leve	Escolher opção segura e ativa, evitando drogas desnecessariamente arriscadas.
3	Infecção grave	Priorizar tratamento materno efetivo, culturas e internação quando indicado.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	▪ Pielonefrite ▪ sepse ▪ hiperêmese/desidratação ▪ infecção obstétrica ▪ falha VO ▪ risco fetal/materno
UTI	▪ Choque ▪ hipoxemia ▪ disfunção orgânica
Gravidade	▪ Febre com dor lombar ▪ hipotensão ▪ taquicardia persistente ▪ alteração fetal/obstétrica ▪ abdome agudo
Falha terapêutica	▪ Persistência febril ▪ vômitos impedindo VO ▪ cultura resistente ▪ piora obstétrica

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Urina em suspeita urinária; hemoculturas se febre alta, pielonefrite, internação, sepse ou foco grave; culturas obstétricas conforme indicação.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Ajustar por cultura e segurança gestacional ▪ Evitar drogas de amplo espectro sem necessidade
Transição EV → VO	VO quando estável, tolerando dieta, afebril/melhorando e com foco adequado para terapia oral

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Ceftriaxona EV	1–2 g EV 24/24 h conforme foco GRAVE 2 g EV 24/24 h; meningite exige esquema específico	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	
Amoxicilina-clavulanato VO/EV	875/125 mg VO 12/12 h GRAVE Usar EV equivalente/protocolo se grave	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	
Ampicilina EV	2 g EV 6/6 h conforme foco GRAVE 2 g EV 4/4 h em meningite/Listeria conforme protocolo	<50 mL/min: Ajustar dose/intervalo conforme função renal, peso, diálise e protocolo local	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.13

Antibiótico Antes de Transferência/Regulação — PS

GRAVE

HOSPITALAR

ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional obrigatória

Orientação para não atrasar antibiótico em infecções tempo-dependentes enquanto aguarda vaga, imagem, ambulância ou avaliação especializada. A transferência não deve ser usada como motivo para postergar primeira dose quando há indicação clara.

CONDUTA DE PARTIDA

Primeira dose antes da transferência se infecção grave provável

Escolher esquema pelo foco/gravidade; registrar horário e culturas

VIA

EV

DURAÇÃO

Primeira dose + continuidade no destino

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Meningite/seps/fasciite/pneumonia grave	TEMPO-DEPENDENTE	Atraso de antibiótico pode piorar desfecho
Infecção com necessidade cirúrgica	IMPORTANTE	Antibiótico não substitui transferência para controle de foco
MDR/hospitalar	CONFORME CONTEXTO	Considerar colonização e antibiótico recente

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Indicação clara de antibiótico EV e espera por transferência	Administrar primeira dose no serviço de origem · Usar o quadro específico do foco do foco; registrar horário, dose e culturas · EV	Manter até transferência e reavaliação	Não aguardar vaga/regulação se há seps, choque, meningite, fasciite, pneumonia grave ou outra infecção tempo-dependente.

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Culturas possíveis sem atraso relevante	Colher antes da primeira dose · Hemoculturas/ culturas do foco conforme caso · Conduta	Antes do antibiótico	Se instável, não atrasar por dificuldade de coleta.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Sem foco bacteriano/sem gravidade	Não fazer antibiótico “para garantir” · Conduta: observar e encaminhar conforme diagnóstico quando não há foco bacteriano/gravidade · Conduta	Não se aplica	Evita mascarar quadro sem benefício.

QUANDO AMPLIAR A COBERTURA

ALVO	CRITÉRIOS OBJETIVOS	OPÇÃO SUGERIDA
MRSA	▪ Fasciíte/celulite grave ▪ CVC/hemodiálise ▪ pneumonia grave com risco ▪ colonização	Vancomicina/linezolida conforme foco
PSEUDOMONAS	▪ Hospitalar/UTI ▪ neutropenia ▪ bronquiectasia ▪ antibiótico recente	Cefepime, pip-tazo ou meropenem
ANAEROBIOS	Abdome, necrose, aspiração, períneo, odontogênico profundo	Pip-tazo, carbapenêmico ou metronidazol associado

ALERTAS DE SEGURANÇA

ALERTA CRÍTICO

Transferência não deve atrasar primeira dose

Em infecções graves, iniciar antibiótico e documentar horário antes do transporte.

ATENÇÃO

Antibiótico não substitui controle de foco

Abscesso, abdome, obstrução, necrose e via aérea precisam de procedimento/serviço adequado.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Regulação solicitada	Definir se antibiótico é tempo-dependente e se primeira dose deve ocorrer antes da saída.
2	Antes do transporte	Colher culturas se possível, administrar dose, registrar horário e comunicar esquema ao destino.
3	Controle de foco	Descrever necessidade de cirurgia/drenagem/UTI/via aérea no encaminhamento.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Infecção grave aguardando leito/serviço
UTI	▪ Choque ▪ meningite grave ▪ insuficiência respiratória ▪ vasopressor

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Gravidade	▪ Sepses ▪ choque ▪ meningite ▪ fasciite ▪ epiglote ▪ pneumonia grave
Falha terapêutica	▪ Atraso na dose ▪ esquema sem cobertura ▪ foco sem controle

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Hemoculturas e culturas do foco antes da dose quando possível, sem atrasar em choque/meningite/sepses graves.
Controle de foco	Descrever necessidade de cirurgia/drenagem/UTI/via aérea no encaminhamento.
Marco da duração	Definir a duração a partir do controle adequado do foco e da primeira terapia ativa, conforme a síndrome; documentar o marco usado.
Descalonamento	Destino deve revisar após cultura e controle de foco
Transição EV → VO	Não trocar para VO antes da transferência em infecção grave sem estabilidade e foco definido

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Conforme foco EV	Usar o quadro específico do foco GRAVE Em sepsis/choque, usar dose de gravidade	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome de alto risco, dependente de protocolo institucional, microbiologia local, gravidade, disponibilidade de antimicrobianos e suporte especializado.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

19.14

PCR / Procalcitonina / Leucocitose — Como Não Supertratar

LEVE AMBULATORIAL ADULTO

Bibliografia de capítulo · Revisão · revisão 14/05/2026 · validação institucional recomendada

Interpretação prática de marcadores inflamatórios no plantão. Marcadores ajudam em contexto, mas não definem sozinho infecção bacteriana nem obrigam antibiótico em paciente clinicamente estável.

CONDUTA DE PARTIDA

Não tratar marcador isolado

Decisão deve integrar clínica, foco, gravidade, imagem e culturas

VIA

Conduta

DURAÇÃO

Reavaliar conforme evolução

AGENTES E CONTEXTO

AGENTE	RELEVÂNCIA	CONTEXTO CLÍNICO
Inflamação não infecciosa	COMUM	Trauma, cirurgia, pancreatite, TEP, autoimune e neoplasia podem elevar marcadores
Infecção bacteriana	CONTEXTUAL	Marcadores aumentam probabilidade se quadro clínico compatível
Infecção viral	COMUM	PCR pode elevar; PCT baixa não exclui todas as infecções bacterianas

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS

CENÁRIO	ESQUEMA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Paciente estável, sem foco, marcador alterado isolado	Não iniciar antibiótico apenas pelo exame · Conduta: reavaliar clínica e repetir/acompanhar marcador se necessário · Conduta	Conforme evolução	Tratar paciente e síndrome clínica, não número isolado. Marcadores devem complementar, não substituir, avaliação clínica.
Marcador elevado + síndrome infecciosa/seps	Antibiótico conforme foco/seps · Usar o quadro específico do foco · EV	Conforme foco	Neste cenário, marcador reforça, mas não substitui julgamento clínico.

ALTERNATIVAS E ALERGIA

Classifique a reação antes de substituir o betalactâmico — ver “Alergia a betalactâmico” na abertura e o quadro 19.7.

CENÁRIO	ALTERNATIVA E DOSE	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Boa evolução e baixa probabilidade bacteriana	Considerar suspender/encurtar antibiótico · Basear em evolução, foco e protocolo local · VO/EV	Menor duração efetiva	PCT seriada pode ajudar em alguns contextos, mas não deve ser única decisão.

ALERTAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Leucocitose não é sinônimo de bactéria

Corticoide, estresse, dor, convulsão e inflamação podem elevar leucócitos.

INFORMAÇÃO

Tendência importa mais que valor único

Evolução clínica e tendência de marcadores são mais úteis que medida isolada.

CONDUTA PASSO A PASSO

ETAPA	CONDIÇÃO	AÇÃO
1	Marcador alterado	Reavaliar sinais vitais, exame físico e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana.
2	Sem foco e estável	Não prescrever antibiótico apenas pelo número; orientar retorno ou reavaliar.
3	Com gravidade	Tratar conforme síndrome/foco e usar marcador apenas como apoio.

CRITÉRIOS

CATEGORIA	CRITÉRIOS
Internação	Marcador alterado com instabilidade, foco grave ou comorbidade relevante
UTI	Choque, hipoxemia, disfunção orgânica
Gravidade	Lactato elevado, hipotensão, confusão, hipoxemia, IRA
Falha terapêutica	▪ Marcadores sobem com piora clínica ▪ novo foco ▪ diagnóstico alternativo não investigado

MICROBIOLOGIA, CONTROLE DE FOCO E STEWARDSHIP

EIXO	CONDUTA
Culturas	Culturas devem ser guiadas por foco/gravidade, não por PCR/PCT isoladas.
Marco da duração	Contar a partir da primeira dose ativa, ajustando por resposta, microbiologia e complicações, salvo regra específica do quadro.
Descalonamento	▪ Suspender se baixa probabilidade bacteriana e paciente estável ▪ Não prolongar antibiótico por PCR residual isolada
Transição EV → VO	Não se aplica

ANTIMICROBIANOS E AJUSTES

FÁRMACO	DOSE	FUNÇÃO RENAL	OBSERVAÇÕES
Sem antibiótico por marcador isolado Conduta	Não indicado GRAVE Se sepse/foco, usar o quadro específico do foco	Geral: Não se aplica diretamente; usar para decisão clínica e revisar droga escolhida	

VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

- Síndrome transversal de decisão clínica; recomendações devem ser adaptadas ao protocolo local, epidemiologia, recursos disponíveis e perfil do paciente.
- Confirmar estabilidade clínica, foco provável e probabilidade pré-teste de infecção bacteriana
- Checar culturas necessárias antes do antimicrobiano quando isso não atrasar terapia urgente
- Considerar microbiologia local, colonização/resistência prévia e exposição recente a antimicrobianos
- Registrar racional para iniciar, não iniciar, ampliar, descalonar ou suspender antibiótico

BIBLIOGRAFIA DO CAPÍTULO 19 — SÍNDROMES PRÁTICAS

- Surviving Sepsis Campaign. International Guidelines, 2026.
- CDC. Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs.



Fichas de antimicrobianos

41 fármacos

Referência rápida de espectro, dose e segurança. Atividade depende da espécie, mecanismo, sítio e sensibilidade; grandes grupos não são binários. Fonte farmacêutica sustenta dose/preparo, enquanto indicação e duração pertencem à diretriz da síndrome.

A1

Aciclovir

- ESTREITO
- ANTIVIRAIS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
400 mg VO 8/8 h ou 800 mg VO 5x/dia conforme indicação	10 mg/kg EV 8/8 h em encefalite/infecção grave	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS depende
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------

Vírus: HSV/VZV

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Na via EV: definir peso em obesidade, hidratar, infundir por pelo menos 1 h e ajustar à função renal.
- EV: infundir por pelo menos 1 h, garantir hidratação e ajustar à função renal; acompanhar creatinina e neurotoxicidade.
- Na obesidade, definir peso de dose pelo protocolo/farmácia clínica em vez de usar automaticamente o peso real.
- Iniciar precocemente se suspeita de encefalite herpética.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Nefrotoxicidade cristalina ▪ Neurotoxicidade em DRC ▪ Náusea	• Nefrotóxicos aumentam risco renal

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A2

Amicacina

- INTERMEDIÁRIO
- AMINOGLICOSÍDEOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
15–20 mg/kg EV 24/24 h	20–25 mg/kg EV 24/24 h conforme gravidade/protocolo	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL depende	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------

ESBL: se sensível

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Definir peso real/ideal/ajustado; monitorar níveis, nefrotoxicidade e ototoxicidade; dose estendida não se aplica a todo cenário.
- Útil contra Gram-negativos resistentes somente quando sensíveis; usar peso ajustado em obesidade conforme protocolo.
- Monitorar níveis, função renal e toxicidade auditiva/vestibular. Dose estendida não se aplica a todo cenário clínico.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Nefrotoxicidade ▪ Ototoxicidade	• Nefrotóxicos e diuréticos de alça

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A3

Amoxicilina

- ESTREITO
- PENICILINAS
- VO
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO 8/8 h ou 1 g VO 8/8 h	1 g VO 8/8 h quando dose alta indicada	VO

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G- Bacilli: H. influenzae variável

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Não cobre betalactamase; preferir amoxicilina-clavulanato quando essa cobertura for necessária.
- Muito usada para PAC/otite/sinusite selecionadas em cenário ambulatorial.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Diarreia ▪ Rash ▪ Reação alérgica	▪ Alopurinol pode aumentar rash ▪ Pode alterar INR em usuários de varfarina

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A4

Amoxicilina-clavulanato

- INTERMEDIÁRIO
- PENICILINAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
875/125 mg VO 12/12 h ou 500/125 mg VO 8/8 h	1,2 g EV 8/8 h; em infecção grave considerar protocolo local	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa opção para mordeduras, sinusite/otite com risco de betalactamase e infecção odontogênica leve/moderada.
- Não cobre MRSA, Pseudomonas nem ESBL.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Diarreia • Náusea • Hepatotoxicidade colestática rara	• Varfarina/anticoagulantes: monitorar INR

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A5

Ampicilina

- ESTREITO
- PENICILINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2 g EV 6/6 h	2 g EV 4/4 h em meningite, listeriose e endocardite enterocócica	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS depende	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: Enterococcus faecalis sensível, Streptococcus · G- Bacilli: só sem betalactamase · Anaeróbios: flora oral

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Fármaco de escolha para Listeria monocytogenes — cobertura obrigatória na meningite do maior de 50 anos, imunossuprimido, alcoolista ou gestante.
- Base do tratamento de endocardite e de infecção invasiva por Enterococcus faecalis sensível; a associação com ceftriaxona poupa aminoglicosídeo.
- Não cobre produtores de betalactamase: para essa cobertura, usar ampicilina-sulbactam ou amoxicilina-clavulanato.
- Ajuste renal: > 50 mL/min dose padrão; 10–50 mL/min a cada 6–8 h; < 10 mL/min a cada 8–12 h.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Exantema (muito frequente em mononucleose) ▪ Diarreia ▪ Reação alérgica ▪ Convulsão em dose alta com disfunção renal	▪ Alopurinol aumenta a chance de exantema ▪ Pode reduzir a eficácia de contraceptivos orais (efeito pequeno)

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Ficha acrescentada na 4ª edição. Revisão da ficha: setembro de 2026.

A6

Ampicilina-sulbactam

- AMPLO
- PENICILINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1,5–3 g EV 6/6 h	Uso convencional: até 3 g EV 6/6 h; CRAB: regime especializado visando 9 g/dia do componente sulbactam, sempre com segundo agente e infectologia	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Distinguir uso convencional de regime especializado de alta dose do componente sulbactam em CRAB.
- Útil para aspiração, mordeduras, infecções odontogênicas e SSTI polimicrobiana selecionada.
- O regime convencional não é opção confiável para Pseudomonas ou ESBL.
- CRAB é uma exceção especializada: usar dose alta calculada pelo componente sulbactam, em combinação, com ajuste renal e validação farmacêutica.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Diarreia ▪ Rash ▪ Elevação de transaminases	• Anticoagulantes: monitorar se uso prolongado

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A7

Anfotericina B lipossomal

- MUITO AMPLO
- ANTIFÚNGICOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
3–5 mg/kg EV 24/24 h	5 mg/kg EV 24/24 h ou conforme micose/sítio	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Reservada para micoses invasivas graves e patógenos específicos.
- Monitorar eletrólitos e função renal de perto.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Nefrotoxicidade ▪ Hipocalcemia/hipomagnesemia ▪ Reação infusional	▪ Nefrotóxicos ▪ Digitálicos pelo risco de hipocalcemia

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A8

Azitromicina

- ESTREITO
- MACROLÍDEOS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO/EV 24/24 h; ou 500 mg dia 1 e 250 mg/dia	500 mg EV/VO 24/24 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: pneumococo variável · G- Bacilli: H. influenzae

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa cobertura de atípicos respiratórios.
- Evitar como monoterapia se pneumococo resistente for provável.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ QT longo ▪ Náusea/diarreia ▪ Hepatotoxicidade rara	▪ Antiarrítmicos e outros fármacos que prolongam QT ▪ Varfarina

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A9

Aztreonam

- INTERMEDIÁRIO
- MONOBACTÂMICOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1–2 g EV 8/8 h	2 g EV a cada 6–8 h conforme gravidade	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Cobre apenas Gram-negativos aeróbios, incluindo Pseudomonas.
- Pode ser útil em alergia imediata a betalactâmico, mas não cobre Gram-positivos nem anaeróbios.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Rash ▪ Elevação de transaminases ▪ Diarreia	• Poucas interações relevantes

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A10

Cefalexina

- ESTREITO
- CEFALOSPORINAS
- VO
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO 6/6 h	1 g VO 6/6 h em infecções selecionadas	VO

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G- Bacilli: alguns urinários

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa opção para celulite não purulenta leve e cistite em cenários selecionados.
- Não cobre MRSA, anaeróbios relevantes nem Pseudomonas.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Diarreia • Rash • Náusea	• Varfarina: pode alterar INR

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A11

Cefazolina

ESTREITO

CEFALOSPORINAS

EV

FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1–2 g EV 8/8 h	Tratamento: geralmente 2 g EV 8/8 h conforme foco; 3 g em peso elevado é regra clássica de profilaxia cirúrgica, não dose terapêutica genérica	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G- Bacilli: alguns Enterobacterales sensíveis

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- 3 g em peso elevado é referência clássica de profilaxia cirúrgica, não dose terapêutica genérica.
- Excelente para MSSA e estreptococos; usada em profilaxia cirúrgica. Na profilaxia, peso elevado pode alterar a dose conforme protocolo.
- Não cobre MRSA, Enterococcus, anaeróbios nem Pseudomonas.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Rash • Diarreia • Citopenia rara	• Varfarina: monitorar INR

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.

- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A12

Cefepime

- AMPLO
- CEFALOSPORINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2 g EV a cada 8–12 h conforme função renal/sítio	2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL depende	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------

ESBL: não preferir

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa opção antipseudomonas e para neutropenia febril.
- Ajuste renal é crítico para evitar neurotoxicidade.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Neurotoxicidade em DRC ▫ Mioclonia/encefalopatia ▫ Diarreia	• Aminoglicosídeos/diuréticos: nefrotoxicidade aditiva

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A13

Ceftazidima

- AMPLO
- CEFALOSPORINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2 g EV 8/8 h	2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: fraca para G+

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Anti-Pseudomonas, mas fraca para Gram-positivos.
- Não cobre MRSA, Enterococcus, anaeróbios nem ESBL de forma confiável.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Diarreia ▫ Neurotoxicidade em DRC ▫ Rash	• Aminoglicosídeos: nefrotoxicidade aditiva

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A14

Ceftazidima-avibactam

- MUITO AMPLO
- CEFALOSPORINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2,5 g EV 8/8 h em infusão de 2 h	2,5 g EV 8/8 h; ajustar por função renal	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Opção para CRE/KPC e alguns DTR-Pseudomonas conforme sensibilidade.
- Não cobre metalo-betalactamases sem combinação específica; não cobre MRSA/anaeróbios.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Náusea ▫ Diarreia ▫ Elevação de transaminases	• Poucas interações clinicamente relevantes

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A15

Ceftriaxona

- INTERMEDIÁRIO
- CEFALOSPORINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1–2 g EV/IM 24/24 h	2 g EV 12/12 h para meningite; 2 g/dia em quadros graves conforme sítio	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa penetração no LCR quando meninges inflamadas.
- Não cobre Pseudomonas, MRSA, Enterococcus, anaeróbios relevantes nem ESBL.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Colestase/pseudotifase ▫ Diarreia ▫ Precipitação com cálcio em neonatos	▫ Soluções com cálcio em neonatos ▫ Varfarina

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A16

Cefuroxima

- INTERMEDIÁRIO
- CEFALOSPORINAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO 12/12 h	1,5 g EV 8/8 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Opção para algumas infecções respiratórias/urinárias por patógenos sensíveis.
- Não cobre Pseudomonas, MRSA ou ESBL.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Diarreia ▫ Rash ▫ Náusea	• Antiácidos/IBP podem reduzir absorção da forma axetil

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A17

Ciprofloxacino

- INTERMEDIÁRIO
- QUINOLONAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500–750 mg VO 12/12 h ou 400 mg EV a cada 8–12 h	400 mg EV 8/8 h em Pseudomonas grave se sensível	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: fraco para pneumococo

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa atividade Gram-negativa urinária/abdominal quando sensível.
- Evitar uso indiscriminado por resistência e eventos adversos.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Tendinopatia/ruptura ▫ QT longo ▫ Disglicemia/neurotoxicidade	▫ Cátions/antiácidos reduzem absorção ▫ Corticoide aumenta risco tendíneo ▫ Warfarina

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A18

Claritromicina

- ESTREITO
- MACROLÍDEOS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO 12/12 h	500 mg VO/EV 12/12 h se disponível	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: pneumococo variável · G- Bacilli: H. influenzae

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Mais interações que azitromicina.
- Ajustar em insuficiência renal.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ QT longo ▪ Gosto metálico ▪ Hepatotoxicidade	▪ Inibidor CYP3A4: estatinas, benzodiazepínicos, antiarrítmicos ▪ Varfarina

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A19

Clindamicina

- INTERMEDIÁRIO
- OUTRAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
300–450 mg VO a cada 6–8 h	600–900 mg EV 8/8 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA depende	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

MRSA: se sensível

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa inibição de toxinas em fasciite/choque tóxico quando associada.
- MRSA é variável; confirmar sensibilidade quando possível.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• C. difficile • Diarreia • Rash	• Eritromicina pode ter antagonismo

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A20

Daptomicina

- ESTREITO
- LIPOPEPTÍDEOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
4–6 mg/kg EV 24/24 h conforme indicação	8–10 mg/kg EV 24/24 h em bacteremia/endocardite por MRSA/VRE	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Não usar em pneumonia alveolar; monitorar CPK.
- Não usar para pneumonia: é inativada pelo surfactante pulmonar.
- Útil para bacteremia/endocardite por Gram-positivos conforme sensibilidade.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Miopatia/CPK elevada • Pneumonite eosinofílica rara	• Estatinas: aumenta risco de miopatia

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A21

Doxiciclina

- INTERMEDIÁRIO
- TETRACICLINAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
100 mg VO/EV 12/12 h	100 mg VO/EV 12/12 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS cobre	MRSA depende	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: inclui alguns CA-MRSA · G- Bacilli: alguns · MRSA: CA-MRSA variável

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Muito útil para rickettsioses, atípicos, ISTs e algumas SSTI por CA-MRSA.
- Evitar em gestação e crianças pequenas salvo indicações específicas de alto risco.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Fotossensibilidade • Esofagite medicamentosa • Náusea	• Cátions/antiácidos/ferro reduzem absorção • Isotretinoína

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A22

Ertapenem

AMPLIO	CARBAPENÊMICOS	EV	FICHA
--------	----------------	----	-------

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1 g EV/IM 24/24 h	1 g EV 24/24 h; ajustar na DRC	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Carbapenêmico sem cobertura para Pseudomonas, Acinetobacter e Enterococcus.
- Útil para ESBL comunitária sem risco antipseudomonas.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Diarreia • Convulsão rara • Elevação de transaminases	• Valproato: reduz níveis de forma importante

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A23

Fluconazol

- INTERMEDIÁRIO
- ANTIFÚNGICOS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
200–400 mg VO/EV 24/24 h	Dose de ataque 800 mg, depois 400 mg VO/EV 24/24 h para candidemia selecionada	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS depende	VÍRUS não cobre
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fungos: Candida sensível

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa biodisponibilidade oral e penetração urinária.
- Não cobrir empiricamente Candida glabrata/krusei grave sem sensibilidade.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Hepatotoxicidade • QT longo • Náusea	• Warfarina aumenta INR • Fenitoína • Estatinas/CYP

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A24

Fosfomicina trometamol

- NITROFURÂNICOS/FOSFOMICINA
- ESTREITO
- VO
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
3 g VO dose única para cistite não complicada	Não indicada para pielonefrite/seps	VO

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: alguns Enterococcus · G- Bacilli: E. coli urinária

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Uso principal: cistite baixa por patógenos sensíveis.
- Não usar para pielonefrite, prostatite ou bacteremia.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Diarreia ▫ Náusea ▫ Cefaleia	• Metoclopramida pode reduzir concentração urinária

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A25

Gentamicina

- INTERMEDIÁRIO
- AMINOGLICOSÍDEOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
5–7 mg/kg EV 24/24 h conforme alvo/protocolo	7 mg/kg EV 24/24 h; monitorar níveis	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: sinergia

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Definir peso real/ideal/ajustado; monitorar níveis, nefrotoxicidade e ototoxicidade; dose estendida não se aplica a todo cenário.
- Usar peso ajustado em obesidade quando definido pelo protocolo; confirmar peso ideal/ajustado, função renal e nomograma.
- Dose estendida não se aplica automaticamente a sinergia em endocardite, gestação, grandes queimados, ascite importante ou função renal muito instável; monitorar pico/vale ou estratégia institucional.
- Nefrotoxicidade e ototoxicidade exigem revisão diária; evitar monoterapia fora de ITU selecionada.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Nefrotoxicidade ▫ Ototoxicidade ▫ Bloqueio neuromuscular raro	• Vancomicina/anfotericina/diuréticos: toxicidade aditiva

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A26

Levofloxacino

- INTERMEDIÁRIO
- QUINOLONAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500–750 mg VO/EV 24/24 h	750 mg VO/EV 24/24 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS depende	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

Pseudomonas: dose alta se sensível

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Fluoroquinolona respiratória com cobertura de atípicos.
- Ajuste renal obrigatório.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Tendinopatia/ruptura ▪ QT longo ▪ Disglicemia/neurotoxicidade	▪ Cátions/antiácidos ▪ Corticoide ▪ Antiarrítmicos

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A27

Linezolida

- ESTREITO
- OXAZOLIDINONAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
600 mg VO/EV 12/12 h	600 mg VO/EV 12/12 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Excelente biodisponibilidade oral e penetração pulmonar.
- Evitar para bacteremia/endocardite quando alternativa bactericida for indicada.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Trombocitopenia ▪ Neuropatia periférica/óptica se prolongado ▪ Síndrome serotoninérgica	▪ ISRS/IRSN/IMAO/tramadol: serotoninérgica ▪ Mielossuppressores

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A28

Meropenem

- MUITO AMPLO
- CARBAPENÊMICOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
1 g EV 8/8 h	2 g EV 8/8 h; considerar infusão estendida em SNC/MDR	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: não Enterococcus faecium

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Reserva para ESBL grave, sepsse grave e infecções hospitalares selecionadas.
- Não cobre MRSA, VRE ou KPC/CRE sem sensibilidade.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Diarreia ▪ Convulsão rara ▪ Trombocitopenia	• Valproato: queda acentuada dos níveis

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A29

Metronidazol

- ESTREITO
- NITROIMIDAZÓIS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
500 mg VO/EV 8/8 h	500 mg EV 8/8 h	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS depende	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

Atípicos: protozoários

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Excelente para anaeróbios abaixo do diafragma e protozoários.
- Não cobre aeróbios; geralmente precisa associação.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Gosto metálico • Náusea • Neuropatia se prolongado	• Álcool: reação tipo dissulfiram • Varfarina aumenta INR

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A30

Micafungina

- AMPLO
- ANTIFÚNGICOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
100 mg EV 24/24 h	100–150 mg EV 24/24 h conforme sítio/gravidade	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Equinocandina: boa escolha inicial para candidemia em paciente hospitalizado.
- Baixa penetração urinária; não é ideal para candidúria isolada.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Elevação de transaminases • Náusea • Flebite	• Poucas interações relevantes

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A31

Nitrofurantoína

NITROFURÂNICOS/FOSFOMICINA

ESTREITO

VO

FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
Confirmar formulação: monoidratada/macro-cristais costuma usar 100 mg VO 12/12 h; macrocristais pode exigir intervalo diferente conforme bula brasileira	Não indicada para pielonefrite/sepse	VO

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: Enterococcus urinário · G- Bacilli: uropatógenos

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Intervalo depende da formulação; não trata pielonefrite ou prostatite.
- Apenas para cistite baixa não complicada e com função renal compatível; o intervalo depende da formulação efetivamente dispensada.
- Não usar em pielonefrite, prostatite, bacteremia ou sepse urinária.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▮ Náusea ▮ Pneumonite rara ▮ Hepatotoxicidade rara ▮ Neuropatia	• Antiácidos com magnésio reduzem absorção

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A32

Oseltamivir

ESTREITO

ANTIVIRAIS

VO

FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
75 mg VO 12/12 h por 5 dias	75 mg VO 12/12 h; duração maior em grave/imunossuprimido conforme protocolo	VO

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS depende
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------

Vírus: Influenza A/B

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Maior benefício se iniciado nas primeiras 48 h, mas considerar em grave/hospitalizado mesmo após esse período.
- Ajustar na insuficiência renal.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Náusea/vômitos ▫ Cefaleia ▫ Eventos neuropsiquiátricos raros	• Poucas interações relevantes

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A33

Oxacilina

- ESTREITO
- PENICILINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2 g EV a cada 4–6 h	2 g EV 4/4 h em bacteremia/endocardite por MSSA	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI	G- BACILLI	ANAERÓBIOS	ATÍPICOS	MRSA	PSEUDOMONAS	ESBL	FUNGOS	VÍRUS
cobre	não cobre	não cobre	não cobre	não cobre	não cobre	não cobre	não cobre	não cobre

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Preferida para MSSA grave quando disponível.
- Não cobre MRSA, Enterococcus nem Gram-negativos.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▫ Hepatotoxicidade ▫ Neutropenia se uso prolongado ▫ Flebite	• Pode reduzir níveis de varfarina por indução enzimática

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A34

Penicilina benzatina

- ESTREITO
- PENICILINAS
- IM
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2,4 milhões UI IM dose única ou semanal conforme indicação	Não usar para infecção grave sistêmica	IM

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Não atinge níveis séricos adequados para sepse, meningite ou endocardite.
- Útil em faringite estreptocócica e sífilis conforme estágio.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▮ Dor local ▮ Reação alérgica ▮ Anafilaxia rara	• Poucas interações relevantes

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A35

Penicilina G cristalina

- ESTREITO
- PENICILINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
2–4 milhões UI EV 4/4 h conforme indicação	18–24 milhões UI/dia divididos 4/4 h ou infusão contínua	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS depende	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

Anaeróbios: clostrídios sensíveis

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Base para neurosífilis, meningococo sensível, estreptococos e clostridioses específicas.
- Dose depende muito do sítio e do patógeno.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Hipernatremia/hipercalcemia conforme formulação ▪ Convulsão em dose alta + DRC ▪ Alergia	▪ Metotrexato ▪ Probenecida

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A36

Piperacilina-tazobactam

MUITO AMPLO

PENICILINAS

EV

FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
4,5 g EV a cada 6–8 h	4,5 g EV 6/6 h; considerar infusão estendida	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL depende	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------

ESBL: não preferir em ESBL grave

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Boa cobertura empírica hospitalar para abdome, aspiração grave e sepse com Pseudomonas.
- Não cobre MRSA; ESBL grave geralmente exige carbapenêmico conforme sítio/gravidade.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Lesão renal especialmente com vancomicina ▪ Hipocalcemia ▪ Citopenias se uso prolongado	▪ Vancomicina aumenta risco de nefrotoxicidade ▪ Metotrexato

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A37

Polimixina B

- MUITO AMPLO
- POLIMIXINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
Dose de ataque 2–2,5 mg/kg EV, depois 1,25–1,5 mg/kg EV 12/12 h	Usar conforme protocolo institucional e sensibilidade	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI não cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA não cobre	PSEUDOMONAS cobre	ESBL cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Reserva para Gram-negativos extensivamente resistentes.
- Não cobre Proteus, Serratia, Providencia, Burkholderia nem Gram-positivos/anaeróbios.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▮ Nefrotoxicidade ▮ Neurotoxicidade ▮ Bloqueio neuromuscular	• Outros nefrotóxicos

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A38

Rifampicina

- ESTREITO
- RIFAMICINAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
600 mg VO/EV 24/24 h (10 mg/kg/dia, máximo 600 mg)	600 mg 12/12 h na quimioprofilaxia de meningococo, por 2 dias	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI depende	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS depende	MRSA depende	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

G+ Cocci: sempre em associação · G- Bacilli: Neisseria, Haemophilus · Atípicos: micobactérias · MRSA: só como adjuvante em biofilme

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Nunca usar em monoterapia numa infecção estabelecida: a resistência emerge em dias.
- Como adjuvante anti-biofilme em infecção de prótese ou material, só iniciar depois do desbridamento, com carga bacteriana reduzida, ferida estável e sem bacteremia ativa.
- Indutor potente do citocromo P450: reduz o efeito de anticoagulantes orais, contraceptivos, antirretrovirais, azólicos, corticoides, tacrolimo e ciclosporina. Revisar toda a prescrição antes de iniciar.

- Colore urina, lágrima e suor de laranja e mancha lentes de contato gelatinosas — avisar o paciente para não interromper o tratamento por susto.
- Monitorar transaminases e bilirrubinas, sobretudo em hepatopatia e em associação com isoniazida e pirazinamida.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Hepatotoxicidade • Coloração alaranjada de secreções • Náusea • Citopenias • Síndrome gripal no uso intermitente	• Indução do CYP450: varfarina, contraceptivos, antirretrovirais, azólicos, tacrolimo, ciclosporina, corticoides, metadona

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Ficha acrescentada na 4ª edição. Revisão da ficha: setembro de 2026.

A39

Sulfametoxazol-trimetoprim

- INTERMEDIÁRIO
- SULFONAMIDAS
- VO/EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
800/160 mg (1 comprimido) VO 12/12 h	TMP 8–10 mg/kg/dia para infecção grave; TMP 15–20 mg/kg/dia para PJP	VO/EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI depende	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA depende	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS depende	VÍRUS não cobre
---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

G+ Cocci: CA-MRSA variável · MRSA: CA-MRSA · Fungos: PJP

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Útil para CA-MRSA, ITU sensível, Stenotrophomonas e PJP.
- Evitar no final da gestação e em deficiência de G6PD conforme risco.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
• Hiperpotassemia • Rash/SJS • Mielossupressão • Lesão renal funcional	• IECA/BRA/espironolactona: hipercalcemia • Varfarina aumenta INR • Metotrexato

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A40

Tigeciclina

- MUITO AMPLO
- TETRACICLINAS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
Dose de ataque 100 mg EV, depois 50 mg EV 12/12 h	Considerar dose alta em infecção grave conforme protocolo	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI cobre	ANAERÓBIOS cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Baixa concentração sérica/urinária; evitar como solução para bacteremia/ITU e considerar alerta de mortalidade.
- Não cobre Pseudomonas, Proteus ou Providencia de forma confiável.
- Baixas concentrações séricas e urinárias: inadequada para bacteremia e ITU. Evitar se houver alternativa eficaz em infecção sistêmica.
- Há alerta de aumento de mortalidade; reservar quando benefício superar risco e validar com infectologia.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Náusea/vômitos frequentes ▪ Pancreatite rara ▪ Aumento de mortalidade em alguns cenários	• Varfarina: monitorar INR

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

A41

Vancomicina

- ESTREITO
- GLICOPEPTÍDEOS
- EV
- FICHA

DOSE PADRÃO	DOSE EM QUADRO GRAVE	VIA
15–20 mg/kg EV a cada 8–12 h conforme função renal/nível	Dose de ataque 20–30 mg/kg EV; manutenção guiada por AUC/nível	EV

ESPECTRO — NÃO SUBSTITUI ANTIBIOGRAMA

G+ COCCI cobre	G- BACILLI não cobre	ANAERÓBIOS não cobre	ATÍPICOS não cobre	MRSA cobre	PSEUDOMONAS não cobre	ESBL não cobre	FUNGOS não cobre	VÍRUS não cobre
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

SEGURANÇA E MONITORIZAÇÃO

- Confirmar indicação, peso, função renal/hepática, alergias, interações, dose e duração.
- Cobertura MRSA para pneumonia, bacteremia, meningite e infecções graves.
- Monitorização terapêutica é essencial em uso prolongado/DRC/graves.

EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

EFEITOS ADVERSOS	INTERAÇÕES
▪ Nefrotoxicidade ▪ Reação relacionada à infusão ▪ Neutropenia se uso prolongado	▪ Piperacilina-tazobactam aumenta risco renal ▪ Aminoglicosídeos/anfotericina: nefrotoxicidade

FONTE E DATA DA FICHA

- Bulário Eletrônico da Anvisa e bula da apresentação dispensada — dose, preparo, contraindicações e ajuste.
- Diretriz da síndrome correspondente — indicação e duração.
- Conteúdo clínico revisto em 15/08/2026; revisão clínica e editorial da 4ª edição em setembro de 2026. Essas fontes não representam a mesma evidência.

Índice de antimicrobianos

Onde cada antimicrobiano aparece com dose e ajuste. O número é o do quadro; em seguida, a página.

Aciclovir

7.2 p. 146 · 11.5 p. 230 · 12.8 p. 256 · 19.11 p. 413 ·
ficha p. 423

Ácido fólico

7.5 p. 153

Amicacina

ficha p. 423

Amoxicilina

1.1 p. 13 · 2.1 p. 40 · 2.3 p. 44 · 3.8 p. 74 · 13.1 p. 261 ·
14.1 p. 279 · 14.2 p. 282 · 14.4 p. 286 · ficha p. 424

Amoxicilina-clavulanato

1.1 p. 13 · 1.3 p. 21 · 1.4 p. 23 · 2.8 p. 54 · 3.1 p. 58 ·
3.2 p. 60 · 3.5 p. 68 · 3.6 p. 70 · 3.7 p. 72 · 4.3 p. 83 ·
4.4 p. 86 · 6.1 p. 121 · 9.5 p. 190 · 10.7 p. 215 ·
12.4 p. 247 · 12.7 p. 254 · 14.2 p. 282 · 14.3 p. 284 ·
14.11 p. 302 · 15.2 p. 309 · 17.9 p. 350 · 19.12 p. 415 ·
ficha p. 425

Ampicilina

7.1 p. 142 · 10.3 p. 205 · 10.4 p. 208 · 19.12 p. 415 ·
ficha p. 425

Ampicilina + Ceftriaxona

8.1 p. 161

Ampicilina-sulbactam

1.5 p. 26 · 1.6 p. 28 · 2.2 p. 42 · 3.2 p. 60 · 3.3 p. 63 ·
3.7 p. 72 · 4.3 p. 83 · 4.4 p. 86 · 9.8 p. 197 ·
14.11 p. 302 · 15.3 p. 311 · 18.12 p. 384 · ficha p. 426

Anfotericina B lipossomal

15.9 p. 324 · ficha p. 427

Anidulafungina

15.4 p. 313

Artesunato

13.5 p. 269

Azitromicina

1.1 p. 13 · 3.8 p. 74 · 6.6 p. 133 · 10.8 p. 217 ·
11.1 p. 221 · 11.3 p. 226 · 13.6 p. 271 · 17.6 p. 345 ·
ficha p. 427

Aztreonam

8.2 p. 164 · 8.5 p. 171 · 18.8 p. 374 · 19.7 p. 404 ·
ficha p. 428

Cefalexina

4.1 p. 78 · 4.8 p. 96 · 9.7 p. 195 · 10.6 p. 212 ·
12.9 p. 258 · 14.5 p. 288 · 14.6 p. 291 · 14.7 p. 293 ·
ficha p. 428

Cefazolina

4.1 p. 78 · 4.6 p. 91 · 8.4 p. 169 · 9.1 p. 180 ·
9.2 p. 182 · 9.4 p. 187 · 9.6 p. 192 · 14.10 p. 300 ·
17.10 p. 352 · ficha p. 429

Cefepime

1.1 p. 13 · 1.2 p. 17 · 1.9 p. 36 · 2.5 p. 47 · 2.6 p. 49 ·
5.3 p. 106 · 7.1 p. 142 · 7.4 p. 150 · 8.2 p. 164 ·
8.5 p. 171 · 8.6 p. 174 · 9.2 p. 182 · 9.3 p. 185 ·
9.4 p. 187 · 9.6 p. 192 · 14.9 p. 297 · 15.1 p. 306 ·
15.7 p. 319 · 16.1 p. 328 · 18.1 p. 356 · 18.5 p. 366 ·
19.11 p. 413 · ficha p. 430

Cefiderocol

18.9 p. 377

Ceftazidima

ficha p. 430

Ceftazidima-avibactam

18.8 p. 374 · ficha p. 431

Ceftazidima intravítrea

12.6 p. 252

Ceftazidima/Cefepime

18.4 p. 364

Ceftolozano-tazobactam

18.9 p. 377

Ceftriaxona

1.1 p. 13 · 1.7 p. 31 · 2.6 p. 49 · 2.7 p. 52 · 5.1 p. 100 ·
6.1 p. 121 · 6.2 p. 124 · 6.4 p. 129 · 6.5 p. 131 ·
6.6 p. 133 · 6.8 p. 138 · 7.1 p. 142 · 7.3 p. 148 ·
8.1 p. 161 · 9.1 p. 180 · 9.2 p. 182 · 9.3 p. 185 ·
10.1 p. 201 · 10.2 p. 203 · 10.7 p. 215 · 10.8 p. 217 ·
11.1 p. 221 · 11.2 p. 223 · 11.7 p. 234 · 12.2 p. 243 ·
12.5 p. 249 · 13.2 p. 263 · 13.6 p. 271 · 14.1 p. 279 ·
14.3 p. 284 · 14.5 p. 288 · 14.8 p. 295 · 14.9 p. 297 ·
15.3 p. 311 · 17.5 p. 343 · 17.9 p. 350 · 19.2 p. 391 ·
19.12 p. 415 · ficha p. 432

Ceftriaxona + Metronidazol

3.4 p. 66 · 4.6 p. 91

Ceftriaxona + Metronidazol + Vancomicina

7.7 p. 157

Cefuroxima

ficha p. 432

Ciprofloxacino

1.8 p. 34 · 2.5 p. 47 · 5.1 p. 100 · 6.6 p. 133 ·
15.2 p. 309 · 17.5 p. 343 · ficha p. 433

Ciprofloxacino/ofloxacino otológico

2.4 p. 45

Claritromicina

ficha p. 434

Clindamicina

2.2 p. 42 · 3.1 p. 58 · 4.5 p. 89 · 4.8 p. 96 · 9.7 p. 195 ·
10.3 p. 205 · 10.4 p. 208 · 10.6 p. 212 · 12.7 p. 254 ·
14.6 p. 291 · 14.10 p. 300 · ficha p. 434

Clindamicina + Primaquina

15.5 p. 315

Clindamicina + Rifampicina

4.7 p. 94

Cloroquina + Primaquina

13.4 p. 267

Colistina/Polimixina

18.12 p. 384

Daptomicina

8.3 p. 167 · 8.4 p. 169 · 8.6 p. 174 · 18.10 p. 380 ·
ficha p. 435

Dexametasona

7.1 p. 142

Doxiciclina

1.4 p. 23 · 4.2 p. 81 · 4.7 p. 94 · 10.1 p. 201 ·
11.1 p. 221 · 11.3 p. 226 · 11.4 p. 228 · 11.7 p. 234 ·
11.8 p. 236 · 11.9 p. 238 · 12.2 p. 243 · 13.1 p. 261 ·
13.3 p. 265 · ficha p. 435

Doxiciclina + Metronidazol

4.3 p. 83

Doxiciclina + Rifampicina

13.7 p. 273

dT/dTpa ± TIG

17.4 p. 341

Ertapenem

ficha p. 436

Fidaxomicina

6.7 p. 136

Fluconazol

15.4 p. 313 · ficha p. 437

Fluoroquinolona tópica

12.1 p. 241 · 12.3 p. 245

Fosfomicina trometamol

5.2 p. 104 · ficha p. 437

Ganciclovir

15.8 p. 322

Gentamicina

10.3 p. 205 · 10.4 p. 208 · 11.2 p. 223 · 13.7 p. 273 ·
ficha p. 438

HBIG + Vacina hepatite B

17.2 p. 337 · 17.8 p. 348

Imunoglobulina humana antitetânica

13.8 p. 275

Levofloxacino

1.1 p. 13 · 1.3 p. 21 · 18.11 p. 382 · ficha p. 439

Linezolid

18.2 p. 359 · 18.10 p. 380 · ficha p. 439

Meropenem

1.2 p. 17 · 4.4 p. 86 · 4.5 p. 89 · 5.1 p. 100 · 5.3 p. 106 ·
6.3 p. 126 · 6.4 p. 129 · 6.5 p. 131 · 7.4 p. 150 ·
8.7 p. 176 · 10.2 p. 203 · 10.5 p. 210 · 15.1 p. 306 ·
15.6 p. 317 · 15.7 p. 319 · 16.1 p. 328 · 18.5 p. 366 ·
18.6 p. 369 · 18.7 p. 371 · 18.12 p. 384 · 19.3 p. 393 ·
19.4 p. 396 · ficha p. 440

Metronidazol

1.7 p. 31 · 6.1 p. 121 · 6.2 p. 124 · 6.4 p. 129 ·
6.7 p. 136 · 6.8 p. 138 · 7.3 p. 148 · 9.5 p. 190 ·
9.8 p. 197 · 10.1 p. 201 · 10.8 p. 217 · 11.6 p. 232 ·
12.5 p. 249 · 13.8 p. 275 · 17.10 p. 352 · 19.7 p. 404 ·
ficha p. 440

Micafungina

8.5 p. 171 · 15.4 p. 313 · 15.9 p. 324 · 16.1 p. 328 ·
18.3 p. 361 · 18.6 p. 369 · 19.4 p. 396 · 19.5 p. 399 ·
ficha p. 441

Moxifloxacino

11.8 p. 236

Mupirocina

4.8 p. 96 · 14.7 p. 293

Nitrofurantoína

5.2 p. 104 · ficha p. 442

Oseltamivir

17.7 p. 346 · ficha p. 442

Oxacilina

8.1 p. 161 · 8.3 p. 167 · 8.7 p. 176 · 9.1 p. 180 ·
9.2 p. 182 · 9.4 p. 187 · 9.6 p. 192 · ficha p. 443

Penicilina benzatina

2.1 p. 40 · 11.4 p. 228 · 14.4 p. 286 · ficha p. 444

Penicilina G cristalina

4.5 p. 89 · 13.2 p. 263 · ficha p. 444

Piperacilina-tazobactam

1.1 p. 13 · 1.5 p. 26 · 1.6 p. 28 · 1.8 p. 34 · 3.2 p. 60 ·
3.3 p. 63 · 3.4 p. 66 · 4.4 p. 86 · 4.5 p. 89 · 4.6 p. 91 ·
5.3 p. 106 · 6.1 p. 121 · 6.2 p. 124 · 6.3 p. 126 ·
6.5 p. 131 · 6.8 p. 138 · 8.7 p. 176 · 9.5 p. 190 ·
10.2 p. 203 · 10.5 p. 210 · 15.1 p. 306 · 15.7 p. 319 ·
16.1 p. 328 · 18.2 p. 359 · 19.2 p. 391 · 19.3 p. 393 ·
ficha p. 445

Pirimetamina

7.5 p. 153

Polimixina B

ficha p. 446

Rifampicina

17.5 p. 343 · ficha p. 446

Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida/Etambutol

7.6 p. 155

Sulbactam-durlobactam

18.12 p. 384

Sulfadiazina

7.5 p. 153

Sulfametoxazol-trimetoprima

4.2 p. 81 · 5.2 p. 104 · 10.6 p. 212 · 12.4 p. 247 ·
15.5 p. 315 · 15.6 p. 317 · 18.7 p. 371 · 18.11 p. 382 ·
ficha p. 447

TDF/3TC + Dolutegravir

17.1 p. 335 · 17.8 p. 348

Terapia combinada com artemisinina

13.4 p. 267

Tigeciclina

ficha p. 448

Tobramicina colírio 0,3%

12.1 p. 241

Tobramicina pomada oftálmica 0,3%

12.9 p. 258

Vacina antirrábica ± SAR/IGHAR

17.3 p. 338

Valaciclovir

11.5 p. 230 · 12.8 p. 256

Valganciclovir

15.8 p. 322

Vancomicina

1.1 p. 13 · 1.2 p. 17 · 1.9 p. 36 · 2.7 p. 52 · 3.3 p. 63 ·
4.1 p. 78 · 4.2 p. 81 · 4.5 p. 89 · 6.3 p. 126 · 7.1 p. 142 ·
8.1 p. 161 · 8.2 p. 164 · 8.3 p. 167 · 8.4 p. 169 ·
8.6 p. 174 · 9.1 p. 180 · 9.2 p. 182 · 9.3 p. 185 ·
9.4 p. 187 · 9.5 p. 190 · 9.6 p. 192 · 9.7 p. 195 ·
9.8 p. 197 · 10.5 p. 210 · 12.5 p. 249 · 14.8 p. 295 ·
14.9 p. 297 · 16.1 p. 328 · 18.1 p. 356 · 18.3 p. 361 ·
18.4 p. 364 · 19.3 p. 393 · 19.4 p. 396 · 19.5 p. 399 ·
19.7 p. 404 · 19.11 p. 413 · ficha p. 448

Vancomicina (via oral, para C. difficile)

6.7 p. 136

Vancomicina + Ceftazidima/Tobramicina tópicas fortificadas

12.3 p. 245

Vancomicina intravítrea

12.6 p. 252

Voriconazol

15.9 p. 324